

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-graduação em Educação

Evergisto Souto Maior Lopes

**O PROCESSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR EM QUIROPRACTIA NO BRASIL:
das orientações da Organização Mundial da Saúde ao processo de construção das
Diretrizes Curriculares Nacionais**

Belo Horizonte

2026

Evergisto Souto Maior Lopes

**O PROCESSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR EM QUIROPRAIXIA NO BRASIL:
das orientações da Organização Mundial da Saúde ao processo de construção das
Diretrizes Curriculares Nacionais**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Educação.

Orientadora: Prof. Dra. Maria Inês Martins

Belo Horizonte

2026

FICHA CATALOGRÁFICA

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

L864p	Lopes, Evergisto Souto Maior O processo de formação superior em Quiropraxia no Brasil: das orientações da Organização Mundial da Saúde ao processo de construção das Diretrizes Curriculares Nacionais / Evergisto Souto Maior Lopes. Belo Horizonte, 2026. 163 f.: il. Orientadora: Maria Inês Martins Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Educação 1. Organização Mundial da Saúde. 2. Quiroprática - História. 3. Quiroprática - Estudo e ensino (Superior) - Brasil. 4. Quiroprática - Currículos - Brasil. 5. Quiroprática - Regulamentação - Brasil. 6. Quiroprática - Formação profissional - Brasil. 7. Prática profissional. I. Martins, Maria Inês. II. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Educação. III. Título.
-------	---

SIB PUC MINAS

CDU: 371.214

Ficha catalográfica elaborada por Fabiana Marques de Souza e Silva - CRB 6/2086

Evergisto Souto Maior Lopes

**O PROCESSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR EM QUIROPRAIXIA NO BRASIL:
das orientações da Organização Mundial da Saúde ao processo de construção das
Diretrizes Curriculares Nacionais**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Educação.

Profa. Dra. Maria Inês Martins – PUC Minas (Orientadora)

Profa. Dra. Ranieli Gehlen Zapelini – Universidade FEEVALE – RS (Banca Examinadora)

Prof. Dr. Teodoro Adriano Costa Zanardi – PUC Minas (Banca Examinadora)

Belo Horizonte, 20 de março de 2026.

Dedico esse trabalho aos pioneiros que, desde 1913, semearam os ideais da quiropraxia no Brasil, e àqueles que, em 2000, acreditaram na viabilidade de uma formação superior pautada pela resiliência.

Aos entusiastas que, com inabalável compromisso ético, não recuaram ante as lacunas normativas e as pressões de outrora, mantendo viva a essência da filosofia, ciência e arte quiroprática.

Que este trabalho, orientado à construção das DCN, constitua-se em um marco para a proteção da nossa gente, assegurando que a excelência clínica seja um direito soberano e institucionalizado no cenário da saúde pública brasileira.

AGRADECIMENTOS

À amada esposa, Elida, por acreditar em mim e por sua dedicação e apoio, sob sacrifício do próprio tempo e atenção em muitas madrugadas, sem os quais eu jamais seria capaz de desenvolver esse trabalho com a seriedade e comprometimento que merece.

Aos meus filhos Weverlley, Helton e Évelyn, por me ajudarem a ver, sob novas perspectivas, as distinções de valores e percepções que muito contribuíram para esta obra.

Aos pacientes que me inspiraram a continuar a luta pela estruturação da quiropraxia em favor da nossa gente, de forma ética, coesa e legítima.

Aos colegas do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e Avaliação Educacional, pelas ricas contribuições ao universo da pesquisa séria e valorosa.

À equipe da Biblioteca da PUC Minas, na pessoa da brilhante Paola Arantes, cujo profissionalismo e rigor técnico, aliados ao apoio nas inúmeras etapas da pesquisa, em especial na Revisão Sistemática da Literatura, permitiram o aprofundamento necessário à realização desse trabalho.

Ao professor Jefferson França Gordiano, pelo irrestrito apoio nas inúmeras traduções do inglês e do espanhol no universo técnico quiroprático.

Aos 12 participantes, nacionais e internacionais, que cederam seu tempo e conhecimento nas entrevistas que viabilizaram maior robustez a pesquisa.

A CAPES, cuja bolsa viabilizou essa pesquisa.

À Prof.^a Dra. Maria Inês Martins, cujo exemplo transcendeu a orientação para tornar-se inspiração absoluta. Minha gratidão pelo rigor técnico e pela seriedade ética que balizaram cada etapa deste mergulho investigativo. Agradeço pela condução firme e pela leveza providencial, que permitiram que este mestrado fosse um espaço de descobertas genuínas. No privilégio desta parceria acadêmica, assumo a honra de ter seu nome como a referência maior e o norte constante de minha formação.

Sobretudo, meu agradecimento a Deus, por me amar e por ter ouvido as minhas preces nos momentos de incertezas; por ter colocado essas pessoas em meu caminho para contribuir tão ricamente nesta pesquisa; por ter me capacitado a abrir o olhar para o universo da pesquisa numa perspectiva leve e eficaz, permitindo-me o senso de missão cumprida.

Um Conselho de Educação é, antes de tudo, um órgão público voltado para garantir, na sua especificidade, um direito constitucional da cidadania. Suas funções são um múnus público e sua função normativa, a mais nobre do órgão, implica o ser um intelectual da legislação para, em sua aplicação ponderada, garantir o padrão de qualidade. A equidade é, assim, uma adequação prudente, uma correção da lei quando ela é deficiente em razão de sua universalidade, sendo indispensável para assegurar a supremacia axiológica da Constituição no resguardo do interesse coletivo e da segurança social.

(Carlos Roberto Jamil Cury)

RESUMO

A presente dissertação investiga o processo de institucionalização da formação superior em Quiropraxia no Brasil, explorando o hiato normativo entre as recomendações internacionais e a realidade regulatória nacional. O objetivo geral consiste em analisar os marcos legais da oferta de bacharelado no país para subsidiar a estruturação de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), em consonância com o consenso mundial de segurança clínica. A fundamentação histórica revela que as Terapias Manipulativas Articulares (TMA) remontam a registros de 1552 a.C. no Egito e práticas milenares no Oriente, evoluindo pela Europa até a sistematização universitária nos EUA em 1897 por D.D. Palmer. Mundialmente, a profissão é regida pela Federação Mundial de Quiropraxia (WFC) — em relação oficial com a OMS — e por órgãos de acreditação como o Concelho Internacional de Educação em Quiropraxia (CCEI) e o Conselho Latino-Americano de Educação em Quiropraxia (CCE-LA), que garantem padrões globais do ensino da quiropraxia. No Brasil, o processo histórico iniciou-se no século XX (1913 e 1919), consolidando-se em 2000 com os cursos pioneiros de bacharelado em quiropraxia por meio da Universidade FEEVALE-RS e UAM-SP, baseados em convênios internacionais e as prerrogativas regulatórias do Ministério da Educação (MEC). A metodologia de natureza qualitativa ancorou-se na triangulação entre Revisão Sistemática da Literatura (RSL), Análise Documental de marcos normativos e Pesquisa Empírica mediante 12 entrevistas semiestruturadas com atores nacionais e internacionais estratégicos. Os resultados desvelam um paradoxo: embora os cursos detenham legitimidade acadêmica desde 2000, a formação permanece sob o estatuto de Inovador e Experimental (Art. 81 da LDB) há 25 anos, sem DCN específicas. Esta lacuna fomenta a proliferação de ofertas despadronizadas, oriundas das dicotomias dos cursos livres por profissionais sem formação comprovada, presentes no país desde a década de 1960, agravada pela interferência sistemática de autarquias corporativistas de áreas correlatas que obstaculizam a regulamentação da profissão por lei específica. As conclusões asseveram o exaurimento do ciclo experimental e a premência da formalização das DCN apresentada em texto sugestivo a partir da compilação dos marcos regulatórios balizadores globais advindos das sugestões da OMS, dos standards do CCE-LA e o regramento do Conselho Nacional de Educação e Conselho Nacional de Saúde, como um múnus público indispensável para converter a maturidade da experiência acumulada em norma soberana, garantindo a segurança biológica da coletividade e a equivalência internacional da formação.

Palavras-chave: Quiropraxia; Ensino Superior; Diretrizes Curriculares Nacionais; Regulamentação Profissional.

ABSTRACT

This dissertation investigates the process of institutionalization of higher education in Chiropractic in Brazil, exploring the normative gap between international recommendations and the national regulatory reality. The general objective is to analyze the legal frameworks governing the provision of bachelor's degree programs in the country in order to support the structuring of National Curricular Guidelines (DCNs), in line with the global consensus on clinical safety. The historical foundation reveals that Joint Manipulative Therapies (JMT) date back to records from 1552 BC in Egypt and to millennia-old practices in the East, evolving through Europe until their university systematization in the United States in 1897 by D.D. Palmer. Worldwide, the profession is governed by the World Federation of Chiropractic (WFC)—in official relations with the World Health Organization (WHO)—and by accreditation bodies such as the Council on Chiropractic Education International (CCEI) and the Latin American Council on Chiropractic Education (CCE-LA), which ensure global standards for chiropractic education. In Brazil, the historical process began in the early 20th century (1913 and 1919), consolidating in 2000 with the pioneering bachelor's degree programs in chiropractic through Universidade FEEVALE-RS and UAM-SP, based on international agreements and the regulatory prerogatives of the Ministry of Education (MEC). The qualitative methodology was grounded in triangulation among a Systematic Literature Review (SLR), Documentary Analysis of normative frameworks, and Empirical Research through 12 semi-structured interviews with strategic national and international stakeholders. The results reveal a paradox: although the programs have held academic legitimacy since 2000, training has remained under the status of Innovative and Experimental (Art. 81 of the LDB) for 25 years, without specific DCNs. This gap fosters the proliferation of non-standardized offerings, arising from the dichotomies of non-degree courses taught by professionals without proven training, present in the country since the 1960s, and exacerbated by systematic interference from corporatist public bodies of related fields that obstruct professional regulation through specific legislation. The conclusions assert the exhaustion of the experimental cycle and the urgency of formalizing DCNs, presented in a proposed text based on the compilation of global guiding regulatory frameworks derived from WHO recommendations, CCE-LA standards, and the regulations of the National Council of Education and the National Health Council, as an indispensable public duty to transform the maturity of accumulated experience into sovereign norms, ensuring collective biological safety and international equivalence of training.

Keywords: Chiropractic; Higher Education; National Curricular Guidelines; Professional Regulation.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Critério para o levantamento das produções acadêmicas	23
Quadro 2 - Levantamento das produções acadêmicas nas Fontes	24
Quadro 3 - Teses e Dissertações incluídos na RSL	26
Quadro 4 - Cronologia: TMA – da origem documental à sistematização nos EUA.....	34
Quadro 5 - Instituições de Graduação em Quiropraxia no Mundo de 1897 a 2025	43
Quadro 6 - ONGs em relação oficial com a OMS	44
Quadro 7 - Status da Prática da Quiropraxia mundialmente em 2025.....	74
Quadro 8 - Primeiros Cursos Oficiais de Graduação em Quiropraxia no Brasil	77
Quadro 9 - Projetos de Lei que preveem a regulamentação da Quiropraxia no Brasil	79
Quadro 10 - Triangulação entre as 3 categorias com os 12 temas em 94 perguntas aos 12 entrevistados	101
Quadro 11 - Categoria I: resultados do Tema 1	102
Quadro 12 - Categoria I: resultados do Tema 2	104
Quadro 13 - Categoria I: resultados do Tema 3	105
Quadro 14 - Categoria II: resultados do Tema 4.....	107
Quadro 15 - Categoria II: resultados do Tema 5.....	109
Quadro 16 - Categoria II: resultados do Tema 6.....	112
Quadro 17 - Categoria III: resultados do Tema 7	115
Quadro 18 - Categoria III: resultados do Tema 8	117
Quadro 19 - Categoria III: resultados do Tema 9	120
Quadro 20 - Categoria III: resultados do Tema 10	122
Quadro 21 - Categoria III: resultados do Tema 11	125
Quadro 22 - Categoria III: resultados do Tema 12	127
Quadro 23 - Questões exploradas, na entrevista por Temas	131

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Mapeamento Prisma da RSL em Teses e Dissertações	25
Figura 2 -	Rede de entrevistados no contexto do objeto da análise proposta nessa pesquisa	31
Figura 3 -	Placa do Papiro Edwin Smith, com casos de lesão na coluna em escrita hierática	35
Figura 4 -	Prática do Tuiná, derivado da Medicina Tradicional Chinesa (1.600 – 1.110 a.C.) formalizado no séc. VI d.C.	36
Figura 5 -	<i>The Chiropractic Adjuster</i> uma obra redigida por B.J. Palmer em 1921	38
Figura 6 -	Daniel David Palmer.....	38
Figura 7 -	Primeira Escola de Quiropraxia.....	39
Figura 8 -	“ <i>Princípios Essenciais da Quiropraxia</i> ” uma obra de Virgil V. Strang.....	40
Figura 9 -	Linha Regressa do Processo Histórico da Educação em Quiropraxia no Brasil ..	59
Figura 10 -	Organograma do status da educação em Quiropraxia no mundo	69
Figura 11 -	Linha do tempo da tramitação dos PL da Quiropraxia junto ao Poder Legislativo	79
Figura 12 -	Organograma estruturante para construção da DCN da quiropraxia	97

LISTA DE IMAGENS

Imagem 1 - Registro da brasileira Isabel Biskels no Palmer College of Chiropractic em 1913	48
Imagem 2 - Ex-alunos Estrangeiros no Davenport College of Chiropractic em 1917.....	49
Imagem 3 - Quiropraxista escocês residente no Brasil em 1919	50
Imagem 4 - Carta do CCE do Estado do Colorado – USA sobre universidade que teria formado 28 brasileiros em Curitiba no ano de 1964, ter encerrado suas atividades em 1962	52
Imagem 5 - Pal Garry Krakos (Palmer) e Francisco A. Stürmer (FEEVALE): assinatura do convênio Palmer College e Universidade FEEVALE, 1997	55
Imagem 6 - Credenciamento do IBRAQUI para curso de especialização	61
Imagem 7 - Resposta ao questionamento ANQ sobre registro de especialista	62
Imagem 8 - Questionamento MP sobre registro de especialista	64
Imagem 9 - Entidade representante da especialidade da Quiropraxia para fisioterapeutas em 08/2008	65
Imagem 10 - IFOMPT/WCPT declara distinção entre Fisioterapia e Quiropraxia na prática das Terapias Manipulativas Articulares	66
Imagem 11 - Diretrizes da OMS para Quiropraxia em vários idiomas.....	73
Imagem 13 - Tramitação da proposta legislativa da quiropraxia aprovada no Senado	80
Imagem 14 - Atos regulatórios do bacharelado em Quiropraxia Universidades FEEVALE e UAM	85
Imagem 15- Homologação do parecer referendando a DCN do Físico	88
Imagem 16 -Homologação das DCN do Sanitarista	89
Imagem 17 -Regulamentação da profissão de sanitarista	89
Imagem 18 - Curso de Quiropraxia na Modalidade EaD: Registro no Sistema e-MEC	92
Imagem 19 - Oferta de Cursos Online de Quiropraxia.....	93
Imagem 20 - Recurso da FEEVALE ao CNS em 2008 para o curso de Quiropraxia	94

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografia 1 - Formatura do curso para capacitação de docentes FEEVALE & Palmer, 03/2000	57
Fotografia 2 - Alunos da primeira turma do bacharelado em Quiropraxia – FEEVALE 2000..	57
Fotografia 3 - Alunos da primeira turma do bacharelado em Quiropraxia – UAM 2000	58
Fotografia 4 - Participação dos coordenadores e alunos da primeira turma de graduação em Quiropraxia da UAM e FEEVALE na Conferência Mundial de Educação em Quiropraxia pela WFC e ACC – São Paulo – Brasil, 2002	58

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABQ	Associação Brasileira de Quiropraxia
ACC	Associação das Faculdades de Quiropraxia
AECC	Anglo-European College of Chiropractic
ANQ	Associação Nacional de Quiropraxia
ARB	Associação de Renovação Biológica
ASO	American School of Osteopathy
BDTD	Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CBO	Classificação Brasileira de Ocupações
CCEC	Conselho de Educação em Quiropraxia do Canadá
CCE	Conselho de Educação em Quiropraxia
CCEA	Conselho de Educação em Quiropraxia da Australásia
CCEB	Conselho Canadense de Exames em Quiropraxia
CCEC	Conselho de Educação em Quiropraxia do Canadá
CCEI	Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia
CCE-LA	Conselho de Educação em Quiropraxia da América Latina
CCEUS	Conselho de Educação em Quiropraxia dos Estados Unidos da América
CFCRB	Federação Canadense de Conselhos Reguladores
CE	Critérios de exclusão
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CI	Critérios de inclusão
CHA	Conhecimento, Habilidade e Atitude
CMCC	Canadian Memorial Chiropractic College
CNAE	Código Nacional de Atividades Econômicas
CNE	Conselho Nacional de Educação
CREFITO	Conselho Regional de Fisioterapia
DCC	Davenport College of Chiropractic
DCN	Diretrizes Curriculares Nacionais
EaD	Educação a Distância
ECCE	Conselho Europeu de Educação em Quiropraxia
ECU	European Chiropractic Union
FCC	Federation of Canadian Chiropractic

FCLB	Federação dos Conselhos de Habilitação Profissional em Quiropraxia
FEEVALE	Universidade FEEVALE – Rio Grande do Sul
FLAQ	Federação Latino-Americana de Quiropraxia
IBCE	Conselho Internacional de Examinadores de Quiropraxia
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBRAQUI	Instituto Brasileiro de Quiropraxia
ICEA	Aliança Internacional de Educação em Quiropraxia
IES	Instituição de Ensino Superior
IFOMPT	Federação Internacional de Fisioterapeutas Manipulativos Ortopédicos
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC	Ministério da Educação
MECh	Ministério da Educação do Chile
MEM	Ministério da Educação do México
MS	Ministério da Saúde
NBCE	Conselho Nacional dos Examinadores em Quiropraxia
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONG	Organização não governamental
OPAS	Organização Pan-Americana da Saúde
PNIC	Políticas Nacionais das Práticas Integrativas e Complementares
PPC	Projetos Pedagógicos de Cursos
PL	Projeto de Lei
RSL	Revisão Sistemática da Literatura
SUS	Sistema Único de Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TMA	Terapias Manipulativas Articulares
UAM	Universidade Anhembi Morumbi – SP
UCEFF	Unidade Central de Educação FAEM Faculdade
USA	Estados Unidos da América
WCPT	Confederação Mundial de Fisioterapia
WFC	World Federation of Chiropractic = Federação Mundial de Quiropraxia

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	15
1.1	Tema.....	15
1.2	Problema.....	18
1.3	Objetivos.....	19
1.3.1	<i>Objetivo geral</i>	<i>19</i>
1.3.2	<i>Objetivos específicos</i>	<i>19</i>
1.4	Justificativa	20
2	METODOLOGIA.....	22
2.1	A pesquisa bibliográfica: Revisão Sistemática da Literatura.....	22
2.2	A pesquisa documental: instrumento de exame histórico-regulatório	29
2.3	A pesquisa empírica: percepção dos atores estratégicos.....	30
2.4	A análise de conteúdo: sistematização e inferência	32
3	HISTÓRICO DA QUIROPRAXIA	34
3.1	Das primeiras práticas à consolidação profissional nos Estados Unidos.....	34
3.2	A expansão da profissão no mundo.....	41
3.3	A chegada da Quiropraxia no Brasil	46
3.4	Impasse Quiropraxia X Fisioterapia brasileiras.....	60
4	REGULAMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM QUIROPRAXIA	69
4.1	Organograma do consenso mundial da formação e prática da Quiropraxia.....	69
4.2	OMS – Diretrizes Para Formação Básica e Segurança em Quiropraxia.....	71
4.3	Órgãos de acreditação e controle da formação e prática no mundo.....	73
4.4	Conselhos Regionais: o caso do CCE-LA	76
4.5	Cursos ativos de Quiropraxia no Brasil.....	76
5	REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM QUIROPRAXIA	78
5.1	Surgimento do impasse da regulamentação por Lei no Brasil	78
6	CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS.....	82
6.1	Papel das DCN nos cursos superiores	82
6.2	DCN na área da Saúde	86
6.3	Precedente de DCN sem regulamentação em Lei: o caso do Físico e do Sanitarista	87
6.4	Caminhos para construção das DCN para formação em Quiropraxia	94
7	APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS ...	99
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	137
	REFERÊNCIAS.....	141
	APÊNDICE A ARCABOUÇO PARA CONSTRUÇÃO DA DCN DA QUIROPRAXIA	151

1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema

A institucionalização da Quiropraxia no Brasil configura-se como a afirmação de uma racionalidade em saúde complexa e autônoma, transcendendo a descrição histórica para constituir-se em um marco regulatório propositivo fundamentado no tripé indissociável da filosofia, ciência e arte quiroprática. Sob o rigor científico da educação e a supremacia axiológica da Constituição Federal, visando assegurar a identidade do bacharel e a segurança biológica da coletividade, esta investigação escrutina a trajetória formativa para sanar o hiato normativo de um quarto de século em que a profissão permanece sob o estatuto de excepcionalidade experimental. Diante do exaurimento do ciclo facultado pelo Artigo 81 da LDB e das tensões corporativistas que fragmentam a categoria, o estudo instiga o leitor a desvelar as bases de uma solução normativa definitiva, materializada no Apêndice A (Arcabouço para construção da DCN da Quiropraxia). Este instrumento constitui-se como um imperativo de múnus público indispensável para converter a maturidade da experiência acumulada pelas instituições pioneiras em norma soberana e estável, garantindo a excelência clínica e a legitimidade da Quiropraxia como profissão de primeiro contato no cenário da saúde pública brasileira.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), da qual o Brasil é signatário (Organização Pan-Americana da Saúde, 2023), aponta a Quiropraxia como uma profissão da área da saúde, de formação universitária, de origem Norte Americana, dedicada à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento conservador das disfunções biomecânicas da coluna vertebral e os seus efeitos no sistema nervoso e na saúde em geral. A mesma OMS estabelece Diretrizes, com os pressupostos teórico-conceituais acerca da Formação Básica e a Segurança em Quiropraxia (Organização Mundial da Saúde, 2005).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, Lei nº 9.394/1996, trouxe uma série de inovações para o sistema educacional brasileiro, incluindo a possibilidade de criação de cursos superiores inovadores e experimentais, conforme descrito no Artigo 81 da referida Lei (Brasil, [2024b]) “[...] permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições desta Lei”.

A formação em Quiropraxia, requer critérios técnicos elaborados em padrões determinados para formação de profissionais que desenvolvam habilidades e competências mínimas necessárias à prática segura na saúde pública (Organização Mundial da Saúde, 2005).

Nos países desenvolvidos, a formação em Quiropraxia é subordinada a critérios de educação estabelecidos por agências oficiais de acreditação, fiscalização e controle, tanto da formação quanto da prática no exercício profissional, tais como o Conselho Internacional de Examinadores de Quiropraxia (IBCE), o qual é composto por:

[...] equipe de especialistas em testes composta por especialistas em conteúdo, especialistas em psicomетria e pesquisadores que acreditam no avanço da quiropraxia em todo o mundo por meio de um compromisso intransigente com a qualidade e pesquisas rigorosas. Além disso, o IBCE emprega vários consultores que estão familiarizados com o estado da quiropraxia em sua região específica do mundo (International Board of Chiropractic Examiners, 2023, tradução nossa).

No consenso de que cada país ou jurisdição tem autonomia regulatória, o IBCE oferece pressupostos para a aceitação mundial de um padrão de assistência em quiropraxia, bem como de um nível aceitável de educação e competência, que auxiliam nos processos regulatórios da formação e da prática quiropráticas. Nessa perspectiva, foi criado o Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia (CCEI):

[...] estabelecido em 2001 pelas agências de credenciamento de quiropraxia na Australásia, Canadá, Europa e Estados Unidos da América para garantir altos padrões para a educação em quiropraxia em todo o mundo fornece [...] uma Estrutura Internacional para Educação e Credenciamento de Quiropraxia para as organizações de credenciamento de quiropraxia do mundo para garantir a qualidade da educação de quiropráticos internacionalmente (Peterson *et al.*, 2022, p. 1-2, tradução nossa).

A Federação Mundial de Quiropraxia (WFC) defende que cabe ao Estado formalizar uma diretriz que abarque o consenso sobre a formação quiroprática no mundo, na autonomia do sistema de educação brasileiro, diante das competências curriculares mínimas necessárias à prática dessa profissão da saúde (World Federation of Chiropractic, 2010).

Dentro desse contexto, em 1998, surge a introdução do primeiro programa oficial para formação superior em Quiropraxia no Brasil (Chapman-Smith, 2001), por meio da Universidade FEEVALE – Rio Grande do Sul, em parceria com o Palmer College of Chiropractic – USA. Preliminarmente, a formação ocorre no modelo de especialização, visando a capacitação de docentes para estruturar as bases da oferta do bacharelado em quiropraxia, amparado na Lei nº 9.394 da LDB (Brasil, [2024b]) como uma formação inovadora em uma área da saúde ainda pouco explorada no país.

Este feito possibilitou que a Universidade FEEVALE, no Rio Grande do Sul, em fevereiro de 2000, seguida pela Universidade Anhembí Morumbi, em São Paulo, em março de 2000, inaugurarem os dois cursos pioneiros de bacharelado em Quiropraxia no Brasil,

autorizado e posteriormente reconhecidos pelo Ministério da Educação (Brasil, 2025) modulados no consenso internacional de educação na área (Organização Mundial da Saúde, 2005; Council on Chiropractic Education, 2023; World Federation of Chiropractic, 2009). Tal formação abre espaço a um novo paradigma no cenário do sistema brasileiro de saúde.

As universidades brasileiras, pioneiras na formação superior do profissional quiropraxista, juntamente com as entidades representativas da profissão, marcam presença no Legislativo e no Executivo Federal na luta pela estruturação e regulamentação da profissão no país. Essa iniciativa, gerou avanços, no reconhecimento do bacharel quiropraxista pelo Ministério do Trabalho, através da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 2261-05 (Brasil, 2013); para Inclusão da atividade de quiropraxista no Código de Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2025) por meio do código 8650-0/99; pela a inclusão da atividade de quiropraxista nas Políticas Nacionais das Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde (SUS)/ Ministério da Saúde (MS) Portaria nº 849, 27 de março de 2017 (Brasil, 2017). Houve ainda avanços por decisões judiciais reforçando a autonomia do profissional bacharel quiropraxista, tais como o processo nº. 2001.31003-7 da 14ª Vara Federal de Brasília, por meio da sentença nº 348/2003-B (Brasil, 2003) que reitera o livre exercício do bacharel quiropraxista no país, e o Mandado de Segurança nº 2009.61.00.004375-1 distribuído à 7ª Vara Federal Cível de São Paulo (Brasil, 2009) que resultou na liminar que determinou ao Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO) abster-se de fiscalizar e autuar os profissionais bacharéis quiropraxistas (Brasil, 2014). Por fim, destacam-se Projetos de Lei pela regulamentação da profissão (Fraga, 2001; Zulke, 2011; Moreira, 2015; Abreu, 2021), apoiados por parlamentares que compreendem e defendem sua relevância no enfrentamento ao embate provocado por Autarquias que lutam pela não regulamentação da Quiropraxia como profissão independente (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2023).

A legalidade e a legitimidade dos cursos superiores de Quiropraxia no Brasil compreendem a análise de atributos regulatórios e normativos determinados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelos conselhos profissionais de saúde. No intuito de considerar a aceitação e valorização da formação profissional e o reconhecimento profissional dos quiropraxistas, este estudo versa sobre a legalidade e legitimidade dos cursos de bacharelado em Quiropraxia no Brasil bem como a pertinência da construção de uma Diretriz Curricular Nacional DCN a exemplo do parecer CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 2001 do Conselho Nacional de Educação (CNE) (Brasil, 2001a), e consequente regulamentação da formação e prática profissional da Quiropraxia por lei específica no país.

Esta análise explora o processo de formação superior em Quiropraxia no Brasil, destacando a ausência de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) específicas para essa área de formação superior, apesar do reconhecimento e das renovações periódicas pelo MEC, e os desafios enfrentados devido à tramitação de projetos de lei que preveem a regulamentação da profissão de quiropraxista em solo brasileiro.

1.2 Problema

O reconhecimento da Quiropraxia como profissão de formação universitária surgiu mundialmente no final do século XIX, com a fundação da primeira escola de Quiropraxia por Daniel David Palmer nos Estados Unidos em 1897 (Bracher; Benedicto; Facchinato, 2013). Desde então, a profissão evoluiu e se expandiu globalmente, com a criação de associações reguladoras entre outras entidades oficiais, o que levou à implementação de diretrizes e práticas que asseguram a qualidade da formação e do atendimento para a segurança do paciente (Chiropractic Board of Australia, 2023).

Diante da oferta dos primeiros cursos oficiais de bacharelado em quiropraxia no Brasil no ano de 2000 em conformidade com o consenso mundial para formação e prática da profissão e sucessivos reconhecimentos pelo MEC a partir de 2006 (Brasil, 2006); dos 12 cursos de formação em Quiropraxia em diversos formatos de ensino de base e conteúdo pedagógico registrados no portal do MEC em 2025 (Brasil, 2025a); da legalidade da prática profissional do bacharel quiropraxista reiterada em sentenças judiciais (Brasil, 2003, 2009, 2014); do reconhecimento do ofício em solo brasileiro pelo Ministério do Trabalho (Brasil, 2013); da inclusão da Quiropraxia na Práticas Integrativas e Complementares do SUS (Brasil, 2017), frente ao embate pela regulamentação por lei específica para a formação e prática da Quiropraxia no Brasil, por meio de 8 Projetos de Lei junto ao legislativo brasileiro (Brasil, 2025c, 2025d), coloca-se como problema: O que é necessário para avançar na construção de uma DCN que consolide orientações e parâmetros para desenvolver as habilidades e competências mínimas para a formação e a prática segura da Quiropraxia em solo brasileiro?

O objeto de estudo desta pesquisa norteia a relevância do ordenamento legal, necessário ao desenvolvimento de parâmetros mínimos, por meio de DCN, determinantes à formação universitária de quiropraxistas como profissionais de primeiro contato na área da saúde. A formação do bacharel quiropraxista no Brasil mantém-se legítima por 25 anos com reconhecimento do MEC em caráter INOVADOR EXPERIMENTAL, sem evoluir na construção de uma DCN.

No cotejamento dos referenciais teóricos abarcados nessa pesquisa, verificam-se legítimas ações junto ao Estado brasileiro, pela elaboração de regramentos legais necessários à formação consistente e ao controle do exercício profissional pela prática segura dessa profissão da área da saúde, conforme recomendado pela OMS e o consenso estabelecido na estrutura internacional da profissão. A legitimidade desses esforços resta comprometida com a interferência de Autarquias/Conselhos Fiscalizatórios de algumas profissões, em destaque, o Conselho Federal de Fisioterapia, que tenta impedir e/ou dificultar a estruturação dos tais regramentos legais para a garantia da formação e da prática segura da profissão de quiropraxista no Brasil (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2023).

A presente investigação tem como ponto de partida a análise documental da estrutura, fundamentação e parâmetros legais na formação universitária da profissão de quiropraxista mundialmente; da introdução da formação e da prática da profissão no Brasil; do estabelecimento dos primeiros cursos universitários; das conquistas e estruturação da profissão no país; e das dificuldades e desafios no propósito da promulgação de lei específica para o controle da formação e prática segura no país, amparada na construção de uma DCN para oferta dos cursos superiores nessa área do saber, com os pressupostos teórico-conceituais acerca das referências que embasam a legalidade e a legitimidade da formação universitária e da prática profissional do Quiropraxia.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Investigar os processos legais na oferta de curso superior em Quiropraxia no Brasil, visando contribuir para a estruturação de DCN e a regulamentação da profissão de quiropraxista, abarcando o que é consenso na formação quiroprática no mundo, com as habilidades e competências necessárias para a prática segura dessa profissão no nosso país.

1.3.2 Objetivos específicos

Têm-se como seguintes objetivos específicos:

- a) Descrever o processo histórico da quiropraxia mundialmente, destacando a estruturação do controle legal na formação e prática segura da profissão;

- b) Identificar e analisar os ordenamentos legais, dados empíricos e dados públicos que consubstanciaram a introdução dos dois primeiros cursos superiores em quiropraxia no Brasil (FEEVALE – RS e UAM – SP);
- c) Apontar os parâmetros das bases curriculares na oferta da formação em quiropraxia, frente ao embate no processo legislativo para a formulação de uma lei específica que determine os critérios legais para formação e prática da profissão quiroprática no Brasil;
- d) Refletir sobre os efeitos na educação e na saúde pública decorrentes da falta de uma DCN e de uma lei explícita como pressuposto legal que garanta a formação e a prática segura em Quiropraxia;
- e) Indicar caminhos para a estruturação de DCN de Quiropraxia regulamentada por Resolução específica, a partir da consolidação de 25 anos de oferta da formação e consequente exaustão do caráter experimental e inovador do curso de Quiropraxia do MEC.

1.4 Justificativa

A educação em Quiropraxia requer critérios técnicos elaborados em padrões determinados para formação de profissionais que desenvolvam habilidades e competências mínimas necessárias à prática segura na saúde pública (Organização Mundial da Saúde, 2005).

Por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (2023), o Brasil é signatário da OMS, contudo, a soberania nacional desobriga o país a adotar tais padrões como regra, mantendo-os no âmbito das recomendações.

O Artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federativa Brasileira de 1988 (Brasil, [2024a]) estabelece que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Esse inciso ressalta que a lei pode prover regulamentações que definam requisitos para a formação e o exercício de determinadas profissões, principalmente na área da saúde como recomendado pela OMS em relação a Quiropraxia. Contudo, a não existência de lei específica para formação e prática em determinado ofício, abre espaço ao seu livre exercício, que no caso em tela, fragiliza a identidade da profissão, bem como a legalidade, a legitimidade da formação acadêmica em paradoxo com a LDB (Brasil, [2024b]) e, sobretudo, à orientação da OMS para prática segura da profissão, em paradoxo também com o ordenamento da Lei nº 8.080 (Brasil, [2025b]) do Sistema Único de Saúde (SUS).

Surge assim a motivação desse estudo, ancorado na necessidade de refletir e assinalar

práticas que estabeleçam o amparo legal do Estado à formação acadêmica do bacharel quiropraxista. Acredita-se que a formulação de DCN em Quiropraxia, além de sanar a lacuna que tem fragilizado a legitimidade e a identidade da profissão no país, trará aporte ao Poder Legislativo para o estabelecimento de lei específica que garanta a formação consistente com a prática segura da Quiropraxia no Brasil.

2 METODOLOGIA

A presente investigação, voltada à análise do processo de formação superior em Quiropraxia no Brasil e à premência da construção de suas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), ancora-se em uma abordagem de natureza qualitativa. Esta opção metodológica justifica-se pela necessidade de compreender fenômenos humanos complexos que não podem ser reduzidos a meras métricas estatísticas. No entendimento de Minayo (2001, p. 21), a pesquisa qualitativa “[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”.

A estruturação deste estudo é classificada como pesquisa exploratória, que, para Chehuen Neto (2012, p. 103), “[...] visa proporcionar maior familiaridade com o problema, na premissa de torná-lo explícito ou para construir novas hipóteses. [...] Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado”.

Para conferir robustez científica e assegurar a validade dos resultados, a investigação fundamenta-se na triangulação de três procedimentos distintos e complementares: a Pesquisa Bibliográfica, a Análise Documental e a Pesquisa Empírica por meio de entrevistas semiestruturadas.

2.1 A pesquisa bibliográfica: Revisão Sistemática da Literatura

A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) consiste em um método de pesquisa que utiliza procedimentos explícitos para identificar, selecionar e avaliar a produção científica sobre um determinado tema. Sampaio e Mancini (2007, p. 84) destacam que a RSL “[...] possibilita uma síntese confiável da literatura existente, sendo especialmente útil para mapear o conhecimento produzido, orientar novas investigações e apoiar a tomada de decisão científica.” Assim, para a realização da pesquisa, adotou-se o método da RSL, com o objetivo de mapear, de forma confiável, a produção de dissertações e teses sobre a Quiropraxia a nível nacional.

A RSL foi conduzida conforme as etapas propostas por Costa e Zoltowski (2014), assegurando procedimentos transparentes, sistemáticos e reprodutíveis. Essas etapas compreendem: delimitação da questão de estudo; seleção das fontes; definição das palavras-chave; organização dos resultados; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; seleção dos estudos relevantes; análise crítica do material; e apresentação dos resultados.

A “delimitação da questão do estudo” com foco na Quiropraxia, abordando sua história, formação acadêmica e a acreditação do curso no Brasil. O objetivo foi mapear as teses e

dissertações brasileiras disponíveis para busca no período de 1987 a 2025. Entretanto, no decorrer da etapa de triagem, observou-se que a aplicação restrita desse recorte resultaria em um número muito reduzido de estudos plenamente alinhados ao objetivo central da pesquisa. Diante desse cenário, optou-se por ampliar o escopo da seleção, incluindo também trabalhos que abordassem a prática da Quiropraxia, de modo a possibilitar uma visão mais abrangente da produção acadêmica nacional sobre o tema.

Na “seleção das fontes” científicas, foram utilizadas três bases: Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e Dados Abertos CAPES, selecionadas pela relevância, confiabilidade e complementaridade. Esta abordagem contribui para garantir um conjunto de dados mais representativo e abrangente.

Assim, com o objetivo de mapear a produção científica e compreender o panorama geral da discussão, foram definidos Critérios de Inclusão (CI) e Critérios de Exclusão (CE) para o levantamento das produções acadêmicas, conforme apresentado no Quadro 1:

Quadro1 - Critério para o levantamento das produções acadêmicas

Inclusão	Exclusão
• CI 1: Teses e Dissertações dos Programas de Pós-Graduação do país; • CI 2: Recorte temporal de 1987 a 2025; • CI 3: Acesso livre ao texto completo; • CI 4: Palavras-chave almejadas: "Quiropraxia", "Correção Postural" e "Manipulação da coluna"	• CE 1: Teses e Dissertações em Duplicidade; • CE 2: Excluído após leitura do Título e Resumo por não abordarem o tema da pesquisa; • CE 3: Excluído após a leitura do Texto Completo, por não abordarem o tema da pesquisa; • CE 4: O trabalho não possui divulgação autorizada pelo Autor;

Fonte: Elaborado pelo autor.

Considerando as especificidades de cada fonte, as buscas foram realizadas em 20 de janeiro de 2026, orientadas pela “definição das palavras-chave”: Quiropraxia, Correção Postural e Manipulação da coluna. Na busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e a BDTD, utilizando estratégia de busca com os termos centrais do estudo, empregaram-se operadores booleanos (AND, OR, NOT) e truncamentos para refinamento e recuperação dos estudos relevantes. Nos Dados Abertos da CAPES, adotou-se a busca por termos centrais em cada extrato. As estratégias, filtros e etapas de busca em cada fonte estão descritos no Quadro 2.

Quadro 2 - Levantamento das produções acadêmicas nas Fontes

Catálogo da CAPES
• Filtros: Busca simples; Período sem restrição; Idiomas todos. • Estratégia: Quiropraxia OR "Manipulação da coluna" OR "Correção Postural" OR Quiroprática OR "Manipulação Quiroprática" OR "Ajuste Quiroprático da Coluna" OR "Alinhamento Postural Quiroprático" OR "Correção Postural Quiroprática" OR "formação em quiropraxia" OR "educação em quiropraxia" OR "curso de quiropraxia" OR "graduação em quiropraxia" OR "currículo de quiropraxia" OR "regulamentação da quiropraxia". • Resultado: 53 Títulos • Os resultados foram organizados em uma planilha do Excel®.
BDTD
• Filtros: Busca simples; Período sem restrição; Idiomas todos. • Estratégia: Quiropraxia OR "Manipulação da coluna" OR "Correção Postural" OR Quiroprática OR "Manipulação Quiroprática" OR "Ajuste Quiroprático da Coluna" OR "Alinhamento Postural Quiroprático" OR "Correção Postural Quiroprática" OR "formação em quiropraxia" OR "educação em quiropraxia" OR "curso de quiropraxia" OR "graduação em quiropraxia" OR "currículo de quiropraxia" OR "regulamentação da quiropraxia". • Resultado: 54 Títulos • Os resultados foram exportados em formato CSV e organizados em uma planilha do Excel®.
Dados Abertos CAPES
Busca realizada por etapas: • Exportação das 37 planilhas contendo informações sobre Teses e Dissertações do período de 1987 a 2024, disponível pela CAPES. Em seguida, em cada planilha utilizou-se a ferramenta de localização do Excel® para buscar a palavras-chave principais "Quiropraxia", "Correção Postural" e "Manipulação da coluna". • Resultado: 67 Títulos contendo os termos. • Os resultados foram organizados em uma planilha do Excel®.

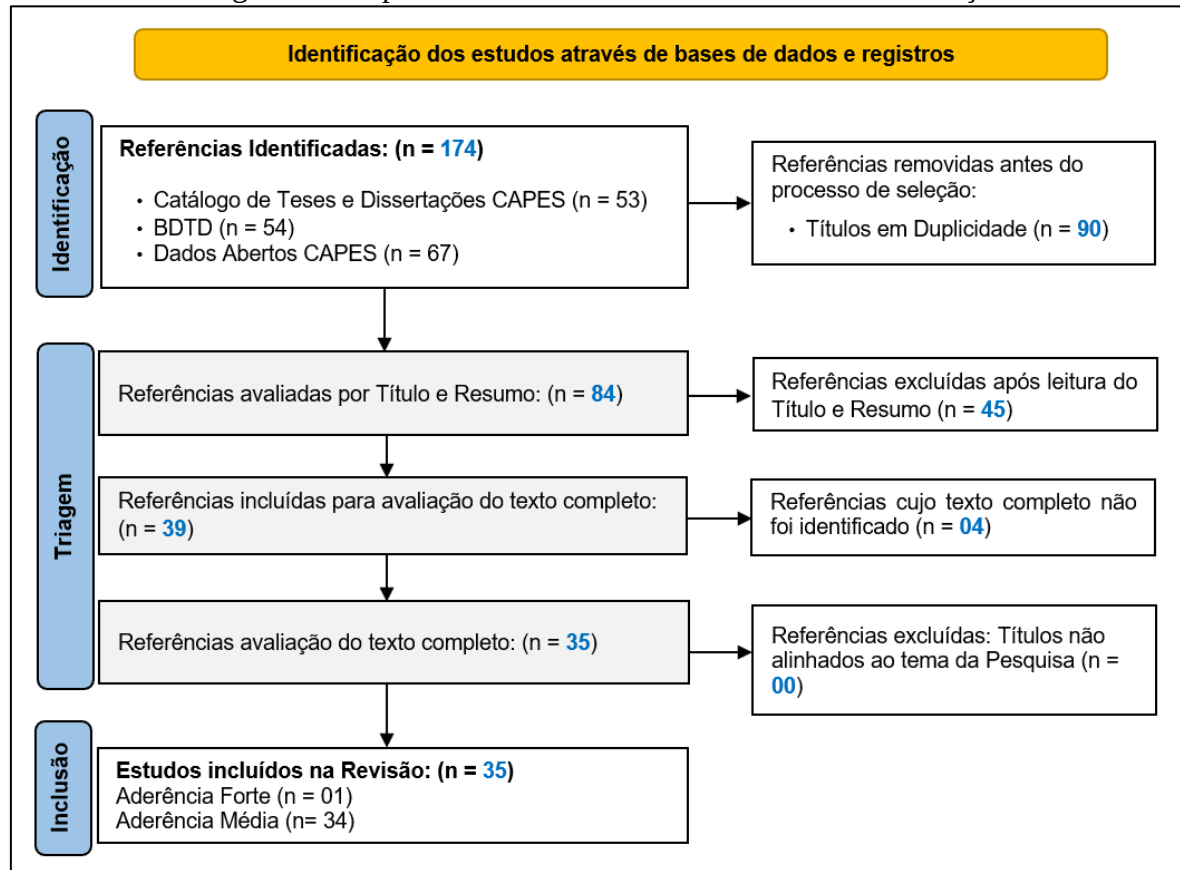
Fonte: Elaborado pelo autor.

Durante a etapa de “seleção dos achados relevantes ao tema”, os resultados das três fontes de busca foram consolidados em uma única planilha, totalizando 174 registros. Realizou-se a limpeza e padronização dos dados (títulos, autores, orientadores e Instituições de Ensino Superior), com correção de erros de digitação e caracteres especiais. Aplicados os critérios de exclusão, identificaram-se 91 registros duplicados, não sendo encontrados termos não relacionados ao tema.

A triagem ocorreu em três etapas. Na primeira, procedeu-se à leitura de títulos e resumos, com a exclusão de 45 títulos sem alinhamento com os objetivos da pesquisa. Na segunda etapa, realizou-se a busca dos textos completos nos repositórios institucionais e na web, com a exclusão de 4 títulos com indisponibilidade de acesso seja por ser anterior à Plataforma Sucupira ou não possui divulgação autorizada pelo autor. Na terceira etapa, os estudos remanescentes foram submetidos à leitura integral. Esse processo resultou na seleção

final de 35 títulos que compõem a seleção da RSL. A sistematização do processo está apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Mapeamento Prisma da RSL em Teses e Dissertações



Fonte: Elaborada pelo autor, adaptada de Page *et al.* (2021).

Como resultado, identificou-se uma única dissertação com aderência forte ao objetivo da busca, a qual aborda diretamente a história da origem da Quiropraxia a partir de D.D. Palmer (1845–1913). Os demais 34 estudos selecionados apresentaram aderência média ao tema, uma vez que o foco principal das investigações se concentrou na dimensão aplicada da práxis quiroprática. Esses trabalhos abordam, predominantemente, correlações com a quiropraxia veterinária, análises dos efeitos de técnicas específicas da Quiropraxia em diferentes etiologias, caracterização do perfil de pacientes, desenvolvimento de softwares voltados à prática profissional e estudos de caráter preventivo relacionados às disfunções da coluna vertebral. O Quadro 3 a seguir sistematiza os títulos analisados, distinguindo o único estudo com forte aderência ao objetivo da pesquisa na parte histórica dos demais, classificados com aderência média.

Quadro 3 – Teses e Dissertações incluídos na RSL

(Continua)

Nº	Dissertação	Título	Produção	Ano	Aderência
1	Selma C. Neves	D.D. Palmer (1845-1913) e as origens da quiropraxia no século XIX	Dissertação	2016	Forte
2	Marta C. Saraiva	Assistência de saúde a idosos que buscam atendimento quiroprático	Dissertação	2006	Média
3	Inês A. X. Lima	Estudo da prevalência de alterações posturais em escolares do ensino fundamental do município de Florianópolis / SC	Dissertação	2006	Média
4	Thiana P. Schmidt	A quiropraxia na construção da saúde coletiva: a visão dos quiropraxistas	Dissertação	2008	Média
5	Carolina Kolberg	Efeito da manipulação articular vertebral de alta velocidade e baixa amplitude sobre a concentração de nitritos/nitratos e parâmetros de estresse oxidativo em sangue de indivíduos com cervicalgia	Dissertação	2009	Média
6	Ana Paula A. Facchinato	Manipulação Articular da coluna cervical e torácica: repercussões na qualidade do canto	Dissertação	2010	Média
7	Ronaldo F. de Oliveira	Efeitos imediatos da terapia manipulativa vertebral específica ou inespecífica em pacientes com dor lombar crônica: Um estudo controlado aleatorizado	Dissertação	2012	Média
8	Mauricio G. B. da Mota	Avaliação quiroprática e localização das disfunções articulares da coluna vertebral e articulação sacroilíaca de equinos das raças puro sangue inglês e crioula	Dissertação	2013	Média
9	Melina N. Haik	Cinemática escapular: confiabilidade e efeitos pré e pós uma manipulação torácica em sujeitos com e sem sintomas de impacto - um estudo controlado randomizado	Dissertação	2013	Média
10	Hugo P. Neto	Órteses na marcha de crianças com paralisia cerebral: estudo clínico aleatorizado controlado	Tese	2013	Média
11	Carolina Kolberg	Efeito do tratamento de manipulação articular vertebral ou exercícios de resistência e estabilização da coluna na percepção dolorosa e marcadores periféricos de estresse oxidativo e nitrosativo em indivíduos com cervicalgia e/ou lombalgia	Tese	2013	Média
12	Felipe C. K. Duarte	Activator com ponteira adaptada para uso em animais: valor da força e efeito sobre o limiar mecânico e índice funcional do nervo isquiático em ratos com imobilização de membro posterior	Dissertação	2014	Média
13	Letícia B. Calixtre	Disfunção temporomandibular: aspectos relacionados à ansiedade e depressão e tratamento por terapia manual	Dissertação	2014	Média
14	Tamra C. do Nascimento	Proposta do uso de sistemas inerciais para medição das curvaturas da coluna vertebral	Dissertação	2014	Média
15	Camila de C. Benedicto	Análise de prontuários dos pacientes atendidos pelo curso de quiropraxia no período de 2003 a 2012 – experiência na Universidade Anhembi Morumbi	Dissertação	2015	Média
16	Desiree Moehlecke	A eficácia do ajuste quiroprático nas algias lombares em praticantes de crossfit do Vale dos Sinos	Dissertação	2016	Média
17	Jose N. da S. Filho	Influência de um programa de alongamento na postura corporal e o nível de dor em profissionais de enfermagem	Dissertação	2016	Média

Quadro 3 – Teses e Dissertações incluídos na RSL

(Conclusão)

Nº	Dissertação	Título	Produção	Ano	Aderência
18	Paulo T. Uchiyama	Avaliação do controle postural unipodal após uma manobra de manipulação cervical	Dissertação	2016	Média
19	Pablo Pasqualotti	Efeitos da terapia manipulativa e do treinamento interativo na percepção da dor crônica em idosas	Dissertação	2016	Média
20	Claudia da R. Patricio	Perfil de complexos de subluxação da coluna vertebral de equinos de salto na avaliação quiroprática veterinária	Dissertação	2017	Média
21	Denilson de Q. Cerdeira	Posture adjuster: uma inovação tecnológica para o tratamento e reabilitação das alterações posturais	Tese	2017	Média
22	Ronaldo P. Merenda	Análise dos efeitos imediatos de uma manipulação da coluna cervical em pacientes com DTM	Dissertação	2018	Média
23	Mario E. M. Vieira	Protótipo para auxílio de identificação do tipo de pisada baseada em sensores piezoelétricos e redes neurais artificiais	Dissertação	2018	Média
24	Mauricio de A. Neto	Queroquiro – expansão de uma clínica de quiropraxia	Dissertação	2019	Média
25	Clécio Vier	Influência dos fatores biopsicossociais e da manipulação vertebral no controle da dor em indivíduos com dor lombar inespecífica crônica	Tese	2019	Média
26	Marcelo A. Bracht	Efeitos da manipulação vertebral e educação em dor na cervicalgia crônica: estudo clínico randomizado e controlado	Tese	2019	Média
27	Djanira F. Silva	Programa educativo de uma “escola de coluna” como recurso ativador de mudanças nos hábitos posturais	Dissertação	2019	Média
28	André U. Veloso	Tratamento conservador da síndrome do desfiladeiro torácico neurogênica: análise da funcionalidade e qualidade de vida	Dissertação	2020	Média
29	Ronaldo F. de Oliveira	Abordagens de gerenciamento e as diferenças entre a manipulação vertebral direcionada e a manipulação vertebral genérica em indivíduos com dor lombar crônica	Tese	2020	Média
30	Mariana C. J. Rodrigues	Atitude dos ortopedistas brasileiros frente à quiropraxia	Dissertação	2021	Média
31	Francielle B. O. da Silva	Instrumento de ajuste quiroprático (impulse®) reduz nocicepção em paralelo a alterações na atividade de marcadores de estresse oxidativo em nervo isquiático e medula espinal de ratos com dor neuropática	Dissertação	2021	Média
32	Yusseff O. Zoghbi	Análise cientométrica da relação entre dor lombar crônica e tratamentos de osteopatia, quiropraxia e manipulação vertebral	Dissertação	2022	Média
33	Joao P. Freitas	Efeitos imediatos da manipulação vertebral na sensibilidade dolorosa e estabilidade postural de indivíduos com dor lombar crônica inespecífica: ensaio clínico randomizado placebo controlado	Tese	2022	Média
34	Daniel L. Ometto	Investigação das características bioquímicas da saliva após um procedimento quiroprático usando espectroscopia raman	Dissertação	2023	Média
35	Thais de S. Horsth	Efeito da quiropraxia instrumental na variabilidade da frequência cardíaca no paciente com dor musculoesquelética	Dissertação	2023	Média

Fonte: Elaborado pelo autor.

A distribuição dos resultados evidencia a escassez de produções acadêmicas, especialmente no campo da Educação, que abordem a Quiropraxia a partir da perspectiva da formação profissional, da organização dos cursos superiores e dos processos de regulamentação no Brasil. Tal lacuna revela que, embora a Quiropraxia esteja presente de maneira expressiva em estudos de cunho clínico e aplicado, permanece pouco explorada enquanto objeto de análise educacional e de política pública. Nesse sentido, o presente estudo assume relevância científica e social ao contribuir para o mapeamento crítico dessa ausência, oferecendo subsídios para o debate sobre a institucionalização da Quiropraxia no ensino superior, a qualificação da formação profissional e o fortalecimento de processos regulatórios e acadêmicos ainda incipientes no país.

A fundamentação teórica desta investigação sustenta-se na compreensão da Quiropraxia como uma área do saber científico e uma profissão de saúde autônoma, cuja identidade é balizada por marcos regulatórios internacionais e nacionais explorados nos capítulos três (Histórico da Quiropraxia) e quatro (Regulamentação da Formação em Quiropraxia).

A literatura historiográfica aponta que a sistematização deste campo ocorreu em 1895, com a fundação da primeira instituição de ensino por Daniel David Palmer em 1897, nos Estados Unidos. Desde então, a evolução acadêmica da profissão consolidou-se através de um rigoroso consenso educacional global, capitaneado pelo Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia (CCEI), visando garantir a segurança do paciente e a competência técnica do profissional de primeiro contato.

No cenário brasileiro, o aporte bibliográfico revela que o ensino superior em Quiropraxia foi inaugurado em 2000 pelas universidades FEEVALE e Anhembí Morumbi (UAM), em convênio com instituições norte-americanas de referência. Tais cursos foram autorizados sob a égide do Artigo 81 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que faculta a organização de cursos experimentais e inovadores. Contudo, a pesquisa bibliográfica evidencia um paradoxo regulatório: embora os cursos possuam legitimidade acadêmica e sucessivas renovações de reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC) com notas máximas, a ausência de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) específicas mantém a formação em um limbo normativo há 25 anos.

A necessidade de transpor o status experimental para uma diretriz consolidada é discutida à luz do pensamento de Carlos Roberto Jamil Cury, apresentado no capítulo 6 (Construção de Diretrizes Curriculares Nacionais), que define o papel dos Conselhos de Educação como um múnus público e o conselheiro como um intelectual da legislação (Cury,

2006, p. 42). Sob esta perspectiva, a construção de uma DCN para a Quiropraxia transcende o rito burocrático; constitui um ato de responsabilidade social indispensável para assegurar a supremacia axiológica da Constituição Federal, que garante o livre exercício profissional e o direito à saúde.

A bibliografia consultada reforça que a falta de um balizamento nacional fragiliza a identidade da profissão, abordada no item 3.4 (Impasse Quiropraxia x Fisioterapia brasileira) e no capítulo 5 (Regulamentação do Exercício Profissional em Quiropraxia), permitindo a proliferação de ofertas formativas despadronizadas que podem pôr em risco a saúde pública. Assim, a pesquisa bibliográfica consubstancia ainda o capítulo 6 (Construção das Diretrizes Curriculares Nacionais), que fornece a base para compreender que a DCN é o instrumento técnico necessário para converter a experiência acumulada pelas instituições pioneiras em norma estável, alinhando o Brasil às recomendações da OMS e aos padrões de qualidade exigidos globalmente pelas agências de acreditação internacional.

2.2 A pesquisa documental: instrumento de exame histórico-regulatório

Dada a centralidade dos marcos normativos internacionais e nacionais para este estudo, a Análise Documental configura-se como o procedimento primordial para o exame do teor de documentos que ainda não receberam tratamento analítico ou que carecem de novas interpretações. Conforme asseveram Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p. 5), trata-se de “[...] um procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos”.

O corpus documental desta pesquisa compreende as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), os *standards* de acreditação do Conselho Latino-Americano de Educação em Quiropraxia (CCE-LA), pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) e Projetos de Lei em tramitação. A relevância do documento escrito é ressaltada por Cellard (2008, p. 295), ao afirmar que:

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas.

Neste contexto, a investigação distingue rigorosamente as fontes primárias das secundárias, utilizando-se das primeiras para acessar materiais sem tratamento científico

prévio, como relatórios institucionais e atas legislativas.

Na busca da compreensão da trajetória da formação quiroprática e das políticas públicas de saúde e de suas inter-relações, por meio da “Pesquisa Documental”, investigaram-se, de um lado, os ordenamentos legais educacionais regulamentados pelos Ministérios da Educação e da Saúde e, de outro lado, os contornos e os condicionantes do embate profissional na área da Saúde que tem postergado a regulamentação da quiropraxia no Brasil. A coleta de dados secundários (dados públicos) da área da educação e da saúde foi realizada nos sites oficiais dos Ministérios da Educação, da Saúde, do Trabalho, da área Legislativa e da área Judiciária.

O processo de análise documental seguiu as etapas propostas por Cellard (2008) e Cechinel *et al.* (2016), iniciando-se pela avaliação preliminar (contexto, autores, autenticidade, natureza do texto e conceitos-chave) até a análise propriamente dita, que visa a obtenção de informações significativas para a elucidação do objeto de estudo.

2.3 A pesquisa empírica: percepção dos atores estratégicos

Por fim, procedemos com a pesquisa empírica, através da coleta de dados primários por meio de entrevista semiestruturada, “[...] que permitem uma padronização da qualidade e da quantidade dos fatores, tornando os resultados mais seguros” (Chehuen Neto, 2012, p. 105), realizada por meio de 12 representantes de diversas entidades-chave, incluindo 4 (quatro) coordenadores de cursos pioneiros iniciados no ano de 2000 e demais cursos de bacharelado em quiropraxia reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC); 1 (um) representante do curso de capacitação de docentes para introdução do bacharelado em quiropraxia no Brasil entre 1997 e 2000; 1 (um) representante de curso de bacharelado em quiropraxia com previsão de turma para 2026; 2 (dois) representantes de organizações internacionais relacionadas com a estrutura educacional quiropraxia globalmente; 1 (um) representante da Associação Brasileira de Quiropraxia; 1 (um) bacharel em quiropraxia atuante nos EUA; 1 (um) profissional fisioterapeuta com segunda graduação em quiropraxia atuando nas duas profissões no país; 1 (um) profissional da área técnica legislativa federal em projetos relacionados com a educação, trabalho e saúde.

Para estabelecer a seleção das instituições/personagens que compuseram a rede de pesquisa adotada, utilizou-se as referências apontadas na História da Quiropraxia no Brasil entre 1920 e 2004 (Lopes, 2004) e Quiropraxia, Uma Profissão da Área da Saúde (Chapman-Smith, 2001), que destacam a articulação política da Associação Brasileira de Quiropraxia (ABQ) diretamente relacionada com os trabalhos que levou a formalização do curso de

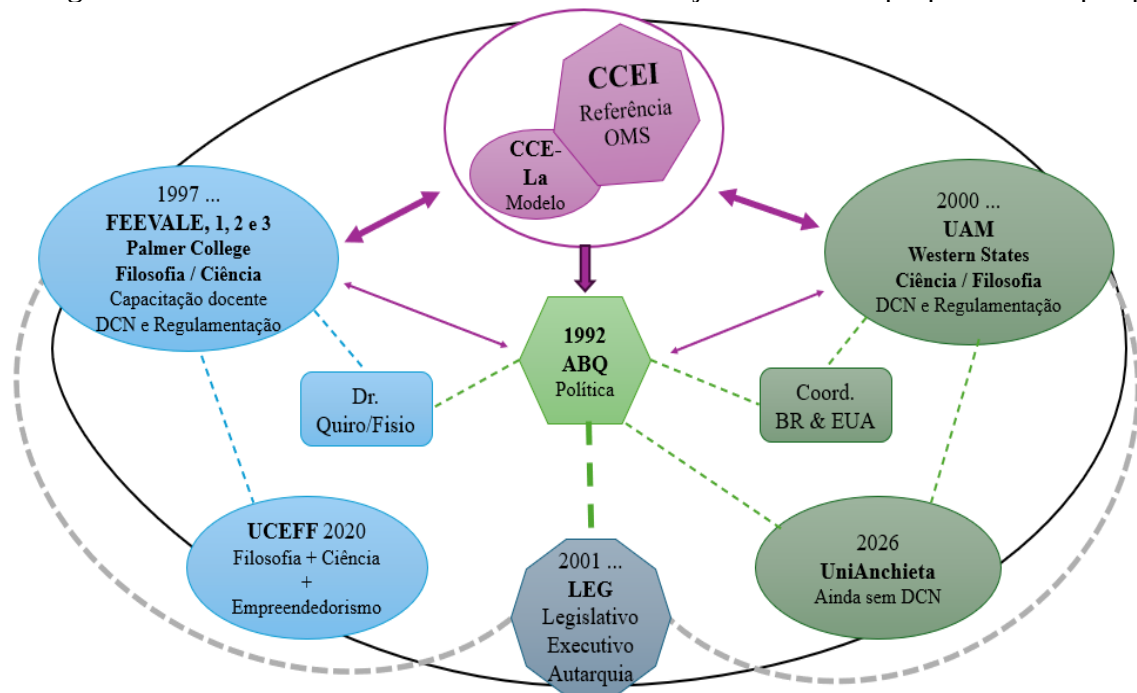
capacitação de docentes para formação universitária e quiropraxia promovido pela Universidade FEEVALE – RS em parceria com o Palmer College of Chiropractic, bem como, da Universidade Anhembi Morumbi – SP (UAM) em parceria com a Western States Chiropractic – USA, ambas pioneiras na estruturação e introdução dos dois cursos superiores em quiropraxia no Brasil a partir do início do ano de 2000.

Os cursos pioneiros foram estruturados em conformidade com o consenso mundial para educação em quiropraxia determinado pelo Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia (CCEI) que aponta o Conselho Latino-Americano de Educação em Quiropraxia (CCE-LA) como detentor dos *standards* da educação em quiropraxia adaptados ao contexto da cultura educacional em saúde na América Latina.

Por fim, chegou-se ao legislativo e executivo federal, por meio dos quais a ABQ, FEEVALE e UAM estabeleceram, em conjunto e individualmente, ações para viabilizar as demandas relacionadas à legitimidade e à legalidade da formação e prática da quiropraxia no país.

Os preâmbulos que circundam os caminhos políticos/institucionais e documental dessas referências possibilitaram determinar a rede composta com os 12 entrevistados no contexto do objeto da análise apontados, representada na Figura 2, a seguir.

Figura 2 - Rede de entrevistados no contexto do objeto da análise proposta nessa pesquisa



Fonte: Desenvolvido pelo autor.

A Figura 2 mostra as relações e representações imbricadas na composição dos sujeitos entrevistados, revelando a capilaridade da rede de atores estratégicos selecionados para sustentar a fase empírica desta investigação. A rede materializa a triangulação de perspectivas, integrando 12 vozes que personificam a trajetória da Quiropraxia no Brasil, desde o projeto matriz na capacitação de docentes em 1997, até o marco inaugural dos cursos pioneiros em 2000 e as projeções para 2026.

Ao contemplar um espectro que abrange desde a gestão acadêmica e a representação de classe ABQ até o suporte técnico-legislativo e a estrutura acadêmica internacional (CCEI/CCE-LA), a rede assegura a pluralidade indispensável para apreender o universo dos significados, dos motivos, das aspirações e dos valores que cercam o objeto de análise. A disposição desses sujeitos reflete o esforço metodológico em confrontar a experiência histórica acumulada pelas instituições pioneiras com a realidade contemporânea de despadronização curricular, permitindo que a coleta de dados alcance o princípio da saturação teórica.

Os entrevistados foram acionados via telefone, e-mail e whatsapp. As entrevistas semiestruturadas foram feitas em formato virtual síncrono, por meio da plataforma Microsoft Teams. As perguntas macro e pré-definidas foram verbalizadas pelo entrevistador aos entrevistados, somente no ato da entrevista. Posteriormente, o áudio das entrevistas foi transcrito com o aplicativo de transcrição de áudio e vídeo TurboScribe.

Em cumprimento aos padrões éticos, a pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC-Minas, sob o parecer nº 7.811.643 (CAAE 90240125.2.0000.5137), todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo-lhes garantido o sigilo, o anonimato e a possibilidade de retirada do consentimento a qualquer momento sem prejuízos.

A abordagem das entrevistas respeitou o princípio da saturação teórica, garantindo que o campo de estudo tenha sido adequadamente explorado (Thiry-Cherques, 2009), assegurando que a coleta de dados fosse interrompida no momento em que as informações obtidas passaram a apresentar redundância e não mais acrescentassem novos elementos à compreensão do fenômeno. A organização dos relatos buscou confrontar as experiências vivenciadas pelos pioneiros com a realidade contemporânea de despadronização curricular.

2.4 A análise de conteúdo: sistematização e inferência

Para o tratamento dos dados coletados tanto na fase documental quanto na empírica, utilizou-se a Análise de Conteúdo, fundamentada na técnica categorial temática. De acordo com

Bardin (1977, p. 42), a análise de conteúdo consiste em:

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens.

A operacionalização desta técnica seguiu as três fases fundamentais preconizadas pela autora: 1) Pré-análise (organização e leitura flutuante); 2) Exploração do material (codificação e categorização); e 3) Tratamento dos resultados e interpretação. Esta sistematização permitiu a construção de 3 categorias de interpretação analítica, estabelecidas *a posteriori*, as quais foram subdivididas em 12 temáticas. No capítulo 7 (apresentação e análise dos resultados das entrevistas) serão detalhadas as categorias analíticas (Consenso Mundial para Formação em Quiropraxia; Identidade da Formação e Prática da Quiropraxia no Brasil; Legalidade e Legitimidade da Formação e Prática da Quiropraxia). A subsequente subdivisão temática será detalhada e exemplificada também no capítulo 7.

A triangulação entre os procedimentos metodológicos da Pesquisa Bibliográfica, da Análise Documental e da Pesquisa Empírica consubstancia-se na experiência acumulada pelas instituições pioneiras (FEEVALE e UAM) e no arcabouço normativo internacional, como referência para a construção e estruturação de uma DCN, consubstanciando um esboço para tais diretrizes, abarcando o que é consenso em educação da formação quiroprática no mundo, respeitando a autonomia do sistema educacional brasileiro, as competências curriculares mínimas necessárias para a prática segura dessa profissão da área da saúde.

3 HISTÓRICO DA QUIROPRAXIA

3.1 Das primeiras práticas à consolidação profissional nos Estados Unidos

Salutar esclarecer que a prática das Terapias Manipulativas Articulares (TMA), também conhecidas popularmente como manipulação articular ou manipulação da coluna vertebral, (Quadro 4), transcende o surgimento da profissão de quiropraxista nos Estados Unidos em setembro de 1895 (Haldeman, 2005).

Quadro 4 – Cronologia: TMA – da origem documental à sistematização nos EUA

África	1700 a.C.	Egito Antigo	Papiro Edwin Smith
Ásia	1500 a.C.	Índia	Ayurveda e Pontos Marm
	Séc. VI d.C.	China	Tuíná
	Séc. XIII	Tailândia	Massagem Nuad Boran
	1940	Japão	Seitai
Europa	400 a.C.	Grécia	Métodos Manipulativos de Hipócrates
	Séc. VIII-XII	Árabe Islâmico	Medicina Islâmica
	Séc. XVI-XVIII	França/Inglaterra ...	Boneseters
Américas	Séc. XVI-XVIII	Colônias Americanas	Boneseters
	1874	Estados Unidos	Osteopatia
	1895	Estados Unidos	Quiropraxia

Fonte: Desenvolvido pelo autor

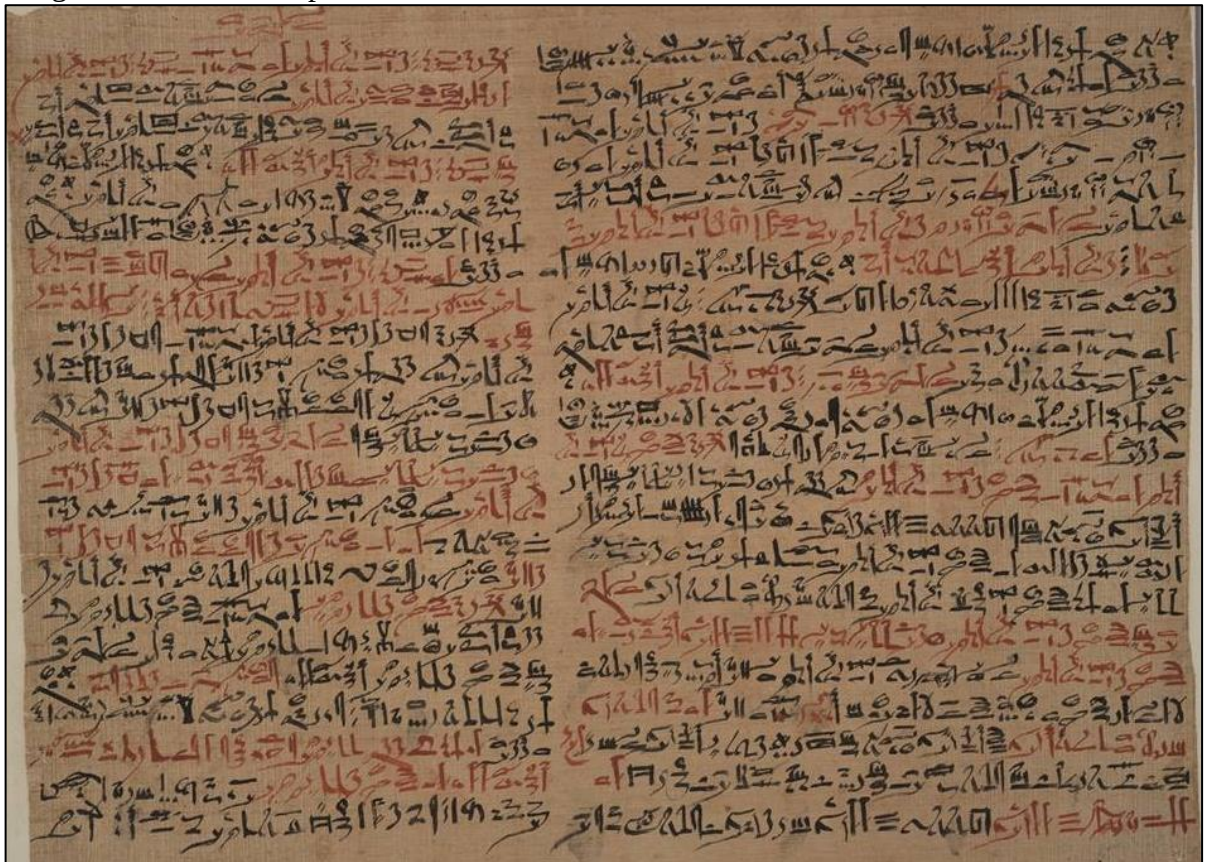
No que diz respeito à manipulação em civilizações ocidentais antigas, as áreas ao redor do Mediterrâneo fornecem a base mais lógica para a existência da prática. A referência histórica à Grécia fornece a primeira evidência direta da prática de manipulação vertebral. O detalhe em que isso é descrito sugere que a prática da manipulação estava bem estabelecida e antecedeu a referência de 400 a.C. (Pettman, 2007).

No Quadro 4, destacam-se os primeiros registros que apontam as práticas das Terapias Manipulativas Articulares TMA nas diversas culturas e épocas da antiguidade, perpassando a idade média, até a idade moderna, apresentando, ao final do século XIX, onze modalidades profissionais que utilizam das TMA, findando com sistematização das técnicas e controle do ensino da Osteopatia por meio da American School of Osteopathy em 1892 e da Quiropraxia, por meio do Palmer College of Chiropractic em 1897, ambas nos Estados Unidos da América.

Descrevemos a seguir, algumas das modalidades das TMA no contexto do Quadro 4 a partir do artigo, *O papiro de Edwin Smith: uma reavaliação clínica do documento mais antigo*

conhecido sobre lesões na coluna, vertebral (Middendorp; Sanchez, Burrridge, 2010). O artigo aponta (Figura 3) as descrições mais antigas datadas de 1552 a.C “[...] 48 casos são apresentados no papiro, dos quais seis lidam com lesões na coluna vertebral”. Tem-se o registro histórico com evidências das raízes das técnicas de manipulação da coluna na Grécia antiga, como prática destinada a aliviar a dor e consertar ossos deslocados como parte da cura humana. (Kaptchuk, 1983; Harris, 2010).

Figura 3 - Placa do Papiro Edwin Smith, com casos de lesão na coluna em escrita hierática



Fonte: Middendorp, Sanchez e Burrridge (2010, p. 1816).

Práticas de TMA de aproximadamente 1500 a.C. encontram-se na Índia, com a medicina ayurvédica e o conceito de pontos Marm, que utilizavam manipulações articulares associadas à circulação energética (Kaptchuk, 1983). Tais práticas eram complementadas pelos textos do *Sushruta Samhita* (700 a.C.), que codificaram tratamentos envolvendo manipulação manual direta para restabelecer o equilíbrio corporal.

Influenciada pelo Ayurveda e pelo Budismo, surge na Tailândia a Massagem Tradicional Tailandesa “Nuad Boran” 200 a.C., a qual se tornou prática popular e se consolidou em templos no Sudeste Asiático por volta do século XIII (IBN Sina, 2005).

Hipócrates (Grécia Antiga ~400 a.C.) descreveu métodos de ajuste e tração vertebral para tratamento de deformidades. Ele destacou o uso de "dispositivos para tração" e manipulação direta da coluna vertebral para restaurar funções, consolidando práticas manipulativas na medicina ocidental. Destaca que “O médico deve entender muitas coisas, e entre elas como lidar com o alinhamento da espinha dorsal, pois muitos problemas podem ser corrigidos com ajustes físicos precisos, devolvendo harmonia ao corpo” (Hipócrates *apud* Unschuld, 2003, p. 45).

Figura 4 – Prática do Tuiná, derivado da Medicina Tradicional Chinesa (1.600 – 1.110 a.C.) formalizado no séc. VI d.C.



Fonte: (Veith, 2002; Unschuld, 2003).

Na China, as TMA foram formalizadas como parte integrante da Medicina Tradicional Chinesa MTC por meio do Tuiná, cuja origem remonta à Dinastia Shang (1600 a.C. – 1046 a.C.). Porém, essa terapia foi sistematizada no século VI d.C., no tratado *Zhubing Yuanhou Lun*, que a estabeleceu como um método para desbloquear canais energéticos e promover a harmonia corporal, como uma prática basilar da MTC (Wang; Robertson, 2008).

A obra *Cultural Perspectives on Bonesetting: A Comparative Study* (Card, 2020, p. 202-220), apresenta os ajustadores de ossos do século XVIII, termo original, os “*Bone-Setting*” como sendo “uma [...] prática que remonta a épocas ancestrais, onde a manipulação de ossos e articulações não era apenas um ato mecânico, mas um ritual carregado de significados sociais e culturais” (Card, 2020, p. 45).

Pettman (2007) descreve as TMA como:

[...] das práticas de saúde mais antigas da humanidade, transcendendo a mera manipulação mecânica articular. O termo engloba uma arte complexa de cura que evoluiu através de gerações de prática empírica, formando uma entidade histórico-

cultural distinta dentro dos sistemas de medicina tradicional (Pettman, 2007, p. 166, tradução nossa).

Em diversas culturas, a Sally Mapp é frequentemente destacada como uma das primeiras montadoras de ossos documentadas no início do século XVIII, (Friedman, 2001), atuando como uma figura respeitada em sua comunidade, época em que a medicina convencional estava em seus estágios iniciais e as práticas de cura eram frequentemente baseadas em conhecimentos empíricos e tradições orais (Harris, 2010).

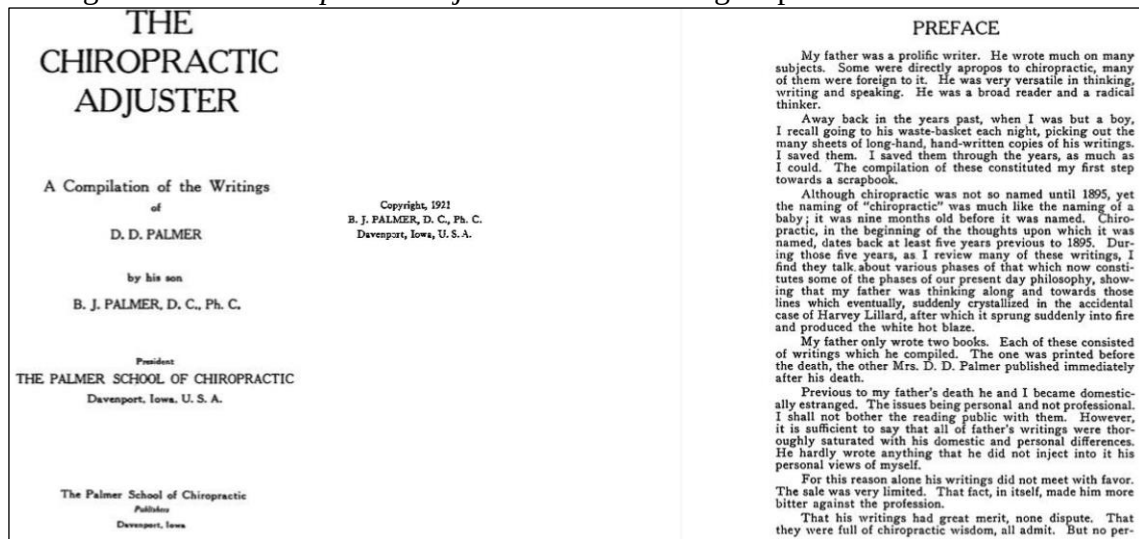
Segundo a obra *The History of Osteopathy: A Brief Overview* (McGowan, 2010), o médico Norte Americano, Andrew Taylor Still (1828-1917), de Lee County, Virginia, EUA, em 1874 sob crença de que a manipulação do sistema musculoesquelético poderia influenciar a saúde geral do organismo. O médico desenvolveu estudos que o levaram à sistematização das terapias manipulativas articulares e à institucionalização da Osteopatia como uma forma distinta de cuidado em saúde através das manipulações do corpo humano (McGowan, 2010), culminando com a inauguração da American School of Osteopathy (ASO), em Kirksville, Missouri, em 1892 (Still, 1899; Kaptchuk, 1983):

A osteopatia emergiu de uma combinação das tradições dos bonesetters e da abordagem inovadora de Still para a medicina. As práticas dos bonesetters, que existiam há séculos tanto na Europa quanto na América, forneceram uma base sobre a qual Still desenvolveu sua abordagem mais sistemática para a terapia manual e os cuidados com a saúde (Trowbridge, 1991, p. 105-106).

Na dissertação para obtenção do título de Mestre em História da Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2016, sob o tema: *D. D. Palmer (1845-1913) e as origens da quiropraxia no século XIX*, Selma Cosso Neves (2016), apresenta em tradução própria, o relato encontrado no livro *The Chiropractic Adjuster* (Palmer, 1921) uma compilação redigida por B. J. Palmer em 1921 (Figura 5), filho de D.D. Palmer, retratado na Figura 6, criador da quiropraxia em 1895:

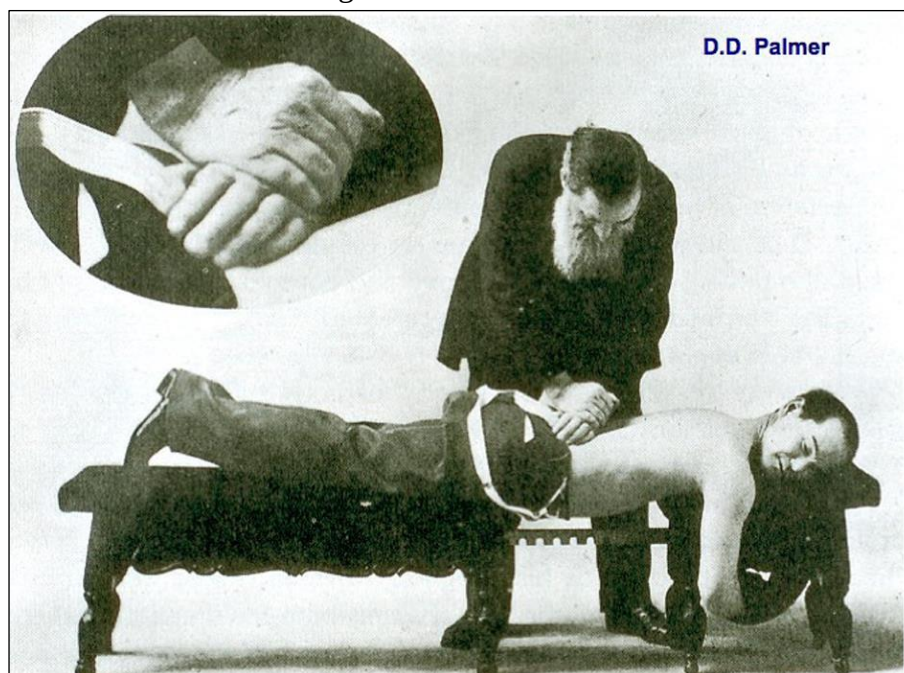
[...] 1895, Dr. D.D. Palmer, que era nesse período terapeuta magnético, entrou em contato um Harley Lillard, [...] era tão surdo que não escutava os barulhos da rua ou tic tac do relógio, [...] audição deste homem foi restaurada pelo Dr. Palmer, pelo ajuste da vertebra que estava fora da posição. Apesar do ajustamento ser bruto e sem conhecimento do resultado que se seguiria, Dr. Palmer foi favorecido com o fato de que o ajustamento foi feito corretamente, com um resultado favorável. Este [evento] forneceu ao Dr. D.D. Palmer a teoria de que os ossos deslocados causavam doença devido ao pinçamento dos nervos (Palmer, 1921 *apud* Neves, 2016, p. 26).

Figura 5 - *The Chiropractic Adjuster* uma obra redigida por B.J. Palmer em 1921



Fonte: Palmer (1921)

Figura 6 - Daniel David Palmer

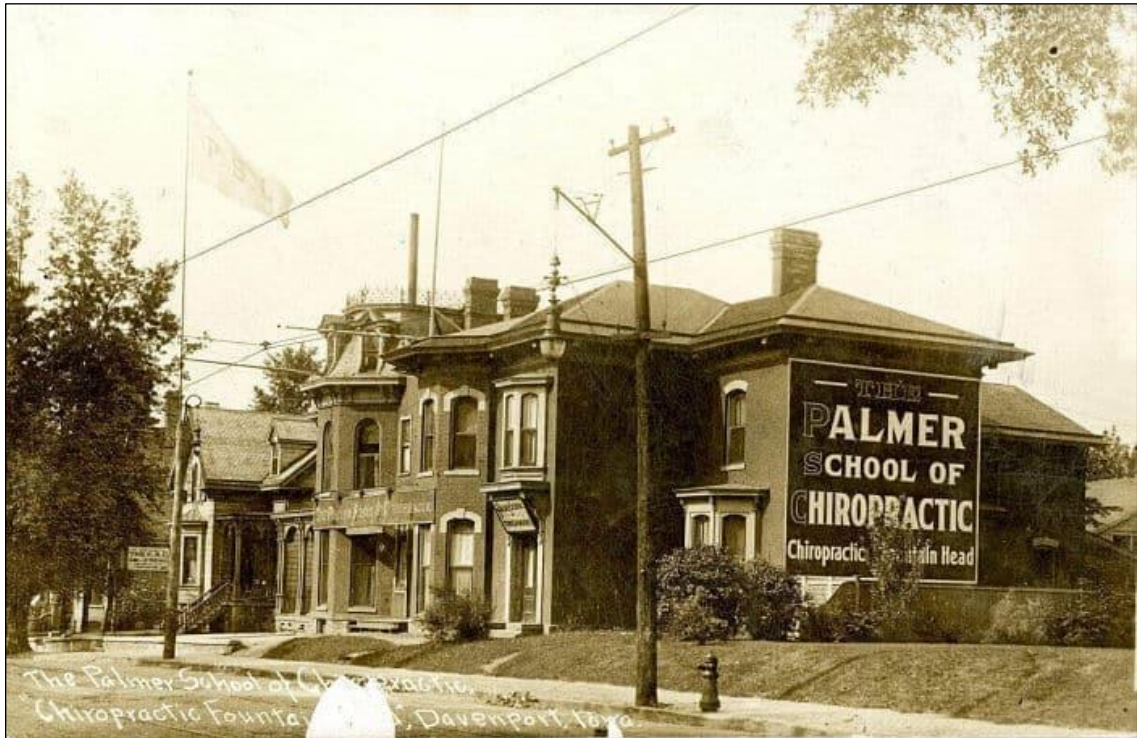


Fonte: Bracher, Benedicto e Facchinato (2013, p. 175).

Na publicação das *Diretrizes da OMS para Formação Básica e Segurança em Quiropraxia* (Organização Mundial da Saúde, 2005), tem-se descrita a informação histórica da primeira escola de Quiropraxia (Figura 7):

[...] a descoberta da quiropraxia é atribuída a D.D. Palmer em 1895, com a primeira escola para formação de quiropraxistas iniciada na cidade de Davenport, Estado de Iowa, nos Estados Unidos da América em 1897 (Organização Mundial da Saúde, 2005 p. 5).

Figura 7 - Primeira Escola de Quiropraxia

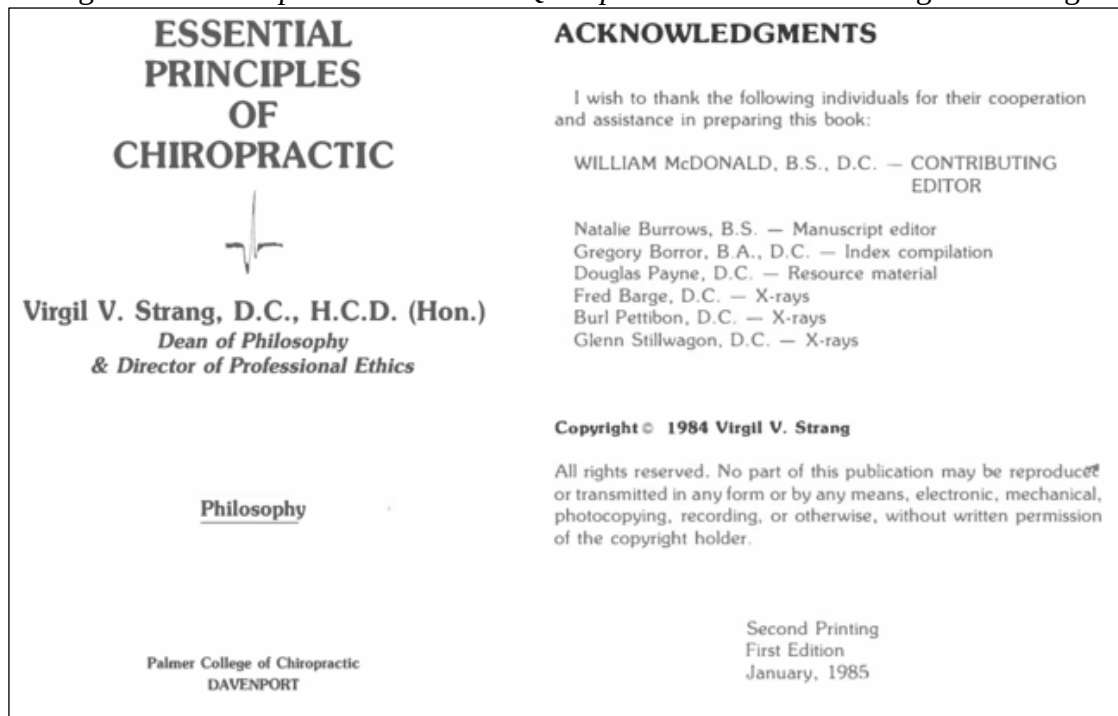


Fonte: Norum (2024).

O filósofo, ex-presidente do Palmer College of Chiropractic, Virgil V. Strang (1984), em sua obra *Princípios Essenciais da Quiropraxia* (Figura 8), referindo-se aos conceitos hipocráticos da Grécia antiga na aplicação dos medicamentos e das manipulações, ao traçar comparação com os fundamentos da quiropraxia, verificou que ambas tinham seus princípios em interface. Contudo, o tempo as teria distanciando, com o paradoxo na instituição do pensamento alopático, medicamentoso e cirúrgico versus o pensamento conservador por meios naturais para potencializar a capacidade adaptativa, de cura e manutenção da saúde de forma não invasiva. Strang (1984) destaca que em nenhum momento se propõe a quiropraxia como substituto da medicina. Segundo o autor, é tolo, tanto para uma como para outra disciplina tentar suplantiar as forças da outra. Nenhuma arte de cura pode arvorar-se como possuidora de todas as soluções para a miríade de males que assolam a humanidade.

Agora [...] há inúmeras situações que claramente exigem o uso de cirurgia ou terapia medicamentosa. Mas argumentar que essas situações seletivas exigem que quiropraxistas devam fazer incisões ou prescrever medicamentos é argumentar por algo pouco sensato. Defender isso levaria à ideia de que todos os médicos, de todas as áreas, deveriam oferecer toda e qualquer especialidade, o que é perigoso para a qualidade do cuidado (Strang, 1984, p. 130).

Figura 8 - “Princípios Essenciais da Quiropraxia” uma obra de Virgil V. Strang



Fonte: Virgil V. Strang (1984)

David Chapman-Smith (2001), em seu livro *Quiropraxia uma Profissão na Área da Saúde*, cita o relatório *Chiropractic in the United States: Training, Practice and Research 1997*, (Quiropraxia nos E.U.A.: Treinamento, Prática e Pesquisa):

[...] a quiropraxia é agora reconhecida como a fonte principal de um dos poucos tratamentos recomendados por diretrizes baseadas em evidências nacionais para o tratamento de dor nas costas, a manipulação da coluna vertebral. Nas áreas treinamento, prática e pesquisa, a quiropraxia emergiu da periferia do sistema de saúde e desempenha um papel cada vez mais importante nas discussões das políticas de saúde (Achpman-Smith, 2001, p. 3).

A visão do fundador da quiropraxia, Daniel David Palmer, sobre os fundamentos filosóficos e científicos da quiropraxia como uma ciência inovadora e educadora, um novo paradigma no campo da saúde, é citada em seu livro *Text-book of the science, art and philosophy of chiropractic* (Palmer, 1910), que descreve que:

A quiropraxia surgiu em um momento oportuno. O mundo havia evoluído para aceitá-la — havia uma demanda por ela — era necessária. Não veio para antagonizar outros métodos, mas foi exigida, pois cada um dos outros já havia cumprido seu tempo e propósito. A quiropraxia surgiu como uma educadora. Aqueles que praticam outros métodos estão absorvendo seus princípios e movimentos na medida em que são mentalmente capazes. As pessoas exigem que a Medicina e a Terapêutica avancem ou deem lugar a algo novo. A quiropraxia é um fato demonstrado; é uma ciência. À medida que nos familiarizarmos com seus princípios, fundamentados em leis tão antigas quanto os vertebrados, cometeremos menos falhas. Essa ciência só pode se

desenvolver ao longo das linhas traçadas por seu fundador (Palmer, 1910, p. 694, tradução nossa).¹

Palmer (1910) destaca a importância de seus princípios baseados em leis naturais e a necessidade de avançar no conhecimento para reduzir falhas na prática dos cuidados da saúde.

A contextualização do processo histórico das terapias manipulativas articulares nas diversas culturas mundiais é salutar ao entendimento da distinção entre as técnicas de manipulação da coluna vertebral, com a evolução científica por meio dos estudos e processos que levaram à institucionalização da Quiropraxia no final do século XIX como uma profissão estruturada em fundamentação, história e atuação específica na área da saúde. Haldeman (2005) afirma que Quiropraxia deve ser reconhecida como uma profissão de saúde distinta, com uma base teórica e prática que examina a saúde e a doença em um contexto holístico.

Meeker e Haldeman (2002) em seu artigo *Chiropractic: A Profession at the Crossroads of Mainstream and Alternative Medicine* destacam a importância da estrutura corporal para a saúde geral do indivíduo, concentrando-se em abordagens naturais e holísticas para a cura.

A partir da elucidação das primeiras práticas documentadas das TMA nas diversas culturas e épocas até a sistematização do ensino e prática em modelos com base científica por meio da consolidação profissional da Osteopatia e da Quiropraxia nos Estados Unidos no séc. XIX, será abordado nos próximos capítulos o desenvolvimento da Quiropraxista como uma profissão da área da saúde de formação universitária específica com história, fundamentação e estruturas distintas.

3.2 A expansão da profissão no mundo

O primeiro programa oficial de educação em Quiropraxia foi incorporado em 1897, com a criação da “Palmer's School of Magnetic Cure”, que mais tarde se tornaria a “Palmer School of Chiropractic” nos EUA. Esse foi, historicamente, o início da educação em Quiropraxia que viria a expandir-se globalmente numa escalada de crescimento e de necessidade de formação de profissionais cada vez mais qualificados. Ainda em 1906, o currículo foi ampliado para

¹ É o texto original: Palmer (1910, p. 694): “Text-book of the science, art and philosophy of chiropractic. Portland Printing House. “Chiropractic came in its own good time. The world had grown to it—there was a demand for it—it was needed. It did not come to antagonize other methods. It was demanded, each of the others having served its time and purpose. Chiropractic came as an educator. Those practicing other methods are absorbing its principles and movements as fast as they are mentally able. The people demand that Medicine and Therapeutics shall move forward or step aside. Chiropractic is a demonstrated fact; it is a science. As we become acquainted with its principles, founded upon laws as old as the vertebrate, we will make less failures. The science can only develop along the lines laid down by its founder”.

incluir disciplinas como anatomia, fisiologia, patologia, diagnóstico e técnicas de ajuste quiroprático. Essa iniciativa torna-se o marco da transformação na educação quiroprática, que passou a adotar currículos mais longos e padronizados (Johnson *et al.*, 2022). Por volta de 1919, os programas de formação de quiropraxistas já tinham uma duração de 3 anos e 6 meses, com maior complexidade e exigência para profissionalização da área (Keating; Callender; Cleveland, 1998).

No artigo *A Brief Review of Chiropractic Educational Programs and Recommendations for Celebrating Education on Chiropractic Day*, Johnson *et al.* (2022) apontam que:

Os primeiros programas de quiropraxia eram curtos, com duração de apenas alguns meses. O programa original de treinamento de D. D. Palmer durava 3 meses, mas rapidamente foi expandido para 9 meses. Em 1906, após vender sua escola para seu filho, Bartlett Joshua Palmer, o programa foi ampliado para incluir disciplinas como anatomia, fisiologia, patologia, diagnóstico e técnicas de ajuste quiroprático (Johnson *et al.*, 2022, p. 46, tradução nossa).²

A expansão internacional da educação em quiropraxia consolidou-se 50 anos após a fundação da profissão, Quadro 5. O primeiro programa fora dos Estados Unidos foi estabelecido no Canadá, em 1945, com a criação do Canadian Memorial Chiropractic College. Na Europa, o primeiro programa foi fundado em 1965, no Reino Unido, com o Anglo-European College of Chiropractic (atualmente AECC University College) (Health Science University, 2025). Desde então, a educação em Quiropraxia se expandiu para outras regiões, incluindo a Austrália, Nova Zelândia, América Latina, Ásia e o Mediterrâneo Oriental (World Federation of Chiropractic, 2024a; Johnson *et al.*, 2022).

² É o texto original: Johnson *et al.* (2022, p. 46): “The earliest chiropractic programs were short, lasting only several months. D. D. Palmer's original chiropractic training program lasted 3 months but quickly expanded to 9 months. In 1906, after D. D. Palmer sold his school in Davenport to his son, Bartlett Joshua Palmer, the program was expanded to include anatomy, physiology, pathology, in addition to diagnosis and chiropractic adjusting”.

Quadro 5 – Instituições de Graduação em Quiropraxia no Mundo de 1897 a 2025

	Fundação	País	Instituição	Status	Endereço Eletrônico
1	1897	USA	Palmer College of Chiropractic Davenport	Accredited. CCE	https://www.palmer.edu
2	1904	USA	University of Western Atates	Accredited. CCE	https://www.uwv.edu/
3	1906	USA	National University of Health Sciences	Accredited. CCE	https://www.nuhs.edu
4	1908	USA	Texas Chiropractic College	Accredited. CCE	https://www.txchiro.edu
5	1911	USA	Southern California University of Health Sciences	Accredited. CCE	https://www.scuhs.edu
6	1919	USA	Northeast College of Health Sciences	Accredited. CCE	https://www.northeastcollege.edu
7	1922	USA	Cleveland Chiropractic Kansas City	Accredited. CCE	https://www.cleveland.edu/
8	1935	USA	Logan University	Accredited. CCE	https://www.logan.edu
9	1941	USA	Northwestern Health Sciences University	Accredited. CCE	https://www.nwhealth.edu
10	1945	Canadá	Canadian Memorial Chiropractic College	Accredited. FCC	https://www.cmcc.ca
11	1965	United Kingdom	Health Sciences University (formerly AECC)	Accredited. ECCE	https://www.hsu.ac.uk/
12	1972	United Kingdom	McTimoney College of Chiropractic (Manchester)	Accr. ECCE and GCC	https://mctimoney-college.ac.uk/locations/manchester/
13	*1972	United Kingdom	McTimoney College of Chiropractic (Oxfordshire)	Acr. ECCE and GCC	https://www.mctimoney-college.ac.uk/
14	1973	USA	Sherman College of Chiropractic	Accredited. CCE	https://www.sherman.edu
15	1974	USA	Life University	Accredited. CCE	https://www.life.edu
16	1978	USA	Parker University	Accredited. CCE	https://www.parker.edu
17	1980	USA	Palmer of Chiropractic West	Accredited. CCE	https://www.palmer.edu/
18	1981	USA	Life Chiropractic College West	Accredited. CCE	https://www.lifewest.edu
19	1983	França	Institut Franco-Européen de Chiropratique (Paris)	Accredited. ECCE	https://www.ifec-net
20	1983	Suécia	Skandinaviska Kiropraktorhögskolan	Accredited. NBHW	https://www.kiropraktorhogskolan.se/
21	1989	África do Sul	Durban University of Technology	Accredited. ECCE	https://www.dut.ac.za
22	1990	Austrália	Macquarie University	Accredited. CCEA	https://www.mq.edu.au
23	1991	USA	University of Bridgeport College of Chiropractic	Accredited. CCE	https://info.bridgeport.edu/chiro
24	1992	Austrália	RMIT University	Accredited. CCEA	https://www.rmit.edu.au
25	1992	Canadá	Université du Québec à Trois-Rivières - UQTR	Accredited. FCC	https://www.uqtr.ca
26	1993	África do Sul	University of Johannesburg	Accredited. ECCE	https://www.uj.ac.za
27	1994	Nova Zelândia	New Zeland College of Chiropractic	Accredited. CCEA	https://www.chiropractic.ac.nz
28	1995	Dinamarca	Syddansk Universitet Odense	Accredited. ECCE	https://www.sdu.dk/da
29	1995	Japão	**Tokyo College of Chiropractic	Accredited. CCEA	https://www.chiro.jp/
30	2000	Brasil	Universidade Anhembi Morumbi	Accredited. MEC	https://portal.anhembi.br/graduacao/cursos
31	2000	Brasil	Universidade FEEVALE	Accredited. MEC	https://www.feevale.br/graduacao/quiropaxia
32	2001	México	Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	Accredited. MEM	https://www.uneve.edu.mx
33	2001	United Kingdom	Welsh Institute of Chiropractic	Accredited. ECCE	https://www.southwales.ac.uk/chiropractic-clinic
34	2002	USA	Palmer College of Chiropractic Florida	Accredited. CCE	https://www.palmer.edu
35	2004	USA	D'Youville College	Accredited. CCE	https://www.dyc.edu
36	2006	Austrália	Murdoch University	Accredited. CCEA	https://www.murdoch.edu.au
37	2007	Espanha	Madrid College of Chiropractic-RCU	Accredited. ECCE	https://www.rcumaricristina.es
38	2008	Suíça	University of Zurich	Accredited. ECCE, CSA	https://www.balgrist.ch/en/offer/centers/chiropractic-medicine/
39	2008	França	Institut Franco-Européen de Chiropratique (TLS)	Accredited. ECCE	https://www.ifec-net
40	2009	Espanha	Barcelona College of Chiropractic	Accredited. ECCE	https://www.bechiropractic.es/
41	2009	México	Universidad Estatal del Valle de Toluca	Accredited. MEM	https://unext.edomex.gob.mx/
42	2010	Malásia	International Medical University	Accredited. CCEA	https://www.imu.edu.my/
43	2010	Chile	Universidad Central de Chile	Accredited. MEC	https://www.uccentral.cl/
44	2012	Austrália	Central Queensland University	Accredited. CCEA	https://www.cqu.edu.au
45	2013	México	Universidad Veracruzana	Accredited. MEM	https://www.uv.mx/
46	2015	Turquia	Bahçesehir University	Accredited. YÖK	https://www.bahcesehir.edu.tr/2015/04/01/13770-kurumsal-ozel-bahcesehir-universitesi-programlari
47	2016	Austrália	Australian Chiropractic College	Accredited. CCEA	https://acc.sa.edu.au/
48	2016	USA	Keiser University	CCE in process	https://www.keiseruniversity.edu/doctor-chiropractic-de/
49	2018	United Kingdom	London South Bank University	Accredited. GCE	https://www.lsbu.ac.uk/
50	2018	Puerto Rico	Universidad Central del Caribe	CCE in process	https://www.uccaribe.edu
51	***2019	Alemanha	Hochschule Fresenius	ECCE in process	studieren@chiropraktik.de
52	2020	United Kingdom	Teesside University	Accredited. GCE	https://www.tees.ac.uk/
53	2021	USA	Campbellsville University	CCE in process	https://chiropractic.campbellsville.edu/
54	2021	Espanha	McTimoney College of Chiropractic (Madrid)	Accr. ECCE and GCC	https://mctimoney-college.ac.uk/locations/spain/
55	2021	Brasil	Centro Universitário UCEFF	Accredited. MEC	wolney.quirpraxia@uceff.edu.br
56	2022	Brasil	Centro Universitário Gama e Souza - UNIGAMA	Pendente	https://www.gamaesouza.edu.br/
57	2023	Filipinas	Camara Institute for Chiropractic Sciences	Acr. CSP and PITAHC	https://cics-edu.ph/
58	2023	Brasil	Centro Universitário FAMETRO	Pendente	https://presencial.fametro.edu.br/curso/quiropaxia/
59	****2025	USA	University of Pittsburgh (NUHS)	CCE in process	https://www.shrs.nitt.edu/chiropractic

Fonte: Desenvolvido pelo autor - compilação dos sítios eletrônicos da Federação Mundial de Quiropraxia (WFC); Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia (CCEI); Conselho de Educação em Quiropraxia da Austrália (CCEA); Conselho Europeu de Educação em Quiropraxia (ECCE); Conselho de Educação em Quiropraxia do Canadá (CCEC); Conselho de Educação em Quiropraxia dos Estados (CCE-US); e do Ministério da Educação (EMEC) / *Os órgão de acreditação e sítio eletrônico da Universidade descrevem o início do curso em 1972 para Manchester e que o campus de Oxfordshire iniciou em seguida, mas não descreve a data / **Tokyo College of Chiropractic - por efeito da pandemia COVID 19, encerrou suas atividades em 2022 / ***Divergência de informação do sítio eletrônico da instituição e os órgãos de acreditação em quiropraxia do país, não foi possível confirmar a dada de início desse programa de educação em quiropraxia na Alemanha / ****Outono de 2025 é a previsão do início do curso NUHS.

No Quadro 5, tem-se o panorama cronológico, entre 1897 e 2025, de 59 instituições que oferecem formação universitária em Quiropraxia, distribuídas por continente em 7 regiões definidas por cores: **África (cinza claro); América Latina (verde claro); América do Norte**

(laranja); Ásia (amarelo fosco); Europa (azul); Mediterrâneo Oriental (cinza escuro); e, Pacífico (azul escuro). São 20 países com os respectivos status de acreditação e/ou reconhecimento dos programas educacionais por regramento legal ao redor do mundo, detalhados no capítulo 3 sobre a Regulamentação da Formação em Quiropraxia.

Como demonstrado, ainda no Quadro 5, em 44 anos, a partir de 1897, com a inauguração do Palmer School of Chiropractic em Davenport, no Estado de Iowa, até 1941, com o Northwestern Health Sciences University, localizado em Bloomington, Minnesota, surgiram 9 cursos superiores para formação de quiropraxistas nos EUA. Em 1945, a América do Norte apresenta o décimo curso superior para formação de quiropraxista, por meio da inauguração do Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC) localizado na província de Ontário, em Toronto - Canadá.

Nos anos 1950 e 1960, a formação superior em Quiropraxia começou a expandir para outros países, especialmente no Canadá, na Europa, na Austrália e na Nova Zelândia. Em 1965, o Reino Unido criou a primeira escola de Quiropraxia na Europa, a Anglo-European College of Chiropractic (2025), que se tornou um modelo para outros países.

Com o propósito de promover a conscientização, utilização e integração da Quiropraxia internacionalmente, em 1988, por meio do Congresso Mundial de Quiropraxia em Sydney, Austrália, foi criada a Federação Mundial de Quiropraxia (World Federation of Chiropractic, 2025a), culminando, em janeiro de 1997, no estabelecimento de relações oficiais da WFC com a OMS, (Quadro 6) como uma organização não governamental (ONG). Essa relação inclui a colaboração em várias áreas, como suporte às políticas da OMS e participação em eventos e reuniões relevantes. Um marco dessa parceria foi a criação das *Diretrizes da OMS para Formação Básica e Segurança em Quiropraxia* (Organização Mundial da Saúde, 2005), que define padrões educacionais e regulamentares para a prática quiroprática em diferentes países.

Quadro 6 - ONGs em relação oficial com a OMS

Organization	Lead
International Association of Cancer Registries (IACR)	Joanne Aitken
International Council of Nurses (ICN)	Nick Hardiker
International Federation of Health Information Management Associations (IFHIMA)	Mary Stanfill
International League of Dermatological Societies (ILDS)	Jo Groves
Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC)	David Baorto
World Federation of Chiropractic (WFC)	Richard Brown
World Federation of Occupational Therapists (WFOT)	Richard Ledgerd
World Organization of Family Doctors (WONCA)	Diego Schrans
World Physiotherapy	Jonathon Kruger

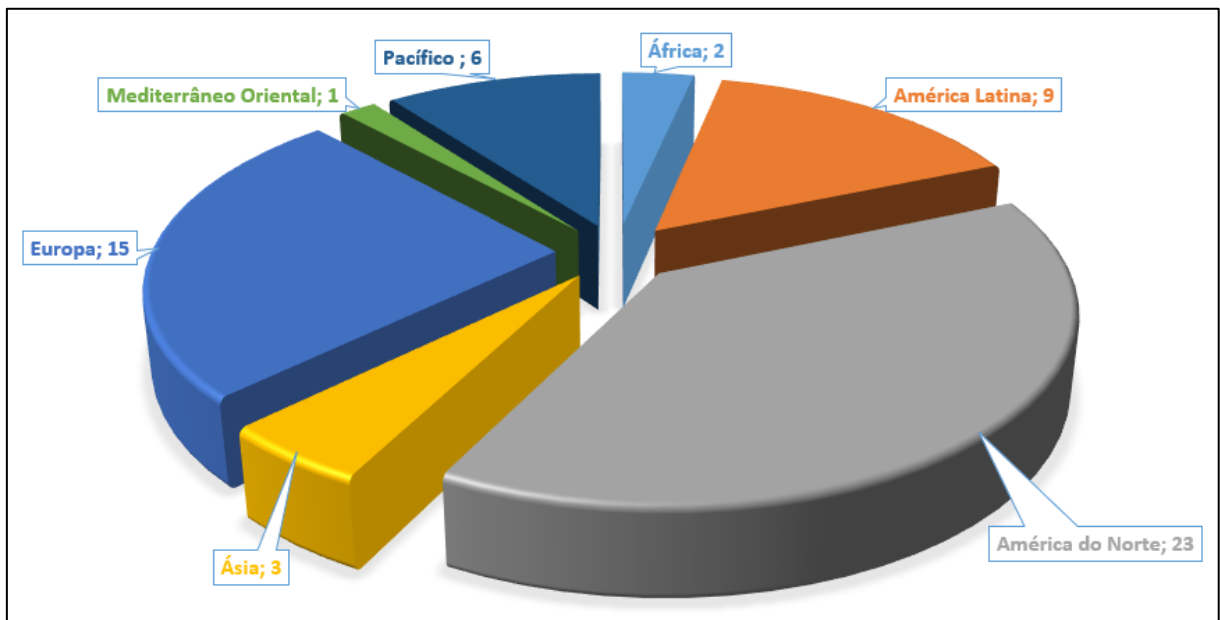
Fonte: World Health Organization (2021)

O Quadro 6 destaca a formalização da OMS, com o reconhecimento da sua relação oficial com a WFC no espectro de uma organização não governamental em colaboração para questões relacionadas à saúde e à Quiropraxia.

Os membros da Federação Mundial de Quiropraxia são associações nacionais de quiropraxistas de mais de 90 países em 7 regiões do mundo (World Federation of Chiropractic, 2025a). A parceria entre a WFC e a OMS reforça a importância do reconhecimento da medicina complementar e alternativa, incluindo a quiropraxia, no contexto global da saúde pública.

O Gráfico 1 apresenta as 7 regiões ao redor do mundo em 2025, com a respectiva quantidade de cursos universitários oficiais em 59 instituições de ensino: 2 na África, 9 na América Latina, 23 na América do Norte, 3 na Ásia; 15 na Europa, 1 no Mediterrâneo Oriental, e, 6 no Pacífico, que aplicam em seus projetos acadêmicos para formação de quiropraxistas o consenso internacional preconizado pela Organização Mundial da Saúde por meio das *Diretrizes da OMS sobre a Formação Básica e Segurança em Quiropraxia* (Organização Mundial da Saúde, 2005).

Gráfico 1 - (59) Cursos Universitários Distribuídos por Continentes em 7 Regiões em 2025



Fonte: Elaborado pelo autor.

A WFC dedica-se à padronização do ensino da Quiropraxia, proporcionando orientações educacionais e contribuindo para o reconhecimento global da profissão. Durante os anos 1980 e 1990, com apoio de uma das primeiras entidades representativas da Quiropraxia fora da América do Norte, a European Chiropractic Union (ECU), a WFC contribuiu para que diversas

universidades ao redor do mundo começassem a oferecer programas de graduação em Quiropraxia, que passaram a ser reconhecidos pelos organismos educacionais de seus respectivos países (World Federation of Chiropractic, 2025b).

A expansão da educação em Quiropraxia, por meio de cursos superiores oficiais em 59 países, reflete não apenas o crescimento da profissão, mas também o reconhecimento de sua importância na promoção da saúde pública (Quadro 5), sob ação de quiropraxistas atuando em 99 países. Segundo a WFC, a partir da sistematização de padrões de educação em Quiropraxia com o apoio de agências de acreditação internacionalmente reconhecidas e organizações de testes, os padrões educacionais (detalhados no capítulo 3 desse estudo) têm sido estabelecidos e mantidos em nível global. Essa evolução contínua reforça o papel da educação na formação de profissionais capacitados e no fortalecimento da Quiropraxia como uma profissão de saúde essencial no século XXI.

Segundo a World Federation of Chiropractic (2025a), a quiropraxia surgiu como uma profissão distinta nos Estados Unidos na década de 1890. Até a década de 1950, a profissão estava concentrada na América do Norte e em grande parte isolada dos cuidados de saúde convencionais. Nas décadas de 1960 e 1970, foram lançadas as bases para uma aceitação mais ampla da profissão – melhores padrões educacionais e de licenciamento, investigação significativa, textos de investigação e revistas científicas, e reconhecimento legal e regulamentação em todos os Estados dos EUA e em vários outros países (Organização Mundial da Saúde, 2005).

3.3 A chegada da Quiropraxia no Brasil

Na análise das referências relativas ao processo histórico sobre a chegada da Quiropraxia no Brasil, percebe-se que estas transitam na dicotomia entre fatos e narrativas e, quanto ao modelo de formação e controle para prática segura da profissão no país. Tais dicotomias e paradoxos cercam eventos muitas vezes moldados por experiências pessoais, interpretações culturais, além das dinâmicas políticas, corporativas e sociais que influenciam a percepção da Quiropraxia no cenário brasileiro e internacional. Essa percepção, por vezes, é reinterpretada a partir de novas descobertas interpostas pela análise crítica entre a história contada e a história documental, que no cotejamento dos fatos e dos dados, nos traz nova luz a favorecer o desenvolvimento historiográfico em metodologias que contribuam com a recontextualização do processo histórico da profissão no país.

Nesse sentido, apresentamos a seguir, na forma de linha do tempo, uma cronologia referenciada, seguida por sínteses dos pontos relevantes à temática desse capítulo também compreendido como processo histórico da Educação em Quiropraxia no Brasil.

Percebe-se duas fases marcadamente distintas na década de 1990 como um divisor de águas entre os relatos dos primeiros quiropraxistas em solo brasileiro e, a construção acadêmica das primeiras turmas de bacharéis quiropraxistas por meio de Instituições de Ensino Superior que oferecem a formação em Quiropraxia, em conformidade com o consenso mundial para formação nessa área do saber atendendo as prerrogativas do Ministério da Educação, em contraposição com a demanda de cursos livres e cursos de especialização antagônicos à raiz epistemológica da estrutura educacional da profissão de quiropraxista no mundo, ora com 130 anos.

Preliminarmente, segundo Azevedo e Lopes com a colaboração do departamento “Special Collections” do Palmer College of Chiropractic³, documentos datados de 1913, apresentam a primeira brasileira estudante de Quiropraxia, Isabel Bichels. A brasileira aparece em foto utilizada para divulgação do programa de educação em Quiropraxia no Palmer College of Chiropractic (Imagem 1) intitulada “Doze razões pelas quais você deve estudar Quiropraxia”. Enumerada da esquerda para a direita entre 12 personagens representando nacionalidades distintas, a personagem de nº 7 é a própria Isabel Bichels em destaque como a primeira brasileira a formar-se em curso oficial de Quiropraxia. Em outro documento: *Estudantes de Países Estrangeiros no Davenport College of Chiropractic* (DCC) datado de 1917 sob o título: *A School You Will Eventually Attend*, Isabel Bichels (Imagem 2) se apresenta como brasileira de Curitiba no Paraná, em que declara “[...] desde que me formei no D.C.C., estou preparada para aliviar o sofrimento da humanidade [...]”. O Palmer College of Chiropractic guarda outra foto, pertencente ao acervo da Igreja Presbiteriana de Curitiba, na qual sob o nº 8, Isabel Bichels figura entre professoras e alunas da Escola Americana de Curitiba no início do século XX. Tal fato é corroborado pela dissertação intitulada “Escola Americana de Curitiba (1892-1934): um estudo do americanismo na cultura escolar” pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a qual Geysa Spitz Alcoforado de Abreu cita que a ex-aluna “Isabel Bichels foi professora da Escola Americana de Curitiba em 1902” (Abreu, 2003, p. 63).

A autora, Geysa S. A. Abreu (2003), menciona que a Escola Americana de Curitiba, em 1902, oferecia apenas os cursos Primário e Intermediário, atualmente compondo a Educação Básica, que é estruturada em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

³ Pesquisa em andamento entre Azevedo e Lopes e departamento “Special Collections” do Palmer College of Chiropractic. As imagens 1 e 2 foram encaminhadas através do e-mail.

Imagem 1 - Registro da brasileira Isabel Bickels no Palmer College of Chiropractic em 1913



Fonte: Desenvolvido pelo autor com a colaboração de Fernando Azevedo e do Special Collections - Palmer College of Chiropractic, sob o registro - <Isabel Bichels_Matric Card.jpg><Isabel Bichels_Graduation Photo.jpg><US City Directory_Isabel Bickels_1913.jpg>

Imagem 2 - Ex-alunos Estrangeiros no Davenport College of Chiropractic em 1917

Students from Foreign Countries



DR. JOSEPH MOEHRINGER of Altdorf, Germany, says:

I earnestly and cordially recommend your College as the best school which men and women are successfully and practically prepared for this dignified, honorable and most lucrative profession.

A SCHOOL YOU



MISS ISABEL BICHELS of 23 Rua Comendador Arago Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, South America, says:

Since graduating from the D. C. C. I know I am prepared to relieve suffering humanity, as I have every confidence in the merits of the school where I was restored to health.

WILL EVENT



LORD CHAS. KENNEDY of Calzean Castle, Ayr, says:

I hope to introduce Chiropractic in the British Kingdom and interest some of my friends to take it up, and if I succeed I will surely recommend the D. C. C. as the institution to obtain a thorough training in all the branches of this wonderful science.

UALLY ATTEND



OLIVER FINCHARD, D. C., of Paris, France, says:

Previous to entering your school I had spent five months in attendance at another school. I am truly glad that I ever investigated. I have been convinced of the merits of the D. C. C. and will heartily recommend this College as being the place to become a well qualified Chiropractor.



J. M. PEREZ, of Cairo, Egypt, says:

After twelve months stay in Davenport, I found that in your College pupils are given the best Chiropractic instructions and I would advise my friends in Europe and Egypt to come and study in your College.

The above students all entered another college before investigating, but afterwards enrolled in the D. C. C.; their full testimony given as to why they entered our College upon request.

35

Fonte: Special Collections, 037_Davenport College of Chiropractic_1917_pg037

Portanto, a partir da análise documental das imagens sob a hipótese de Isabel Bichels ser a primeira brasileira a participar de programa oficial para formação em Quiropraxia, tem-se o marco temporal de 1913 como ponto de partida da linha do tempo referente à chegada da Quiropraxia no Brasil.

Azevedo e Lopes, no episódio nº 3 - canal do YouTube, BACKBONE, em 21 de abril de 2021, apresentam documentos que atestam presença do quiropraxista estrangeiro, o escocês Alexander Atkinson (Imagem 3), em 1919 atuante na cidade de Monte Negro no Estado do Rio Grande do Sul (Backbone [...], 2021).

Imagem 3 - Quiropraxista escocês residente no Brasil em 1919



Fonte: Acervo da família Atkinson – Monte Negro - RS

Antes das descobertas apontadas por Azevedo e Lopes (Backbone [...], 2021), pela pesquisa documental em andamento e outras citações relacionadas com a história da Quiropraxia no Brasil, como a publicação do Mosby-Year Book, Inc., em parceria com a Associação para a História da Quiropraxia e a Fundação do Centenário da Quiropraxia, na obra *Chiropractic – an Illustrated History* cujo capítulo 16 “Chiropractic Around the World”, Veal *et al.* (1995, p. 485) afirmam que “a quiropraxia foi introduzida no Brasil por William Fipps na

década de 1920” que:

[...] em 1945, um curso foi oferecido pela Universidade de Artes Naturais, localizada em Denver, Colorado. Esse curso foi realizado em Curitiba de 1958 a 1964, onde 28 estudantes foram titulados quiropraxistas. Contudo, em 1972, a prática foi declarada ilegal, o que levou a maioria dos praticantes a deixar o país ou a mudar de profissão. O único quiroprático que permaneceu no país em 1985 foi preso por 8 dias [...] (Veal *et al.*, 1995, p. 485, tradução nossa).

Contudo, segundo o Conselho de Examinadores de Quiropraxia do Estado do Colorado – USA (Imagem 4), a universidade que supostamente teria formado 28 brasileiros em Quiropraxia na ARB em Curitiba no ano de 1964 teria encerrado suas atividades em 1962, ou seja, dois anos antes da emissão dos referidos diplomas.

Em outra obra, desenvolvida pelo secretário-geral da WFC, David Chapman-Smith (2001), intitulada *Quiropraxia: uma Profissão da Área da Saúde*, ao descrever o período inicial da Quiropraxia no Brasil, o autor menciona não existir, até a década de 1990, registros oficiais de cursos de Quiropraxia organizados com a participação de instituições da Quiropraxia ou quiropraxistas com títulos reconhecidos. “[...] no Brasil não há referências organizadas sobre a história da Quiropraxia”, acredita ser possível que entre as décadas de 1940 e 1980, alguns profissionais quiropraxistas com formação oficial na América do Norte, ao passar por períodos no Brasil, “[...] tenham ensinado rudimentos da profissão para brasileiros” (Shapman-Smith, 2001, p. 158).

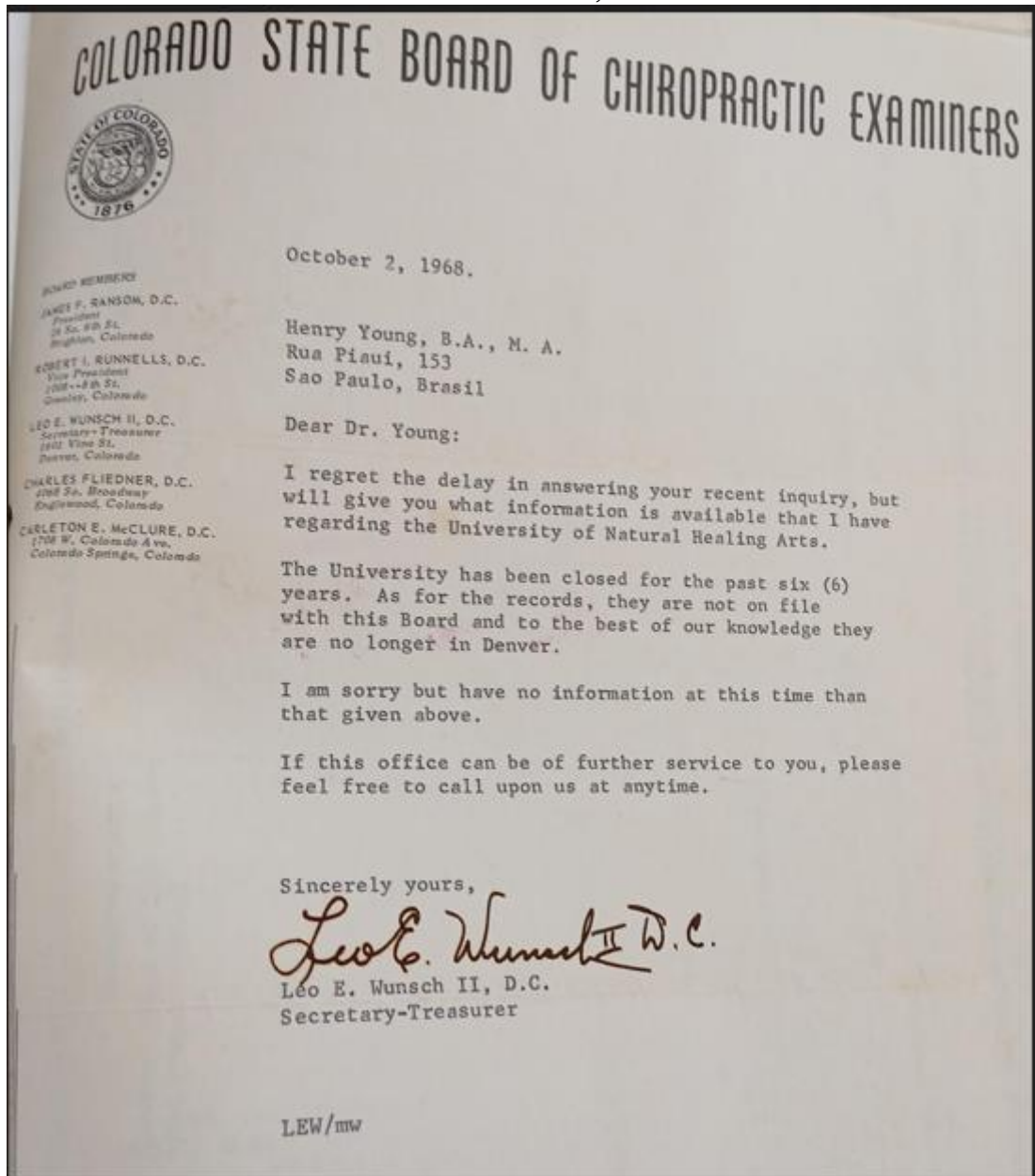
Na pesquisa de natureza histórica, Lopes (2004) concluiu que

[...] até 1998 práticas da Quiropraxia foram ensinadas no Brasil através de cursos informais não oficiais ministrados por professores que não possuíam formação superior em Quiropraxia ou tivessem passado por algum curso oficial da profissão que se enquadre nas diretrizes que a define internacionalmente (Lopes, 2004, p. 13).

Segundo Lopes (2004), M. Matheus de Souza declara ser formado em Quiropraxia em curso que ocorreu entre 1958 e 1964 no Brasil em convênio entre Universidade de Artes Naturais, localizada em Denver, Colorado e a Associação de Renovação Biológica (ARB) de Curitiba em 1964, por meio do qual, 28 brasileiros, liderado pelo norte americano Henry Wilson Young, titularam-se quiropraxistas, referindo que a prática foi declarada ilegal desencadeando perseguições traumáticas levando a maioria dos praticantes a deixar o país ou a mudar de profissão (Veal *et al.*, 1995). M. Matheus de Souza, o único que permaneceu atuando como quiropraxista no país, participou, inclusive como sócio fundador da Associação Brasileira de Quiropraxia (ABQ). Contudo, por não conseguir apresentar documentos que respaldassem sua

qualificação como quiropraxista, e por não concordar com os fundamentos da ABQ em promover a formação de quiropraxistas no Brasil apenas em nível superior dentro dos padrões internacionais da profissão, teve seu descredenciamento da ABQ e dos órgãos internacionais da profissão (Shapman-Smith, 2001).

Imagem 4 - Carta do CCE do Estado do Colorado – USA sobre universidade que teria formado 28 brasileiros em Curitiba no ano de 1964, ter encerrado suas atividades em 1962



Fonte: Acervo pessoal, cortesia Dorothy Young.

Observa-se, portanto, nas referências preliminares sobre a chegada da quiropraxia no Brasil, que a dicotomia se faz presente em contextos distintos:

- 1º na documentação que corrobora a presença da brasileira Isabel Bichels como estudante em programa oficial de formação em Quiropraxia nos EUA em 1913, que em 1917, do Brasil, declara em documento para o Palmer College de estar aliviando o sofrimento da humanidade por meio da Quiropraxia. Tem-se, ainda no primeiro contexto, a confirmação documental do escocês Alexander Aktinson, diplomado em curso oficial de Quiropraxia atuando no Brasil em 1919.
- 2º na referência bibliográfica utilizada na publicação internacional do centenário da Quiropraxia menciona o nome William Fipps como o introdutor da profissão no Brasil na década de 1920, e, que em 1964, 28 brasileiros titularam-se quiropraxistas por meio de um curso em Curitiba oferecido por uma Universidade de Denver no Colorado – USA, contudo, somente um desses titulados teria permanecido atuando no Brasil, alegando que em 1972, a prática foi declarada ilegal, o que teria levado a maioria dos praticantes a deixar o país ou a mudar de profissão. Não foi possível localizar o nome de nenhum dos demais participantes do suposto curso, e, segundo o Conselho de Examinadores de Quiropraxia do Estado do Colorado – USA, a instituição que supostamente teria ministrado o curso encerrou suas atividades dois anos antes da data da referida titulação para esses 28 brasileiros.
- 3º na publicação do secretário geral da WFC em 2001 por meio da obra *Quiropraxia uma Profissão da Área da Saúde*, na qual declara acreditar ser possível que entre as décadas de 1940 e 1980, alguns profissionais quiropraxistas com formação oficial na América do Norte, tenham ensinado rudimentos da Quiropraxia para brasileiros, e, que não há nenhum registro de cursos oficiais de Quiropraxia no país até a década de 1990. E na pesquisa de natureza histórica (Lopes, 2004) ao concluir que até o final da década de 1990 práticas da Quiropraxia foram ensinadas no Brasil através de cursos informais não oficiais ministrados por professores que não possuíam formação superior em Quiropraxia.

O bojo historiográfico analisado no desenvolvimento dessa pesquisa debruça-se sobre os cursos de formação universitária em Quiropraxia ofertados no país desde fevereiro de 2000 com sucessivas renovações de reconhecimento pelo MEC, que, contrariando a recomendação da própria OMS, cujo Brasil é signatário, até a presente data encontra-se sem DCN, dando margens a lacunas que fragilizam a identidade da profissão de quiropraxista estruturada mundialmente desde 1895, atualmente presente em 99 países, e, principalmente, ao controle e prática de uma profissão de primeiro contato na área da saúde.

O arcabouço da história da educação em Quiropraxia no Brasil até a oficialização dos dois cursos pioneiros de formação universitária em Quiropraxia no país a partir do ano de 2000 por meio das Universidades Anhembi Morumbi – SP e FEEVALE – RS, em conformidade com o consenso mundial para formação e prática segura da profissão, enfrenta lacunas que fragilizam a identidade da profissão de quiropraxista no país em contraposição à legitimidade e à legalidade dos fundamentos educacionais da Quiropraxia desde a sua origem nos EUA há mais de 130 anos, estruturada mundialmente como profissão de formação universitária.

Diante desse claro conflito epistemológico, na busca de compreender a educação em Quiropraxia no Brasil, há de se considerar que, de acordo com Hobsbawm (2011, p. 23), “a história é um processo contínuo, onde as revoluções e mudanças sociais moldam o presente e influenciam o futuro”. Isso implica que sem um entendimento das origens históricas, é impossível compreender plenamente os eventos contemporâneos e suas complexidades (Hobsbawm, 2011).

Nesse sentido, consideraremos a análise temporal da chegada da Quiropraxia ao Brasil a partir de 1913 (Figura 9) como ponto de partida dos processos históricos que influenciaram a dicotomia aqui descrita e os paradoxos que permeiam a linha divisória do cenário educacional da Quiropraxia.

Segundo McNabb (2004), o retorno ao Brasil de Sira Borges, médica brasileira formada em Quiropraxia no Palmer College – USA em 1990, unindo-se a outros quiropraxistas brasileiros e estrangeiros, também originários de cursos oficiais na área, representa o marco para viabilizar aos brasileiros os cuidados em Quiropraxia por profissionais capacitados internacionalmente.

A formação adequada e prática segura surge no Brasil consubstanciada em mais de um século de desenvolvimento em dezenas de países, corroborado pela OMS ao definir a Quiropraxia como “uma profissão da área da saúde que lida com o diagnóstico, o tratamento e a prevenção das desordens do sistema neuro-músculo-esquelético e dos efeitos destas desordens na saúde em geral” (Organização Mundial da Saúde, 2005, p. 5), considerando o diagnóstico quiroprático como não nosológico, acrescenta “para que haja o exercício profissional qualificado e a utilização adequada da Quiropraxia, sistemas se fazem necessários para monitorizar a profissão, o exercício, e a educação e capacitação dos profissionais” (Organização Mundial da Saúde, 2005, p. 6).

Como sócia fundadora e presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia (ABQ), Sira Borges, junto aos seus pares, com amparo da Federação Mundial de Quiropraxia (WFC), encontrou abrigo para esse ideal junto a Angela Kolberg, fisioterapeuta brasileira, diretora do

departamento de Fisioterapia do, à época, Centro Universitário FEEVALE-RS. Ao compreender a estrutura, a história e os fundamentos da profissão, ambas viram a oportunidade de trazer para o Brasil a formação em Quiropraxia consistente com os padrões internacionais da profissão (Lopes, 2004).

A junção entre a ABQ e seus pares, com amparo da WFC e o aporte de Angela Kolberg viabilizou o divisor de águas que garantiu o desenvolvimento da formação universitária em Quiropraxia no Brasil consolidado a partir do convênio firmado entre o Palmer College of Chiropractic – USA e a Universidade FEEVALE – RS em 1997, (Imagem 5) dentro das prerrogativas do MEC e o consenso mundial de educação em Quiropraxia (Shapman-Smith, 2001).

Imagem 5 - Pal Garry Krakos (Palmer) e Francisco A. Stürmer (FEEVALE): assinatura do convênio Palmer College e Universidade FEEVALE, 1997



Fonte: Schemes e Silva (2019, p. 176).

Segundo Shapman-Smith, (2001), em 1999, o médico fisiatra brasileiro, graduado em Quiropraxia pelo Palmer College of Chiropractic West (San Jose, California, EUA) em 1995, Dr. Eduardo Bracher, foi convidado pela Universidade Anhembi Morumbi – SP, a elaborar o projeto inicial do curso de Bacharelado em Quiropraxia concomitantemente ao programa da Universidade FEEVALE – RS, com aporte da ABQ e WFC, por meio dos quais estruturou o curso em parceria com universidades norte-americanas que assumiram o compromisso de

fornecer consultoria e auxílio acadêmico.

Em novembro de 1999, os Drs. Reed Philips, presidente da Southern Californian University of Health Sciences; Jim McDonald, vice-presidente do Northwestern College of Chiropractic; David Wickes, vice-presidente do National University of Health Sciences, e o Dr. Andries Kleynhans, coordenador do corpo docente da faculdade de quiropraxia da Royal Melbourne Institute of Technology, em visita ao Brasil, traçaram linhas gerais para o curso de graduação em quiropraxia (Chapman-Smith, 2001, p. 160)

culminando na aula inaugural do curso de graduação em Quiropraxia na UAM em março de 2000.

Segundo Shapman-Smith, (2001) a UAM firmou acordo com mais uma universidade norte-americana, o Western States College of Chiropractic, sob a coordenação do Dr. Lester Lamm, diretor da área de pós-graduação, produziu junto ao corpo docente do Western States a maioria do material didático utilizado nas aulas específicas do curso de Quiropraxia da UAM.

No relatório final de pós-doutorado sob o tema *Avaliação do Programa de Quiropraxia como um Sistema Dinâmico*, Martins (2024, tradução nossa) em referência ao vínculo da Western States Chiropractic College WSCC com a Universidade Anhembi Morumbi UAM, cita o descrito sob o título “A Conexão Brasileira”, contido na linha do tempo da história da instituição no ano de 2000:

No início de 2000, a WSCC foi contatada por um quiropraxista brasileiro interessado em iniciar um programa de quiropraxia em São Paulo. Eduardo Bracher, DC, MD, queria que a WSCC formasse uma parceria nesta empreitada. Representantes da faculdade voaram até o Brasil para se encontrar com o Dr. Bracher e avaliar os riscos, benefícios e desafios potenciais de se afiliar a uma universidade lá. A WSCC concordou em produzir um currículo de Quiropraxia para ensino a distância para exportação à Anhembi Morumbi University (AMU), onde a equipe da AMU transliteraria o currículo para o português para instrução de quiropraxistas brasileiros. Após um acordo assinado pelos presidentes da WSCC e da AMU, o corpo docente da faculdade começou a criar materiais de aula, notas de aula e gravações de vídeo para exportação ao Brasil (Martins, 2024, p. 46, tradução nossa).

O programa de Quiropraxia da FEEVALE, estabelecido em 2000 como um dos pioneiros no Brasil, iniciou suas atividades com uma perspectiva considerada mais filosófica, derivando de um acordo de dez anos com o Palmer College of Chiropractic. Essa orientação buscava distintamente preservar a identidade da Quiropraxia, mantendo-a afastada da abordagem tradicional da Medicina (Martins, 2024, tradução nossa), ao passo que a Universidade Anhembi Morumbi “[...] tomou como principais referências três Programas Americanos considerados mais baseados em evidências, tentando estar mais próximos da Medicina” (Martins, 2024, p. 44). “Apesar de ter estudado na Palmer College, Dr. Bracher

buscou uma abordagem distinta, uma baseada em evidências” (Martins, 2024, p. 47, tradução nossa) buscando maior alinhamento com a área médica.

A parceria entre as instituições educacionais Palmer College com a Universidade FEEVALE e Western States e demais universidades norte-americanas com a UAM estruturou, desde a capacitação formal de docentes iniciada em 1998 e os dois cursos pioneiros (Fotografias 1 e 2) com colação de grau das primeiras turmas de bacharéis quiropraxistas no Brasil em 2004 (Lopes, 2004).

Fotografia 1 - Formatura do curso para capacitação de docentes FEEVALE & Palmer, 03/2000



Fonte: Acervo pessoal

Fotografia 2 - Alunos da primeira turma do bacharelado em Quiropraxia – FEEVALE 2000



Fonte: Acervo pessoal

Na Fotografia 2, parte dos primeiros alunos e professores, em frente a clínica escola da graduação em Quiropraxia no ano de 2000, exibindo banners das Universidade FEEVALE e Palmer College, com a presença do Dr. Everett Langhans (professor do Palmer College), de jaleco branco, segundo da direita para esquerda, compondo o corpo docente da FEEVALE.

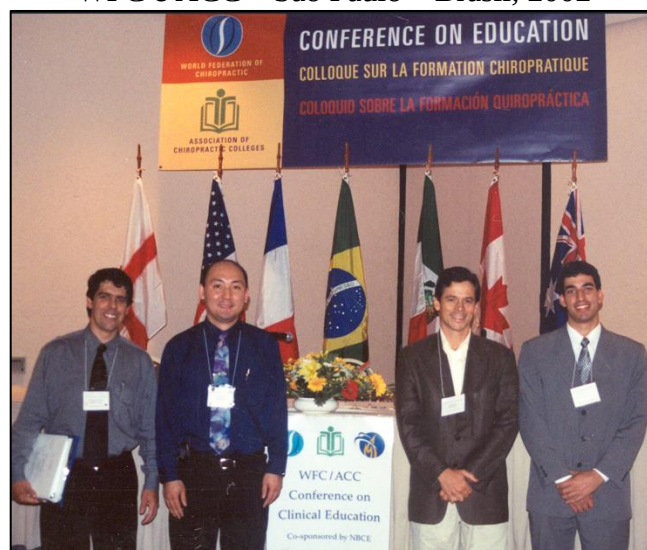
Fotografia 3 - Alunos da primeira turma do bacharelado em Quiropraxia – UAM 2000



Fonte: Acervo pessoal

Na Fotografia 3, parte dos primeiros alunos nos corredores da clínica-escola da graduação em Quiropraxia da UAM-SP.

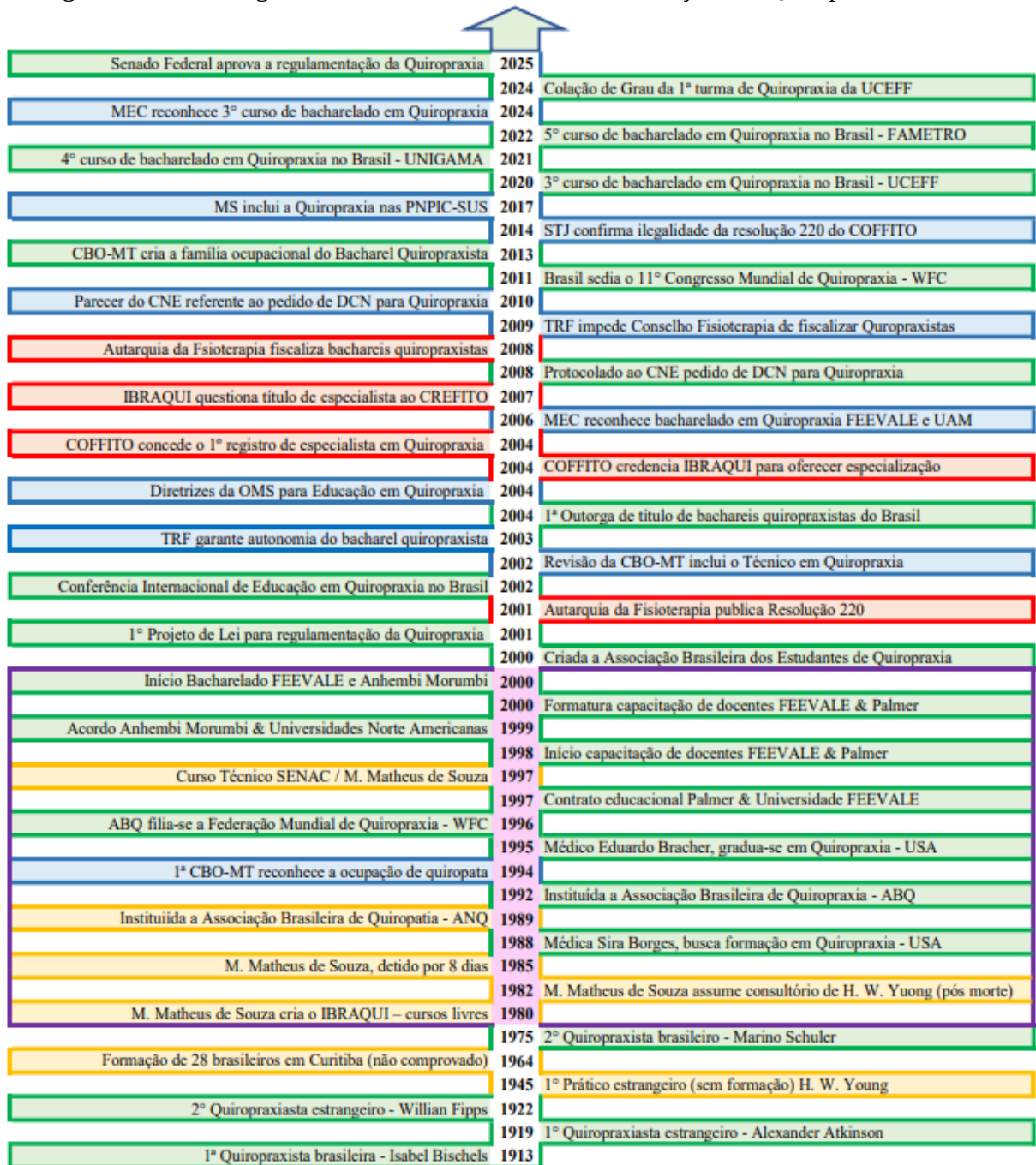
Fotografia 4 - Participação dos coordenadores e alunos da primeira turma de graduação em Quiropraxia da UAM e FEEVALE na Conferência Mundial de Educação em Quiropraxia pela WFC e ACC – São Paulo – Brasil, 2002



Fonte: Acervo pessoal

Na Fotografia 4, em 2002, da esquerda para direita, Evergisto Souto Maior (aluno da 1ª turma de graduação em Quiropraxia da FEEVALE), Dr. Ricardo Fijikawa (Coordenador da clínica escola de Quiropraxia da FEEVALE), Dr. Eduardo Bracher (Coordenador da graduação em Quiropraxia da UAM), e, Marcelo Botelho (aluno da 1ª turma de graduação em Quiropraxia da UAM), participam da Conferência Internacional de Educação em Quiropraxia, realizada em São Paulo – Brasil, organizada pela WFC e a ACC.

Figura 9 - Linha Regressa do Processo Histórico da Educação em Quiropraxia no Brasil



Fonte: Desenvolvido pelo autor

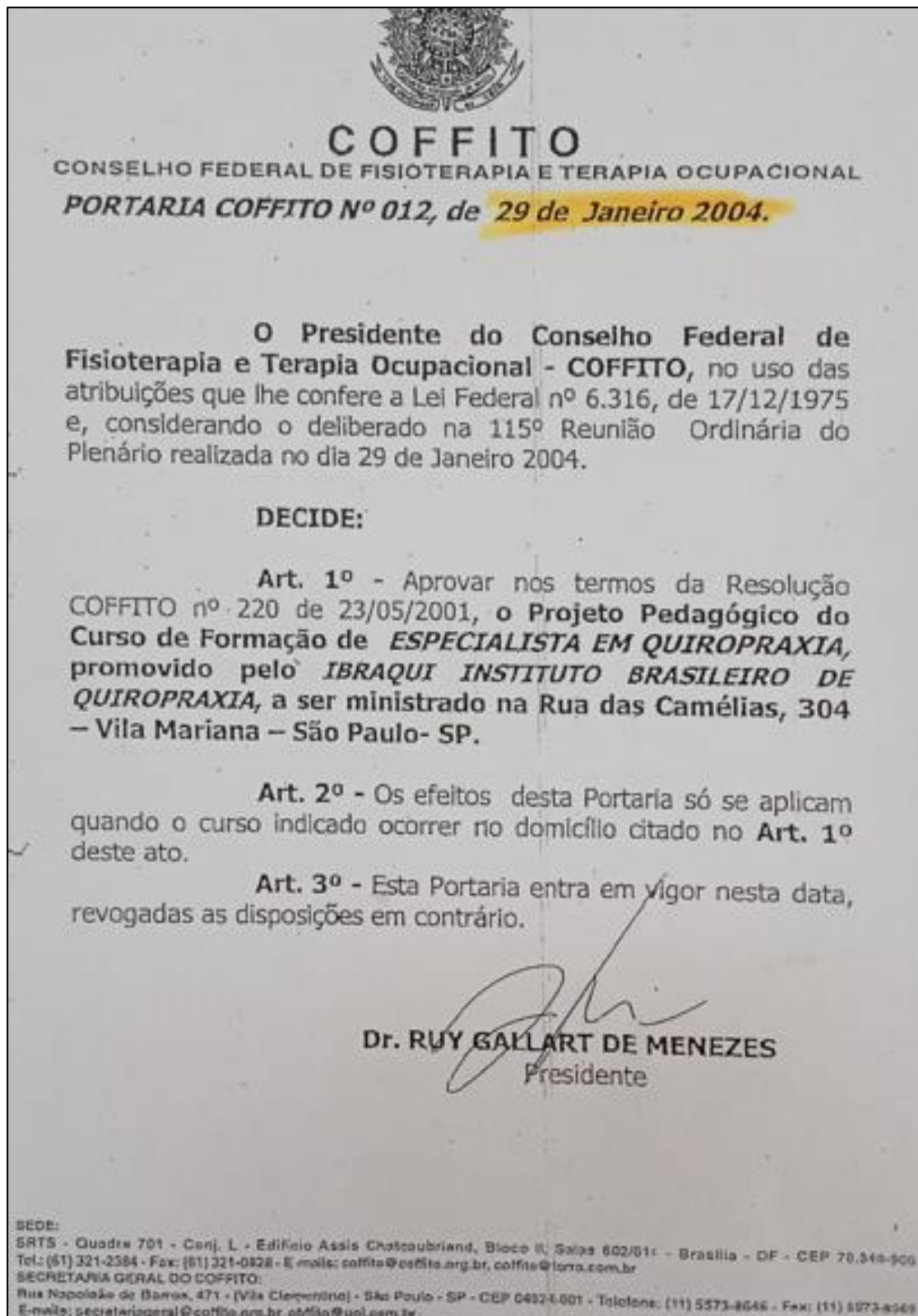
A Figura 9 representa em cores 4 contextos: A cor **verde** refere-se às situações formais em Quiropraxia conforme o consenso mundial para formação e prática na área. A cor **laranja** refere-se às dicotomias historiográficas sem comprovação da formação dos personagens citados, tão pouco dos vínculos institucionais que supostamente teriam dado origem a titulação de quiropraxistas no Brasil na década de 1960, através do qual inicia-se o paradoxo do contexto educacional por meio de cursos livres ofertados por profissionais sem formação oficial reconhecida em Quiropraxia. A cor **azul** refere-se aos dados oficiais da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça no tocante a formação e prática da Quiropraxia no Brasil. E, finalmente, a cor **vermelha** refere-se ao desdobramento do ato infralegal da Autarquia que editou uma resolução pretendendo que a quiropraxia no Brasil seja uma especialidade do profissional fisioterapeuta. Tem-se em destaque enquadrado na linha **roxa** da referida linha do tempo, o ano de 1980 com os ensaios que evoluíram para os cursos livres e o ano de 2000 com início dos cursos oficiais de bacharelado em Quiropraxia, ponto nevrálgico das raízes dos paradoxos que a historiografia nos traz luz às questões elencadas no teor desse estudo referente a educação em Quiropraxia no Brasil.

3.4 Impasse Quiropraxia X Fisioterapia brasileira

Em maio de 2001, a Autarquia da Fisioterapia brasileira, publica, em ato infralegal, uma resolução descrevendo a Quiropraxia como especialidade do fisioterapeuta (Resolução 220/2001) na qual o Artigo 2º e o respectivo parágrafo único descreve que “os certificados de conclusão de cursos de quiropraxia e/ou de osteopatia somente serão aceitos, se oriundos de instituição de reconhecida idoneidade no ensino das linhas de conhecimento referenciadas, devendo comprovar uma carga horária mínima de 1500 h (um mil e quinhentas horas), sendo 1/3 (um terço) de atividades práticas, com duração mínima de 2 (dois) anos” e “para que os títulos tenham validade perante o Sistema COFFITO/CREFITOs, as instituições concedentes deverão remeter seus projetos pedagógicos à análise e deliberação do Plenário do COFFITO” (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2001).

Em 2004, por meio da Portaria 12, de 29 de janeiro, o COFFITO formaliza o Instituto Brasileiro de Quiropraxia (IBRAQUI) como apto a ofertar o curso de especialização em Quiropraxia para fisioterapeutas nos termos da resolução 220 de maio de 2001 (Imagem 6), destacando que o referido curso de especialização deveria ocorrer no domicílio do IBRAQUI em SP (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2004).

Imagem 6 - Credenciamento do IBRAQUI para curso de especialização

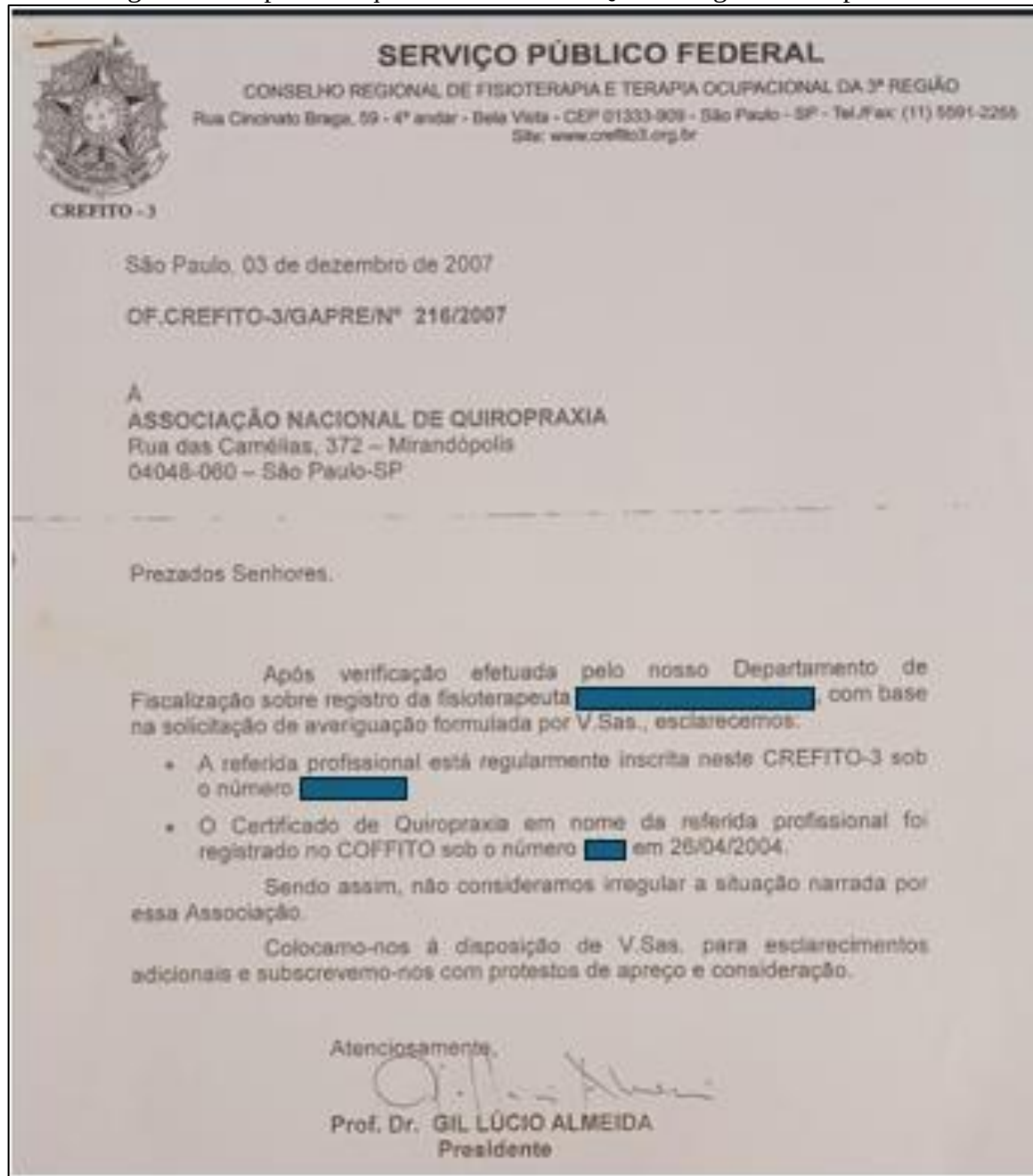


Fonte: (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2004).

A Autarquia da Fisioterapia recebe em 2006, da parte da Associação Nacional de Quiropraxia (ANQ)/IBRAQUI, a informação de que até aquela data o IBRAQUI não teria

concluído nenhum curso de especialização em Quiropraxia e por essa razão pede esclarecimento sobre registro de especialista em Quiropraxia emitido pelo COFFITO em 26 de abril de 2004. Em resposta (Imagem 7), em dezembro de 2007, a Autarquia declara não haver irregularidade no registro de especialização indicado (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região, 2007).

Imagem 7 - Resposta ao questionamento ANQ sobre registro de especialista



Fonte: (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região, 2007).

Em resposta ao Ministério Público Federal (Imagem 8), questionado sobre instituições credenciadas à autarquia da Fisioterapia para ministrar cursos de especialização em Quiropraxia e a quantidade de fisioterapeutas com título de especialistas em Quiropraxia conforme previsto na resolução 220 de maio de 2001, o COFFITO responde que até 2008, o IBRAQUI é a única entidade aprovada pela autarquia para os efeitos da resolução 220 e que até a data de 2008 existe somente uma fisioterapeuta registrada como especialista em Quiropraxia junto ao Conselho Federal de Fisioterapia. Trata-se do registro de 26 de abril de 2004 questionado pela ANQ/IBRAQUI ao Conselho Regional de Fisioterapia de São Paulo (Imagem 8).

Salutar esclarecer que a própria autarquia da Fisioterapia atesta que desde a publicação oficial da resolução 220 de 23 de maio de 2001 do COFFITO, ao colocar a Quiropraxia como especialidade da Fisioterapia e descrever as condições acadêmicas para outorgar ao fisioterapeuta o título de especialista em Quiropraxia, em Ofício de outubro de 2008 ao Ministério Público Federal, delega somente ao IBRAQUI a concessão para a oferta do curso nos moldes da resolução em apreço, e até aquela data de 2008 existia apenas uma profissional fisioterapeuta registrada como especialista em Quiropraxia. Nesse período, as universidades pioneiras no bacharelado em quiropraxia no país já haviam formado 12 turmas, totalizando cerca de 300 quiropraxistas, entre fevereiro de 2000 e dezembro de 2008, egressos dos cursos superiores oficiais reconhecidos pelo MEC e pelo consenso mundial de educação em quiropraxia.

Imagem 8 - Questionamento MP sobre registro de especialista


COFFITO
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

Ofício GAPRE nº. 310/2008

Brasília, 08 de outubro de 2008

A Sua Senhoria o Senhor
PETERSON DE PAULA PEREIRA
Procurador da República
Ministério Público Federal
Av. L2 Sul, Quadras 603/604, Lote 23
70 200-600 - Brasília - DF

Assunto: Procedimento Administrativo nº. 1.15.000.001311/2008-36

Senhor Procurador,

Pelo presente, informamos que:

- 1) respondendo ao item "b" do item 11.2 da representação em tela, a única entidade que foi aprovada pelo COFFITO para efeito no disposto na Resolução nº. 220 de 23.05.2001, se trata do IBRAQUI – Instituto Brasileiro de Quiropraxia, conforme documentação anexada (anexo 01).
- 2) respondendo ao item "c" do item 11.2 da representação em tela, a única especialista em Quiropraxia registrado neste COFFITO se trata da Dra. [REDACTED] conforme documentação anexada (anexo 02).
- 3) respondendo ao item "d" do item 11.2 da representação em tela o senhor [REDACTED] não é fisioterapeuta inscrito neste Conselho Federal.

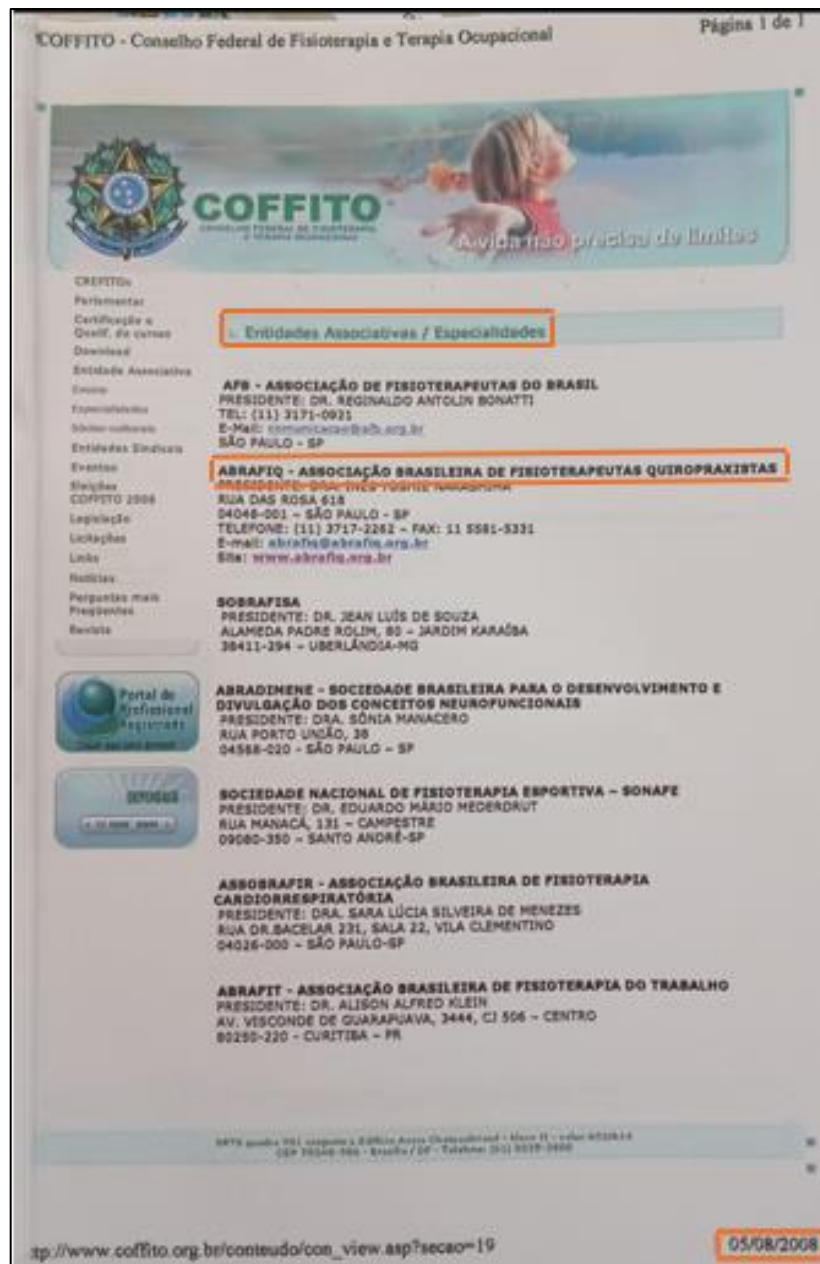
1

SRTVS - Quadra 701 - Conj. L - Edifício Assis Chateaubriand, Bloco D, Salas 502/514 - Brasília DF - CEP: 70340-906
Tel: (61) 3035-3800 - Fax: (61) 3321-0828 - e-mail: coffito@coffito.org.br

Fonte: (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2008a).

Paradoxalmente, a resposta da Autarquia da Fisioterapia ao Procurador do Ministério Público que a até a data de 08 de outubro de 2008 a única instituição credenciada ao COFFITO para cursos de especialização em Quiropraxia para fisioterapeutas conforme a resolução 220 trata-se do IBRAQUI vinculado a ANQ, no sítio eletrônico da mesma Autarquia, (Imagem 9) em 05 de agosto de 2008, a representatividade da especialidade em tela está apontada para outra entidade não vinculada ao IBRAQUI.

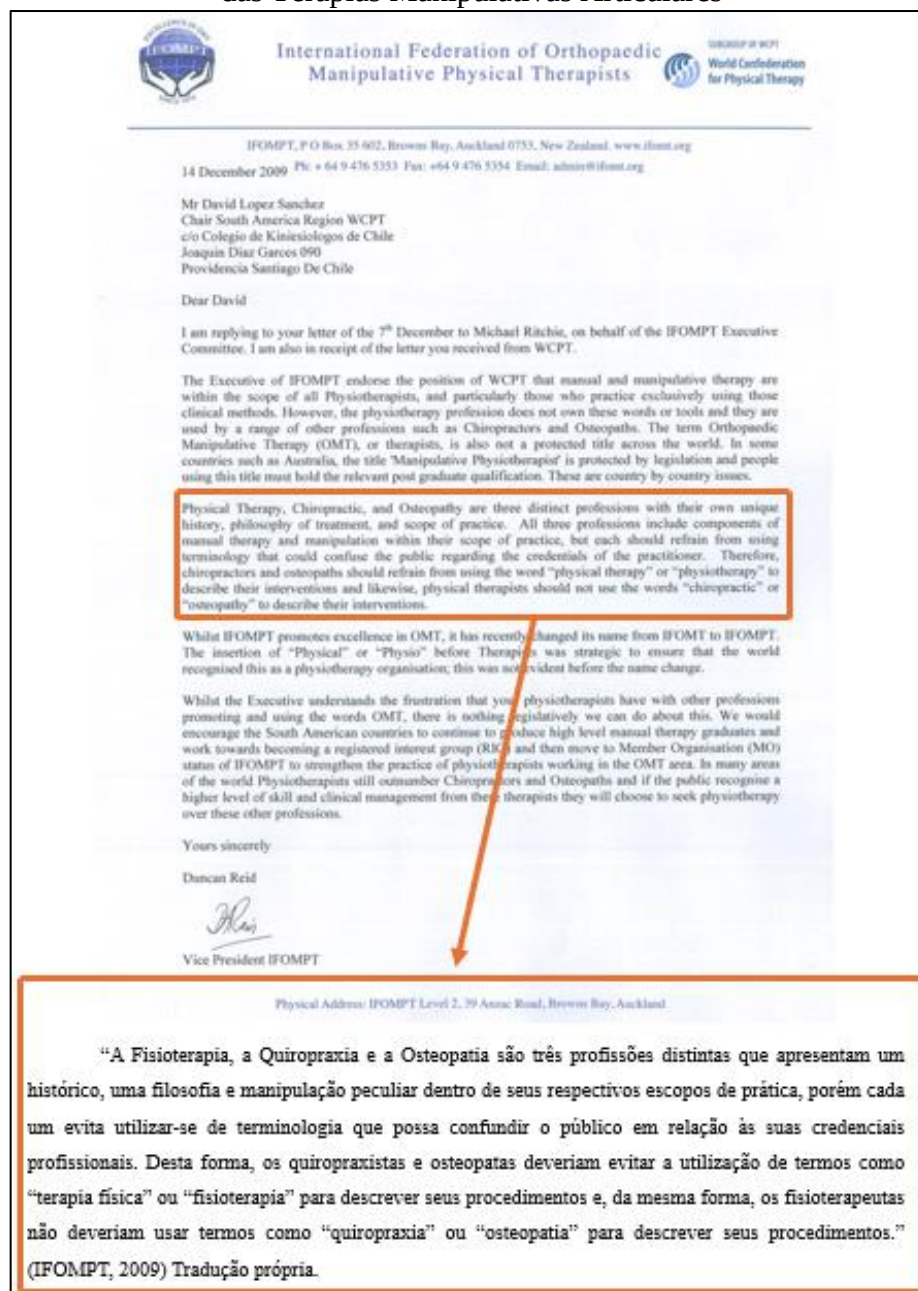
Imagem 9 - Entidade representante da especialidade da Quiropraxia para fisioterapeutas em 08/2008



Fonte: (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2008b)

A Federação Internacional de Fisioterapeutas Manipulativos Ortopédicos (IFOMPT), diretamente relacionada com as terapias manipulativas articulares aplicadas por fisioterapeutas, membro da Confederação Mundial de Fisioterapia (WCPT) (Imagem 10), atesta em dezembro de 2009 distinção entre as modalidades das terapias manipulativas articulares do universo da Fisioterapia, da Quiropraxia e da Osteopatia, e recomenda que os fisioterapeutas não utilizem termos da Quiropraxia para descrever seus procedimentos.

Imagem 10 - IFOMPT/WCPT declara distinção entre Fisioterapia e Quiropraxia na prática das Terapias Manipulativas Articulares



Fonte: (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists, 2009).

Em 2009, por força de Liminar em Mandado de Segurança contra a Autarquia da Fisioterapia ao tentar interferir na atuação do profissional bacharel quiropraxista, a resolução 220, de maio de 2001 do COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2001) foi considerada ilegal, no contexto de efeitos sobre não fisioterapeutas, amparada em 4 fundamentos constitucionais pelo “(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA, MAS – APELAÇÃO CÍVEL – 317953 – 0004375-43.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHNDOM DI SALVO, julgado em 09/10/2014, e-DJF# Judicial 1 DATA: 17/10/2014)” ao quais em síntese descrevem:

[...]

1. O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei, constitui direito individual fundamental (CF/88, art. 5º, XIII)
2. A Resolução 220/2001 do COFFITO, ao reconhecer a quiropraxia como especialidade da fisioterapia, extrapolou as competências administrativas fiscalizatórias conferidas ao COFFITO [...]
3. Na medida em que a atuação dos Conselhos Profissionais não pode ocorrer fora dos limites da lei vigente (Lei nº 6.316, de 17/12/75) não contempla como atribuição da impetrada a fiscalização dos praticantes de quiropraxia [...] que não se vinculam necessariamente a Fisioterapia – revela-se ilegal a Resolução nº 220/COFFITO.
4. Esse entendimento não salvaguarda os quiropráticos de responsabilidade por seus atos profissionais; só que essa responsabilização não se fará através da vigilância do COFFITO à conta da falta de competência administrativa para isso, como dito na r. sentença, responderão na forma das leis civis e penais (Brasil, 2014, grifo nosso).

Com a sentença, que considerou ilegal a resolução 220/2001 do COFFITO, no contexto fiscalizatório a não fisioterapeutas, iniciada por Mandado de Segurança Liminar em fevereiro de 2009 e reiterada em sequência provocada por diversos recursos nas instâncias superiores ao fim comprovada em outubro 2014 seguida da anuência do STJ, durante esse percurso, em agosto de 2011, a Autarquia da Fisioterapia publicou nova Resolução, (Resolução 399/2011) disciplinando a Especialidade Profissional de Fisioterapia em Quiropraxia como descrito no “Artigo 1º Disciplinar a atividade do Fisioterapeuta no exercício da Especialidade Profissional em Quiropraxia. Artigo 2º Para efeito de registro, o título concedido ao profissional Fisioterapeuta será de Especialista Profissional em Quiropraxia” (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2011).

De igual forma, em 2012, foi impetrada ação judicial na tentativa de anular a nova Resolução 399 da Autarquia da Fisioterapia referente à Quiropraxia como especialidade do fisioterapeuta, bem como as provas de títulos promovidas pelo COFFITO para concessão de tais títulos, por meio da qual, o Juiz Federal Substituto da 3ª Vara Federal/SJDF, julga

[...] PROCEDENTE O PEDIDO, em parte, para anular a Resolução COFFITO nº 399/2011, ante a sua ilegalidade, com efeitos a partir da publicação desta sentença, devendo o réu se abster de pronunciar ou emitir pareceres sobre a quiropraxia e o exercício da profissão dos quiropraxistas, bem como de oferecer titulações ou especializações referente à quiropraxia dentro da fisioterapia, a partir desta data (Brasil, 2021).

As duas Resoluções anteriormente aludidas, e, os cursos livres propalados anteriormente e igualmente vigentes até a presente data desse estudo, nos vêm como referência as diversas outras dicotomias na mesma lide, em que por força de lei, segundo reza o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer” (Brasil, [2024a], art. 5º, XIII). Tal ordenamento assegura que, em não havendo regramento legal que defina por meio de diretriz específica parâmetros mínimos necessários à formação e prática segura ao exercício da profissão, no Brasil, a formação e a prática da Quiropraxia configuram-se como livres e sem controle.

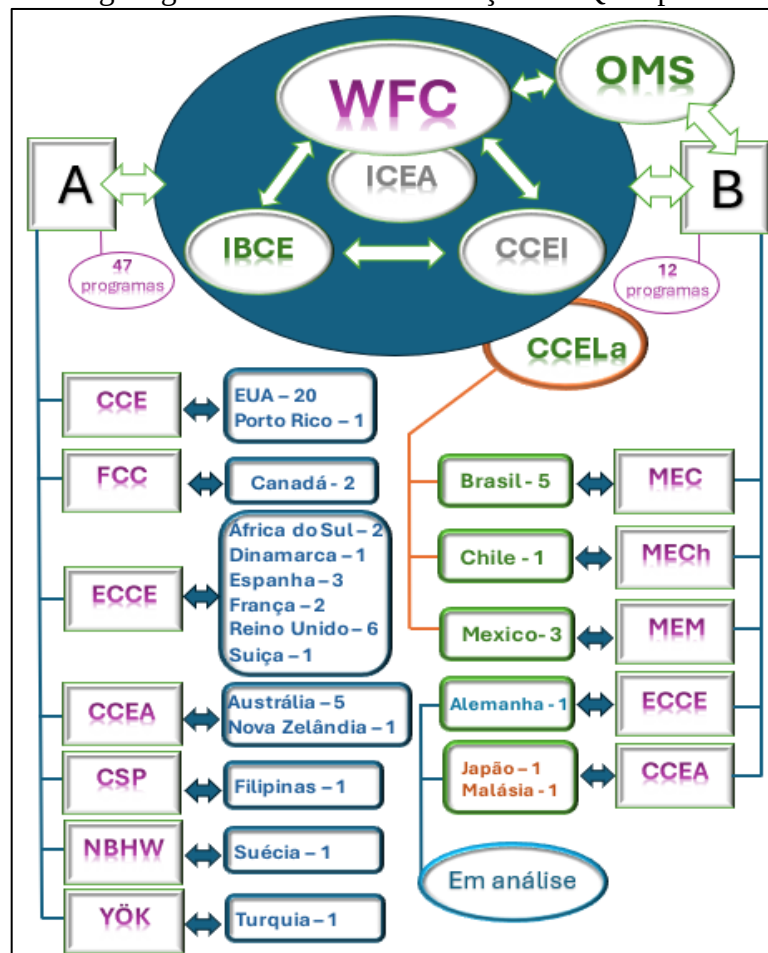
4 REGULAMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO EM QUIROPRAXIA

Cada região do mundo desenvolveu abordagens próprias para a educação em Quiropraxia, adaptando-se às necessidades locais e aos requisitos regulatórios. Por exemplo, na América do Norte, os programas exigem um mínimo de 4.200 horas de curso, enquanto outras regiões possuem critérios específicos baseados em regulamentações específicas (World Federation of Chiropractic, 2022).

4.1 Organograma do consenso mundial da formação e prática da Quiropraxia

O status da educação em Quiropraxia no mundo inicia-se pela Federação Mundial de Quiropraxia (WFC) que abriga as entidades representativas da profissão dos 99 países onde é praticada, dos quais 20 países possuem cursos oficiais para formação em quiropraxia por meio de 59 instituições (World Federation of Chiropractic, 2022).

Figura 10 - Organograma do status da educação em Quiropraxia no mundo



Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de (World Federation of Chiropractic, 2022).

Dos 59 programas de educação em Quiropraxia no mundo, 47 cursos estão delineados em cascata (Figura 10) a partir da letra [A]. Esses cursos são amparados por lei específica para formação e prática do ofício subordinados a órgãos oficiais de acreditação e controle coligados ao Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia (CCEI) e ao órgão de examinação da habilidade e competência profissional por meio do International Board of Chiropractic Examiners (IBCE).

Os outros 12 programas de educação, delineados em cascata (Figura 10) a partir da letra [B], possuem estrutura educacional reconhecida pela legislação local, contudo, não há lei específica que regule a formação e prática da Quiropraxia no país. Tal lacuna permite que a formação em Quiropraxia seja ofertada e a sua prática seja desenvolvida sem controle rigoroso. Ainda na categoria [B] junto aos 12 cursos listados, 3 destes estão em análise de acreditação para subir para a categoria [A] por meio dos Conselhos de Educação em Quiropraxia Europeu e da Austrália.

A WFC foi instituída oficialmente em 1988 e desde 1997, mantém relações oficiais com a Organização Mundial da Saúde, representando a profissão de Quiropraxia. Um produto dessa relação, detalhado no item 3.2, é o primeiro documento político da OMS sobre Quiropraxia, *Diretrizes da OMS para Formação Básica e Segurança em Quiropraxia*, publicado em 2005, disponível em vários idiomas, para dar suporte aos países onde a formação e a prática da quiropraxia ainda não estejam regulamentadas por lei, como percebido na categoria [B] da Figura 10.

A WFC estruturou a Aliança Internacional de Educação em Quiropraxia (ICEA) com o objetivo de agregar às organizações nacionais e internacionais que representam todos os aspectos da profissão – conselhos de educação, credenciamento, pesquisa, exame e licenciamento, e áreas de prática especializadas da profissão (World Federation Of Chiropractic, 2024b).

O Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia - Councils On Chiropractic Education International (CCEI) agrega as agências regionais de acreditação de Quiropraxia como o Council on Chiropractic Education (CCE) - Conselho de Educação em Quiropraxia dos Estados Unidos que é reconhecido pelo Bureau of Education dos EUA desde 1974 (Johnson *et al.*, 2022).

Sob o CCEI, além do CCE (EUA), configuram-se o FCC (Canadá), ECCE (Europa), CCEA (Austrália), CSP (Filipinas), NBHW (Suécia) e YÖK (Turquia).

Na América Latina, existem 9 programas oficiais de educação em Quiropraxia reconhecidos pela WFC dentro da categoria [B]: 3 programas no México que são reconhecidos

pelo Ministério da Educação do México (MEM); 1 no Chile, também reconhecido pelo Ministério da Educação do Chile (MECh); e, 3 no Brasil, cujos cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC) amparados na LDB de 1996 como curso Inovador e Experimental desde 1998. Reitera-se que a quiropraxia brasileira, até a presente data do desenvolvimento desse estudo, não se ancora em Diretrizes Nacionais Curriculares (DCN) que apontem as exigências acadêmicas necessárias para a formação e a prática segura em Quiropraxia como recomendado nas Diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde, 2005). Na ausência de DCN para a quiropraxia, entende-se que as diretrizes da OMS servem de referência para formulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos nos países onde a profissão ainda não é regulamentada por lei específica.

4.2 OMS – Diretrizes Para Formação Básica e Segurança em Quiropraxia

Na compreensão de que a Quiropraxia “[...] reside principalmente no fato de que ela oferece potencial para uma abordagem custo-eficaz de distúrbios musculoesqueléticos”. Vê a necessidade “[...] de desenvolver diretrizes para a Quiropraxia referente à formação educacional e segurança no exercício, incluindo informações a respeito das contraindicações para tal serviço”. Diante de tal necessidade, a parceria entre a OMS e o WFC, em dezembro de 2004, “[...] junto a 160 revisores, incluindo especialistas e autoridades nacionais, profissionais e organizações não governamentais em mais de 54 países [...]” em reunião de consulta em Quiropraxia da OMS, ocorrida em Milão, Itália foram criadas as *Diretrizes da OMS sobre Formação Básica e Segurança em Quiropraxia* traduzida em diversos idiomas (Imagem 11) (Organização Mundial da Saúde, 2005, p. I-II).

Ao prefaciar a versão em português das *Diretrizes sobre Formação Básica e Segurança em Quiropraxia* (Organização Mundial da Saúde, 2005) o, à época, presidente da WFC, Gerard Clum, descreve que:

Na medida em que a profissão de Quiropraxia se torna cada vez mais estabelecida internacionalmente, como tem ocorrido nestas duas últimas décadas, e com melhores evidências clínicas de pesquisa que apoiam a segurança e a eficiência do tratamento quiroprático, a exploração comercial da educação em Quiropraxia e sua prática clínica feita por profissionais não qualificados tem se tornado um problema difícil, tanto para o público, como para as autoridades (Organização Mundial da Saúde, 2005, p. III, grifo nosso).

Com objetivo de “[...] facilitar o exercício seguro e qualificado da Quiropraxia, bem como a proteção do paciente e do público [...]” (Organização Mundial da Saúde, 2005, p. 2), o

documento é apresentado por 38 páginas subdividas em duas partes: A primeira parte do documento é direcionado para “formação básica em Quiropraxia” desenvolvida entre as páginas 5 e 16 e a segunda parte, entre as páginas 17 e 24 focaliza as “diretrizes sobre segurança em Quiropraxia”.

As “Diretrizes sobre Formação Básica e Segurança em Quiropraxia” apresentam também na forma de anexos exemplos de modelos curriculares reconhecidos e modelo de programas de conversão direcionados a 3 categorias de profissionais que atuam como quiropraxistas sem ter passado por formação exclusiva na área por curso reconhecido.

O detalhamento dos tópicos contemplados nas “Diretrizes sobre Formação Básica e Segurança em Quiropraxia” em interface com a temática da formação e prática da Quiropraxia no Brasil é o escopo do desenvolvimento dessa pesquisa.

Imagem 11 - Diretrizes da OMS para Quiropraxia em vários idiomas



Fonte: (World Federation of Chiropractic, [2008?])

4.3 Órgãos de acreditação e controle da formação e prática no mundo

A longevidade de algumas instituições pioneiras, como o Palmer College of Chiropractic (fundado em 1897), a National University of Health Sciences (1906) e o Texas Chiropractic College (1908), segundo Johnson *et al.*, (2022) demonstra que a resiliência e a capacidade de adaptação da profissão ao longo do tempo somada à colaboração internacional e à inovação pedagógica, têm favorecido para a consolidação da Quiropraxia como uma profissão globalmente reconhecida (Quadro 7), atualmente presente em 99 países, subdivididos em 4 categorias distintas quanto à legalidade da formação e da prática da Quiropraxia.

Quadro 7 – Status da Prática da Quiropraxia mundialmente em 2025

99 Países - 7 Regiões - 4 Categorias de Legalidade				
Regiões	50 Países		37 Países	9 Países
	Regulamentação Plena		Reconhecida e Permitida	Reconhecida e sem controle
	Categoria - A		Categoria - B	Categoria - C
	Formação e prática profissional regulamentada por lei específica.		Formação reconhecida de acordo com a lei geral, prática sem regulamentação específica.	Formação e prática sem regra jurídica clara.
				Categoria - D
				Formação e prática sem regra jurídica, sob risco de processo judicial.
África	7 A; 5 B; 1 C	13	1 Etiópia 2 Gana 3 Quênia 4 Maurício 5 Zâmbia	1 Uganda
Ásia	3 A; 3 B 3 C; 3 D	12	6 Japão 7 Malásia 8 Singapura	1 China 2 Índia 3 Vietnã
Mediterrâneo Oriental	8 A; 4 B; 2 C	14	9 Egito 10 Jordânia 11 Líbano 12 Líbia	5 Marrocos 6 Síria
Europa	13 A; 9 B; 3 C; 1 D	26	13 Bélgica 14 Croácia 15 Estônia 16 Alemanha 17 Irlanda 18 Luxemburgo 19 Holanda 20 Federação Russa 21 Eslováquia	7 Áustria 8 Grécia 9 Hungria
América Latina	5 A; 8 B	13	22 Argentina 23 Brasil 24 Chile 25 Colômbia 26 Equador 27 Honduras 28 Peru 29 Venezuela	
América do Norte	8 A; 6 B	16	30 Bahamas 31 Barbados 32 Canadá 33 Ilhas Cayman 34 Ilhas de Sotavento 35 Porto Rico 36 Ilhas Turcas e Caicos 37 Estados Unidos	10 Belize 11 Bermudas 12 Ilhas Virgens Britânicas 13 Ilhas Virgens dos EUA 14 Jamaica 15 Trinidad e Tobago
Pacífico	5 A; 2 B	7	38 Fiji 39 Papua Nova Guiné	

Fonte: Desenvolvido pelo autor

As categorizações apresentadas no Quadro 7, representam como a prática da quiropraxia é mundialmente estabelecida nos 99 países onde está presente:

- Categoria (A) - Regulamentação Plena, 50 países (Formação e prática profissional regulamentada por lei específica);
- Categoria (B) - Reconhecida e Permitida, 37 países (Formação reconhecida de acordo

com a lei geral, prática sem regulamentação específica);

- c) Categoria (C) - Reconhecida e Sem Controle, 9 países (Formação e prática sem regra jurídica clara); e,
- d) Categoria (D) - Sem Amparo Legal, 3 países (Formação e prática sem regra jurídica, sob risco de processo judicial).

Segundo Chapman-Smith (2001) na América do Norte e em outras regiões onde a profissão de quiropraxista é regulamentada por lei, o quiropraxista graduado deve ser aprovado nos exames das comissões nacionais de habilitações e comissões dos Estados/Províncias, antes de receber permissão para praticar,

[...] antes de 1965, os quiropraxistas da maioria dos Estados dos EUA passavam pelos mesmos exames de ciências básicas das bancas examinadoras por que passavam os médicos. Desde aquela época, os exames quiropraxistas se separaram, enquanto permanecem num padrão equivalente ao da medicina (Chapman-Smith, 2001, p. 53).

Internacionalmente, em 2001, as organizações educacionais em Quiropraxia estruturavam-se, a partir do Conselho de Educação em Quiropraxia (CCE), do Conselho de Educação em Quiropraxia do Canadá (CCE Canadá) e da Associação das Faculdades de Quiropraxia (ACC) e a licença para atuação profissional estrutura-se inicialmente pela Federação dos Conselhos de Habilitação Profissional em Quiropraxia (FCLB), do Conselho Nacional dos Examinadores em Quiropraxia (NBCE), da Federação Canadense de Conselhos Reguladores (CFCRB) e do Conselho Canadense de Exames em Quiropraxia (CCEB) (Chapman-Smith, 2001).

Segundo Peterson *et al.* (2022, tradução nossa), no artigo “*Projeto de mapeamento internacional dos Conselhos de Educação Quiroprática: comparação dos padrões educacionais das organizações membros com o documento-quadro internacional dos Conselhos de Educação Quiroprática*”, como demonstrado na (Figura 9) do organograma da educação em Quiropraxia no mundo, em 2001 foi estabelecido o Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia (CCEI) pelas agências regionais e internacionais de acreditação quiroprática. Naquela época, o Conselho de Educação em Quiropraxia da Australásia (CCEA), o Conselho de Educação em Quiropraxia do Canadá (CCEC), o Conselho de Educação em Quiropraxia dos Estados Unidos da América (CCEUS) e o Conselho Europeu de Educação em Quiropraxia (ECCE). Essas agências membros combinaram seus esforços para colaborar, garantir a excelência e orientar a melhoria consistente da qualidade na educação em Quiropraxia por meio da acreditação. Os autores atestam que:

O CCEI reconhece a necessidade de padrões internacionalmente aceitos para a educação e os sistemas educacionais em quiropraxia, como parte de culturas diversas e inovadoras de jurisdições geográficas. O processo de acreditação deve respeitar a autonomia do programa educacional, a legislação e os regulamentos nacionais (Peterson *et al.*, 2022, tradução nossa).

4.4 Conselhos Regionais: o caso do CCE-LA

A Federação Latino-Americana de Quiropraxia (FLAQ), por meio do Conselho de Educação em Quiropraxia da América Latina (CCE-LA), apresenta os *Standards of Accreditation CCE-LA* (Federación Latinoamericana de Quiropráctica, 2024) como bases para estrutura educacional em Quiropraxia na América Latina dentro do consenso internacional de educação na área.

Esse documento representa um conjunto de critérios que um programa ou instituição de Quiropraxia deve atender para obter a sua acreditação. O texto detalha a organização legal e a missão do programa do curso, que deve focalizar diversos aspectos da educação de clínicos de cuidados primários, pesquisa e serviço comunitário. O documento aborda a estrutura de governança e administrativa, a alocação de recursos financeiros e humanos qualificados, a infraestrutura física e tecnológica necessária, e políticas institucionais abrangentes como liberdade acadêmica e não discriminação, bem como os padrões da gestão estudantil, desde a admissão e o apoio (incluindo recursos de aprendizagem e saúde mental) até a avaliação do desempenho, e os critérios para garantir a segurança pública e a qualidade do cuidado clínico oferecido pelos estagiários sob supervisão.

Ao seguir ou adaptar esses padrões, seria possível estabelecer e manter programas de educação em Quiropraxia no Brasil que atendam a critérios internacionais de qualidade, garantindo a formação de profissionais competentes e a segurança dos pacientes, alinhando-se com as expectativas para uma educação terciária em uma disciplina baseada em ciências.

4.5 Cursos ativos de Quiropraxia no Brasil

O Quadro 8 apresenta os cursos ativos de graduação em Quiropraxia ofertados no Brasil que são reconhecidos pela WFC e atendem às prerrogativas do MEC e às *Diretrizes da OMS sobre Formação Básica e Segurança em Quiropraxia* (Organização Mundial da Saúde, 2005).

Quadro 8 - Primeiros Cursos Oficiais de Graduação em Quiropraxia no Brasil

	Instituição	Ato Regulatório no MEC	Status
1º	Universidade FEEVALE - FEEVALE - RS	Ato regulatório em 29/09/1999, início em 21/02/2000, reconhecimento MEC em 14/06/2007, conceito MEC 2018: 5/5.	***
2º	Universidade Anhembi Morumbi - UAM - SP	Início em 28/02/2000, conceito MEC 2018: 5/5, aumento de vagas em 16/12/2020.	***
3º	Centro Universitário FAI - UCEFF - SC	Ato regulatório em 01/02/2021, conceito MEC 2024: 4/5.	**
4º	Centro Universitário Gama e Souza - UNIGAMA - RJ	Ato regulatório em 07/02/2022, ainda não avaliado para reconhecimento do MEC	*
5º	Centro Universitário CEUNI - FAMETRO - AM	Ato regulatório em 11/12/2023, ainda não avaliado para reconhecimento do MEC.	*

Fonte: Desenvolvido pelo autor, consulta portal MEC (Brasil, 2025a)

A indicação dos asteriscos do Quadro 8 segue o seguinte parâmetro:

- (***) indica pioneirismo do curso iniciado em 2000 com sucessivas renovações de reconhecimento pelo MEC e mantém a colação do grau de bacharel em quiropraxia regular desde 2004;
- (**) indica ter iniciado após 2020, que o curso possui reconhecimento do MEC com a primeira colação do grau de bacharel em Quiropraxia em 2024;
- (*) indica ter iniciado após 2020, que o curso ainda não foi avaliado pelo MEC e ainda não tem turmas com formação concluída.

5 REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM QUIROPRAXIA

Conforme descrito na justificativa dessa pesquisa, a OMS esclarece que a educação em Quiropraxia requer critérios técnicos elaborados em padrões determinados para formação de profissionais que desenvolvam habilidades e competências mínimas necessárias à prática segura na saúde pública (Organização Mundial da Saúde, 2025).

O Artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federativa Brasileira (Brasil, [2024a]) estabelece que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, esse inciso ressalta que a lei pode prover regulamentações que definam requisitos para a formação e o exercício de determinadas profissões, principalmente na área da saúde como recomendado pela OMS em relação a Quiropraxia. Ao assegurar que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado” (Brasil, [2024a], art. 196), a Constituição corrobora a necessidade de regulamentar a profissão de quiropraxista no Brasil.

Por outro lado, a não existência de lei específica para formação e prática em determinado ofício na área da saúde, abre espaço ao seu livre exercício, que no caso em tela, fragiliza a identidade da profissão, bem como a legalidade, a legitimidade da formação acadêmica em paradoxo com a LDB (Brasil, [2024b]) e, sobretudo, a orientação da OMS para prática segura da profissão.

Diante do explícito direito aqui pautado, a partir da estruturação dos cursos de graduação em Quiropraxia por meio das pioneiras UAM e FEEVALE no ano de 2000, surge o movimento pela regulamentação da profissão de quiropraxista no Brasil por meio do regramento legal junto ao poder legislativo brasileiro, iniciado em março de 2001 com o Projeto de Lei (PL) 4199-2001 (Lopes, 2004).

5.1 Surgimento do impasse da regulamentação por Lei no Brasil

Ao iniciar a tramitação do PL 4199/2001 em março de 2001 prevendo a regulamentação da Quiropraxia no Brasil conforme o modelo praticado mundialmente em cerca de 50 países como descrito no Quadro 7 – “Status da Prática da Quiropraxia mundialmente em 2025”, em maio do mesmo ano, a Autarquia da Fisioterapia publica, em Ato Infralegal a Resolução 220 de 23 de maio de 2001, conforme apresentado no item 3.4 (Impasse Quiropraxia x Fisioterapia brasileira), alegando ser a Quiropraxia uma especialidade do fisioterapeuta. Inicia-se então franco embate no contexto político/corporativista contra a estruturação da Quiropraxia segundo

o modelo mundial da profissão.

No levantamento da relação dos Projetos de Lei (PL) que preveem a regulamentação da profissão de Quiropraxista no Brasil desenvolvido por Évelyn F. S. M Lopes em 2024, sob a temática *História da Quiropraxia no Brasil de 2004 a 2024, através da análise de dados públicos* (Lopes, 2024), como requisito para conclusão do bacharelado em Quiropraxia no Centro Universitário FAI – Unidade Central de Educação FAEM Faculdade (UCEFF) – SC , a autora, referindo-se à tramitação dos projetos junto ao Poder Legislativo, Câmara e Senado Federal, descreve que todo aparato legal da estruturação da Quiropraxia no país deu origem aos PL específicos da Quiropraxia sob fortes interferências políticas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional junto aos parlamentares (Lopes, 2024).

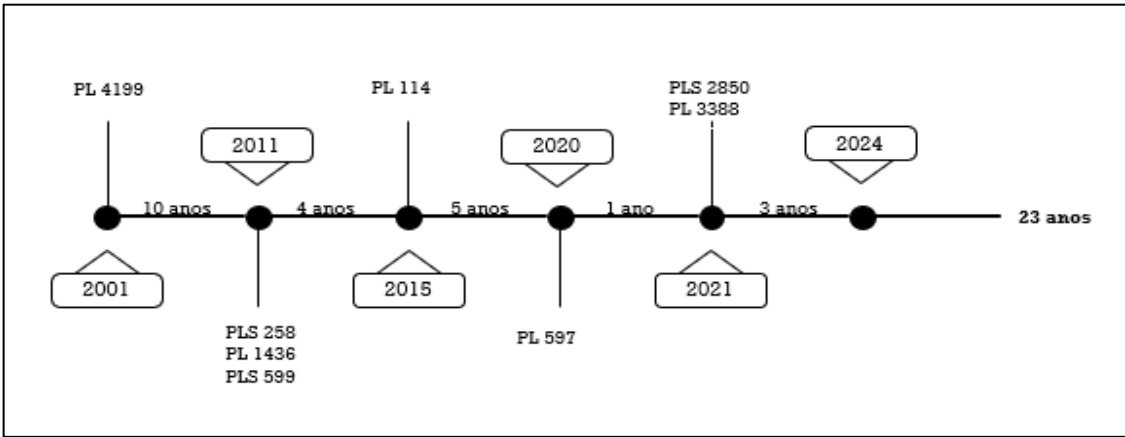
Quadro 9 - Projetos de Lei que preveem a regulamentação da Quiropraxia no Brasil

Nº do PL	Início	Status
PL 4199	08/03/2001	Arquivado em 31/01/2011 (não reeleição do autor)
PL 1436	25/05/2011	Arquivado em 31/01/2015 (não reeleição do autor)
PL 114	03/02/2015	*Em tramitação da Comissão de Educação desde 04/03/2015
PL 597	11/03/2020	Apensado ao PL 114/2015 em 13/04/2020
PL 3388	30/09/2021	Apensado ao PL 114/2015 em 11/11/2021
PLS 258	17/05/2011	Arquivado em 02/06/2011 (para evoluir texto ao 599/2011)
PLS 599	15/09/2011	Arquivado em 20/12/2018 (fim da legislatura)
PLS 2850	17/08/2021	*Aprovado no Senado em 11/25 – em revisão na Câmara dos Deputados
PL 3246	03/07/2025	Apensado ao PL 114/2015 em 28/08/2025

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir de (Brasil, 2025c, 2025d)

O Quadro 9 apresenta nove Projetos de Lei pela regulamentação da Quiropraxia, cinco em tramitação, com destaque ao PLS 2850/2021 aprovado no Senado e encaminhado para revisão na Câmara dos Deputados, e outros quatro arquivados por não reeleição do seu autor.

Figura 11 - Linha do tempo da tramitação dos PL da Quiropraxia junto ao Poder Legislativo



Fonte: Elaborado por Lopes (2024).

Com 24 anos desde o primeiro Projeto de Lei (PL) 4199/2001 (Fraga, 2001), prevendo a regulamentação da quiropraxia no Brasil por lei específica, o foco dos trabalhos políticos nesse pleito, encontra-se centrado na Comissão de Educação, sem evolução técnica às demais comissões de mérito, por influência dos *lobbies* da autarquia da fisioterapia sobre todos os cinco PL ativos apensados ao 114/2015 (Moreira, 2015) cujo teor se funde na proposta aprovada no Senado em novembro de 2025 (Imagem 13). Contudo, outras frentes de relevante impacto na estruturação da profissão no cenário brasileiro logram êxito com importantes conquistas nesse período.

Imagem 13 - Tramitação da proposta legislativa da quiropraxia aprovada no Senado

Atividade Legislativa		Secretaria-Geral da Mesa		SENADO FEDERAL	
Projeto de Lei nº 2850, de 2021					
Iniciativa: Senadora Kátia Abreu (PP/TO)					
Ementa:					
Dispõe sobre o exercício da profissão de Quiropraxista.					
Assunto:	Política Social - Trabalho e Emprego				
Data de Leitura:	17/08/2021				
Tramitação encerrada					
Decisão:	Aprovada por Comissão em decisão		Último local:	11/11/2025 - Secretaria de Expediente	
Destino:	À Câmara dos Deputados		Último estado:	14/11/2025 - REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS	

Fonte: (Abreu, 2021)

No bojo dos 24 anos de atividade política pela estruturação da profissão, mesmo sob força contrária dos *lobbies* da autarquia da fisioterapia nas demais frentes junto ao executivo e judiciário, a quiropraxia conquistou sucessivas renovações de reconhecimento dos cursos de bacharelado em Quiropraxia pelo Ministério da Educação. Conquistou a consolidação de mais três cursos superiores oficiais de bacharelado em Quiropraxia, somando cinco no total pelo país (Brasil, 2025a). A quiropraxia conquistou a inclusão da família ocupacional específica de bacharel quiropraxista na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do trabalho (CBO 2236-45) (Brasil, 2013). A incorporação da Quiropraxia junto às Políticas Nacionais das Práticas Integrativas e Complementares (PNIC) ocorreu em 2017 (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017) do Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2017). Além disso, reiteradas decisões judiciais garantiram o livre exercício da profissão de forma independente

das Autarquias de outras profissões da saúde; atualmente ultrapassando os milhares de egressos bacharéis quiropraxistas por meio dos cursos de graduação em Quiropraxia conforme o consenso mundial de educação orientado pela OMS e reconhecidos pela WFC.

Resta ainda a construção da DCN do bacharel Quiropraxista a dar o aporte conclusivo aos pressupostos legais pela regulamentação da profissão no país.

6 CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS

A análise da arquitetura normativa que sustenta o ensino superior de Quiropraxia no Brasil exige, primordialmente, o aporte teórico de Carlos Roberto Jamil Cury, cuja obra eleva a compreensão dos Conselhos de Educação para além da esfera puramente burocrática. Para Cury, o conselheiro atua como um "intelectual da legislação", investido de uma função pública delegada que visa, em última análise, garantir o direito constitucional à educação e à cidadania (Cury, 2006, p. 42). Sob essa ótica, a atuação do Conselho Nacional de Educação (CNE) assume um múnus público, um dever-poder em que a interpretação da lei deve estar em estrita harmonia com a supremacia axiológica da Constituição Federal.

Nesse contexto, a educação superior não é meramente a prestação de um serviço acadêmico, mas um instrumento de elaboração de intelectuais e profissionais qualificados para atender às demandas sociais e de saúde. O prolongamento do status de inovador e experimental para os cursos de Quiropraxia por 25 anos, sem a consolidação de uma Diretriz Curricular Nacional (DCN), configura uma omissão desse múnus público. Como assevera Cury, os atos normativos do Conselho, ao ganharem força de lei após a homologação (Cury, 2006, p. 49), devem assegurar ao cidadão a clareza e a procedência de seus direitos; no caso da Quiropraxia, a ausência da DCN impede que o Estado exerça plenamente sua prerrogativa de garantia de padrão de qualidade preconizada pelo Art. 211 da Carta Magna (Cury, 2006, p. 44).

Portanto, a construção da DCN para a Quiropraxia transcende o rito administrativo: é um ato de responsabilidade social indispensável para conferir densidade normativa a um campo profissional que lida diretamente com o bem-estar e a segurança biológica da população.

6.1 Papel das DCN nos cursos superiores

A base legal para as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) encontra-se na Constituição Federal de 1988, que estabelece a educação como um direito de todos e um dever tanto do Estado quanto da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e à sua qualificação para o trabalho (Brasil, [2024a], Art. 205). Complementar a essa legislação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, detalha a organização do sistema de ensino brasileiro e confere à União, por meio do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE), a competência para estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional (Brasil, [2024b], Art. 9º, inciso IV; 86, Art. 9º, inciso IV).

Historicamente, as DCN surgiram como uma resposta à rigidez dos currículos mínimos

fixos. O Parecer CNE/CES nº 776/97, de 03 de dezembro de 1997, foi uma referência inicial que orientou que as DCN deveriam servir como diretrizes para as instituições de ensino superior (IES) na organização de seus programas de formação, permitindo flexibilidade na construção curricular (Brasil, 1997). Posteriormente, o Parecer CNE/CES nº 583/2001, de 04 de abril de 2001, também contribuiu para a definição dos objetivos das DCN, reforçando a necessidade de flexibilidade e a adequação à realidade dos alunos (Brasil, 2001b).

A compreensão da gênese das DCN exige, o desvelamento do papel institucional do Conselho Nacional de Educação (CNE). Segundo Carlos Roberto Jamil Cury, em sua obra “Conselhos de Educação: fundamentos e funções”, um Conselho de Educação é um órgão público voltado para garantir o direito constitucional à cidadania por meio de uma função pública delegada. Esta função permite que o conselheiro interprete a legislação e a aplique em prol das finalidades maiores da educação escolar, agindo como um intelectual da legislação para garantir a qualidade do ensino (Cury, 2006).

O Parecer CNE/CES nº 146/2002, homologado em 09 de maio de 2002, detalha as DCN para diversos cursos de graduação, como Direito, Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria, Secretariado Executivo, Música, Dança, Teatro e Design (Brasil, 2002). Este parecer estabelece que as DCN, devem ser observadas pelas IES na elaboração de seus Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) e na organização curricular (Brasil, 2002, Art. 1º e Art. 2º).

Ao analisarmos a trajetória das DCN no Brasil, é imperativo recorrer à crítica de Maria Ciavatta e Marise Ramos (2012) que caracterizam o período pós-LDB/1996 como a “era das diretrizes” (Ciavatta; Ramos, 2012, p. 37), pois tais documentos se tornaram “instrumento de direção política e cultural da sociedade por intermédio da educação” (Ciavatta; Ramos, 2012, p. 61).

No caso da Quiropraxia, a permanência no limbo do experimentalismo por 25 anos sem a consolidação de uma DCN própria abre espaço para o que Ciavatta e Ramos (2012) identificam como a “lógica pragmática da prática utilitária” (Ciavatta; Ramos, 2012, p. 54). A falta de um regramento nacional robusto permite a fragmentação curricular, em que o conhecimento é reduzido a “desempenhos operacionais” (Ciavatta; Ramos, 2012, p. 51), negligenciando a base científica profunda que a profissão exige. Como alertam as autoras:

O currículo flexível é, na verdade, o currículo fragmentado que propõe um tipo de rotatividade formativa. O trabalhador flexível, por sua vez, vem a ser aquele capaz de renovar permanentemente suas competências, aproveitando diversas oportunidades, dentre as quais, a oferta desses currículos flexíveis/fragmentados” (Ciavatta; Ramos, 2012, p. 56).

A necessidade de evolução do status de Experimental para uma DCN consolidada torna-se evidente ao confrontarmos o cenário da Quiropraxia com a Resolução CNS nº 569 de 2017. Este documento estabelece que a formação em saúde deve ser pautada pela “integração ensino-serviço-gestão-comunidade” e orientada para um perfil de egresso “generalista, humanista, crítico, reflexivo, ético e transformador” (Conselho Nacional de Saúde, 2017). Enquanto a Resolução CNS nº 569/2017 defende que a saúde é um “direito de todos e dever do Estado” (Conselho Nacional de Saúde, 2017), a inexistência de DCN específicas para a Quiropraxia impede que o Estado exerça plenamente sua prerrogativa de ordenar a formação de recursos humanos. O modelo “Inovador e Experimental”, facultado pelo Art. 81 da LDB, viabilizou os cursos pioneiros em 2000. Contudo, como aponta o Parecer CNE/CES nº 120/2010 (Brasil, 2010), a regulação não pode ser eterna refém da inexistência de diretrizes, pois isso fragiliza a identidade da profissão e abre lacunas para cursos de curta duração sem rigor acadêmico (Brasil, 2010).

A ausência desse balizamento fere o princípio da “unidade dialética entre teoria e prática” (Ciavatta; Ramos, 2012, p. 55), pois sem DCN, a prática deixa de ser organizadora do currículo para tornar-se mera técnica adaptativa. Como conclui Cury (2006), o Conselho deve “zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem” (Cury, 2006, p. 54). Para o autor, citando Gramsci, “a escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis” (Cury, 2006, p. 65), e a Quiropraxia deve finalmente alcançar sua maioria normativa para garantir a segurança da sociedade e a integridade da formação acadêmica.

A construção de uma DCN para a quiropraxia não é apenas um trâmite administrativo, mas um ato que busca traduzir a supremacia axiológica da Constituição em normas capazes de disciplinar um campo profissional específico. Sob esta ótica, o CNE atua no hiato deixado pelo legislador, exercendo uma adequação prudente para contextualizar fenômenos educativos ainda não regulamentados integralmente por lei. Portanto, a DCN para a quiropraxia configura-se como um ato de múnus público indispensável para a segurança jurídica e social da profissão.

Segundo Lopes (2004), o amparo estético com embasamento legal para o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) dos primeiros cursos superiores de Quiropraxia no Brasil se deu por meio de modelos pré-existentes em Instituições Internacionais que seguem o consenso mundial de educação em Quiropraxia e as *Diretrizes da Organização Mundial da Saúde para Formação Básica e Segurança em Quiropraxia* (Organização Mundial da Saúde, 2005).

A Imagem 14 descreve a oferta oficial no portal E-MEC dos dois cursos pioneiros da FEEVALE e da UAM.

Imagem 14 - Atos regulatórios do bacharelado em Quiropraxia Universidades FEEVALE e UAM

Instituição de Educação Superior
Endereço
Curso

DETALHES
ATO REGULATÓRIO
PROCESSOS E-MEC
OCORRÊNCIAS

DETALHES DA IES

(Código) Nome da IES:
(23) UNIVERSIDADE FEEVALE - FEEVALE
Situação: Ativa

DETALHES DO CURSO

(Código) Grau:
(39749) Bacharelado em QUIROPRAXIA
Modalidade:
Educação Presencial

ATO REGULATÓRIO

Ato Regulatório	Tipo de documento	Nº do documento	Data do documento	Data de publicação	Prazo de validade	Arquivo para download
Renovação de Reconhecimento de Curso	Portaria	823	22/11/2018	26/11/2018	Vinculado ao Ciclo Avaliativo	
Renovação de Reconhecimento de Curso	Portaria	156 de 04/04/2013	04/04/2013	05/04/2013	Vinculado ao Ciclo Avaliativo	
Reconhecimento de Curso	Portaria	521 de 11/06/2007*	-	14/06/2007	Vinculado ao Ciclo Avaliativo	Não Anexado
Autorização	Portaria	020 de 29/09/1999	-	29/09/1999	Art. 35 Decreto 5.773/06 (Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07)	Não Anexado

Instituição de Educação Superior
Endereço
Curso

(466) UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAM
Em supervisão - Procedimento Sancionador sem Medida Cautelar: Portaria nº 288, de 08/08/2023- DOU 09/08/2023, art. 1º. Portaria nº 193, de 21/05/2024- DOU 22/05/2024, art. 1º.
Situação: Ativa

DETALHES DO CURSO

(Código) Grau:
(21620) Bacharelado em QUIROPRAXIA
Modalidade:
Educação Presencial

ATO REGULATÓRIO

Ato Regulatório	Tipo de documento	Nº do documento	Data do documento	Data de publicação	Prazo de validade	Arquivo para download
Aumento de Vagas	Resolução	135	16/12/2020	16/12/2020	Vinculado ao Ciclo Avaliativo	
Renovação de Reconhecimento de Curso	Portaria	822	22/11/2018	26/11/2018	Vinculado ao Ciclo Avaliativo	
Renovação de Reconhecimento de Curso	Portaria	198 de 13/05/2013	13/05/2013	14/05/2013	Vinculado ao Ciclo Avaliativo	
Reconhecimento de Curso	Portaria	903 de 10/04/2006**	-	12/04/2006	Vinculado ao Ciclo Avaliativo	Não Anexado
Autorização	Resolução	07 de 14/12/1999	-	14/12/1999	Art. 35 Decreto 5.773/06 (Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07)	Não Anexado

Fonte: Portal E-MEC (Brasil, 2025a)

O bacharelado na Universidade Feevale RS com início em 21/02/2000, o qual se encontra ativo em 2025, com nota 5. O curso foi reconhecido pela Portaria nº 521 de 11/06/2007 – DOU de 14/06/2007, com subsequentes renovações de reconhecimento pelas Portarias nº 156 de 04/04/2013 – DOU de 05/04/2013 e nº 822 de 22/11/2018 – DOU de 22/11/2018.

A oferta do bacharelado na Universidade UAM SP teve início em 28/02/2000, o qual se encontra ativo em 2025, com nota 5. O curso foi reconhecido pela Portaria nº 903 de 10/04/2006 – DOU de 12/04/2006, com subsequentes renovações de reconhecimento pelas Portarias nº 198 de 13/05/2013 – DOU de 14/05/2013, DOU de 05/04/2013 e DOU de 26/11/2018 (Brasil, 2025a).

6.2 DCN na área da Saúde

Dentro do arcabouço legal para a educação brasileira, incluindo o ensino superior, as DCN constituem os pressupostos para a organização dos cursos de graduação, inclusive e especialmente na área da saúde (Brasil, [2024b]). Nesse entendimento, o Conselho Nacional da Saúde (CNS) por meio da Resolução CNS nº 569, de 8 de dezembro de 2017, estabelece os princípios gerais “[...] a serem incorporados nas DCN de todos os cursos de graduação da área da saúde, como elementos norteadores para o desenvolvimento dos currículos e das atividades didático-pedagógicas, e que deverão compor o perfil dos egressos desses cursos” de graduação da área da saúde, ancorados no direito à saúde, garantido pela Constituição Federal de 1988, e na organização do Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de delinear os critérios mínimos para a formação de profissionais para atuar de forma integral e interprofissional no âmbito do SUS e dos demais cenários de prática, com perfil amplo, crítico e socialmente responsável (Conselho Nacional da Saúde, 2018, Art. 2º).

As DCN para os cursos da área da saúde se inserem no sistema de regulamentação do ensino superior brasileiro, sob a égide da LDB e a deliberação do CNE, a partir de propostas do MEC, fornecendo diretrizes gerais e objetivos de aprendizagem aos cursos de graduação que devem seguir, respeitando a autonomia institucional para fixar seus currículos (Brasil, [2024b]).

Historicamente, a Resolução CNS nº 569, de 8 de dezembro de 2017, transita em um debate contínuo sobre a formação em saúde, buscando romper com paradigmas curriculares tradicionais e alinhar a educação às necessidades sociais e às políticas de saúde vigentes. Ela considera discussões prévias no âmbito do CNS e do CNE, reconhecendo a necessidade de preparar profissionais para o SUS e para as demandas da área da saúde (Conselho Nacional da Saúde, 2018).

Como profissão da saúde, a quiropraxia deve alinhar suas DCN à Resolução CNS nº 569/2017, que determina que a formação deve ser pautada nas necessidades sociais e no fortalecimento do SUS. Os currículos devem contemplar a interprofissionalidade, a ética e a segurança do paciente, rompendo com sistemas verticalizados e fragmentados. A formação deve ser generalista, humanística e crítica, preparando o egresso para atuar em redes de atenção à saúde.

A Construção das DCN para a quiropraxia não deve ser um processo de mera "adaptação ao mercado", conforme a crítica de Ciavatta e Ramos, mas um exercício de "equidade" e "adequação prudente", como preconiza Cury. Trata-se de elevar a formação do quiropraxista ao nível de uma "escola única inicial de cultura geral, humanística, formativa", integrando

ciência, técnica e compromisso social. Somente assim a quiropraxia brasileira superará o hiato da experimentalidade para consolidar-se como uma práxis de saúde legítima e indispensável ao cenário nacional.

A construção das DCN para a quiropraxia é o mecanismo necessário para consolidar parâmetros de prática segura, conforme recomendado pela OMS. A diretriz deve traduzir o consenso mundial de educação quiroprática, respeitando a autonomia do sistema brasileiro e as demandas do SUS, para garantir que a formação não seja apenas utilitária, mas uma verdadeira práxis social e produtiva. Para a quiropraxia, a DCN é o instrumento que deve converter a experiência acumulada pelas universidades pioneiras em norma estável, garantindo a formação e a prática segura recomendada pela OMS.

6.3 Precedente de DCN sem regulamentação em Lei: o caso do Físico e do Sanitarista

Homologado em 4/12/2001, a aprovação do parecer CNE/CES 1.304/2001, publicado no Diário Oficial da União de 7/12/2001, Seção 1, que estabelece as DCN para os cursos de Física, cujo Conselheiro Relator Francisco César de Sá Barreto justifica o seu parecer favorável à criação das DCN dos cursos de Física “[...] com base nas discussões e sistematização das sugestões apresentadas pelos diversos órgãos, entidades e Instituições à SESu/MEC” (Brasil, 2001c, p. 25, grifo nosso)

O Parecer CNE/CES nº 120/2010, referente ao pedido de construção de DCN para Quiropraxia, esclarece que a regulação de cursos superiores não depende da existência prévia de DCN (Brasil, 2006, p. 4), o que validou a legalidade dos cursos existentes. Contudo, a ausência de uma diretriz específica gera lacunas que fragilizam a identidade profissional frente a impasses corporativistas.

O caso do Físico serve como precedente histórico relevante, pois a área da Física teve sua DCN homologada (Brasil, 2001), (Imagem 15), dezessete anos antes da regulamentação da profissão por lei específica (Lei nº 13.691 de 10 de julho de 2018) (Brasil, 2018).

Imagem 15 - Homologação do parecer referendando a DCN do Físico

PARECER CNE/CES 1.304/2001 - HOMOLOGADO
Despacho do Ministro em 4/12/2001, publicado no Diário Oficial da União de 7/12/2001, Seção 1, p. 25.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO**

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Superior		UF: DF
ASSUNTO: Diretrizes Nacionais Curriculares para os Cursos de Física		
RELATOR(A): Francisco César de Sá Barreto, Carlos Alberto Serpa de Oliveira e Roberto Claudio Frota Bezerra		
PROCESSO(S) N.º(S): 23001.000319/2001-10		
PARECER N.º: CNE/CES 1.304/2001	COLEGIADO: CES	APROVADO EM: 06/11/2001

Fonte: (Brasil, 2001)

De igual forma, o caso do sanitarista, como profissional de formação universitária na área da saúde, com cursos superiores no país desde 2008 em caráter inovador e experimental, em 10 de outubro de 2017 teve a sua DCN homologada pelo MEC (Imagem 16) e seis anos após, em 16 de novembro de 2023 conquistou a sanção presidencial que regulamentou a profissão com lei específica (Imagem 17).

Imagem 16 - Homologação das DCN do Sanitarista

HOMOLOGADO DOU 14/10/2022, Edição 196, Seção 1, Página 89		
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		
INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior		UF: DF
ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Saúde Coletiva.		
COMISSÃO: Luiz Roberto Liza Curi (Presidente), José Loureiro Lopes (Relator), Arthur Roquete de Macedo e Yugo Okida.		
PROCESSO Nº: 23001.000195/2016-59		
PARECER CNE/CES Nº: 242/2017	COLEGIADO: CES	APROVADO EM: 6/6/2017

Fonte: Parecer CNE/CES nº 242/2017 (Brasil, 2017)

Imagem 17 - Regulamentação da profissão de sanitarista

LEI Nº 14.725, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 <i>Regula a profissão de sanitarista.</i> O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Esta Lei regula a profissão de sanitarista e estabelece os requisitos para o exercício de sua atividade profissional. Art. 2º É livre o exercício da atividade profissional de sanitarista em todo o território nacional, desde que observadas as disposições desta Lei. Art. 3º Poderão habilitar-se ao exercício da profissão de sanitarista e exercer suas atividades: I – os diplomados em curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação e por ele classificado na área de Saúde Coletiva ou de Saúde Pública, ofertado por instituição de ensino superior nacional credenciada pelo Ministério da Educação; ...

Fonte: Lei nº 14.725, de 16 de novembro de 2023 (Brasil, 2023)

No teor do texto do Parecer CNE/CES nº 242/1017 das DCN do curso de graduação em saúde coletiva/sanitarista, de 06/06/2017, o CNE destaca no tópico 5 – sob o título “Marcos Internacionais” o item: “[...] b) Documento da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Organização Mundial da Saúde (OMS), em especial, no que se refere ao esforço e ao compromisso das nações, discutindo políticas públicas em saúde [...]” (Brasil, 2017, p. 7).

Destarte, a OMS tem publicado em dezenas de idiomas as *Diretrizes da OMS para Formação Básica e Segurança em Quiropraxia* (Organização Mundial da Saúde, 2005) com pressupostos conceituais para estruturação da formação e da prática da quiropraxia aos países

onde a profissão ainda não detém regramento legal consolidado.

Corroborando com a disposição dos organismos internacionais, item 4.1 (Organograma do consenso mundial da formação e prática da quiropraxia) que atuam no contexto da acreditação dos cursos de quiropraxia nos países onde a profissão é regulamentada por lei, em prestar auxílio por meio de documentação oficial na área aos governos dos países que estão em processo de estruturação da profissão em quiropraxia em conformidade com o consenso mundial de educação na área, o Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia (CCEI) e o Conselho Latino Americano de Educação em Quiropraxia (CCE-LA) disponibilizam os *standards* para formação em quiropraxia elaborado em consenso entre os governos desses países como referência às competências necessárias para formação desse profissional da saúde.

Como apresentado no Quadro 9, constam nove projetos de lei que preveem a regulamentação da profissão de quiropraxista no Brasil, 5 destes estão ativos e em trâmite no Poder Legislativo Federal, sendo um destes já aprovado no Senado com encaminhamento à Câmara dos Deputados, a despeito da estruturação da prática profissional do bacharel quiropraxista no país em conformidade com o consenso mundial da educação básica e prática segura da profissão, em inúmeras conquistas, elencadas no teor dessa pesquisa, que dão aporte a estruturação da profissão.

Defende-se como necessária a construção das DCN em quiropraxia, ainda que não se tenha efetivado a regulamentação profissional como mencionado. Pauta-se em situação congênere ora exemplificada pela construção e aprovação de DCN da Física e do Sanitarista, antes da regulamentação do exercício profissional. Essas áreas de formação tiveram seus pareceres e suas DCN fundamentadas nas discussões entre as partes representativas da área, no caso da física: “[...] com base nas discussões e sistematização das sugestões apresentadas pelos diversos órgãos, entidades e instituições à SESu/MEC” (Brasil, 2001c, p. 25), e, mais recentemente no caso do sanitarista:

[...] a Câmara de Educação Superior (CES), do CNE, designou comissão para retomar os estudos, discutir e, posteriormente, propor encaminhamentos sobre o tema. [...] Foi realizado estudo criterioso dos novos contornos e demandas [...] A construção do texto das Diretrizes [...] elaboradas pelo CNE, tomou forma após amplo debate entre as áreas da Educação e Saúde, envolvendo a comunidade educacional, científica, entidades civis acadêmicas, trabalhadores da área da saúde e sociedade em geral, objetivando a formação geral e específica dos egressos/profissionais [...] incluiu, ainda, análises das propostas constantes no documento (minuta) elaborado pelo CNE e submetido à consulta pública. [...] os referidos eventos contaram com a participação de diferentes representações, o que possibilitou construção coletiva, democrática e transparente deste processo de definição dos requisitos legais e normativos para a formação de graduados em Saúde Coletiva, no país [parecer CNE/CES nº 242/1017] (Brasil, 2017, p. 1, grifo nosso).

Antes da promulgação da regulamentação do ofício de sanitarista por lei, o que na verdade favoreceu o caminho inverso de amparo aos legisladores nesse sentido, conforme destacado por Cury (2006, p. 43), sob a prerrogativa da função normativa e consultiva do Conselho Nacional de Educação (CNE), não há óbice em ouvir as autarquias representativas das profissões da saúde que possuem interface com a profissão de quiropraxista. Contudo, tal consulta deve observar parâmetros de legitimidade e representatividade técnica.

Todo o aparato estruturante da educação em quiropraxia encontra-se mundialmente consolidado nas Diretrizes da OMS, cujo Brasil é signatário, além das normativas do Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia (CCEI), do Conselho Latino-Americano de Educação em Quiropraxia (CCE-LA), e da Federação Mundial de Quiropraxia (WFC). Tais instituições, assim como os bacharéis egressos e demais representantes da profissão no país, não foram apresentados como entidades consultadas para a formulação do parecer nº 120 do CNE (Brasil, 2010) cuja justificação demonstrou forte fundamento no posicionamento da Autarquia da fisioterapia pela não construção das DCN da graduação em quiropraxia.

Destaca-se o posicionamento dos órgãos internacionais da fisioterapia, como a Federação Mundial de Fisioterapia (WCPT) e a Confederação Internacional de Fisioterapia Manipulativa Ortopédica (IFOMPT), apontados na imagem 10 do item 3.4 (Impasse Quiropraxia X Fisioterapia brasileiras) que recomendam aos fisioterapeutas do mundo não se valerem dos procedimentos e nem das nomenclaturas da quiropraxia por constituírem profissões distintas, com histórico, fundamento epistemológico e práticas diferenciadas.

A construção de uma DCN para o curso de graduação em Quiropraxia deve fundamentar-se em: evidências internacionais consolidadas; distinção epistemológica e prática comprovada; legitimidade representativa dos atores envolvidos; interesse público na diversificação das opções terapêuticas e alinhamento com as diretrizes da OMS e CCE-LA para formação quiroprática no Brasil

A ausência de DCN para a formação de quiropraxistas configura uma lacuna normativa que, conforme demonstrado no portal oficial do Ministério da Educação (Brasil, 2025a), permite fragilidades estruturais na formação profissional. Esta análise, ancorada nos precedentes das dicotomias teóricas discutidas no presente estudo, evidencia como tal omissão compromete tanto a adequação formativa quanto a segurança na prática profissional na área da saúde, conforme alertado pela Organização Mundial da Saúde (2005). Para ilustração empírica desta problemática, apresentam-se, a título exemplificativo, as evidências visuais documentadas nas imagens subsequentes (Imagens 18 e 19).

Imagem 18 - Curso de Quiropraxia na Modalidade EaD: Registro no Sistema e-MEC

Consulta Avançada | Consulta Textual | IES Extintas

Buscar por: ☐ Instituição de Ensino Superior ☒ Curso de Graduação ☐ Curso de Especialização

Nome, Sigla ou Código da Instituição:

Curso: QUIROPRAXIA ☐ Pesquisa Exata

Situação: Em Atividade

Resultado da Consulta Por : CURSO

Instituição - IES	Sigla	Curso	Grau	Modalidade	Índices	Vagas Anuais	Data Início
(1491) CENTRO UNIVERSITÁRIO		QUIROPRAXIA	Tecnológico	A Distância	CC: - CPC: - ENADE: - IDD: -	1500	23/10/2023

(Código) Nome da IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO Situação: Ativa

RELAÇÃO DE CURSOS

Código	Modalidade	Grau	Curso	UF	Município	ENADE	CPC	CC	IDD	Situação
	A Distância	Tecnológico	QUIROPRAXIA		Vários municípios	-	-	-	-	

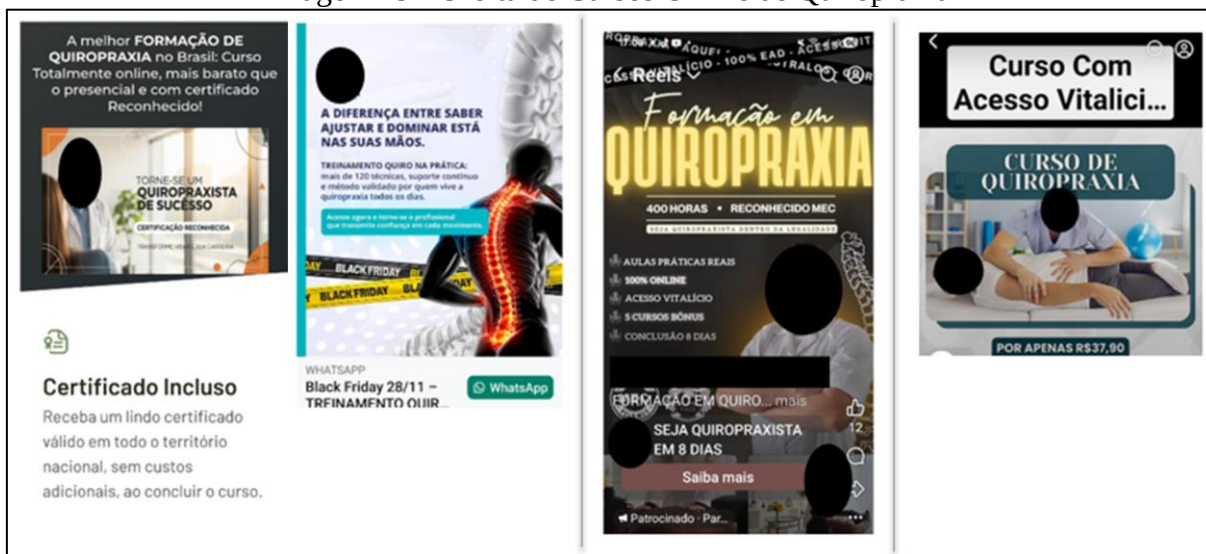
(Código) Grau	Modalidade	Data de início de funcionamento	Data prevista de início	Gratuito	Carga horária do Curso	Periodicidade (Integralização)	Coordenador	Situação de Funcionamento	Vagas Anuais Autorizadas
Tecnológico	Educação a Distância	23/10/2023	-	Não	1660 horas	Não aplica - 6 quadrimestres		Em atividade	1500

Registro(s): 1 a 813 de 813 Página 1 de 1 1000

Fonte: Ministério da Educação. Sistema e-MEC (Brasil, 2025a).

A Imagem 18 consubstancia a configuração estrutural de um curso superior de Quiropraxia devidamente cadastrado no Sistema e-MEC do Ministério da Educação. O programa, ativo na modalidade de Educação a Distância (EaD), apresenta carga horária total de 1.660 horas, sendo ofertado por uma Instituição de Ensino Superior (IES) através de 813 polos distribuídos em municípios de abrangência nacional. A capacidade de atendimento do curso estabelece a disponibilização de 1.500 vagas por polo.

Imagem 19 - Oferta de Cursos Online de Quiropraxia



Fonte: Coleta documental realizada pelo autor (2025)

A Imagem 19 constitui material empírico coletado, exemplificando as consequências decorrentes da lacuna regulatória por ausência de DCN e de regulamentação legal específica profissional. Evidencia-se uma pluralidade de cursos *online* ofertados na contemporaneidade, entre os quais se destacam, programas descritos explicitamente como 100% *online* com autorização do MEC; ofertas formativas que prometem capacitação profissional para atuação como quiropraxista em períodos reduzidos (oito dias), além de propostas que apresentam a certificação como diferencial competitivo para aperfeiçoamento em habilidades técnicas específicas. Esta constelação de ofertas formativas heterogêneas e despadronizadas configura um cenário comprometedor à identidade profissional da quiropraxia quanto aos compromissos éticos e técnicos com a saúde pública.

Ante o exposto, projeta-se que a promulgação do Decreto nº 12.456 (Brasil, 2025e) e da Portaria nº 378 (Brasil, 2025f), ambos datados de 19 de maio de 2025 e emanados do Ministério da Educação, que instituem o marco regulatório para oferta de educação a distância por Instituições de Ensino Superior, venham a constituir instrumentos normativos capazes de solucionar situações anômalas como a exemplificada nas Imagens 18 e 19.

Espera-se que os fundamentos apresentados em referência a essa profissão de formação universitária possam elucidar os pressupostos legais e técnicos disponíveis, visando colaborar com o CNE na construção de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de graduação em Quiropraxia no Brasil, dentro do que é justo e legítimo para a identidade da profissão e, sobretudo, para a saúde pública dos brasileiros.

6.4 Caminhos para construção das DCN para formação em Quiropraxia

Em 06 de novembro de 2008, foi aprovado o parecer CNE/CES 230/2008 “[...] determinando o reconhecimento do Curso de Quiropraxia, ministrado pelo Centro Universitário FEEVALE, com sede na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, até o primeiro ciclo avaliativo a se realizar após esta data, [...]” (Brasil, 2008) (Imagem 20).

Imagem 20 - Recurso da FEEVALE ao CNS em 2008 para o curso de Quiropraxia

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		
INTERESSADA: Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo		UF: RS
ASSUNTO: Recurso contra decisão do Secretário de Educação Superior referente ao reconhecimento do curso de Quiropraxia, ministrado pelo Centro Universitário FEEVALE, com sede na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul		
RELATOR: Mário Portugal Pederneiras		
PROCESSO N°: 23001.000166/2007-04		
PARECER CNE/CES N°: 230/2008	COLEGIADO: CES	APROVADO EM: 6/11/2008

Fonte: (Brasil, 2008)

O relator do parecer CNE/CES 230/2008 em suas argumentações pelo reconhecimento pleno do curso de graduação em Quiropraxia da Universidade FEEVALE – RS considerou que:

[...] o referido curso foi bem avaliado pelo INEP, tendo obtido os conceitos: B (dimensão Corpo Docente); MB (dimensão Organização Didático Pedagógica) e MB (dimensão Instalações).

Tendo em vista o entendimento do CNE expresso em seu Parecer nº 22/2007 e a reavaliação promovida nos autos do processo em referência, do qual consta relatório de avaliação das condições de ensino promovida no ano de 2004 que indica a adequada condução das atividades acadêmicas, conclui-se pela pertinência de recomendar o reconhecimento do curso de Quiropraxia, bacharelado, ministrado pelo Centro Universitário Feevale, na cidade de Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul, nos termos do disposto no artigo 10, § 7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006 (Brasil, 2008).

O cerne da resolução do CNS referente a DCN para graduação na área da saúde está no Art. 3º, da Resolução nº 569/2017 (Conselho Nacional de Saúde, 2017), amparada no Artigo 81 da Lei nº 9.394/1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, [2024b]). Dentre os princípios norteadores do contexto mundial da formação em Quiropraxia,

buscando alinhar a educação em Quiropraxia às necessidades sociais e às políticas de saúde vigentes à soberania nacional, a Universidade FEEVALE protocolou junto ao CNE o pedido de construção das DCN para graduação em Quiropraxia, cuja resposta, por meio do parecer n° 120 do CNE (Brasil, 2010) argumenta:

[...] este Colegiado já se manifestou, em diversas ocasiões, sobre a inexistência de vínculo necessário entre os atos regulatórios de cursos e DCNs. Inicialmente, devemos esclarecer que o art. 81 da Lei n° 9.394/1996 (LDB) permite a criação de cursos inovadores ou experimentais. [...] a regulação de cursos superiores não depende da existência prévia de Diretrizes Curriculares Nacionais, bem assim que esta regulação não se vincula à taxonomia das áreas do conhecimento (Brasil, 2010, p. 2).

O relator complementa o seu voto afirmando que o CNE (Brasil, 2010), além de ouvir o Ministério da Saúde, entidades profissionais e congêneres, incorpora manifestação da Autarquia da Fisioterapia, que em alusão à Resolução n° 220 (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2001), pretende que a Quiropraxia seja uma especialidade da profissão de fisioterapeuta, e paradoxalmente defende, no ato desse parecer, que a Quiropraxia pode ser exercida por profissionais das diversas áreas da saúde, o que fere a raiz epistemológica da educação em Quiropraxia no consenso mundial para formação e prática dessa área da saúde a 130 anos, conforme a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde, 2005) e a lei 8.080/1990 do SUS que “dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências” (Brasil, [2025b]).

Sobre a Resolução n° 220/2001, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decide:

Na medida em que a atuação dos Conselhos Profissionais não pode ocorrer fora dos limites da lei, [...]. A Resolução 220/2001 do COFFITO, ao reconhecer a quiropraxia como especialidade da fisioterapia, extrapolou as competências administrativas fiscalizatórias conferidas ao COFFITO e aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional pela Lei n° 6.316, de 17/12/75 [...] (Brasil, 2014).

Nos capítulos 3.3 “Chegada da Quiropraxia no Brasil” e 3.4 “Impasse Quiropraxia x Fisioterapia brasileira” dessa dissertação, descrevemos algumas das dicotomias e paradoxos que permeiam a estrutura da educação em Quiropraxia no Brasil no contexto da legalidade e legitimidade frente a influência do lobby corporativista do Conselho de Fisioterapia contra o processo de regulamentação da profissão, interferindo, inclusive, no direito dos respectivos cursos de graduação em Quiropraxia evoluir para uma DCN, que a 25 anos, com sucessivas renovações de reconhecimento pelo MEC, permanecem em caráter Inovador e Experimental, dando brechas as oferta das mais variadas formas de cursos livres e até online sem qualquer

critério acadêmico para formação e prática segura da profissão.

Na Cartilha da Série Legislação e Saúde, *Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde*, publicada em (Brasil, 2006), o Ministério da Saúde assinala:

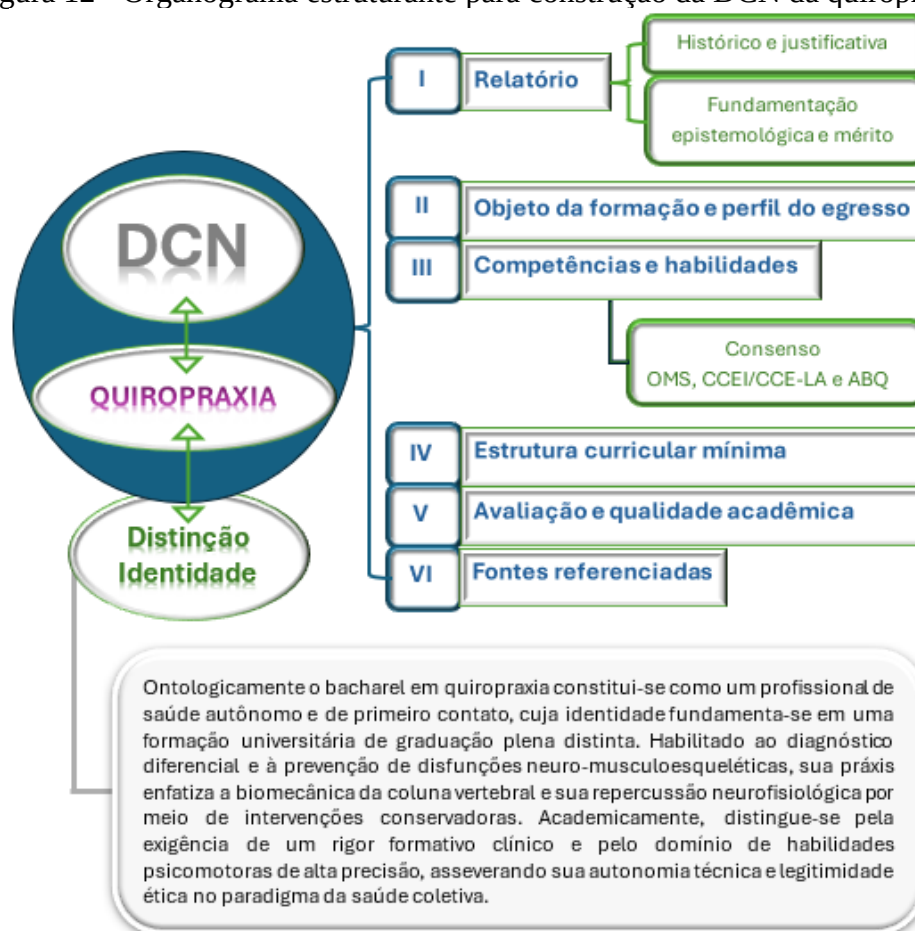
[...] considerando que a saúde é um bem público, compete ao Estado dispor sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, adequando o interesse particular ao interesse público [...] as iniciativas legislativas reproduzem, na maioria das vezes, resoluções internas dos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional, não observando as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Prevalecem, desta forma, os interesses corporativos (Brasil, 2006, p. 4, grifo nosso)

Na disposição preliminar da Lei 8.080/1990 do SUS em epígrafe, estabelece no “Art. 1º Esta Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado”. Nas disposições gerais “Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (Brasil, [2025b], Art. 2º, grifo nosso).

Nesse sentido, embora os cursos oficiais de graduação em Quiropraxia no país estejam amparados pelo MEC, o fato da formação e prática da quiropraxia representarem um novo paradigma no Brasil, traz a necessidade da formulação de ações e medidas para a criação de lei que regule a profissão e promova a elaboração de uma DCN com os critérios mínimos necessários à formação desse profissional. Visando assegurar a flexibilidade e a qualidade da formação aos estudantes, as DCN estabelecem a formação acadêmica oferecendo reconhecimento e credibilidade ao profissional e aos seus assistidos (Brasil, 1997).

Nesse contexto apresenta-se uma contribuição para a construção de DCN para a graduação em Quiropraxia, ora sumarizada, a partir da (Figura 12) e detalhada no Apêndice A.

Figura 12 - Organograma estruturante para construção da DCN da quiropraxia



Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir das Diretrizes da OMS, CCE, CCEI, ABQ e CNE

A Figura 12 representa, além da síntese da distinção/identidade da quiropraxia, seis capítulos balizadores macro como estruturantes à proposta das DCN: I – Relatório, II – Objeto da formação e perfil do egresso, III – Competências e habilidades, IV – Estrutura curricular mínima, V – Avaliação e qualificação acadêmica, e VI – Fontes referenciadas. Reitera-se que a descrição do conteúdo dos capítulos balizadores da sugestão dessas DCN está detalhada no Apêndice A intitulado “Arcabouço Para Construção da DCN da Quiropraxia”.

O Relatório descritivo da proposta para as DCN do bacharelado em quiropraxia ampara-se na descrição do histórico e da justificativa, na fundamentação epistemológica e do mérito, explorados nos capítulos desta dissertação ao tratar o processo histórico da quiropraxia, a expansão da profissão no mundo, a chegada da quiropraxia no Brasil e a influência corporativista da autarquia da fisioterapia brasileira. O Relatório expõe os *standards* de educação em quiropraxia, defendidos pelo Conselho Latino-Americano de Educação em Quiropraxia (CCE-LA), adaptados à cultura acadêmica e aos regramentos da saúde pública dos países da América Latina, subsidiados pelas *Diretrizes da OMS para Formação Básica e*

Segurança em Quiropraxia (Organização Mundial da Saúde, 2005). O Relatório contrapõe a luta pela regulamentação da profissão *versus* o avanço na formação superior em Quiropraxia, com as distorções inerentes à ausência das DCN e da regulamentação profissional. O texto apresenta como precedentes o caso do físico e do sanitário, com DCN sem regulamentação em lei.

No campo da formação e perfil do egresso, adota-se o consenso mundial postulado pela OMS descrito nos “*standards*” consultados, observando-se as áreas do conhecimento que consubstanciam a formação profissional condizente com o exercício seguro e qualificado da quiropraxia.

Como competências são construídas, uma competência geral macro e oito meta-competências específicas, destrinchadas em Conhecimento, Habilidade e Atitude (CHA), trabalhadas espiralmente em três ciclos de aprendizagem (as bases biológicas e a fundamentação holística da quiropraxia; o treinamento de habilidades quiropráticas; a gestão, o empreendedorismo e a abordagem clínica). Sugerem-se 25 habilidades como matriz de formação. Como estrutura curricular de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) defende como padrão mínimo de 4.200 horas de carga horária instrucional, com 1000 horas de Estágio Curricular Supervisionado obrigatório.

O acompanhamento e a avaliação do curso de graduação em Quiropraxia devem constituir um processo contínuo de aferição da qualidade, fundamentado nos *standards* de acreditação internacional do CCE-LA, o qual observa os seguintes critérios: Sistema de Supervisão e Gestão da Qualidade; Autoavaliação Institucional e Melhoria Contínua; Avaliação sob a Perspectiva Externa; Integridade e Ética Acadêmica; Aferição do Desempenho e Competência Clínica; e, Planejamento de Recursos e Sustentabilidade do Programa.

As fontes referenciadas apresentam-se como marcos normativos nacionais derivados dos Conselhos de Educação e de Saúde, e do consenso global formulado por organismos oficiais relacionados com a formação e o controle da prática da profissão de quiropraxista mundialmente. Tais documentos são basilares para conferir isonomia e densidade jurídica à proposta de DCN para a Quiropraxia, utilizando como paradigma o processo de consolidação de outras profissões da saúde no Brasil.

7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS

O presente capítulo destina-se à exposição e ao escrutínio analítico dos dados coligidos durante a fase empírica desta investigação. O tratamento das informações ancora-se na Análise de Conteúdo, sob a perspectiva teórico-metodológica de Bardin (1977). Esta abordagem é definida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, visando à obtenção de indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção das falas dos sujeitos.

A operacionalização desta técnica seguiu o rito tripartite fundamental preconizado pela autora: a pré-análise, que compreendeu a organização do material e a leitura flutuante do corpus; a exploração do material, centrada nas operações de codificação e categorização; e, por fim, o tratamento dos resultados, voltado à condensação, interpretação e inferência das informações obtidas. Esse percurso metodológico permitiu a transposição do conteúdo bruto das transcrições para unidades de significado que fundamentam a compreensão do fenômeno estudado.

A partir da análise das comunicações, foram construídas, *a posteriori*, 3 categorias principais de interpretação analítica. Estas categorias funcionam como eixos estruturantes que reúnem elementos em razão de caracteres comuns e sentidos compartilhados nas respostas dos entrevistados. Visando conferir maior profundidade e especificidade ao tratamento dos dados, estas categorias foram subdivididas em 12 temas centrais, que organizam o universo de significados explorado.

A arquitetura analítica foi estabelecida da seguinte forma:

Categoria I - aborda o Consenso Mundial para Formação em Quiropraxia (englobando os Temas 1 a 3).

Categoria II - debruça-se sobre a Identidade da Formação e Prática da Quiropraxia no Brasil (Temas 4 a 6).

Categoria III - explora a Legalidade e Legitimidade da Formação e Prática da Quiropraxia no Cenário Brasileiro frente à necessidade de DCN e Regulamentação Profissional (Temas 7 a 12).

Esta sistematização por eixos temáticos permite a triangulação necessária para responder ao problema central desta investigação.

Em cumprimento aos padrões éticos na defesa dos direitos e interesses dos participantes propostos na entrevista semiestruturada aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Parecer nº 7.811.643), nominamos simbolicamente os 12 entrevistados de forma aleatória, como demonstrado no Quadro 10 em letras maiúsculas de (A) até (L). Suas respostas estão contextualizadas nas três categorias e doze temas supracitados, abrangendo, a partir das questões primárias aplicadas a cada ator estratégico, um total de 94 perguntas (p) dispostas no Quadro 23 – (Questões exploradas, na entrevista por Temas) dentro do escopo do estudo em epígrafe.

Quadro 10 -Triangulação entre as 3 categorias com os 12 temas em 94 perguntas aos 12 entrevistados

3 CATEGORIAS		12 TEMAS (T)	94 PERGUNTAS (p)	12 ENTREVISTADOS
I	CONSENSO MUNDIAL PARA FORMAÇÃO EM QUIROPRAXIA	T1 * Critérios para acreditação e fiscalização da formação em quiropraxia globalmente;	p1, p15, p66, p67 e p82.	A1; C1; I3; I4; K4.
		T2 * Qualidade da formação em quiropraxia no Brasil vista pela comunidade internacional;	p2, p3, p4, p17, p18, p19, p22, p69 e p82.	A2; A3; A4; C3; C4; C5; C8; I6; K4.
		T3 * Como os organismos de educação internacional ajudam a quiropraxia no Brasil;	p5, p6, p7, p14, p20, p21, p31, p37, p57 e p88.	A5; B1; B2; B9; C6; C7; E2; E8; H7; K10.
II	IDENTIDADE DA FORMAÇÃO E DA PRÁTICA DA QUIROPRAXIA NO BRASIL	T4 * Estruturação do PPC dos cursos pioneiros no Brasil;	p6, p7, p11, p13, p14, p31, p32, p33, p37, p43, p47, p49, p50, p51, p52, p53, p56, p60, p63, p70, p79, p89, p91 e p92.	B1; B2; B6; B8; B9; E2; E3; E4; E8; G1; G5; G7; G8; H1; H2; H3; H6; H10; H13; I7; K1; L1; L3 e L4.
		T5 * Vantagens e desvantagens do curso “inovador e experimental” pelo MEC na formação e o exercício profissional da quiropraxia;	p9, p11, p16, p19, p30, p32, p33, p39, p45, p47, p65, p73, p78, p80, p83, p89 e p91.	B4; B6; C2; C5; E1, E3; E4; F2; G3; G5; I2; J3; J8; K2; K5; L1; L3.
		T6 * Diferença da distinção entre formação ciência baseada em evidência e mais filosófica e seu reflexo no cenário da saúde brasileira;	p10, p38, p46, p52, p72, p79, p89 e p90.	B5; F1; G4; H2; J2; K1; L1; L2.
III	LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA FORMAÇÃO E PRÁTICA DA QUIROPRAXIA NO CENÁRIO BRASILEIRO X NECESSIDADE DE DCN E REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL	T7 * Impacto legal na percepção pública quanto a identidade do profissional quiropraxista, causado pela falta de DCN e a não regulamentação da profissão Brasil;	p8, p9, p18, p19, p35, p36, p40, p45, p66, p81 e p86.	B3; B4; C4; C5; E6; E7; F3; G3; I3; K3 e K8.
		T8 * Necessidade da formação em quiropraxia evoluir para uma DCN;	p12, p17, p28, p34, p35, p42, p48, p50, p58, p61, p62, p68, p74, p83, p85 e p94.	B7; C3; D5; E5; E6; F5; G6; G8; H8; H11; H12; I5; J4; K5; K7 e L6.
		T9 * Papel das DCN;	p4, p42, p44, p64, p67, p85, p86, p87 e p92.	A4; F5; G2; I1; I4; K7; K8; K9 e L4.
		T10 * Interferência da autarquia da fisioterapia;	p23, p26, p27, p36, p41, p54, p55, p68, p71, p84 e p93.	C9; D3; D4; E7; F4; H4; H5; I5; J1; K6 e L5.
		T11 * Obstáculos que pesam contra a aprovação dos PL e DCN;	p24, p36, p41, p54, p55, p60, p75 e p76.	D1; E7; F4; H4; H5; H10; J5 e J6.
		T12 * Relevância do reconhecimento da quiropraxia junto ao MEC, CBO, SUS, CNAE perante o cenário brasileiro.	p25, p29, p55, p59 e p77.	D2; D6; H5; H9 e J7.

Fonte: Desenvolvido pelo autor

A “Categoria I - Consenso mundial para formação em quiropraxia” aborda a temática dedicada ao estudo, diagnóstico e tratamento não cirúrgico e não medicamentoso de disfunções articulares na coluna vertebral e a relação dessas disfunções no sistema nervoso e na saúde em geral. A Categoria foi subdividida em três temas:

- a) T1 - Critérios para acreditação e fiscalização da formação em quiropraxia globalmente
- b) T2 - Qualidade da formação em quiropraxia no Brasil vista pela comunidade internacional
- c) T3 - Como os organismos de educação internacional ajudam a quiropraxia no Brasil.

Quadro 11 - Categoria I: resultados do Tema 1

Tema 1 (T1)	
Critérios para acreditação e fiscalização da formação em quiropraxia globalmente	
Perguntas: p1, p15, p66, p67 e p82. Pontos chave: - Estrutura do CCEI e demais CCE; - Standards; - Acreditação; 31 competências; - Padrão mundial de horas mínimas de estágio / Clínica Escola; - Brasil, única região do mundo sem controle; - Escolas não credenciadas; - Profissional sem validade para atuar em outros países.	Entrevistados: A1; C1; I3; I4 e K4. “Visando a segurança do paciente, o Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia (CCEI) estabelece critérios para credenciar e orientar as instituições para o desenvolvimento de um alto padrão do ensino da quiropraxia, para isso, é desenvolvido um Standard com requisitos mínimos para qualificar os cursos de quiropraxia internacionalmente.” “Standard padrão do CCEI compõe todos os demais conselhos que, por sua vez, complementam com regramentos próprios para acreditar os cursos de formação de quiropraxistas nas suas regiões.” “... para que um graduado na África ou na China, tenha o mesmo nível de formação que nos EUA ou no Brasilexiste o Conselho de Educação dos EUA, o Conselho de Educação europeu, o Conselho de Educação dos países asiáticos, o Conselho de Educação em Quiropraxia da América Latina ...” (CCE-La)” “O (CCE-La) tem o Standard desenvolvido dentro dos critérios do CCEI adaptado às peculiaridades educacionais e culturais da América Latina e das Diretrizes da OMS.” “No Brasil, as instituições que têm comprometimento com a formação adequada e conta com um quiropraxista na estruturação de um novo curso e querem manter um padrão internacional devem entender que existe um padrão mínimo ideal na formação do quiropraxista, um mínimo de carga horária, um percentual de carga horária de estágio, de pesquisa e extensão, sempre mantendo aquilo que é o recomendado mundialmente.” “Nos Estados Unidos, esses conselhos de educação são ligados a órgão federal e os cursos só podem funcionar se o conselho de educação em quiropraxia fizer a acreditação liberando a licença para funcionamento.” “A instituição precisa seguir esses standards que são revistos a cada oito a dez anos. O próprio conselho faz essa revisão para adaptar a evolução na educação, ...” “... Existem 31 competências que o quiropraxista/aluno precisa atingir, precisa ser competente nesses 31 itens para poder se formar em quiropraxia. E para obter a acreditação, é necessário demonstrar que o curso todo está focado nessas competências.” “... exigência importante, é o número de aulas que o aluno tem que ficar na clínica atendendo pacientes. Então, tem um mínimo de mil horas de estágio supervisionado ...” “O CCE não só olha o número de horas, se tem maca, se tem professor, isso é o mínimo, se não tem essas coisas, não existe. Mas eles também olham o processo todo de se formar um quiropraxista, se o processo vai formar um

Tema 1 (T1) Critérios para acreditação e fiscalização da formação em quiropraxia globalmente	
	quiropaxista competente... ..assim é no mundo todo.” “A Federação Latino-Americana de Quiropraxia (FLAQ), vê a necessidade dos graduados em quiropraxia nos países da América Latina, serem reconhecidos internacionalmente, nesse momento eles não são!” “A América Latina possui 9 faculdades de quiropraxia, 5 dessas no Brasil, é a única região do mundo onde a profissão é ensinada sem controle, sem fiscalização.” “... um graduado do Brasil, do México, ou do Chile, por exemplo, não pode atuar em determinados países porque as escolas não são credenciadas.” “... não basta ter um diploma reconhecido no Brasil e pedir uma convalidação, isso não vale, ele terá que fazer todo curso de novo, numa escola que é credenciada.” “Quando uma escola atende os critérios da acreditação, os seus alunos vão poder atuar em qualquer outro país porque ele vem de uma escola reconhecida dentro do Standard.” “... para atuar em outro país, ele terá que se subordinar as leis de cada país e dos protocolos de licenciamento para atuar, mas tem a possibilidade trabalhar em outros países, ...” “...a grande vantagem é saber que os profissionais estão com capacidade suficiente para manter a segurança do tratamento com a quiropraxia. No final tudo é para o paciente.”

Fonte: Elaborado pelo autor

As evidências colhidas nas entrevistas corroboram a existência de um rigoroso sistema de governança educacional internacional, estruturado pelo CCEI, que transcende a mera organização curricular ao focar na segurança biológica do paciente. A análise dos relatos indica que a acreditação não é um rito burocrático, mas um mecanismo de aferição de competências clínicas específicas, o que ratifica a fundamentação apresentada no capítulo 4 sobre a padronização global como pressuposto para a mobilidade profissional. Observa-se, pela fala dos sujeitos, que o estágio supervisionado de 1.000 horas é o pilar inegociável dessa qualidade, estabelecendo um contraste crítico com a realidade brasileira atual, onde a ausência de controle externo permite uma formação alheia aos *standards* mundiais.

Quadro 12 - Categoria I: resultados do Tema 2

Tema 2 (T2)	
Qualidade da formação em quiropraxia no Brasil vista pela comunidade internacional	
Perguntas: p2, p3, p4, p17, p18, p19, p22, p69 e p82. Pontos chave: • Autonomia dos países; • Ensino livre e sem controle; • Indisposição das IES em se aproximar do CCE-La; • Cursos pioneiros no início atendiam padrão CCE; • Redução de carga horária; • Cursos estruturados sem informação; • Identidade da profissão fragilizada; • Estímulo a autocrítica; • Redução de horas de estágio; • Risco na saúde pública; • Importância de acreditação ao CCE-La; • Chancela da ABQ; • Cursos abertos fora do mínimo recomendado pela OMS.	Entrevistados: A2; A3; A4; C3; C4; C5; C8; I6 e K4. “O CCEI respeita a autonomia dos países, ele orienta, mas não interfere, ...” “... Por ainda não existir lei específica no Brasil, a formação e a prática da quiropraxia é livre, por enquanto qualquer um pode se dizer quiropraxista e atuar sem qualquer controle nesse país... ...uma coisa é o padrão educacional, outra coisa é a regulamentação.... é a proteção de título, quem pode atuar.” “... até agora as tentativas em reunir com todas as escolas [da América-Latina] não deram certo. Esse é o nosso grande desafio, apresentar a nossa missão e a nossa visão, como o standard vai impactar na formação dos seus graduados, e como os graduados vão poder desenvolver o conhecimento adequado em quiropraxia e poder demonstrar que têm tudo o que precisam para serem profissionais de saúde completos e validados por qualquer departamento de educação em qualquer país.” “... tanto a Universidade FEEVALE com o Palmer College quando a Universidade Anhembí Morumbi com o Western States, essas universidades americanas nos deram os currículos deles que são públicos e vimos que os primeiros cursos do Brasil começaram muito parecidos com as matrizes dos Estados Unidos, ...” “...1 mil tem que ser em clínica [estágio supervisionado] e atualmente, mesmo no Brasil não há muita universidade que esteja seguindo as 4 mil horas eles baixaram a quantidade de horas, uma e outra segue ...” “O que percebemos é que talvez algumas universidades brasileiras não queiram começar os processos de acreditação porque eles veem que precisam subir a carga acadêmica de horas ou fazer algumas mudanças que nesses momentos não podem fazer.” “... maioria delas, sentimos que é por falta de informação quanto a identidade da quiropraxia como profissão autônoma e sua base de formação próxima com a medicina nos países desenvolvidos.” “... tendo como bases os standards do CCE-La, estamos estimulando a começarem com o self-study, que é o autoestudo, para então se dar conta quais são as coisas que podem modificar e muitas das coisas são fáceis de modificar ...” “... começam a se dar conta que é o que precisam fazer para ter seus cursos acreditados pelo CCE-La e consequentemente reconhecidos pelo CCEI.” “Um problema sério, supõe-se que se está acontecendo nas escolas que ao tirar horas aulas prática de clínica, porque querem tentar fazer as coisas um pouco mais online ou algo do tipo e a parte prática sofre quando você corta horas clínicas então realmente não conseguimos fazer uma avaliação completa de nenhuma das universidades, porque há dificuldade para nós podermos saber detalhes do curso e entrar para ver o que estão fazendo.” “As instituições brasileiras que têm comprometimento com algum quiropraxista, normalmente procuram a Associação Brasileira de Quiropraxia (ABQ) porque elas querem manter um padrão, internacional e que seja chancelado pela ABQ.” “... querem abrir um curso, sem um quiropraxista com formação reconhecida, eles têm algum outro profissional da saúde, uma ideia do que é o curso de quiropraxia e montam uma grade curricular que não tem nada a ver com as

Tema 2 (T2)	
Qualidade da formação em quiropraxia no Brasil vista pela comunidade internacional	
	diretrizes da Organização Mundial de Saúde...” “Em se tratando de Brasil, fica muito complexo, porque falta o mínimo, que são essas exigências mínimas impostas por standards...” “para formar um quiropraxista, se fala em horas de curso, número de macas, estrutura física mínima. Isso é muito menos que o mínimo...” “... no Brasil não existe referência, a gente não tem nada para guiar, por isso se criou essa base no início dos cursos pioneiros de graduação em quiropraxia em parceria com universidades dos Estados Unidos, justamente para dar uma estrutura mínima para começar e formar profissionais competentes, esperando evoluir sempre e, continuar progredindo.” “não é só para você ter um profissional competente, mas é uma questão de saúde pública, você tem que ter profissionais competentes para que o público esteja protegido e seja bem tratado,é uma questão de saúde pública para proteger o público.”

Fonte: Elaborado pelo autor

A percepção da comunidade internacional revela um paradoxo regulatório no cenário brasileiro: se por um lado as instituições pioneiras buscaram inicialmente mimetizar as matrizes norte-americanas, por outro, a autonomia universitária sem o balizamento de uma DCN resultou em uma progressiva diluição da carga horária e da identidade profissional. A triangulação entre as falas e os marcos teóricos permite inferir que a indisposição das IES brasileiras em se submeterem ao CCE-LA fragiliza a legitimidade dos diplomas no exterior, conforme antecipado na discussão sobre a soberania nacional versus as recomendações da OMS. Os entrevistados reforçam que a redução de horas práticas em clínica-escola não é apenas uma perda acadêmica, mas um risco iminente à saúde pública, o que reitera a necessidade de converter a experiência experimental em norma estável.

Quadro 13 - Categoria I: resultados do Tema 3

Tema 3 (T3)	
Como os organismos de educação internacional ajudam a quiropraxia no Brasil	
Perguntas: p5, p6, p7, p14, p20, p21, p31, p37, p57 e p88. Pontos chave: • Oferece referências como modelo; • Documentos, dados e orientações para IES e governo; • Auxílio no desenvolvimento dos PPC;	Entrevistados: A5; B1; B2; B9; C6; C7; E2; E8; H7 e K10. “O que o CCEI disponibiliza documentos, dados, e oferece orientação tanto para as instituições de ensino quando para os departamentos governamentais que solicitam.” “... o CCE-La disponibiliza os standards já adaptado às características culturais, acadêmicas e da formação e prática das profissões da saúde na América-Latina.” “A orientação primária é iniciar o processo de adequação dos cursos oferecidos no Brasil aos standards do CCE-La que contempla o padrão mundial de educação em quiropraxia desenvolvido pelo CCEI.” “Esse protocolo de ajuda, serve de base para o governo desenvolver a DCN e

Tema 3 (T3)	
Como os organismos de educação internacional ajudam a quiropraxia no Brasil	
• Construção de DCN; • Aporte técnico ao legislativo.	nesse mesmo nível auxiliará na busca de legislação, quando chegar o momento.” “... a parte educacional vai influenciar também na legislativa, porque a DCN vai mostrar que só pode exercer a quiropraxia, o profissional que vier de um curso reconhecido e credenciado.” “O CCE-La pode ajudá-los oferecendo modelos de currículos; de aulas; de carga horária por disciplina; como trabalhar as horas de clínica, questões básicas pré-clínica, pesquisas, dar o aporte para adaptação do curso aos standards de forma clara.” “... um estudo self-study, para os coordenadores enxergarem quais são os requisitos que precisam de reparo e ver se o seu programa está apto para que tenha excepcionais profissionais da saúde.” “Na introdução dos dois cursos pioneiros de quiropraxia no Brasil, por meio da ABQ, da Federação Mundial de Quiropraxia (WFC), do CCEI, do Palmer College of Chiropractic e outras universidades Norte Americanas, houve um esforço muito grande para desenhar os projetos desses dois cursos... com o tempo, as instituições de ensino, por não existir lei que determine os padrões mínimos para formação e prática da profissão no país, a coisa ficou sem controle e decaiu muito.” “... no início, todo aporte técnico, documental, de informação, serviço de orientação, todo curso foi rigorosamente dentro das regras do MEC e do consenso internacional de educação em quiropraxia. não existia viés político ...” “... as entidades internacionais da profissão podem auxiliar efetivamente, como fontes primárias de informação, oferecendo dados oficiais sobre a estrutura acadêmica, fundamentação e prática da profissão mundialmente.”

Fonte: Elaborado pelo autor

Os depoimentos confirmam que os organismos internacionais atuam como guardiões da raiz epistemológica da profissão, oferecendo suporte técnico que preenche o hiato deixado pelo Estado brasileiro. A articulação histórica descrita por Chapman-Smith (2001) é ratificada pelos entrevistados ao mencionarem que o aporte de modelos de PPC e ementas padronizadas foi determinante para a introdução dos cursos em 2000. Contudo, a análise empírica sugere que este auxílio, embora disponível, esbarra na falta de um regramento nacional que obrigue a adesão a tais padrões, confirmando que o papel do CCE-LA como consultor é subutilizado pelas autoridades educacionais brasileiras, o que retarda a maturidade normativa do setor.

A triangulação das perguntas da Categoria II foi subdividida em três Temas:

- a) T4 - Estruturação do PPC dos cursos pioneiros no Brasil
- b) T5 - Vantagens e desvantagens do curso inovador e experimental pelo MEC na formação e o exercício profissional da quiropraxia
- c) T6 - Diferença da distinção entre formação ciência baseada em evidência, versus a mais

filosófica, e seu reflexo no cenário da saúde brasileira.

Quadro 14 - Categoria II: resultados do Tema 4

Tema 4 (T4)	
Estruturação do PPC dos cursos pioneiros no Brasil	
Perguntas: p6, p7, p11, p13, p14, p31, p32, p33, p37, p43, p47, p49, p50, p51, p52, p53, p56, p60, p63, p70, p79, p89, p91 e p92. Pontos chave: - Sem referência curricular e docente no Brasil; - Convênio/contrato de 10 anos FEEVALE & Palmer; - Capacitação docente conjunto com o Palmer College em 1997; - Dois coordenadores por 10 anos; - Currículo padrão Norte Americano e MEC; - Reconhecimento pelo MEC; - Avaliadores do MEC sem conhecimento em quiropraxia; - União entre as coordenações e alunos dos dois cursos pioneiros; - Publicação das Diretrizes da OMS novos desafios curriculares; - Robustez do curso conforme modelo internacional - Lobbies da fisioterapia no MEC; - Comunicação sobre a profissão; - Condição do PPC hoje; - Autonomia Universitária; - DCN geral dos cursos na saúde (CNS); - Respeito as Diretrizes da OMS; - Organismos internacionais hoje; - Cursos novos ainda sem DCN; - Presencialidade.	Entrevistados: B1; B2; B6; B8; B9; E2; E3; E4; E8; G1; G5; G7; G8; H1; H2; H3; H6; H10; H13; I7; K1; L1; L3 e L4 “... não existia formação em quiropraxia aqui no Brasil, a gente teve que pegar um modelo internacional, ...” “... a gente estruturou o nosso curso aqui no Brasil tal qual o do Palmer... conforme o acordo assinado entre a FEEVALE e o Palmer College.” “O curso de preparação de docentes era de dois anos com oito meses no Palmer College... todo mês vinham professores do Palmer College ministrar as aulas presenciais, as aulas práticas e as provas.” “A FEEVALE honrou o convênio firmado com o Palmer College por 10 anos, até 2007, essa parceria foi muito importante para dar o fundamento da formação em quiropraxia no mesmo padrão que é praticado nos EUA.” “Algumas escolas Norte Americanas, principalmente as vinculadas aos dois primeiros cursos no ano de 2000, Palmer College e Western States, cederam toda documentação dentro das orientações daquilo que era aplicado nos Estados Unidos, desenvolver o mesmo o mesmo modelo nos primeiros cursos no Brasil.” “A coordenação do primeiro curso de graduação em quiropraxia na universidade FEEVALE foi gerido conjuntamente por dois coordenadores, um brasileiro que passou pelo curso de capacitação de docentes no projeto FEEVALE & Palmer College, e, uma coordenadora do próprio Palmer College of Chiropractic, presencial na FEEVALE...” “... para graduação em cinco anos de curso com as adaptações necessárias ao exigido pelo padrão internacional de formação em quiropraxia e o MEC... sem qualquer referência no Brasil...” “... a Universidade Anhembi Morumbi, que também iniciou o curso pioneiro de quiropraxia em SP na mesma época de 2000 também em parceria com outras universidades americanas.” “... foi enviado para o MEC o modelo que evoluímos para a avaliação do curso que conquistou o seu reconhecimento a partir de comissões de avaliadores que o MEC enviou para a FEEVALE e UAM, gerando sucessivas renovações de reconhecimento até hoje, ...” “Com a publicação das Diretrizes da OMS, tivemos mesas de conversas com toda estrutura gestora da FEEVALE e UAM, os pró-reitores de graduação das duas faculdades e com organismos internacionais, ficamos preocupados com a validação internacional do curso, ... de que no nosso curso tivesse a robustez para formar profissionais quiropraxistas, como tem que ser, com todas as exigências internacionais.” “... a nossa carga horária era mais extensa que a proposta pela OMS... chegamos ao consenso de ter no Brasil como referência para formação de quiropraxistas, o descrito nas Diretrizes da OMS sem perder o reconhecimento internacional do nosso curso.”

Tema 4 (T4) Estruturação do PPC dos cursos pioneiros no Brasil	
	“... a coordenação do curso de quiropraxia da FEEVALE e da UAM eram muito próximas, as reitorias das duas universidades se conversavam... ...os alunos dos dois cursos faziam viagens para promover seminários na área, e as coordenações dos dois cursos eram bem participativas...” “...na mesma época, porque sofriamos lobbies contrários muito fortes da parte do conselho de fisioterapia até dentro do MEC para dificultar ou impedir o reconhecimento dos cursos e principalmente a regulamentação da profissão no Congresso Nacional...” “A ciência baseada em evidência foi a base do curso de quiropraxia da UAM... os alunos de quiropraxia tinham aulas junto com os alunos de medicina, tinham aulas junto com os alunos de enfermagem, junto com os alunos de biomedicina, e todo mundo sabia o que era quiropraxia a partir do momento que a gente explicava, explicar isso de um ponto de vista mais científico ajudou muito a criar esse respeito e essa colaboração com as outras profissões.” “O MEC demorou um tempo para fazer a nossa visita, porque eles estavam tentando achar pessoas que tivessem o conhecimento suficiente sobre áreas parecidas com a quiropraxia... ...eles tinham perguntas básicas do que era a quiropraxia, de como funcionava as aulas, mesmo alguns deles sendo de áreas similares da área da saúde.” “Procuramos manter a carga horária de estágio mínima, a quantidade de horas mínimas também em relação à educação básica, as vertentes em relação às disciplinas práticas, buscamos manter mais ou menos a mesma qualidade do que existe internacionalmente, de acordo com aquilo que é exigido pelo MEC e pelas instituições aqui do Brasil.” “A Universidade goza de autonomia plena para as decisões.a opção aqui da Universidade sempre foi se balizar na concepção do curso de acordo com o que diz as DCN gerais da área da saúde.” “...temos um parecer do Conselho Nacional de Saúde que tangencia a formação do profissional na área da saúde. Esse é o nosso primeiro referencial, ...” “... a gente também segue algumas diretrizes mais gerais da formação de várias profissões da área da saúde... ...Na quiropraxia, entendemos que existe um documento balizador que é da Organização Mundial da Saúde que baliza o curso com 4 mil e 200 horas. Então a universidade respeita esse documento da Organização Mundial da Saúde e define a carga horária mínima da formação em quiropraxia em 4 mil e 200 horas...” “...Os conteúdos, eles são definidos também com base no documento da Organização Mundial da Saúde e as ementas são construídas com o suporte do NDE, dos quiropraxistas do curso, e o referencial bibliográfico disponível. É assim que a gente opera aqui em termos de organização e gestão do curso de quiropraxia, mesmo não tendo uma diretriz curricular nacional específica.” “Fomos contatados várias vezes pelo pessoal do Conselho Latino-Americano de Educação em Quiropraxia para discutirmos uma espécie de chancela de certificação alinhada com as diretrizes que o CCE-La desenvolveu mais alinhada com a realidade da América Latina... ...mas inda não concluímos essa questão com o CCE-La que está sobre a mesa... ...Na ausência de DCN, o que temos como parâmetro, são as diretrizes da OMS.” “Pela ausência de uma DCN oficial, tivemos a liberdade para desenvolver o PPC do curso da forma que entendemos ser a melhor... ...seguindo as normas

Tema 4 (T4) Estruturação do PPC dos cursos pioneiros no Brasil	
	institucionais, somamos com a diretriz da ABQ sugere.” “... o desafio está sendo muito forte na questão da presencialidade de muitas disciplinas práticas. Esse é o grande desafio de hoje, onde a gente vê uma grande parte dos cursos caminhando mais para um outro lado, o lado remoto, estamos tentando trazer um curso com um aspecto mais presencial.”

Fonte: Elaborado pelo autor

A gênese pedagógica dos cursos pioneiros (FEEVALE e UAM) é descrita pelos sujeitos como um esforço de transposição cultural e acadêmica, em que a falta de docentes nacionais exigiu um modelo de capacitação de docentes assistida por universidades americanas. Esta triangulação evidencia que o rigor inicial das matrizes curriculares, com forte presencialidade e supervisão, buscava suprir a inexistência de uma DCN, conforme detalhado no capítulo 4 sobre os convênios internacionais. As falas ratificam que a ciência baseada em evidências e os fundamentos filosóficos foram amalgamados para garantir o respeito de áreas correlatas, embora a atual tendência de despresencialização das disciplinas práticas seja apontada como um retrocesso à robustez curricular outrora estabelecida.

Quadro 15 - Categoria II: resultados do Tema 5

Tema 5 (T5) Vantagens e desvantagens do curso inovador e experimental pelo MEC na formação e o exercício profissional da quiropraxia	
Perguntas: p9, p11, p16, p19, p30, p32, p33, p39, p45, p47, p65, p73, p78, p80, p83, p89 e p91. Pontos chave: • Adaptação a cultura acadêmica brasileira e demanda social; • Não obrigatoriedade de coordenador quiropraxista; • Horas de estágio; • Quantidade de professores por número de alunos; • Reconhecimento público; • Dificulta regulamentação; • Sem obrigatoriedade curricular mínima; • Formados sem reconhecimento internacional;	Entrevistados: B4; B6; C2; C5; E1, E3; E4; F2; G3; G5; I2; J3; J8; K2; K5; L1 e L3 “Uma das vantagens é justamente a autonomia que permite fazer com que a quiropraxia se reporte mais aquilo que é culturalmente aceito em relação ao Brasil...” “... não tendo uma DCN, nos da flexibilidade de abordar certos pontos que faz mais sentido para o Brasil como um todo.” “... uma das grandes desvantagens em não ter DCN se configura quando a gente não tem um profissional quiropraxista na linha de frente na condução dos cursos de graduação... não conhece quiropraxia como um quiropraxista conhece, e aí não entende a necessidade de você ter mil horas de estágio, não entende a necessidade, muitas vezes, de você ter um professor dando assistência para 20 alunos durante uma aula prática...” “... hoje, nós temos uma realidade de um professor para 60 alunos. Então, você tem a perda da qualidade e acaba fugindo muito em relação ao que se espera de um profissional realmente formado em curso superior na área da saúde...” “... só o quiropraxista sabe como deveria ser a formação de um outro quiropraxista também.” “Infelizmente a maioria das universidades brasileiras não procuram o CCE-La para ter aporte na estrutura dos seus cursos.”

Tema 5 (T5)	
Vantagens e desvantagens do curso inovador e experimental pelo MEC na formação e o exercício profissional da quiropraxia	
• Cursos sérios; • Cursos à distância e por vídeo; • Cursos em DVD; • Impacto na identidade da profissão; • Segurança do paciente; • Concorrência acadêmica desleal; • Confunde o público; • Necessidade de comprovação social pela necessidade de DCN; • 25 anos como experimental; • OMS X Soberania Nacional; • Desmotiva criação de novos cursos universitários; • Confunde técnica e profissão; • Disparate na base curricular entre os cursos; • Falta de padronização; • Fase experimental vencida; • Formação aquém do que deveria por falta de DCN; • Avaliadores do MEC sem conhecimento; • Sem norte para o PPC; • Sem regra para forma profissional da saúde de primeiro contato; • Formar profissionais com as competências necessárias na Saúde Pública; • Necessidade de seguir o standard da profissão mundialmente.	“... nós da quiropraxia fomos provocados a criar uma matriz como proposta de DCN para quiropraxia, e foi daí que reorganizamos o PPC da quiropraxia, de uma matriz que a universidade desenvolveu para o curso de quiropraxia.” “... o nosso curso mantém alto padrão de formação desde o início, o problema é que sem uma DCN para formação de quiropraxistas, ocorre o que temos visto por aí, uma série de cursos sem qualquer critério, de curta duração, ministrados até a distância e por vídeo, isso impacta diretamente toda a estrutura da profissão organizada a mais de um século nos EUA com uma base acadêmica extensa, impacta a identidade da profissão, e principalmente a segurança ao paciente.” “Em termos de concorrência mercadológica para o egresso, não é tão bom, porque da mesma forma que ao entrar entra no portal do MEC para abrir um curso de bacharel em quiropraxia, tu podes abrir um curso de tecnólogo em quiropraxia, também de caráter experimental, e tu pode abrir uma pós-graduação de quiropraxia em caráter experimental, tudo dentro da plataforma do MEC.” “...o fato de estar em caráter experimental abre uma lacuna muito grande... ...isso confunde muito a pessoa, e, ao mesmo tempo, abre uma concorrência, de certa forma desleal... ...pensando na instituição que quer fazer a coisa certa dentro dos critérios mínimos necessários para formação em quiropraxia...” “A maioria dos nossos alunos que a gente recebe, vem por indicação de outros alunos ou das instituições que representam a profissão no Brasil. Fora isso, quando um candidato, leigo, entra na internet para pesquisar a respeito, muitas vezes ele vai para um outro caminho que não é o caminho do bacharelado, justamente por causa dos cursos no Brasil estarem nesse caráter experimental e inovador do MEC a mais de duas décadas...” “...fragiliza a identidade da educação em quiropraxia e da própria profissão e mais ainda, confunde o público quanto o que propõe essa profissão da área da saúde tão importante e reconhecida mundialmente.” “25 anos atrás, essa era uma demanda social importante... ...a questão do curso experimental permite que sejam criados cursos a partir das demandas emergentes da sociedade.” “...desvantagem... ...é o fato de não se ter uma normativa institucional... ...a gente já tem 25 anos de existência de curso, está mais do que na hora de termos uma DCN, para formalizarmos esse processo de formação profissional dentro do Brasil...” “...têm um certo comprometimento com aquilo que é preconizado fora do país, em termos de Organização Mundial de Saúde, que são as diretrizes que a gente segue na hora de elaborar o curso de quiropraxia, mas falta o delineamento da questão nacional, e aí realmente fica complicado até para inserção de novos cursos, que têm um comprometimento com um curso de alta qualidade, dentro dos parâmetros também reconhecidos mundialmente.” “...prejudica a visão do quiropraxista e da população em relação ao quiropraxista... ...uma parte da nossa população não tem conhecimento suficiente para conseguir fazer a distinção de um bom profissional com uma formação adequada daquele que fez um curso de algumas horas...” “...vejo as DCN como uma necessidade para padronizar isso e ter uma diretriz de fato, bem desenhada. Entendo que o caráter inovador experimental deva se

Tema 5 (T5)	
Vantagens e desvantagens do curso inovador e experimental pelo MEC na formação e o exercício profissional da quiropraxia	
	aplicar a uma fase mais inicial... ..já cumprimos essa fase e deveríamos estar com a DCN delineada...” “...25 anos após o início da graduação, com milhares de profissionais formados... ..deveríamos estar em uma terceira fase. A segunda fase, seria já ter as DCN bem delineadas, e atualmente já até sendo aperfeiçoadas em mais de uma edição.” “Quando você escreve um projeto pedagógico e você mostra o que você tá fazendo, mas no caso da quiropraxia no Brasil, não tem com o que comparar, ou o que você tá comparando não é exatamente a mesma coisa que você tá fazendo, fica complicado para você mostrar que tudo que você tá fazendo tá certo, então é principalmente porque o MEC vem, é para ter certeza de que tudo que você está fazendo tá certo, mas o que ele tem como base de comparação não é exatamente o que você tá fazendo...” “Imagina que você não tem regra de como formar um quiropraxista, e aí qualquer um pode ir lá e aprender a estalar as costas sem critérios adequados de diagnóstico, radiologia, e tudo mais que necessário antes de executar ajustes articulares na coluna vertebral?” “A gente está pensando na segurança da população do Brasil. A população do Brasil precisa de profissionais formados adequadamente, com um mínimo de competência ou de uma formação adequada para poder estar seguro de falar, eu vou ao quiropraxista porque eu sei que é uma profissão segura. Então, a população do Brasil precisa ter essa segurança de ir ao profissional que é formado, com um mínimo de standard, se não tem uma palavra melhor.” “Essa prerrogativa de inovador experimental nos dá liberdade para fazer uma matriz/PPC da forma que quisermos, então, seguimos as normas institucionais e as sugestões da ABQ.” “...ao mesmo tempo que o caráter Inovador e Experimental... ..nos dá a liberdade de inovar, a ausência de uma DCN, deixa tudo com rédea muito solta e sem controle, colocando em risco os pacientes e prejudicando a identidade da profissão que fica banalizada.

Fonte: Elaborado pelo autor

O regime de curso experimental (Art. 81 da LDB) é identificado nas entrevistas como uma faca de dois gumes: se foi o motor que viabilizou o nascimento da graduação, sua perpetuação por 25 anos gerou um estado de anomia regulatória. A análise dos relatos demonstra que a liberdade de inovar converteu-se em um mecanismo de concorrência desleal, permitindo a proliferação de cursos de curta duração e na modalidade EaD, que banalizam a complexidade do diagnóstico quiroprático. A fala dos entrevistados ratifica o conceito de "múnus público" de Cury (2006), ao sinalizar que o Estado, ao não homologar uma DCN, falha em sua prerrogativa de garantir o padrão de qualidade e a proteção da sociedade contra práticas profissionais precárias.

Quadro 16 - Categoria II: resultados do Tema 6

Tema 6 (T6)	
Diferença da distinção entre formação ciência baseada em evidência, versus a mais filosófica, e seu reflexo no cenário da saúde brasileira	
Perguntas: p10, p38, p46, p52, p72, p79, p89 e p90. Pontos chave: • Identidade profissional frágil; • Caráter individual do docente; • Muito viés quanto a segurança; • Terra de ninguém; • As duas vertentes dão importantes; • Mudança de paradigma com o tempo, a filosófica se tornando mais médica; • Perda da raiz Palmer; • Nova visão, soma a filosófica com a mais empreendedora; • Visão das primeiras turmas com as turmas de hoje; • Adaptação a demanda de mercado; • Demanda social modifica a raiz do curso; • Ciência baseada em evidência é o olhar contemporâneo; • Prática filosófica é raiz; • Os cursos de hoje valorizam as duas vertentes; • A escolha é do aluno; • Capacitação dos docentes Palmer = filosofia raiz; • Primeiro curso da América-Latina com filosofia muito forte; • DNA da profissão; • Filosofia e Ciência juntas dão a identidade da profissão, não tem como separar; • Foco em profissionais de primeiro contato; • Base científica como molde do profissional de hoje; • Base científica fica mais fácil de explicar a profissão;	Entrevistados: B5; F1; G4; H2; J2; K1; L1; L2. “Os alunos são formados mais na percepção que cada docente tem da profissão, isso acaba impactando em relação também à identidade profissional...” “vai muito de acordo com os profissionais que estão na linha de frente...” “... essa questão de ciência baseada em evidência ou mais filosófica, vai muito da cabeça de cada professor e como ele passa isso para os alunos, mas entendo que as duas vertentes são importantes e devem nortear a base de todo curso de quiropraxia, é por uma questão de identidade e de cientificidade que está presente na quiropraxia. “...a FEEVALE já mudou o currículo totalmente, está muito mais baseado em evidência, uma visão mais médica do que em uma visão tão quiroprática como veio do Palmer.” “...além dessa visão mais filosófica, nós temos uma visão também mais empreendedora... esse profissional tem que ter uma visão realista do mundo que a gente vive, ele tem que ter uma visão de marketing, uma visão de gestão de clínica, uma visão de modelo de negócio, uma visão de comunicação. Então, esse profissional tem que ter uma inteligência emocional realista para o profissional da área da saúde.” “É marcante o aprofundamento filosófico que os alunos das primeiras turmas tiveram e esses profissionais são muito bem resolvidos quanto a identidade da profissão...” “...qualquer curso de graduação, com DCN ou sem DCN, em vínculo experimental ou não, ele é moldado de acordo com as demandas do mercado e as demandas de que a sociedade emana.” “... nunca um curso com uma trajetória de 25 anos, como da quiropraxia ou qualquer outro curso, terá o mesmo perfil de egressos da sua primeira turma com a vigésima quinta turma.” “... hoje a gente tem um contexto formativo que é... alicerçado ao que diz os documentos da Organização Mundial da Saúde, mas com uma característica marcante, que é a questão de práticas baseadas em evidências, que é o que sustenta hoje todo o contexto formativo de qualquer profissional da área da saúde que se preze...” “...importante deixar claro que todo o contexto formativo em termos de filosofia, ele não se perdeu no currículo. O aluno tem a possibilidade de compreender tanto a base filosófica quanto a base contemporânea” “...no programa de capacitação de docentes, passamos por todas as áreas, inclusive nas clínicas, em várias disciplinas e na parte filosófica que a gente sabe que é muito forte na Palmer College, que trouxe para o currículo da FEEVALE como o primeiro da América Latina, acho que eles se basearam nisso para trazer o DNA da quiropraxia raiz...” “Não tem como separar a parte filosófica da científica, a filosofia da quiropraxia nos deu a verdadeira noção da quiropraxia segundo o próprio Palmer, o criador da profissão.” “...com o decorrer do curso, a gente foi adequando essa realidade, a realidade

Tema 6 (T6) Diferença da distinção entre formação ciência baseada em evidência, versus a mais filosófica, e seu reflexo no cenário da saúde brasileira	
• Ciência produz respeito entre profissionais das outras áreas da saúde; • Pesquisa como norte e visão de mercado; • Para a acreditação não importa, tem que obedecer aos standards; • Importa estar preparado para atender o paciente com segurança.	da educação brasileira que mesclou como uma mistura que deu muito certo... ...com certeza, as primeiras turmas tiveram uma parte filosófica bem forte. Eu acho que isso foi bem positivo para manter essa raiz, essa origem da quiropraxia que se mostra presente nos egressos do curso...” “...quando a gente começou o curso de quiropraxia, muita gente nem sabia direito o que era quiropraxia. ...a base científica da quiropraxia foi muito importante para moldar o que eu sou como quiropraxista hoje.” “...uma profissão nova, que as pessoas nunca ouviram falar, elas precisam entender se aquilo funciona ou não. Então, eu acho que a ciência baseada em evidência, que foi a base do curso de quiropraxia da UAM no início, ajudou muito a dar esse respaldo... ...foi muito importante para dar o prestígio e o entendimento do que a profissão é e o que um quiropraxista faz. Inclusive, gerou muito respeito dos colegas dentro da universidade...” “...os alunos de quiropraxia tinham aulas junto com os alunos de medicina, tinham aulas junto com os alunos de enfermagem, junto com os alunos de biomedicina, e todo mundo sabia o que era quiropraxia a partir do momento que a gente explicava, e eu acho que explicar isso de um ponto de vista mais científico ajudou muito a criar esse respeito e essa colaboração com as outras profissões.” “... um cenário mais recente, foi a questão da pesquisa em si, pelo que eu entendi, é algo opcional, já que a UAM não exige TCC.” “... nos Estados Unidos as creditações são bem, rigorosas, ainda assim eles têm que cumprir os standards mínimos necessários para comprovar, não importa o que eles pensam da quiropraxia, eles têm que obedecer aos standards necessários para que a comunidade saiba que eles estão prontos para atender os pacientes com segurança... ...independe da forma como pensam a profissão, que possam ajustar sem trazer risco ou algo que não seja prudente na saúde dos pacientes.” “...não importa se no Brasil tem cursos no formato vitalista e outros mais ciência baseada em evidências, isso não exclui que os cursos tenham que seguir um currículo mínimo necessário descrito nos standards, como forma de prevenção com menor risco para a população.”

Fonte: Elaborado pelo autor

As narrativas coligidas indicam que a dicotomia entre filosofia e ciência é mais estética do que prática no contexto da saúde pública, uma vez que a competência clínica deve ser o denominador comum. Contudo, a triangulação com o processo histórico revela que a identidade raiz (Palmer) foi o que conferiu ao quiropraxista brasileiro seu DNA profissional e o diferencial ético frente às tentativas de absorção pela fisioterapia. Os sujeitos advertem que a perda dessa essência filosófica nas matrizes curriculares recentes, em favor de uma visão meramente mecanicista ou comercial, compromete a formação de um profissional de saúde de primeiro contato autônomo, reforçando que a DCN deve salvaguardar tanto o rigor científico quanto a

base epistemológica da profissão.

A “Categoria III - Legalidade e legitimidade da formação e prática da quiropraxia no cenário brasileiro X necessidade de DCN e regulamentação profissional”. Aborda a temática da ocasião da introdução da formação universitária em quiropraxia ancorada no modelo mundial de educação na área, restou evidente tratar-se de um novo paradigma no bojo que abarca as profissões da área da saúde no país.

Nasce um divisor de águas no processo histórico da profissão no cenário brasileiro delineado para antes e a partir do ano de 2000, quanto a até pouco antes definida popularmente como quiropatia ou quiroprática, a formação em solo nacional se dava na forma de cursos livres ministrados por professores, na sua maioria, práticos sem formação universitária e tão pouco na área específica da quiropraxia. Criou-se a ideia de a quiropraxia ser sinônimo da técnica de manipulação de coluna, não vinculada a uma formação universitária na área da saúde estruturada mundialmente a mais de um século em dezenas de países onde a formação e a prática do ofício são fiscalizadas e controladas por órgãos oficiais.

O regramento legal da educação universitária no país permitiu o curso de capacitação de docentes numa parceria entre universidades brasileiras e norte-americanas para estruturação do bacharelado em quiropraxia dentro do consenso mundial para formação na área. Contudo, o tempo abre janelas aos desafios para estruturação de parâmetros curriculares mínimos sugeridos pela OMS que visam a segurança dos pacientes assistidos por profissionais quiropraxistas. Tais parâmetros são afrontados com a cultura corporativista da autarquia da fisioterapia ao criar uma frente de batalha na linha política institucional junto ao legislativo, executivo e até judiciário numa briga de mercado pelo direito do fisioterapeuta se identificar como quiropraxista.

Paralelamente ao universo político corporativista da autarquia da fisioterapia, tem-se os práticos informais, também denominados pioneiros, que atuam no mercado com atendimentos e, em muitos casos ministrando cursos livres, se identificando como quiropraxistas.

A triangulação das perguntas da Categoria III foram subdivididas em seis Temas:

- a) Tema 7 - Impacto legal na percepção pública quanto a identidade do profissional quiropraxista, causado pela falta de DCN e não a regulamentação da profissão Brasil
- b) Tema 8 - Necessidade de a formação evoluir para uma DCN
- c) Tema 9 - Papel das DCN
- d) Tema 10 - Interferência da autarquia da fisioterapia
- e) Tema 11 - Obstáculos que pesam contra a aprovação dos PL e DCN
- f) Tema 12 - Relevância do reconhecimento da quiropraxia junto ao MEC, CBO, SUS, CNAE perante o cenário brasileiro

Quadro 17 - Categoria III: resultados do Tema 7

Tema 7 (T7) Impacto legal na percepção pública quanto a identidade do profissional quiropraxista, causado pela falta de DCN e não a regulamentação da profissão Brasil.	
Perguntas: p8, p9, p18, p19, p35, p36, p40, p45, p66, p81 e p86. Pontos chave: • Formação livre e sem controle; • Público não sabe que é formação universitária; • Fragilidade na formação da identidade da profissão; • Confunde técnica de manipulação da coluna e não como uma profissão; • Critério de fiscalização e controle; • Standards CCE-La; • Capacidade de diagnóstico diferencial; • Qualquer um pode atender como quiropraxista; • Representada por uma associação de classe somente; • Curso superior na área da saúde deve ter DCN; • Sem DCN nem o MEC controla; • 25 anos experimental, tem demanda social para ter DCN; • Diretriz da OMS é recomendação, tem que haver regramento legal no país; • Público não sabe se está sendo atendido por profissional capacitado ou profissional de curso de fim de semana; • 31 competências para formar quiropraxista mundialmente; • No Brasil não tem legalmente nada para guiar a formação do profissional; • Primeiros cursos em 2000 com padrão mundial, hoje está muito abaixo; • Autonomia do	Entrevistados: B3; B4; C4; C5; E6; E7; F3; G3; I3; K3 e K8. “A falta de uma DCN, e de uma regulamentação por lei específica, interfere na identidade do profissional... ..o profissional acaba sendo moldado de acordo com as pessoas que instituíram aquela grade ou instituíram aquela linha de conhecimento.” “... Quando o paciente procura quiropraxia, ele não procura muitas vezes um profissional graduado, ele vai procurar um profissional técnico, um profissional que faz a terapia manipulativa, por exemplo, que hoje, querendo ou não, é muito associado ao que é quiropraxia, esse é um sério problema de identidade da profissão no Brasil.” “... quando a gente não tem muito instituído que realmente é necessário um curso superior para ser um quiropraxista, está muito associado à técnica de tratamento e não efetivamente à profissão.” “... qualquer pessoa que tem um cursinho de final de semana e faz a técnica poderia ser chamada de quiropraxia...” “Aqui eu posso atuar porque minha formação atende os requisitos dos standards do CCE, para atuar tem regras que a formação tem que atender, e isso demonstra uma profissão independente dentro do departamento de educação.” “... essas regras eleva o padrão de ensino completamente porque as universidades têm que ter a acreditação dos seus cursos no CCE e torna a formação confiável. Esse cuidado está 100% focado na segurança do paciente e na identidade da quiropraxia.” “Definitivamente não estar seguindo os standards corroborados em todo o mundo compromete a saúde das pessoas... ..um currículo acreditado pelo departamento de Educação... ..está dizendo ao público que esse profissional de saúde... ..pode fazer um diagnóstico diferencial que lhe proporcione um diagnóstico correto e assim dar um tratamento bem definido e seguro ao paciente...” “... tem que ter conhecimentos mínimos necessários para ser uma pessoa responsável com ética e não ser um risco para o cidadão.” “... A gente esclarece para os alunos, que a quiropraxia ainda não é uma profissão regulamentada no Brasil, porém, ...o fato de ela não ter uma regulamentação, não existe nada que impeça um bacharel em quiropraxia de exercer a profissão no país.” “... não existir nenhuma lei que proíba alguém de ser quiropraxista, abre brecha para os que não têm uma graduação na área, de se colocar como quiropraxista sem que haja qualquer controle disso, isso complica a identidade da profissão e coloca em risco o paciente.” “... sempre que tem um questionamento, por exemplo, ou algum aluno que quer se aprofundar nessas questões externas a formação acadêmica, nós o reportamos para a ABQ.” “Por não ter DCN, não existe uma regra, pode ser um curso de horas... ..um curso aí de 12 horas, uma parte online, ou totalmente online, e a gente não tem

Tema 7 (T7) Impacto legal na percepção pública quanto a identidade do profissional quiropraxista, causado pela falta de DCN e não a regulamentação da profissão Brasil.	
profissional pedir exame e encaminhar.	como controlar isso...” “... nem mesmo o Ministério da Educação pode controlar, justamente por não existir DCN ...” “... não deveria ser mais um curso de caráter experimental, a gente já tem 25 anos de existência de curso, está mais do que na hora de termos uma DCN, para esse processo de formação profissional dentro do Brasil...” “...as instituições que existem, elas têm um certo comprometimento com aquilo que é preconizado fora do país, em termos de Organização Mundial de Saúde, que são as diretrizes que a gente segue na hora de elaborar o curso de quiropraxia, mas falta o delineamento da questão nacional...” “... prejudica a visão do quiropraxista e da população em relação ao quiropraxista, porque... ... a população, vai atrás do quiropraxista, mas, uma parte da nossa população não tem conhecimento suficiente para conseguir fazer a distinção de um bom profissional com uma formação adequada daquele que fez um curso de algumas horas e não tem um embasamento para um diagnóstico diferencial, e isso coloca, na mesma posição o quiropraxista, que contempla uma diversidade de técnicas, que tem todo um embasamento fisiológico, biomecânico, que tem a capacidade de um diagnóstico diferencial, que tem uma filosofia na hora de atender o seu paciente, com aquele profissional que, na verdade, usa a quiropraxia como se a quiropraxia fosse uma técnica e não uma profissão.” “... nos EUA... ... não se fala mais em quantas horas o curso de quiropraxia precisa ter. ... fala sobre as competências que um quiropraxista precisa... ... 31 competências que o quiropraxista/aluno precisa atingir ...” “... no Brasil não existe referência, a gente não tem nada para guiar, por isso se criou essa base no início dos cursos pioneiros de graduação em quiropraxia em parceria com universidades dos Estados Unidos, justamente para dar uma estrutura mínima para começar e formar profissionais competentes, esperando evoluir sempre ...” “A base que a gente tem hoje no Brasil não é específica para o curso de quiropraxia, ela é muito geral, e a importância de você formar um quiropraxista seguro, ... é uma questão de saúde pública, você tem que ter profissionais competentes para que o público esteja protegido se você não tiver profissionais competentes, você põe o público em risco.”

Fonte: Elaborado pelo autor

A visão dos entrevistados sobre o impacto legal na percepção pública quanto à identidade do profissional quiropraxista, causado pela falta de DCN e pela não regulamentação da profissão no Brasil, recai fortemente na preocupação de que no Brasil não tem legalmente nada para guiar a formação do profissional quiropraxista.

De fato, os entrevistados afirmam que a formação no país é livre e sem controle, e que o público em geral não sabe que o quiropraxista é um profissional de formação universitária com competência técnica de primeiro contato na saúde pública.

Confunde-se prática profissional como meramente uma técnica de manipulação da coluna vertebral e como uma profissão estruturada mundialmente, com critérios de formação e segurança para o atendimento público, com capacidade de diagnóstico diferencial e autonomia para solicitar exames da conduta quiroprática e encaminhar para demais profissionais da saúde, quando for o caso.

Não existe critério de fiscalização e controle tanto da formação quanto da prática profissional, não há nada que impeça qualquer um de atender como quiropraxista, mesmo sem formação adequada na área. Em geral, a fragilidade na formação da identidade da profissão causada pela falta de regramento legal, através de DCN e regulamentação por lei, faz com que o público não saiba se está sendo atendido por profissional capacitado ou profissional de curso de fim de semana.

No Brasil, como não há um órgão fiscalizador, toma-se como ponto de referência a Associação Brasileira de Quiropraxia (ABQ), uma entidade sem fins lucrativos vinculada à Federação Latino-Americana (FLAQ) e à Federação Mundial de Quiropraxia (WFC), mas não é autarquia e tampouco órgão executivo, trata-se de uma associação de classe que representa seus associados bacharéis quiropraxistas em suas demandas pela estruturação da profissão no país.

O regramento acadêmico mais sólido está nas Diretrizes da OMS para Formação Básica e Segurança em Quiropraxia, entidade da qual o Brasil é signatário, mas na sua soberania nacional, o país é desobrigado de seguir tais recomendações. Todo curso superior na área da saúde deve ter DCN, pois sem DCN, o MEC não consegue controlar com o devido rigor os cursos que por 25 anos estão formando quiropraxistas dentro da categoria de curso “inovador e experimental”.

Os entrevistados relatam que os primeiros cursos em 2000 foram formatados dentro do padrão mundial de educação em quiropraxia, mas atualmente os cursos brasileiros estão muito aquém das competências mínimas exigidas nos *standards* mundiais. Diferentemente dos cursos pioneiros em quiropraxia, que se valeram da viabilidade de inovador e experimental há 25 anos, atualmente temos a demanda social para formação e necessidade pública comprovada, o que ratifica a necessidade de DCN segundo modelo sugerido nos *standards* do CCE-LA.

Quadro 18 - Categoria III: resultados do Tema 8

Tema 8 (T8)	
Necessidade de a formação evoluir para uma DCN	
Perguntas: p12, p17, p28, p34, p35, p42, p48, p50, p58, p61, p62, p68, p74, p83, p85 e p94.	Entrevistados: B7; C3; D5; E5; E6; F5; G6; G8; H8; H11; H12; I5; J4; K5; K7 e L6.
	“... por não ter a DCN, não tem a obrigatoriedade de um coordenador de curso, por exemplo, específico... não entende a necessidade de você ter

Tema 8 (T8) Necessidade de a formação evoluir para uma DCN	
Pontos chave: • Coordenador de curso e professores sem titulação legítima na área; • Pesquisadores na área específica; • Qualidade e competência profissional; • Mérito educacional no embate político, na comissão de educação está o maior entrave de momento; • Interferência da autarquia da fisioterapia; • Cursos sem critérios mínimos até por vídeo; • Compatibilidade com a estrutura mundial da profissão; • Relevância do conhecimento mínimo para atuar na saúde pública; • Dúvida sobre a qualificação dos profissionais; • Sem DCN, os cursos têm muita liberdade para modificar o currículo; • Proposta de DCN na ABQ; • Baixa adesão nos cursos que seguem as diretrizes da OMS, devido a fragilidade na identidade da profissão; • Os desinformados buscam cursos rápidos de final de semana ou online; • Sem DCN fica difícil competir com os cursos ilegítimos; • Mestrado e doutorado profissionalizante; • Programas de pesquisa com mestres e doutores quiropraxistas; • Por falta de conhecimento o candidato busca cursos baratos de poucas horas e pode atuar livremente; • Padrão mundial de 1000 horas de estágio supervisionado.	mil horas de estágio, ... ter um professor dando assistência para 20 alunos durante uma aula prática...” “... tem a perda da qualidade e acaba fugindo muito em relação ao que se espera de um profissional realmente formado em curso superior na área da saúde... só o quiropraxista sabe como deveria ser a formação de um outro quiropraxista também...” “... acaba tendo uma dificuldade muitas vezes em uma instituição, em uma universidade, de levar a quiropraxia como uma profissão independente internamente também ...” “... acaba esbarrando muito na questão da regulamentação, na questão política da gente ser realmente uma profissão independente ...” “... no legislativo, o embate mais forte está justamente na Comissão da Educação... as DCN já vêm com um desenho próprio do regime de educação brasileiro ...” “... a profissão de quiropraxista é estudada pelos parlamentares desde 2001, e se o CNE disser sim as diretrizes curriculares para quiropraxia, ... fica vencida a questão educacional da profissão junto a Comissão de Educação que terá às mãos um documento sólido que revela o necessário para os parlamentares daquela comissão votarem a favor da matéria com mérito.” “... o Conselho de Fisioterapia não quer aceitar que a quiropraxia no Brasil seja regulamentada conforme sua estrutura mundial a mais de um século ... o presidente da república em 1969 fez um decreto e determinou a criação da profissão por lei, não passou por todo escrutínio em todas as comissões de mérito no legislativo federal ...” “... a quiropraxia tem sido escrutinada de todas as formas, virada do avesso, passando por esse processo cansativo a mais de duas décadas. Então, não há dúvidas que uma DCN homologada pelo Ministro da Educação, pode dar um aporte muito importante ao processo de regulamentação da profissão no país.” “Ter a DCN clara sobre a formação em quiropraxia, vai ajudar com que a quiropraxia cresça e que a qualidade do ensino dos quiropraxistas no Brasil se mantenha dentro dos padrões mínimos referendados pela OMS.” “... estamos, primeiramente, preocupados com o aprendizado dos alunos.” “... a DCN trará segurança e nível de conhecimento mínimo para atuação na saúde pública. Porque o que garante, hoje, o conhecimento mínimo necessário para ser um bom quiropraxista? A gente não tem uma garantia.” “... quando você não tem um documento claro, uma regra clara, acaba que isso pode deixar duvidosa a formação desses profissionais. Isso não está certo!” “Sem DCN específica para a formação de quiropraxistas, as instituições de ensino têm muito mais liberdade para modificar os currículos.” “... vai muito da conversa e aproximação com a diretoria acadêmica da ABQ junto com os coordenadores e das pessoas responsáveis pelos cursos de quiropraxia, com a relevância de se manter o currículo dentro do mais próximo possível daquilo que foi idealizado na proposta de DCN que a ABQ

Tema 8 (T8) Necessidade de a formação evoluir para uma DCN	
	elaborou junto com seus pares quiropraxistas, e, também o mais próximo possível do que é preconizado internacionalmente.” “... Os acadêmicos de hoje buscam uma formação mais rápida e por um custo mais acessível e, muitas vezes, cursos na modalidade semipresencial ou até mesmo curso 100% online... ... tem a questão financeira e a gente também precisa assegurar que esses alunos tenham uma qualidade no seu ensino. E como fazer isso sem DCN?” “... a ausência de uma DCN gera impedimentos para a formação, por exemplo, um mestrado profissionalizante, Todos os doutores que nós temos na quiropraxia brasileira, são doutores que vêm de áreas correlatas à medida que a gente não consegue avançar com as DCN, a gente não consegue criar mestrados profissionalizantes.” “... as DCN têm que ser formalizadas... .. para que se consiga abrir um programa de pesquisa em alguma das universidades, tendo como orientadores, mestres e doutores na área da quiropraxia.” “... imagina que você não tem regra de como formar um quiropraxista, e aí qualquer um pode ir lá e aprender a estalar as costas sem critérios adequados de diagnóstico, radiologia, e tudo mais que necessário antes de executar ajustes articulares na coluna vertebral? Quantas pessoas podem se machucar e criar um outro problema porque aquela pessoa que cuidou dele inicialmente não tem uma formação adequada.” “... a população do Brasil precisa de profissionais formados adequadamente, com um mínimo de competência ou de uma formação adequada para poder estar seguro de falar, eu vou ao quiropraxista porque eu sei que é uma profissão segura. Sem DCN, não temos critérios mínimos de controle e nem rigor em relação à carga horária de curso.” “... pode ser que um curso de 400 horas ou até menos forme um quiropraxista, e esse “profissional” formado sem esses critérios vai para o mercado atender gente.” “... a exigência da presencialidade com carga horária mínima, deve ser um ponto forte na DCN da quiropraxia infelizmente, olhando o lado do business, muita gente que encontra essa brecha, oferece no mercado cursos de quiropraxia com qualquer carga horária principalmente na questão da carga horária de estágio supervisionado ...” “... além das demais situações da rede de atuação do quiropraxista, a necessidade de professores também quiropraxistas para as disciplinas de quiropraxia.” “profissionais de outras páreas da saúde que buscam fazer também o curso de quiropraxia alguns desses profissionais já atuam de maneira informal na quiropraxia em alguns casos fazem força contrária a ter que submeter-se a 1000 horas de estágio supervisionado, esse estágio supervisionado tem que ser obrigatoriamente com requisito fundamental para graduação.” “... que a coordenação dos cursos de bacharelados em quiropraxia seja sob a responsabilidade de profissional que também seja bacharel em quiropraxia, assim, além de ter que seguir a DCN, ele traz consigo a identidade da profissão e o seu lugar de fala como profissional da área nada como está na área para sentir as dores da área.”

Os entrevistados foram mais pontuais sobre a necessidade de a formação evoluir para uma DCN, destacando preliminarmente os cursos superiores de quiropraxia cujos coordenadores não possuem formação de base específica na área. Consideram a fragilidade na identidade da formação e prática da profissão no país, entendem que um coordenador sem formação específica em quiropraxia, pode ter dificuldades para compreender a necessidade do padrão mundial de 1000h de estágio clínico supervisionado e o número de alunos por sala de aula prática, impactando na qualidade do curso e na competência do profissional de forma incompatível com a estrutura mundial da profissão.

Sem DCN, os cursos têm muita liberdade para modificar o currículo, gerando fragilidade na identidade da profissão e baixa adesão nos cursos que seguem as diretrizes da OMS pela dificuldade de competir com os cursos ilegítimos, pois interessados na formação, podem buscar cursos rápidos de final de semana ou online, pela falta de informação.

Outro ponto de destaque referido pelos entrevistados é a necessidade de programas de pesquisa com mestres e doutores pesquisadores na área específica da quiropraxia. Por falta de DCN há grande dificuldade em desenvolver programas de pós-graduação para capacitar docentes na área. Os entrevistados acreditam que o mérito educacional no embate político será fortemente agraciado com a construção das DCN que passa a ser referencial para os legisladores discutirem a matéria com critério técnico mais aprofundado, contrariando o viés corporativista por parte das autarquias que tentam impedir a estruturação da profissão no país.

Quadro 19 - Categoria III: resultados do Tema 9

Tema 9 (T9) Papel das DCN	
Perguntas: p4, p42, p44, p64, p67, p85, p86, p87 e p92. Pontos chave: • Base da formação com padrão educacional; • Equidade com a formação internacional; • Consonância com a OMS; • Rigor na segurança em saúde pública; • Ética na formação e prática da profissão; • Valorização do conhecimento técnico adequado; • Exigência de clínica escola adequada; • Mil horas de estágio supervisionado; • Comunicação coerente	Entrevistados: A4; F5; G2; I1; I4; K7; K8; K9 e L4. “... como em alguns países onde não tem esse controle, corre o risco de não se prezar tanto pela qualidade de base da formação ... se preocupam mais com o título para poder atuar em uma ciência de primeiro contato que exige sobretudo, segurança.” “... virá de exemplos de outros países onde os seus programas educacionais em quiropraxia estão estabelecidos já faz muitos anos ... que é reconhecido dentro dos padrões de segurança na área internacionalmente ...” “Exigir requisitos mínimos para formação de um quiropraxista, que seja baseada num consenso do que é praticado mundialmente a mais de um século ...” “... o MEC é autônomo e existem regras que são do ensino na área da saúde no Brasil, mas pelo menos temos uma referência importante e reconhecida no mundo todo que é o consenso para os requisitos mínimos para formar um quiropraxista e a própria diretriz da OMS.” “... que sejam formados quiropraxistas éticos e com conhecimento técnico

Tema 9 (T9) Papel das DCN	
(propaganda e marketing); • Exigência de coordenação e professores formados em quiropraxia; • Investimento em tecnologia; • Exigência de pesquisa e extensão; • Fiscalização e controle; • Respeito ao rigor das 31 competências; • Referendado pelo standard mundial; • Identidade profissional.	para prestar serviços adequados ao seu paciente, com toda segurança, isso é o mínimo que a DCN deve contemplar.” “... clínica adequada para receber os pacientes, local adequado, mantendo a segurança de saúde, como tem que ser para que o curso funcione num primeiro momento, e inovando sempre de forma gradativa, mantendo o padrão em tudo que é necessário na formação adequada em quiropraxia.” “A ética deve ser um dos pontos principais em toda sua abrangência, desde a contratação dos professores, a divulgação, a relação com a sociedade e demais profissionais da saúde, na comunicação coerente.” “Investir na qualidade docente, na formação docente ... para o docente poder transmitir seus conhecimentos para o aluno de forma legítima, sendo um verdadeiro conhecedor da identidade da quiropraxia.” “... formação robusta, com o máximo de segurança para o aluno desenvolver as suas atividades, puxar tudo que puder da tecnologia na área da quiropraxia para que o aluno saia realmente preparado ...” “Qualquer entidade que queira fornecer o curso de quiropraxia, deveria ter uma DCN como referência para estruturação de seu curso.” “... profissionais formados adequadamente, com um mínimo de competência ...” “... a população do Brasil precisa ter essa segurança de ir ao profissional que é formado, com um mínimo de standard ...” “... regra para a formação do profissional ... certeza de que esses benefícios vêm de pessoas que são adequadamente graduadas.” “Ao mesmo tempo que o caráter Inovador e Experimental viabilizado pela LDB nos dá a liberdade de inovar, a ausência de uma DCN, deixa tudo com rédea muito solta e sem controle, colocando em risco os pacientes e prejudicando a identidade da profissão que fica banalizada.”

Fonte: Elaborado pelo autor

O papel das DCN consiste em converter a experiência acumulada no período inovador e experimental em uma norma soberana e estável. A formalização deste múnus público do Estado deve estabelecer critérios soberanos que exijam corpo docente com formação específica, investimento em tecnologia e o fomento à pesquisa e extensão, garantindo que o egresso seja um profissional tecnicamente apto e operando em consonância com os *standards* do CCE-LA. Em última instância, a DCN funciona como um filtro contra a oferta acadêmica de baixa qualidade, coibindo a fragmentação da identidade profissional e assegurando uma comunicação social coerente e ética perante a coletividade brasileira.

Quadro 20 - Categoria III: resultados do Tema 10

Tema 10 (T10)	
Interferência da autarquia da fisioterapia	
Perguntas: p23, p26, p27, p36, p41, p54, p55, p68, p71, p84 e p93. Pontos chave: • Claro consenso mundial; • Profissão autônoma; • Federação Mundial de Fisioterapia diz que são profissões distintas; • Brasil é signatário da OMS/OPAS; • Universidades devem trabalhar a educação e a identidade da profissão; • Promover conscientização junto as autoridades do setor educacional do país; • Falta profissional quiropraxista comprometido com a pesquisa; • Praticar os standards para melhorar o padrão de formação e conscientização de massa; • Educação é a base; • União da classe; • Fortes lobbies da fisioterapia; • Capital político da fisioterapia; • Duas frentes de embate: Legislativo e no CNE contra DCN; • Entre 2008 e 2010 pedido de DCN por IES, COFFITO é ouvido pelo CNE que não ouviu os quiropraxistas; • Falta de informação consistente aos que decidem questões importantes para profissão; • Não existe impedimento para o exercício da quiropraxia no Brasil; • Sem DCN e lei, abre oportunismo; • Cursos de quiropraxia reconhecidos pelo MEC também têm curso de fisioterapia;	Entrevistados: C9; D3; D4; E7; F4; H4; H5; I5; J1; K6 e L5. “... o mais importante de tudo é o que a Organização Mundial da Saúde diz sobre a quiropraxia como uma profissão autônoma, que não é uma especialidade está mundialmente bem claro, a quiropraxia não é uma especialidade de nenhuma outra profissão ...” “... independente da autonomia do país, que deve ser respeitada, o Brasil é membro da OMS através da OPAS, então, em termos de estrutura de cuidados na saúde, muito mais que a autarquia da fisioterapia, que tem seu importante papel para com os fisioterapeutas do Brasil, a OMS traz o padrão do consenso mundial da identidade da quiropraxia como profissão de formação universitária autônoma na área da saúde como é em todo o mundo, não tem como a quiropraxia no Brasil não seguir sua tradição mundial.” “Quando o Brasil definir que a educação em quiropraxia siga os padrões/standards mundiais da profissão e seja criada diretrizes aprovados pelo Ministério de Educação do Brasil, vai ser muito mais fácil ter pessoas de alto nível que ajudem a legalizar a quiropraxia no Brasil.” “Tem que começar a trabalhar a educação e a identidade da quiropraxia no Brasil, as faculdades precisam trabalhar isso para que a população e as autoridades entendam que a quiropraxia não é somente para ajustar articulações falta quiropraxistas conscientes da identidade da profissão desenvolvendo pesquisas, atuando na política, nos departamentos de saúde.” “... o CCEI e a WFC também podem ajudar, mas as universidades têm que praticar os standards da educação em quiropraxia... .. a base é uma estrutura de educação quiropraxia adequada no Brasil.” “... o principal embate está politicamente em duas frentes: Numa forte oposição na Comissão de Educação que sofre interferência do Conselho de Fisioterapia que lança dúvidas sobre a legitimidade dos diversos cursos de formação universitária em quiropraxia no Brasil... .. sempre forçando o embate que leva ao trancamento de pauta, pedidos de Audiências Públicas na maioria das vezes vazias e sem efeito, que são utilizadas como mecanismo regimental numa estratégia da oposição para trancar a matéria ...” “... os representantes do Conselho de Fisioterapia, são muito presentes nos bastidores do legislativo com equipes de assessores parlamentares que visitam os gabinetes, eles representam centenas de milhares de fisioterapeutas brasileiros que se traduz por centenas de milhares de eleitores ...” “... a força política que pesa sobre uma profissão de quiropraxista que embora legítima, ainda detém pouca massa crítica de eleitores se comparados com o volume de fisioterapeutas no país, esse capital político é a forma de convencimento para trancar a matéria ...” “... mesmo assim, os PL da quiropraxia têm evoluído na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, tem parlamentares que são mais estreitos com os interesses corporativistas dos fisioterapeutas, mas tem outros que ao entender da estrutura acadêmica para formação profissional da quiropraxia já reconhecida pelo MEC a tanto tempo, tornam-se afetos ao pleito da quiropraxia e a coisa caminha, a paços lentos, mas sólidos.” “... a segunda frente de interferência do Conselho de Fisioterapia, é junto ao Conselho Nacional de Educação na tentativa de fixar a ideia de que a quiropraxia é uma especialidade da fisioterapia e com isso dificulta a evolução para a criação das DCN.”

Tema 10 (T10) Interferência da autarquia da fisioterapia	
• União FEEVALE, UAM e ABQ X COFFITO; • 2003 decisão judicial por não ter lei, não há impedimento à especialidade, nem ao bacharel; • Necessidade de reforçar a identidade como no início das primeiras turmas em 2000; • Profissional Fisioterapeuta e Quiropraxista; • Fator dificultador – capital político da Fisioterapia tem “budget”; • Resiliência e determinação dos alunos – rifa para ir a Brasília; • O mundo vê com estranheza a interferência política da fisioterapia nas questões da quiropraxia; • Alunos contemporâneos da quiropraxia estão sendo trabalhados para atuar com essas distinções entre as duas profissões.	“... Entre 2008 e 2010 uma das universidades pioneiras da formação em quiropraxia no Brasil, que tem seu curso reconhecido pelo MEC, protocolou um pedido de criação de DCN para a quiropraxia e o Conselho de Fisioterapia fez uma força tarefa tão intensa nesse processo, configurando, inclusive como parte ouvida, e sem que representantes da quiropraxia fossem ouvidos, o processo não prosperou, até hoje não se concluiu.” “... dificuldades no trânsito pela evolução da profissão tanto no legislativo como no executivo estão na questão política corporativista do conselho de fisioterapia interferindo no processo legítimo pleiteado pelos profissionais quiropraxistas ... e ... a falta de informação técnica consistente sobre a profissão junto aos que têm poder de decisão ...” “...o fato de ela não ter uma regulamentação, não existe nada que impeça um bacharel em quiropraxia de exercer a profissão no país não existir nenhuma lei que proíba alguém de ser quiropraxista, abre brecha para os que não têm uma graduação na área, de se colocar como quiropraxista sem que haja qualquer controle disso, isso complica a identidade da profissão e coloca em risco o paciente.” “No início do Projeto FEEVALE & Palmer College, nós tínhamos o curso de fisioterapia e de quiropraxia no escopo do centro da saúde, juntamente com a biomedicina, a fonoaudiologia, farmácia, biologia tivemos reuniões conjunta com representantes da UAM fomos discutir a questão legal com o jurídico referente a essa resolução do conselho de fisioterapia alegando que a quiropraxia seria uma especialidade da fisioterapia ...” “... no tribunal em Brasília, que em 2003 decidiu que, por ainda não ter lei sobre a formação e prática da quiropraxia, não tinha problema algum o fisioterapeuta alegar que a quiropraxia é uma especialidade da fisioterapia, e de igual maneira o bacharel em quiropraxia tinha o seu livre exercício e o conselho de fisioterapia não poderia fiscalizar e nem interferir na prática do profissional quiropraxista.” “... muita informação distorcida que se coloca até hoje da quiropraxia como um tipo de técnica que estala ossos e tudo mais que se vê por falta de informação quando a identidade da profissão.” “... as primeiras turmas eram muito unidas havia uma dedicação, um comprometimento incrível desses alunos com a identidade da profissão, com certeza isso foi construído na base filosófica das aulas de fundamentos da quiropraxia ... “... que a questão educacional ela sirva como uma referência para que realmente se reconheça a profissão a quiropraxia e a fisioterapia são complementares... .. tenho trânsito muito bom nas duas áreas, e nas entidades representativas tanto da fisioterapia quanto da quiropraxia entendi que são duas profissões distintas, são áreas distintas. Seria como se eu tivesse dupla cidadania, como fisioterapeuta e como quiropraxista ...” “A primeira turma da UAM tinha 28 alunos começaram a se formar outras turmas, vinham mais 20, mais 25, a coisa foi crescendo um pouquinho. Enquanto isso, o Conselho Federal de Fisioterapia tinha milhares de fisioterapeutas eles tinham “budget” (verba), eles tinham história, a gente estava só começando a gente nunca teve um “budget” específico muita gente tirou dinheiro do próprio bolso, a gente inclusive fazia rifa e coisas assim para poder arrecadar dinheiro para os alunos irem para Brasília para

Tema 10 (T10) Interferência da autarquia da fisioterapia	
	poder fazer algum tipo de ação de esclarecimento, éramos poucos, mas ninguém nunca desistiu ...” “... não dá para entender como que só o Brasil diferente do restante do mundo a quiropraxia seja uma especialidade/parte de outra profissão se em nenhum outro lugar do mundo a quiropraxia pertence a outra profissão, por que somente a gente tem que fazer assim?” “... na base da filosofia da profissão nesse contexto de saber diferenciar deveres e obrigações nos limites da atuação quiroprática. Informação bem fundamentada e ética. Entendemos que esse será o caminho para lidar com essas questões corporativistas contrárias disciplina de empreendedorismo, gestão de clínicas e de ética, preparamos o aluno para fazer a sua gestão considerando esse aspecto.”

Fonte: Elaborado pelo autor

O escrutínio analítico revela um cenário de tensão institucional provocado pela interferência sistemática da autarquia de Fisioterapia, fenômeno que a comunidade internacional observa com estranheza, dado o consenso global sobre a autonomia da Quiropraxia. Como mencionado nas discussões sobre o histórico do impasse no capítulo 3.4, a autarquia tem utilizado seu capital político e orçamentário para obstruir o mérito educacional no Conselho Nacional de Educação (CNE) e no Legislativo, distorcendo a identidade da profissão ao reduzi-la a uma técnica manipulativa. Os dados indicam que essa oposição se materializa em duas frentes: no trancamento de pautas legislativas mediante estratégias regimentais e na influência junto ao CNE para impedir a homologação das DCN, processo no qual, entre 2008 e 2010, os representantes legítimos da Quiropraxia foram preteridos no diálogo institucional em favor do corporativismo da Fisioterapia.

Ademais, os entrevistados reforçam que esta interferência promove uma assimetria de informação, ignorando que entidades como a IFOMPT e a WFC já declararam a distinção entre as duas profissões. Frente a essa hegemonia corporativista, torna-se necessário reafirmar a identidade epistemológica da profissão, amparando-se em decisões judiciais que já garantem o livre exercício do bacharel quiropraxista de forma independente. A superação deste óbice exige que as Instituições de Ensino Superior (IES) trabalhem a educação e a pesquisa como bases para a conscientização das autoridades, demonstrando que a Quiropraxia não é uma especialidade, mas uma profissão de formação universitária autônoma, em estrita observância às diretrizes da OMS/OPAS.

Quadro 21 - Categoria III: resultados do Tema 11

Tema 11 (T11)	
Obstáculos que pesam contra a aprovação dos PL e DCN	
Perguntas: p24, p36, p41, p54, p55, p60, p75 e p76. Pontos chave: - Falta de informação consistente e diálogo com as partes; - Falta de conhecimento sobre a profissão; - Interesse corporativo; - PL de 2001 houve mais movimento, mais presença de quiropraxista no parlamento; - Problema recente mais forte é a falta de conhecimento do regimento e traquejo político da parte dos representantes da quiropraxia no parlamento; - Tem que ter diálogo entre as partes para ter acordo sem acordo não anda na política; - Falta consenso; - Tem muita truculência pessoal e pouca estratégia com maturidade política; - Aporte técnico dos organismos internacionais da quiropraxia, sem viés político; - Na época das primeiras turmas de graduação, havia mais comprometimento das instituições e dos alunos; - Opositores a DCN e a regulamentação não jogam com a verdade; - Quiropraxistas são amparados tecnicamente, mas não são políticos; - Sucesso das primeiras turmas e grande adesão de alunos estava na divulgação; - Comprometimento dos alunos e instituições da quiropraxia com a divulgação da profissão	Entrevistados: D1; E7; F4; H4; H5; H10; J5 e J6. “O principal obstáculo está na falta de informação sobre a profissão e a busca de um acordo entre quiropraxistas e fisioterapeutas ...” “Os fisioterapeutas alegam que a quiropraxia é uma especialidade ... a questão de confundir a prática da técnica de manipular a coluna com o nome da profissão de quiropraxia é o ponto principal.” “Um quiropraxista não pode se dizer fisioterapeuta e nem um fisioterapeuta pode se dizer quiropraxista, assim é no mundo todo a mais de um século ...” “...falta de conhecimento sobre o que é a quiropraxia de fato ... interesses políticos/corporativistas claramente vistos internamente no Congresso Nacional desde 2001 ... o PL para regulamentar a quiropraxia ... foi muito debatido, em diversas comissões, chegou ao plenário ... visto ter um parecer divergente na Comissão de Educação ... sem parecer divergente, ele iria direto para o senado.” “Para os projetos evoluírem nas comissões de mérito, tem que ser conversado com os parlamentares ... no início os parlamentares nem sabiam o que era quiropraxia ...” “... um ponto muito complexo visto hoje, é que nessa expectativa de trazer informação ao conhecimento dos parlamentares, falta um pouco de traquejo às vezes de quem representa os quiropraxistas para conversar com os parlamentares ...” “... está bem claro que tem que haver um acordo enquanto não houver um consenso político entre as partes, será muito difícil dos PL da quiropraxia serem aprovados ...” “por inúmeras vezes ... um PL da Quiropraxia esteve em pauta para ser votado e foi retirado de pauta por falta de consenso ...” “... as partes não sentam para conversar e tentar um acordo, tudo é muito truculento aí trava tudo ...” “... é necessário que haja maturidade política, de traquejo para que a coisa evolua de forma consistente com os dois lados e consiga achar uma solução coerente.” “... há um novo PL referente a quiropraxia ... contrário a tudo que os demais buscam no contexto estrutural da formação e prática da profissão ... se as partes não sentarem e tentarem construir um acordo, a relatoria do PL fica em situação muito sensível e precisa se posicionar, e considerando a força política da fisioterapia imposta pelo corporativismo, fica muito complicado evoluir nisso ... pode vir um parecer danoso ...” “... a relatoria vai se posicionar a favor de um ou do outro projeto, ou até fazer uma junção dos dois, é necessário que seja conversado com a relatoria para a construção consensual da matéria, se não, não vai ...” “... a gente sempre teve o aporte da Federação Mundial de Quiropraxia, do Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia, da ABQ naquele primeiro momento, o comprometimento da própria FEEVALE, do Palmer College, todos alunos bem envolvidos nesses movimentos ... por isso que a gente sempre pensou que os trâmites da regulamentação da quiropraxia iria

Tema 11 (T11)	
Obstáculos que pesam contra a aprovação dos PL e DCN	
com informação séria; • Maior obstáculo, falta de informação consistente; • União e informação coesa; • IES tem que entregar profissionais competentes; • Falta grupos de quiropraxistas pesquisadores; • Sem doutores de pesquisa na linha específica na quiropraxia.	acontecer com muita facilidade, mas não, a gente está até hoje batalhando para isso.” “Foi decepcionante ... não sei o que faltou, porque tivemos todo aporte técnico, documental, de informação, serviço de orientação, todo curso foi rigorosamente dentro das regras do MEC e do consenso internacional de educação em quiropraxia ...” “... não existia viés político sobre a estruturação da quiropraxia no Brasil, sempre foi totalmente técnico, acadêmico, profissional e legítimo com a formação na área da saúde ... essa questão política e corporativa contrária que nos decepciona, porque não jogam com a verdade.” “... foi na divulgação de informação profunda sobre a profissão, no início do programam FEEVALE & Palmer College, fazíamos divulgação nas feiras de profissões de escolas de ensino médio que estavam formando seus alunos para prestar vestibular, fizemos matérias na mídia, teve uma equipe de jornalismo de um canal aberto da televisão regional que foi até o Palmer College fazer uma matéria ampla sobre a formação em quiropraxia e a parceria daquela universidade americana com a FEEVALE, isso foi muito veiculado nas televisões do Rio Grande do Sul ...” “... havia um grande comprometimento dos professores que passaram pelo curso de capacitação para docência em quiropraxia no Palmer College, trabalhando em várias frentes pela divulgação do curso ...” “... conseguimos manter semestralmente turmas fechadas com alunos vindo a maioria da região e cidades vizinhas, mas também de vários estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia entre outros, a partir disso o curso da FEEVALE foi se espalhando pelo Brasil.” “... o entusiasmo dos professores contagiando os alunos das primeiras turmas que brilhavam os olhos ao falar da quiropraxia e orgulho de estar nessa formação FEEVALE & Palmer ...” “... os alunos das primeiras turmas foram responsáveis por trazer muitos outros alunos para o curso. Eles fundaram a Associação Brasileira dos Estudantes de Quiropraxia – ABEQ em conjunto com os estudantes de quiropraxia da UAM, eles eram muito unidos e fizeram muitos movimentos pela profissão.” “... foi um trabalho de muitas pessoas ... muita gente trabalhando junto para poder realmente divulgar a formação em quiropraxia da forma com tem que ser.” “A experiência do que vimos no passado, quando não existia nada sobre quiropraxia no Brasil, deixa claro a necessidade de união entre os cursos com as entidades internacionais e dos próprios profissionais no Brasil de investir em informação sólida sobre a profissão e a sua identidade ... tudo é questão de investir em união e informação coesa.” “A função principal do centro de formação de profissionais das universidades é entregar profissionais competentes que atuem no mercado difícil as instituições se envolverem nessa frente política, embora elas tenham interesse também que isso aconteça ...” “... as universidades, elas têm dificuldade de formar pesquisadores ... nem um doutor vem da linha de pesquisa específica da quiropraxia, vêm de outras linhas.”

Fonte: Elaborado pelo autor

Por meio das informações colhidas com os entrevistados, identificou-se que os obstáculos que pesam contra a aprovação do PL e DCN, residem na carência de uma estratégia dialógica amadurecida e na falta de informação consistente sobre a profissão junto às instâncias de poder. Diferentemente do vigor observado no período de introdução dos cursos pioneiros, onde havia forte união entre IES, alunos e entidades internacionais, nota-se atualmente um déficit de traquejo regimental por parte dos representantes da área. A análise empírica sugere que a ausência de um consenso político e a "truculência pessoal" em detrimento da estratégia diplomática impedem a construção de acordos necessários para a evolução dos Projetos de Lei (PL), resultando em sucessivos arquivamentos por "falta de acordo" nas comissões de mérito.

Outro entrave estrutural relevante destacado é a escassez de doutores pesquisadores com linha de pesquisa específica em Quiropraxia, o que fragiliza o suporte técnico necessário para convencer os legisladores sobre a singularidade da área. Conforme mencionado pelo entrevistado no tema 8, a falta de programas de pós-graduação *stricto sensu* específicos dificulta a formação de uma massa crítica de pesquisadores, forçando a dependência de doutores vindos de áreas correlatas. Portanto, a superação desses obstáculos exige a maturação do jogo político e o investimento em uma comunicação coesa que resgate o comprometimento institucional visto no início da graduação em 2000, garantindo que a verdade técnica prevaleça sobre os interesses corporativistas que, segundo os entrevistados, não jogam com a verdade.

Quadro 22 - Categoria III: resultados do Tema 12

Tema 12 (T12) Relevância do reconhecimento da quiropraxia junto ao MEC, CBO, SUS, CNAE perante o cenário brasileiro	
Perguntas: p25, p29, p55, p59 e p77. Pontos chave: • Relevante para identidade perante o público; • Resultado do esforço no aprofundamento da raiz da profissão junto as primeiras turmas; • Mostra necessidade de divulgar a profissão conforme a sua estrutura mundial de forma ética; • Evidencia a relevância da construção de uma DCN e da regulamentação por lei;	Entrevistados: D2; D6; H5; H9 e J7. “Principalmente para a identidade da quiropraxia perante o público geral, que foi trabalhada com muito esforço nas primeiras turmas para manter a raiz da profissão...” “...precisamos investir mais em divulgar a profissão de forma séria, condizente com a sua fundamentação e estrutura mundial com ética. Necessitamos de uma DCN e da regulamentação...” “A formação no Brasil ainda não atende a nenhuma exigência legal preestabelecida, não existe critério específico.” “... teoricamente, não têm parâmetro para formar bons profissionais, porque não existe uma diretriz que exija um número de horas necessárias com conteúdo específico para cada disciplina, não tem supervisão, não tem aprofundamento.” “... oferece um acesso muito rápido a um certificado de formação na área, que é totalmente conto de fadas ...”

Tema 12 (T12) Relevância do reconhecimento da quiropraxia junto ao MEC, CBO, SUS, CNAE perante o cenário brasileiro	
• Necessidade de manter a raiz da profissão; • A formação ainda está sem critério; • Não é exigido uma diretriz com solidez, aprofundamento e supervisão profissional; • Promessa sedutora, conto de fadas; • É direito do profissional, a profissão existe no Brasil, está conquistando seus direitos; • Livre exercício profissional por não ter lei, é vago e não delimita; • Tem que ter padrões de ensino e segurança no exercício profissional para atender a saúde pública; • Órgão regulador da prática profissional; • Diretriz legal para formação ética DCN; • Fiscalização do MEC.	“... no caso da formação e prática da quiropraxia, além do reconhecimento e normas abertas garantidas no artigo 5º da constituição, a regulamentação por lei específica é fundamental, porque, da mesma forma como as demais profissões da área da saúde de formação universitária no Brasil, tem que haver padrões mínimos para formar profissionais competentes para a atuação na saúde pública e que sejam subordinados a organismos de fiscalização da conduta ética e prática profissional específica da sua área de atuação.” “... para atuar no cuidado da saúde do cidadão como quiropraxista, não basta um cursinho final de semana sem qualquer critério acadêmico sem acompanhamento pelo MEC, e abrir consultórios para atender pessoas sem o devido preparo.” “Estamos falando de uma prática profissional muito avançada no sentido de avaliar, diagnosticar, cuidar, encaminhar e assistir pessoas com dor, entre muitos outros problemas relacionados com a coluna vertebral ... dentro de um modelo mundialmente estabelecido a muitas décadas e tem o olhar da Organização Mundial da Saúde que mostra o que é necessário para ter profissionais quiropraxistas com boa formação e atendimento com segurança para esses pacientes ...” “... puxando para a necessidade das Diretrizes Curriculares Nacionais, que ao serem criadas, será muito importante porque vai dar mais força para o processo de regulamentação da profissão ...” “... assessorias técnicas na Câmara dos Deputados e Senado federal, comentam que não existe uma boa articulação da parte dos representantes da quiropraxia junto aos ministérios da Saúde, Trabalho e Educação, o que se conseguiu até aqui junto ao CNE, foi o reconhecimento dos cursos, a partir da formatura das primeiras turmas em 2004, mas foi uma conquista articulada pelas próprias pioneiras, Universidade FEEVALE e Anhembí Morumbi ...” “... naquela época notávamos mais a presença política da quiropraxia no parlamento, por isso tiveram grandes avanços, tanto nos projetos de lei, onde um deles chegou a entrar em pauta duas vezes no plenário da Câmara dos Deputados, que não prosperou e foi arquivado por não reeleição do seu autor, houve avanços também nas questões judiciais onde os quiropraxistas obtiveram a garantia de exercer seu ofício sem a interferência do Conselho de Fisioterapia, além do reconhecimento do Ministério do Trabalho, com uma boa articulação política ...” “... parece que o perfil de estratégias políticas dos representantes da quiropraxia passou por mudanças que parece ter estagnado, perderam força, a coisa congelou, não tiveram grandes avanços, e o conselho de fisioterapia marcou presença constante em todos esses locais, todos os PL para regulamentação da quiropraxia que surgiram ficam travados na Comissão de Educação por falta de consenso.” “A influência política de uma categoria profissional depende de maturidade dos representantes das entidades representativas em entender como o sistema brasileiro funciona, seus regimentos e metodologia prática, bem com a forma de abordar seus representantes.” “Tem que ser um ato político e não apenas técnico, é necessário estreitar laços, dialogar com todas as partes, inclusive com a oposição com informações sólidas. É assim que se constrói política para avançar num projeto que visa,

Tema 12 (T12) Relevância do reconhecimento da quiropraxia junto ao MEC, CBO, SUS, CNAE perante o cenário brasileiro	
	sobretudo, ajudar a sociedade, especialmente o pobre pelo SUS, mas para isso acontecer, para o projeto evoluir no parlamento, tem que estar todo mundo de acordo, tem que haver consenso.” “Essa articulação deve ser trabalhada com estratégia política entre as partes, as entidades da quiropraxia precisam saber se comunicar politicamente e apresentar informações consistentes, atuais, técnicas e éticas aos órgãos do governo, de forma a construir boa relação institucional.” “Os órgãos governamentais ao tomarem pé do que a quiropraxia é e pode fazer no sus, começam a ter critérios para buscar informação e criar e a seus pareceres, não existe passe de mágica, os representantes dos órgãos do governo não vão acordar pela manhã e ao chegar no trabalho resolver que vão emitir um parecer favorável a regulamentação da quiropraxia, se não houver uma provocação dentro das regras do parlamento, não adianta ficar dando murro em ponta de faca.” “... conquistar parlamentares e os fazer conhecer da quiropraxia ao ponto de convencê-los a se comprometerem em lutar pela regulamentação. Para isso acontecer, esses parlamentares precisam se sentir seguros em ter aporte de profissionais da área que conheçam a forma de trabalhar internamente o jogo político no legislativo.” “... de quatro em quatro anos acontece uma renovação dos parlamentares e nas comissões também elas não são fixas os seus participantes cada ano mudam ... é uma questão de convencimento constante.” “... há necessidade de ... buscar a maturação do jogo político e trabalhar paralelamente os órgãos governamentais que podem emitir pareceres sugerindo a regulamentação da profissão.”

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise dos dados empíricos, materializada pelas vozes dos atores estratégicos entrevistados, permite concluir que o reconhecimento da Quiropraxia junto a instâncias como o MEC, a CBO, o SUS e o CNAE consubstancia o êxito de uma articulação histórica vigorosa, consolidada no interregno dos primeiros quinze anos subsequentes à gênese dos cursos pioneiros em 2000. Naquele período, a união estratégica entre as Instituições de Ensino Superior pioneiras (FEEVALE e UAM), a ABQ e entidades internacionais logrou conquistas fundamentadas em uma identidade profissional que preservava suas raízes epistemológicas e mantinha uma comunicação ética com a sociedade.

Contudo, os relatos desvelam um contraste crítico: na última década, esse compromisso político institucional perdeu tração, resultando em uma estagnação que compromete a continuidade dos avanços necessários para a plena estruturação da profissão no cenário contemporâneo. Para superar este estado de congelamento normativo, os resultados das entrevistas apontam para a necessidade premente de maturação e profissionalização da atuação

política dos representantes de classe. O cenário político hodierno exige que a representação da Quiropraxia transcenda o debate puramente técnico e adote estratégias de diálogo e busca por consenso, inclusive com a oposição corporativista, mitigando a truculência que tem paralisado a tramitação de projetos de lei no Parlamento.

Os entrevistados asseveram que a influência política de uma categoria profissional é tributária da maturidade das entidades representativas em decifrar a hermenêutica do sistema brasileiro, seus regimentos e metodologias práticas de abordagem institucional. Destaca-se a prevalência do ato político sobre o meramente técnico, no esforço para estreitar laços e dialogar com todas as partes, munidos de informações sólidas e tecnicamente consistentes. Somente por meio de uma articulação constante junto ao Legislativo e ao Executivo será possível converter a maturidade da experiência acumulada em norma estável, garantindo a soberania da formação e a segurança biológica da coletividade.

Essa interlocução estratégica deve ser pautada em informações atuais e éticas, visando construir relações institucionais perenes com o aporte de profissionais que dominem a gramática do jogo político interno no Legislativo. Diante da renovação parlamentar quadrienal, o convencimento deve ser um exercício de persistência e maturação, trabalhando paralelamente junto aos órgãos governamentais capazes de emitir pareceres favoráveis à regulamentação. Em última análise, a materialização das falas indica que a construção das DCN é o avanço necessário para conferir segurança jurídica à profissão e garantir que o projeto de inserção social da Quiropraxia, especialmente via SUS, alcance sua plenitude em conformidade com o múnus público e o consenso social.

Em síntese, o exame analítico das narrativas coligidas nesta investigação, a ser detalhada no campo das considerações finais, revela um panorama complexo de desafios e pleitos pela legitimidade acadêmica e profissional da Quiropraxia no Brasil.

A densidade das falas, submetida ao rigor da análise de conteúdo, permitiu desvelar as tensões entre o caráter inovador e experimental dos cursos pioneiros e a premente necessidade de transpor o atual limbo normativo por meio de um balizamento técnico-legal sólido.

As percepções dos atores estratégicos convergem para o entendimento de que a ausência de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) não apenas fragiliza a identidade da profissão, mas impõe riscos à saúde pública ao permitir a proliferação de ofertas formativas desprovidas de rigor científico e supervisão adequada.

Nessa perspectiva, a fase empírica, materializada por meio de 12 entrevistas semiestruturadas realizadas com participantes de relevância estratégica no cenário nacional e internacional, proporcionou uma base de dados robusta para a triangulação dos resultados. Em

desdobramento às perguntas primárias foram elaboradas 94 questões, as quais permitiram a emersão nas 3 categorias analíticas subdivididas por 12 temáticas centrais. Este arcabouço metodológico assegurou que o fenômeno fosse explorado sob múltiplos prismas, desde o consenso mundial para a formação até os impasses corporativistas locais.

Para conferir transparência à sistematização desta investigação e demonstrar a amplitude das discussões suscitadas, apresenta-se, a seguir, o Quadro 23, que organiza as questões exploradas conforme os eixos temáticos propostos.

Quadro 23 - Questões exploradas, na entrevista por Temas

(p)	Temas	Perguntas trianguladas por temas
p1	T1	Quais são os principais critérios e a metodologia que o CCEI utiliza para credenciar e fiscalizar programas de quiropraxia globalmente?
p2	T2	Como os critérios do CCEI se aplicam a países como o Brasil, onde a profissão ainda não tem regulamentação plena?
p3	T2	Como o CCEI avalia a qualidade da formação em quiropraxia no Brasil onde a formação está na categoria reconhecido e permitido segundo categorização mundial, mas sem regulamentação específica por lei e sem DCN?
p4	T2 e T9	Qual o papel de uma DCN específica para a prática profissional da quiropraxia em um país como o Brasil?
p5	T3	De que forma o CCEI pode auxiliar na criação de legislações específicas que formalizem a quiropraxia como uma profissão autônoma de saúde, promovendo padrões educacionais e de prática seguros?
p6	T3 e T4	Como o (PPC) do curso superior pioneiro no Brasil foi estruturado e vem se atualizando para atender às demandas de uma profissão da saúde, sem DCN específica?
p7	T3 e T4	A universidade manteve, mantém, ou tem algum amparo dos órgãos internacionais, como CCEI e CCE-La, que dão subsídio para a questão da educação em quiropraxia mundialmente?
p8	T7	Quais os impactos que a lacuna regulatória causada pela ausência de uma DCN provoca na identidade do profissional formado e na percepção pública da quiropraxia no Brasil?
p9	T5 e T7	Como é a aceitação pública quanto a identidade da formação e prática da quiropraxia associada a ausência de uma DCN, e não ter regulamentação por lei?
p10	T6	Como a distinção de um perfil de formação mais filosófico ou mais ciência em evidência, refletiu na identidade profissional dos egressos e na aceitação da quiropraxia no cenário da saúde brasileira?
p11	T4 e T5	Quais as vantagens e desvantagens da classificação, inovador e experimental pelo MEC, para a formação e o exercício profissional da quiropraxia?
p12	T8	O que é necessário para que a formação em quiropraxia no Brasil evolua para o status de uma DCN específica na área?
p13	T4	De que forma o currículo do curso pioneiro em quiropraxia se alinha às Diretrizes internacionais e da OMS atualmente?
p14	T3 e T4	Quais foram os principais desafios para adequação das Diretrizes da OMS ao contexto brasileiro?
p15	T1	Quais são os principais desafios enfrentados pelos gestores dos cursos de quiropraxia na América Latina para alinhar seus programas de educação aos Standards do CCE-La?
p16	T5	Como os gestores dos cursos do Brasil se posicionam quanto aos standards, dado que

(p)	Temas	Perguntas trianguladas por temas
		seus cursos são reconhecidos pelo MEC, mas sem DCN específica?
p17	T2 e T8	Como o CCE-La avalia a ausência de uma DCN e de uma lei explícita que regule a quiropraxia no Brasil?
p18	T2 e T7	Quais seriam os impactos da lacuna causada pela falta de uma DCN específica para quiropraxia no contexto da saúde pública no Brasil e demais países da América-latina?
p19	T2, T5 e T7	Como os diferentes modelos de ensino da quiropraxia no Brasil (5 faculdades, 3 reconhecidos pelo MEC e muitos livres), podem influenciar na estrutura da identidade da profissão na América Latina?
p20	T3	Como CCE-La orienta instituições que querem montar novos cursos quiropraxia na estruturação do seu PPC, considerando não existir exigência de um modelo padronizado para formação em quiropraxia no Brasil?
p21	T3	Que tipo de suporte ou orientação o CCE-La pode oferecer ao Brasil para acelerar o processo de construção de uma DCN e de regulamentação legal da profissão, considerando as particularidades do sistema educacional e de saúde brasileiro?
p22	T2	De que forma o CCE-La acompanha e apoia a evolução dos cursos categorizados como inovadores e experimentais, visando a plena regulamentação e reconhecimento da profissão?
p23	T10	Qual seria a orientação, dos organismos internacionais da profissão, referente a interferência da autarquia dos fisioterapeutas do Brasil que utilizam da força política corporativa contrária a criação de uma DCN para quiropraxia e para impedir que a profissão no país seja regulamentada por lei?
p24	T11	Quais são os principais obstáculos à aprovação dos projetos de lei da quiropraxia no legislativo brasileiro?
p25	T12	Qual a relevância do reconhecimento da quiropraxia junto ao Ministério do Trabalho na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), ao IBGE no Código de Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), ao SUS nas Políticas Nacionais para Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) perante o cenário político brasileiro?
p26	T10	De que forma a autarquia da fisioterapia se manifesta para interferir no avanço das questões para construção das DCN e aprovação do PL da quiropraxia?
p27	T10	Qual o impacto da interferência da autarquia da fisioterapia contra o avanço para a construção das DCN e da regulamentação da profissão por lei sobre a identidade da quiropraxia junto a saúde pública?
p28	T8	Como a aprovação de DCN para a quiropraxia poderia impactar o processo legislativo de regulamentação da profissão?
p29	T12	Como as consultorias legislativas veem as articulações entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e do Trabalho para a formalização plena da profissão?
p30	T5	Qual visão os participantes do curso de capacitação de docentes no convênio FEEVALE & Palmer College, tinham sobre a profissão no início da execução do projeto para formação superior em quiropraxia no Brasil?
p31	T3 e T4	No início do projeto FEEVALE & Palmer College, como se pretendia alinhar a formação da quiropraxia no Brasil aos padrões internacionais da época?
p32	T4 e T5	Quais foram os principais desafios pedagógicos e estruturantes enfrentados na capacitação docentes e na definição da grade curricular do primeiro curso superior em quiropraxia no Brasil?
p33	T4 e T5	De que forma essa prerrogativa legal como inovador e experimental foi utilizada para viabilizar a oferta do bacharelado em quiropraxia?
p34	T8	Ao implantar o projeto de bacharelado em quiropraxia no Brasil, quais eram as expectativas em relação à evolução para uma DCN específica?
p35	T7 e T8	Como os gestores dos cursos pioneiros em quiropraxia no Brasil, avaliam a inexistência de DCN após 25 anos ativos dentro das prerrogativas do MEC?

(p)	Temas	Perguntas trianguladas por temas
p36	T7, T10 e T11	Quais eram as expectativas dos envolvidos nos cursos pioneiros em 2000 em relação à regulamentação da profissão de quiropraxista no Brasil?
p37	T3 e T4	De que forma as entidades envolvidas, como a ABQ, a WFC e o CCEI, entre outros, participaram do processo de estruturação dos cursos pioneiros no Brasil?
p38	T6	Quais foram as modificações curriculares mais expressivas implementadas ao PPC da quiropraxia, considerando um novo curso superior surgir 20 anos após os cursos pioneiros, em relação aos modelos mais filosófico ou mais baseado em evidências?
p39	T5	Quais são os maiores obstáculos administrativos ou acadêmicos decorrentes do status de 25 anos como formação inovadora e experimental, interferem no reconhecimento pleno da identidade profissional do egresso?
p40	T7	Considerando a ausência de DCN específica, quais indicadores de qualidade e segurança o curso mais recente reconhecido pelo MEC utiliza formalmente em seu PPC para simular o papel padronizador que uma Diretriz Curricular Nacional deveria exercer na formação?
p41	T10 e T11	De que forma o componente curricular de Ética e Prática Profissional prepara o futuro bacharel para atuar na prática autônoma, gerenciando a incerteza legal e os potenciais conflitos de fronteira com outras profissões?
p42	T8 e T9	Qual o requisito acadêmico obrigatório que uma DCN estabeleceria e que, por sua natureza, inviabilizaria a oferta de cursos sem a qualidade mínima exigida para uma profissão de primeiro contato na área da saúde como a quiropraxia?
p43	T4	Como o PPC do curso pioneiro de quiropraxia foi estruturado para introdução do bacharelado no Brasil?
p44	T9	Como o PPC do curso pioneiro tem sido atualizado para atender às demandas de uma profissão da saúde, sem DCN específica?
p45	T5 e T7	Quais os impactos da lacuna regulatória pela ausência de DCN e de regulamentação por lei, na identidade do profissional formado e na percepção pública da quiropraxia no Brasil?
p46	T6	Como a distinção entre a formação mais filosófica e a mais centrada na ciência com evidência refletiu na formação dos egressos e na aceitação da quiropraxia no cenário da saúde brasileira?
p47	T4 e T5	Quais as vantagens e desvantagens da classificação inovador e experimental pelo MEC na do quiropraxista e no seu exercício profissional?
p48	T8	O que é necessário para que a formação e prática da quiropraxia evolua para um status regido por DCN, e para que a regulamentação da profissão se concretize?
p49	T4	De que forma o currículo do curso de bacharelado em quiropraxia se alinha com as diretrizes internacionais?
p50	T4 e T8	Quais os principais desafios para adequação das diretrizes internacionais para formação em quiropraxia ao contexto brasileiro?
p51	T4	Quais os padrões do consenso internacional que o curso pioneiro utilizou como base para readequação do PPC inicial do bacharelado em quiropraxia?
p52	T4 e T6	De que maneira a orientação filosófica inicial, ligada ao Palmer College, influenciou a definição do perfil do egresso da FEEVALE e a integração dos formandos no cenário da saúde brasileira nos primeiros anos do curso?
p53	T4	Quais foram as principais limitações e flexibilidades encontradas no desenvolvimento e renovação curricular contínua do PPC para a formação em quiropraxia como profissão de primeiro contato na área da saúde?
p54	T10 e T11	Como os gestores dos cursos pioneiros lidaram com a tentativa do Conselho Federal de Fisioterapia (COFFITO) em classificar a quiropraxia como especialidade da fisioterapia a partir da resolução 220 de 23 de maio de 2001?
p55	T10, T11 e T12	Quais estratégias foram adotadas para proteger a identidade e a legitimidade acadêmica

(p)	Temas	Perguntas trianguladas por temas
		do bacharelado em quiropraxia, frente a resolução da autarquia da fisioterapia postular a quiropraxia com especialidade do fisioterapeuta?
p56	T4	De que forma os cursos pioneiros conduziram a readequação do PPC após a publicação das Diretrizes da OMS em 2005?
p57	T3	Qual a participação CCE-La e/ou da WFC no apoio técnico a adequação da educação em quiropraxia ao contexto brasileiro?
p58	T8	Diante do perfil do quiropraxista como profissional de primeiro contato na área da saúde, quais competências devem ser obrigatoriamente padronizadas por meio de uma DCN para garantir a prática segura na saúde pública?
p59	T12	De que maneira a graduação das primeiras turmas de bacharéis, a partir de 2004, sustentaram a legalidade e a identidade da profissão de quiropraxista de forma independente no país?
p60	T4 e T11	Quais desafios, o curso pioneiro enfrentou no processo de manutenção da qualidade do corpo docente, da infraestrutura clínica e laboratorial para avaliação do MEC?
p61	T8	Como os elementos de controle de qualidade internos como do corpo docente, da infraestrutura clínica e laboratorial podem servir de referência para a futura DCN?
p62	T8	Qual o legado estruturante do curso pioneiro deve ser imperativamente incorporado na futura DCN para que se possa sanar a lacuna regulatória e combater a proliferação de cursos inadequados?
p63	T4	Quais foram os caminhos/estratégias para captação de alunos para as primeiras turmas dos cursos pioneiros?
p64	T9	Qual o <i>status</i> da proposta formal da ABQ junto ao MEC/CNE para a construção e homologação de uma DCN específica para o bacharelado em Quiropraxia?
p65	T5	Como o <i>status</i> da classificação como inovador e experimental contínua dos cursos por 25 anos afeta a legitimidade e a identidade do bacharel quiropraxista no mercado de trabalho?
p66	T1 e T7	Qual o impacto da lacuna regulatória causada pela ausência de DCN no controle de qualidade e proliferação de cursos que não seguem os padrões acadêmicos adequados?
p67	T1 e T9	De que forma a construção de uma DCN poderia garantir que os currículos nacionais incorporem integralmente as habilidades e competências mínimas estabelecidas pelas <i>Diretrizes da OMS sobre a Formação Básica e a Segurança em Quiropraxia</i> , alinhando o perfil do egresso brasileiro aos padrões internacionais?
p68	T8 e T10	Qual a capacidade de uma DCN servir como um arcabouço técnico e legal ao ponto de auxiliar no processo legislativo e consequente regulamentação da profissão de quiropraxista no Brasil?
p69	T2	Quais são os principais desafios para manter a uniformidade e a excelência curricular entre os cursos de Quiropraxia no país, na ausência de uma DCN e que harmonize os PPC?
p70	T4	A ABQ encontra alguma dificuldade para auxiliar IES na elaboração ou na análise de PPC para novos cursos de quiropraxia no Brasil?
p71	T10	Como um bacharel quiropraxista, que também é bacharel em fisioterapia, pode conciliar as duas profissões de forma distinta no aspecto acadêmico e prática clínica?
p72	T6	Como professor do curso de bacharelado em quiropraxia de uma instituição pioneira no Brasil avalia a evolução do PPC para garantir as habilidades e competências mínimas para a prática segura dessa profissão de primeiro contato, especialmente na ausência de DCN) específica?
p73	T5	Quais os impactos decorrentes da classificação inovadora e experimental do MEC na identidade e na legitimidade do bacharel quiropraxista no mercado de trabalho e da saúde pública?
p74	T8	De que maneira a ausência de uma DCN para a Quiropraxia dificulta o

(p)	Temas	Perguntas trianguladas por temas
		desenvolvimento de pesquisas específicas e a consolidação de práticas baseadas em evidências para o bacharel quiropraxista no Brasil?
p75	T11	Qual seria o papel de grupos de pesquisas no contexto regulatório da profissão?
p76	T11	Quais seriam as ações mais urgentes, como aporte para a construção de uma DCN e, consequentemente, à regulamentação da profissão de quiropraxista no Brasil?
p77	T12	Qual o impacto da formação e prática livre em quiropraxia na saúde pública?
p78	T5	Qual a sugestão para solucionar a dicotomia na formação e prática livre e sem controle em quiropraxia frente a segurança ao paciente e na estrutura da profissão de quiropraxista no Brasil?
p79	T4 e T6	De que maneira a distinção na ênfase mais filosófica X a mais ciência com evidência entre os cursos pioneiros influenciaram a percepção pública sobre a identidade do quiropraxista brasileiro?
p80	T5	Quais foram os principais desafios enfrentados nos cursos pioneiros para manter o reconhecimento do MEC em um contexto de curso Inovador Experimental?
p81	T7	Ao balizar o PPC na ausência de DCN, como aprimorar o entendimento para a avaliação da qualidade acadêmica e a estrutura curricular do bacharelado em Quiropraxia como um profissional de primeiro contato na área da saúde?
p82	T1 e T2	Quais exigências no controle de qualidade acadêmica no sistema Norte Americano deveriam ser incorporadas em uma DCN para quiropraxia?
p83	T5 e T8	Como as primeiras turmas de bacharéis egressos, a partir de 2004, atuaram para refutar as alegações da autarquia que tentava classificar a quiropraxia como especialidade da fisioterapia?
p84	T10	Como as reiteradas decisões judiciais que confirmam a autonomia do bacharel quiropraxista são utilizadas na estruturação da identidade da profissão?
p85	T8 e T9	Qual a importância de uma DCN para a prática segura do quiropraxista como profissional de primeiro contato?
p86	T7 e T9	Como a ausência de DCN em quiropraxia afeta a segurança da saúde pública no país?
p87	T9	Quais são os componentes clínicos práticos e laboratoriais obrigatórios que uma futura DCN brasileira deve categoricamente padronizar para coibir a oferta de baixa qualidade e garantir a recomendação da OMS para formação em quiropraxia?
p88	T3	De que maneira organizações como o CCEI e a WFC podem efetivamente apoiar CNE para superar o obstáculo político e finalmente estabelecer uma DCN para o bacharelado em Quiropraxia?
p89	T4, T5 e T6	Quais foram as modificações curriculares mais expressivas implementadas ao (PPC) do mais recente de bacharelado em quiropraxia com início previsto para 2026/01?
p90	T6	Qual o diferencial utilizando na proposta do curso mais recente para o bacharelado em quiropraxia, levando em conta a experiência dos modelos iniciais (mais filosófico da FEEVALE ou mais baseado em evidências da UAM)?
p91	T4 e T5	Quais são os obstáculos administrativos ou acadêmicos decorrentes da classificação contínua de curso inovador experimental sobre o reconhecimento da profissão e a identidade profissional do egresso?
p92	T4 e T9	Quais indicadores de qualidade e segurança que o mais recente curso de bacharelado em quiropraxia com início previsto para 2026/01 utiliza formalmente em seu PPC para simular o papel padronizador que uma DCN?
p93	T10	De que forma o componente curricular de Ética e Prática Profissional do curso de bacharelado em quiropraxia pretende preparar o seu egresso para atuar na prática autônoma, gerenciando a incerteza legal e os potenciais conflitos de fronteira com outras profissões?
p94	T8	Qual seria o requisito obrigatório que uma DCN, que por sua natureza, inviabilizaria a

(p)	Temas	Perguntas trianguladas por temas
		oferta de cursos inadequados para uma profissão de primeiro contato na área da saúde?

Fonte: Elaborado pelo autor

A sistematização consubstanciada no Quadro 23 transcende o mero inventário de indagações, representando a materialização do rigor metodológico e da profundidade dialética que sustentam esta investigação. Ao organizar as 94 perguntas que compuseram o roteiro das entrevistas semiestruturadas, este quadro sintetiza o esforço de triangulação entre a teoria, a norma e a percepção dos atores estratégicos, permitindo que a pluralidade de vozes alcançasse o princípio da saturação teórica indispensável para a compreensão do fenômeno em sua totalidade.

A reflexão suscitada por este painel de questões revela a complexidade da Quiropraxia no Brasil, situada em um hiato normativo que confronta a maturidade dos *standards* internacionais com a precariedade do balizamento legal doméstico. Os eixos temáticos propostos no quadro desvelam que a manutenção do estatuto inovador e experimental por 25 anos exauriu sua função pedagógica, convertendo-se em uma lacuna que fragiliza a identidade profissional e impõe riscos à segurança biológica da coletividade. As questões aqui sistematizadas expõem, de forma inequívoca, que a ausência de DCN específicas não é apenas uma omissão administrativa, mas um obstáculo ao exercício do múnus público do Estado na garantia de um padrão de qualidade formativa.

Em última análise, este quadro serve como o alicerce técnico-científico para as proposições que encerram este estudo. Ele demonstra que a transição da experiência acumulada pelas universidades pioneiras para uma norma soberana e estável é um imperativo ético e social. Assim, a organização destas discussões pavimenta o caminho para a construção de um referencial de qualidade que harmonize a autonomia universitária com as recomendações da OMS e as demandas do SUS, garantindo que a Quiropraxia brasileira alcance, enfim, sua plena maioria normativa.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação propôs-se a apurar os processos legais na oferta de cursos superiores de Quiropraxia no Brasil, visando fornecer subsídios teóricos e técnicos para a estruturação de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e a devida regulamentação profissional. A complexidade desta política educacional foi desvelada nesta pesquisa por meio de quatro pilares fundamentais: a reconstrução histórica e documental do ensino global; o exame dos marcos regulatórios nacionais; a percepção de atores estratégicos através de entrevistas; e a análise das consequências da despadronização curricular.

A análise em paralelo demonstra que a estrutura mundial da profissão é consolidada globalmente a 130 anos, hoje em 99 países como uma profissão autônoma, de primeiro contato e formação universitária com competências e habilidades clínicas específicas e o mínimo de mil horas de estágio supervisionado. Sua estrutura organizacional está sob a égide da Federação Mundial de Quiropraxia (WFC) membro da OMS, é fundamentada em rigorosos padrões educacionais de acreditação regida por agências oficiais de fiscalização e controle que garantem a qualidade do ensino por meio de standards internacionais desenvolvidos em conjunto entre o Conselho Internacional de Educação em Quiropraxia (CCEI) e outros organismos oficiais.

A trajetória da formação superior em Quiropraxia no Brasil, teve início consubstanciado nos padrões internacionais de educação em quiropraxia com aporte de instituições internacionais parceiras que por determinado período participavam da estruturação dos PPC dos cursos pioneiros e do desenvolvimento acadêmico dos alunos, tanto na fundamentação teórica, quando nas práticas clínicas. A introdução dos cursos pioneiros no país se deu formalmente amparada no caráter inovador e experimental previsto no Art. 81 da LDB. Contudo, passados 25 anos nesse mesmo perfil de flexibilidade, revela um agudo contraste entre a maturidade da estrutura mundial da profissão e a precariedade do seu balizamento normativo no território nacional. A legitimidade acadêmica, atestada por sucessivos reconhecimentos e notas máximas do Ministério da Educação (MEC), confronta-se com um limbo normativo decorrente da ausência de DCN específica e de uma lei regulamentadora.

A análise das percepções dos entrevistados permitiu identificar que o campo da Quiropraxia brasileira ao longo de 25 anos de oferta ininterrupta do bacharelado, vive sob um paradoxo do experimentalismo: se por um lado o Art. 81 da LDB permitiu a inovação pela introdução dos cursos pioneiros em 2000, por outro, a sua manutenção prolongada exauriu a função pedagógica, tornando-se uma brecha para ofertas formativas desprovidas de rigor técnico.

A pesquisa empírica e documental revelou que essa despadronização no Brasil resultou em uma ameaça direta à saúde pública e à identidade profissional. A manutenção dos cursos sob o rótulo de Inovador e Experimental (Art. 81 da LDB), por mais de duas décadas, abre a lacuna que permite a proliferação de ofertas formativas desprovidas de rigor técnico, como cursos 100% online com cargas horárias reduzidas, o que fere diretamente o princípio da segurança na saúde pública e compromete a identidade do bacharel quiropraxista de primeiro contato.

Postulando o pensamento dos entrevistados, revela-se outra preocupação profunda, trata-se da ausência de acreditação internacional dos cursos brasileiros, enquanto o mundo segue os *standards* do CCEI, a América Latina, e especificamente o Brasil é apontada como a única região onde a profissão é ensinada sem o devido controle e fiscalização externa, resultando em egressos cujos diplomas carecem de validade global. Tal cenário é agravado pela interferência sistemática de autarquias corporativistas, notadamente o Conselho de Fisioterapia, que tem utilizado seu capital político para travar o mérito educacional no Conselho Nacional de Educação e no Legislativo, mantendo a profissão em um vácuo regulatório.

Os depoimentos dos pioneiros e gestores destacaram que a interferência de autarquias de áreas correlatas, pautada em visões corporativistas, tem obscurecido o mérito pedagógico e dificultado o avanço normativo no CNE. O principal fator dificultador no processo de regulamentação e homologação das DCN, conforme unanimidade entre os entrevistados, reside na interferência sistemática da autarquia da Fisioterapia. Os depoimentos destacam que o embate transcende o mérito acadêmico, situando-se em uma disputa de capital político e corporativismo.

Os entrevistados relatam com estranheza que, embora o Brasil seja signatário da OMS, o CNE tenha, em momentos críticos, priorizado o diálogo com órgãos de áreas correlatas em detrimento dos representantes legítimos da Quiropraxia, o que resultou na estagnação normativa observada entre 2008 e 2010. Apontam que a construção das DCN transcende o âmbito meramente burocrático, trata-se de um imperativo ético e social. O caso da Quiropraxia assemelha-se aos precedentes da Física e da Saúde Coletiva, nos quais a estruturação das diretrizes curriculares serviu como alicerce técnico fundamental para a posterior regulamentação legislativa.

Além da barreira corporativista, os entrevistados postulam que a falta de traquejo político e de uma estratégia de comunicação coesa por parte dos representantes atuais da profissão tem contribuído para a paralisia legislativa. Ao contrário das primeiras turmas (2000-2014), que demonstravam alta união e comprometimento com a identidade raiz da profissão, o

cenário contemporâneo revela uma fragmentação que permite a proliferação de cursos 100% online e de curta duração, os quais os entrevistados classificam como contos de fadas perigosos para a sociedade.

Revela-se imperativo destacar que a ausência de DCN específicas para a Quiropraxia compromete a integridade e a eficácia dos processos de avaliação institucional e de curso conduzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)/MEC. Atualmente, as comissões de avaliação operam em um cenário de subjetividade e incerteza, uma vez que o instrumento de avaliação do INEP carece de parâmetros específicos que reflitam o consenso mundial de educação quiroprática.

Sem o balizamento de uma DCN, os avaliadores, que muitas vezes são originários de áreas correlatas e possuem escasso conhecimento sobre a especificidade quiroprática, veem-se obrigados a utilizar critérios genéricos da área da saúde. Esse limbo normativo resulta em três prejuízos fundamentais para a regulação do sistema de ensino:

- a) Fragilidade no Perfil do Egresso: Sem diretrizes, não há como o INEP aferir se a formação garante as competências clínicas mínimas e as 1.000 horas de estágio supervisionado recomendadas pela OMS;
- b) Oportunismo Regulatório: A manutenção da categoria experimental permite a proliferação de cursos com cargas horárias reduzidas ou modalidades 100% online, que são aprovadas por atenderem a requisitos administrativos formais, mas que binalizam a identidade profissional e põem em risco a saúde pública;
- c) Inconsistência da Avaliação Externa: A ausência de uma DCN impede que o Estado estabeleça um referencial de qualidade estável, tornando as renovações de reconhecimento processos baseados em comparações assistemáticas, conforme evidenciado pelo Parecer CNE/CES nº 120/2010.

Em suma, a formalização da DCN é também o mecanismo técnico necessário para que o INEP deixe de avaliar a Quiropraxia como um fenômeno experimental e passe a tratá-la como uma práxis de saúde consolidada, dotada de instrumentos de medição de qualidade rigorosos, legítimos e éticos.

Considerando o exaurimento do ciclo histórico-analítico desta investigação, resta evidenciada a insustentabilidade da manutenção do ensino da Quiropraxia sob o epíteto de inovador e experimental, conforme facultado pelo Artigo 81 da LDB, após vinte e cinco anos de prática ininterrupta e consolidação acadêmica. A exaustão desse modelo, que outrora permitiu o pioneirismo das instituições de ensino superior, transmuta-se hodiernamente em um limbo normativo que fragiliza o estatuto ontológico da profissão e abre flancos para ofertas

formativas desprovidas de rigor científico e supervisão clínica adequada, colocando em risco a segurança biológica da coletividade.

Nesse sentido, o exercício do múnus público conferido ao Conselho Nacional de Educação impõe a necessidade premente de uma estabilidade normativa que ordene a formação de recursos humanos em saúde, transcendendo a mera técnica adaptativa em prol de uma práxis ética e independente.

Nessa perspectiva, e como coroamento do esforço dialético empreendido neste estudo, apresenta-se a sugestão de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Bacharelado em Quiropraxia, Apêndice A, estruturada como um arcabouço técnico-científico centrado em harmonizá-lo com a autonomia universitária brasileira por meio do compilado nos referenciais oficiais do consenso mundial de educação em quiropraxia preconizado nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), nos *standards* do Conselho Latino-Americano de Educação em Quiropraxia (CCE-LA) e demais órgãos afins.

Esta proposição não se limita a um rito administrativo, mas constitui um ato de responsabilidade social e pedagógica, fundamentado em competências clínicas rigorosas, na exigência de mil horas de estágio supervisionado e na delimitação clara da identidade de um profissional de saúde de primeiro contato.

A construção das DCN deve ir além do manejo da dor, fundamentando a Quiropraxia como uma racionalidade médica complexa (Nascimento *et al.*, 2013). Segundo este conceito, a profissão se organiza em seis dimensões: morfologia, dinâmica vital, doutrina médica, sistema diagnóstico, sistema terapêutico e cosmologia. Essa estrutura garante a distinção do saber quiroprático frente a outras áreas da saúde.

O delineamento a seguir, Apêndice A, visa, portanto, converter a maturidade da experiência acumulada pelas universidades pioneiras em um referencial de qualidade estável e soberano, apto a balizar a avaliação institucional e garantir a supremacia axiológica da Constituição Federal no campo da saúde pública.

Revela-se medida urgente que o Estado Brasileiro exerça seu múnus público, protegendo o cidadão contra a formação precária e assegurando que a Quiropraxia seja reconhecida como uma práxis de saúde ética, segura e independente por meio da homologação de uma DCN específica necessária para garantir que a formação de recursos humanos em saúde no Brasil atenda aos padrões de qualidade e segurança exigidos pela sociedade e pelas organizações internacionais.

REFERÊNCIAS

ABREU, Geysa Spitz Alcoforado de. **Escola Americana de Curitiba (1892-1934):** um estudo do americanismo na cultura escolar. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2003.

ABREU, K. **Projeto de Lei nº 2850/2021.** Dispõe sobre o exercício da profissão de Quiropraxista. Brasília: Congresso nacional, 17 ago. 2021. Disponível em: <https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicameras/-/ver/pl-2850-2021>. Acesso em: 18 nov. 2024.

ABREU, Kátia. **Projeto de Lei nº 2850, de 2021.** Dispõe sobre o exercício da profissão de Quiropraxista. Brasília: Congresso Nacional, 2021. Disponível em: <https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicameras/-/ver/pl-2850-2021>. Acesso em: 01 jan. 2026.

ANGLO-EUROPEAN COLLEGE OF CHIROPRACTIC. **Learn more about Health Sciences University.** London: AECC, 2025. Disponível em: <https://www.hsu.ac.uk/about/our-pproach/academic-schools/aecc-school-of-chiropractic/>. Acesso em: 22 jan. 2025.

BACKBONE ep 03: o primeiro quiropraxista do Brasil. Por: Fernando Azevedo e Evergisto Souto Maior Lopes. [S. l.]: Papo Pontual, 2021. 1 vídeo (32 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=U_Wlfw-7zRw. Acesso em: 09 abr. 2025.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 1977.

BASIL. **Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025.** Dispõe sobre a oferta de educação a distância por instituições de educação superior em cursos de graduação [...]. **Diário Oficial da União:** Seção 1, Brasília, n. 93, p. 1, 20 maio 2025e. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-12.456-de-19-de-maio-de-2025-630398639>. Acesso em: 01 jun. 2025.

BASIL. Ministério da Educação. Portaria MEC nº 378, de 19 de maio de 2025. Dispõe sobre os formatos de oferta dos cursos superiores de graduação. **Diário Oficial da União:** Seção 1, Brasília, n. 93, p. 103, 20 mai. 2025f. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mec-n-378-de-19-de-maio-de-2025-630395302>. Acesso em: 01 jun. 2025.

BRACHER, Eduardo Sawaya Botelho; BENEDICTO, Camila de Carvalho; FACCHINATO, Ana Paula Albuquerque. **Revista Médica**, São Paulo, v. 92, n. 3, p. 173-182, jul./set. 2013. Disponível em: <https://revistas.usp.br/revistadc/article/view/79998>. Acesso em: 16 jan. 2025.

BRASIL. Seção Judiciária do Distrito Federal. 3ª Vara Federal Cível. **Procedimento Comum Cível n. 0011911-09.2012.4.01.3400.** Trata-se de Ação de obrigação de fazer ajuizada pela Associação Brasileira De Quiropraxia – ABQ em face do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO. Juiz Federal Substituto Bruno Anderson Santos da Silva. Brasília: Justiça Federal da 1ª Região, 07 jul. 2021. Disponível em: <https://irp.cdn-website.com/f1ff90f1/files/uploaded/12.%20Senten%C3%A7a%20Tipo%20A%20-%20ID%20377092385.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, Presidência da República, [2024a]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 maio 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Propostas legislativas**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2025c. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada>. Acesso em: 01 jun. 2025.

BRASIL. **Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2025b]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm. Acesso em: 25 maio 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.691, de 10 de julho de 2018**. Dispõe sobre o exercício da profissão de físico e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13691.htm. Acesso em: 01 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.691, de 10 de julho de 2018**. Dispõe sobre o exercício da profissão de físico e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13691.htm. Acesso em: 05 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.725, de 16 de novembro de 2023**. Regula a profissão de sanitário. Brasília: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14725.htm. Acesso em: 05 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Presidência da República, [2024b]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 25 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Câmara de Educação Superior. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES nº 120/2010, aprovado em 7 de maio de 2010**. Consulta sobre a área do conhecimento a que pertence o Curso Superior de Quiropraxia e a possibilidade de estabelecer as respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília: MEC, 2010. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/parecer-ces-2010>. Acesso em: 01 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES 1.133/2001**. Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição. Brasília, DF: Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, 2001a. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/ces1133.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES nº 776, de 3 de dezembro de 1997**. Orienta para as diretrizes curriculares dos cursos de Graduação. Brasília: MEC, 1997. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_parecer77697

.pdf. Acesso em: 25 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES nº 583, de 4 de abril de 2001**. Orientação para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação. Brasília: MEC, 2001b. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0583.pdf>. Acesso em: 25 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES nº 146, de 3 de abril de 2002**. Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Direito, Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria, Secretariado Executivo, Música, Dança, Teatro e Design. Brasília: MEC, 2002.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES nº 1.304/2001**. Diretrizes Nacionais Curriculares para os Cursos de Física. Brasília: Ministério da Saúde, 2001c. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES1304.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES Nº: 230/2008**. Recurso contra decisão do Secretário de Educação Superior referente ao reconhecimento do curso de Quiropraxia, ministrado pelo Centro Universitário FEEVALE, com sede na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul. Brasília: MEC, 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/pces230_08.pdf. Acesso em: 01 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES nº 120/2010**, aprovado em 7 de maio de 2010. Consulta sobre a área do conhecimento a que pertence o Curso Superior de Quiropraxia e a possibilidade de estabelecer as respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília: MEC, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES N. 1.304/2001**. Diretrizes Nacionais Curriculares para os Cursos de Física. Brasília: MEC, 2001. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES1304.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CES N. 242/2017**. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Saúde Coletiva. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=72431-pces242-17-pdf&category_slug=setembro-2017-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 05 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Sistema e-MEC. **Cadastro nacional de cursos e instituições de educação superior cadastro e-MEC**. Brasília: e-MEC, 2025a. Disponível em: <https://emec.mec.gov.br/emec/nova#simples>. Acesso em: 25 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 849, de 27 de março de 2017**. Inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0849_28_03_2017.html. Acesso em:

28 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. **Câmara de regulação do trabalho em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Série E. Legislação em Saúde). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_camara_regulacao.pdf. Acesso em: 01 jun. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho. **Classificação Brasileira de Ocupações**: osteopatas e quiropraxistas. Brasília: Ministério do Trabalho, CBO, 2013. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorCodigo.jsf>. Acesso em: 17 nov. 2023.

BRASIL. Senado Federal. **Projetos e matérias**: proposições. Brasília: Senado Federal, 2025d. Disponível em: <https://www6g.senado.leg.br/busca/?q=projetos+de+lei&colecacao=Projetos%20e%20Mat%C3%A9rias%20-%20Proposi%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 01 jun. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (3ª Região). **Apelação/Reexame necessário nº 0004375-43.2009.4.03.6100/SP**. Mandado de segurança - Quiropraxia – Profissão ainda não regulamentada - resolução COFFITO 220/2001. Relator: Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, 10 out, 2014. São Paulo: Tribunal Regional Federal, 20 out. 2014. Disponível em: <https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/3869266>. Acesso em: 18 nov. 2023.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. 14ª Vara. **Sentença Nº: 348/2003-B. Processo Nº: 2001.31003-7**. Ação Cautelar, com pedido de liminar, proposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUIROPRAXIA, qualificada nos autos, contra o CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL – COFFITO, pleiteando a suspensão dos efeitos da Resolução nº 220/2001 do COFFITO até julgamento definitivo da ação principal. Relator: Juiz Charles Renaud Frazão de Moraes. Brasília: TRF 14ª Vara, 2003. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=131>. Acesso em: 02 jun. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. 3ª Região. Mandado de Segurança Coletivo 2009.61.00.004375-1/SP. ABQ - Associacao Brasileira De Quiropraxia (Adv. Df013377 Luis Antonio Castagna Maia) X Presidente Do Conselho Regional De Fisioterapia E Terapia Ocupacional. Juiza Diana Brunstein. **Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região**, São Paulo: 25 fev. 2009. Disponível em: <https://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/BaixarPdf/931>. 2025.

CARD, Elizabeth B. **Cultural perspectives on bonesetting**: a comparative study. [s.l.]: [s.n.], 2020.

CECHINEL, André *et al.* Estudo/análise documental: uma revisão teórica e metodológica. **Criar Educação**, Criciúma, v. 5, n. 1, jan/jun. 2016.

CELLARD, André. A análise documental. In: POUPART, Jean *et al.* **A pesquisa qualitativa Enfoques epistemológicos e metodológicos**. Tradução de Ana Cristina Nasser. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

CHAPMAN-SMITH, David. **Quiropraxia**: uma profissão na área da saúde: educação, prática, pesquisa e rumos futuros. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2001.

CHEHUEN NETO, José Antônio. **Metodologia da pesquisa científica**: da graduação à pós-graduação. Curitiba: CRV, 2012.

CHIROPRACTIC BOARD OF AUSTRALIA. **Regulating Australia's chiropractors**. Melbourne: Ahpra, 2023. Disponível em: <https://www.chiropracticboard.gov.au>. Acesso em: 25 maio 2025.

CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A "era das diretrizes": a disputa pelo projeto de educação dos mais pobres. **Revista Brasileira de Educação**, v. 17, n. 49, p. 11-37, ene./abr. 2012.

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE QUIROPRÁCTICA. Consejo Latinoamericano de Educación Quiropráctica. **Estándares de acreditación del programa educativo de quiropráctica**. [S. l.]: CLAEQ, 2024. Disponível em: <https://flaq.org/wp-content/uploads/2024/09/ESTANDARES-DEL-PROGRAMA-EDUCATIVO-.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. **Diga não!**: em prol da segurança da saúde da população brasileira diga não à regulamentação da profissão de Quiropraxia. Brasília: COFFITO, 04 set. 2023. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?s=quiropaxia>. Acesso em: 02 jun. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. **Entidades associativas/especialidades**. Brasília: COFFITO, 2008b.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. **Ofício GRAPE n. 310/2008**. Procedimento administrativo n. 1.16.000.001311/2008-36. Brasília: COFFITO, 08 out. 2008a.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. **Portaria COFFITO n. 012, de 29 de janeiro de 2004**. Aprova nos termos da Resolução COFFITO n. 220, de 23/05/2001, o Projeto Pedagógico do Curso de Formação de Especialista em Quiropraxia promovido pelo IBRAQUI. Brasília: COFFITO, 2004.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. **Resolução n. 220, de 23 de maio de 2001**. Dispõe sobre o reconhecimento da Quiropraxia e da Osteopatia como especialidades do profissional Fisioterapeuta e dá outras providências. Brasília: COFFITO, 2001. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=2978>. Acesso em: 01 jun. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. **Resolução n. 399, 03 de agosto de 2011**. Disciplina a Especialidade Profissional de Fisioterapia em Quiropraxia e dá outras providências. Brasília: COFFITO, 2011. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1627>. Acesso em: 01 jun. 2025.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (Brasil). Resolução CNS nº 569, de 8 de dezembro de 2017. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, n. 38, p. 85-90, 26 fev. 2018. Disponível em: https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2018/02/anexo_CI_46_18.pdf. Acesso em: 25 maio 2025.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO. **Ofício CREFITO-3/GAPRE/Nº 216/2007**. São Paulo: CREFITO-3, 2007.

COSTA, A. B.; ZOLTOWSKI, A. P. C. Como escrever um artigo de revisão sistemática. In KOLLER, Silvia Helena; COUTO, Maria Clara P. de Paula; VON HOHENDORFF, Jean. (ed.). **Manual de Produção Científica**. Porto Alegre: Penso, 2014. p. 55-70.

COUNCIL ON CHIROPRACTIC EDUCATION. **About**. Scottsdale: CCE, 2023. Disponível em: <https://www.cce-usa.org>. Acesso em: 30 mar. 2025.

COUNCIL ON CHIROPRACTIC EDUCATION. **Mission**. Scottsdale, AZ: CCE, 2023. Disponível em: <https://www.cce-usa.org/missionvalues.html>. Acesso em: 18 nov. 2023.

COUNCILS ON CHIROPRACTIC EDUCATION INTERNATIONAL. **About us**: a brief history. Toronto: CCEI, 2024. Disponível em: <https://www.cceintl.org/about>. Acesso em: 25 maio 2025.

COUNCILS ON CHIROPRACTIC EDUCATION INTERNATIONAL. **Chiropractic education and accreditation**: current trends and future directions. Toronto: CCEI, 2022. Disponível em: <https://www.dyu.edu/news/2023/02/03/chiropractic-director-elected-ccei-usa>. Acesso em: 30 mar. 2025.

CURY, Carlos Roberto Jamil. Conselhos de Educação: fundamentos e funções. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação**, v. 22, n. 1, p. 41-67, jan./jun. 2006.

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE QUIROPRÁCTICA. **Documentos**. [S. l.]: FLAQ, 2025. Disponível em: <https://flaq.org/claeq-cce-la/documentos/>. Acesso em: 01 jun. 2025.

FRAGA, A. **Projeto de Lei nº 4199/2001**. Dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 5º e 12 e acrescenta o art. 4º-A [...]. Brasília: Câmara dos Deputados, 08 mar. 2001. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=26520>. Acesso em: 18 nov. 2024.

FRIEDMAN, H. Cultural perspectives on bonesetting: a comparative study. **Medical Anthropology Quarterly**, v. 15, n. 2, 2001.

HALDEMAN, Scott. (ed.). **Principles and practice of chiropractic**. New York: McGraw-Hill, 2005.

HARRIS, P. Bonesetters and bone-setting: a historical perspective. **Journal of Orthopaedic Surgery and Research**, v. 5, n. 1, 2010.

HEALTH SCIENCE UNIVERSITY. **AECC school of chiropractic**. Bournemouth: Health Sciences University, 2025. Disponível em: <https://www.hsu.ac.uk/about/our-approach/academic-schools/aecc-school-of-chiropractic/>. Acesso em: 25 maio 2025.

HOBBSAWM, Eric. **A era das revoluções: 1789-1848**. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

IBN SINA (Avicena). **O livro da cura = Al Qanun fi Al-Tibb = The canon of medicine**. Tradução por profissionais especializados com base nas edições latinas. Oxford: Oxford University Press, 2005. Original do século XI.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Comissão Nacional de

Classificação. **Quiropraxia**: serviços de. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://cnae.ibge.gov.br/?option=com_cnae&view=atividades&Itemid=6160&tipo=cnae&chave=quiropaxia&versao_classe=7.0.0&versao_subclasse=10.1.0. Acesso em: 27 maio 2025.

INTERNATIONAL BOARD OF CHIROPRACTIC EXAMINERS. **Who we are**. USA: IBCE, 2023. Disponível em: <https://www.ibce.org/who-we-are/>. Acesso em: 25 maio 2025.

INTERNATIONAL FEDERATION OF ORTHOPAEDIC MANIPULATIVE PHYSICAL THERAPISTS. [Correspondência]. Destinatário: David Lopes Sanchez do Colegio de Kinesiologos de Chile. New Zealand: IFOMPT, 14 Dec. 2009.

JOHNSON, Claire D. *et al.* A brief review of chiropractic educational programs and recommendations for celebrating education on Chiropractic Day. **Journal of Chiropractic Humanities**, v. 29, p. 44–54, Dec. 2022.

KAPTCHUK, Ted J. **The Web that has no weaver**: understanding chinese medicine. Nova York: Congdon & Weed, 1983.

KEATING, Joseph C.; CALLENDER, Alana K.; CLEVELAND, Carl S. **A history of chiropractic education in North America**: report to the council on chiropractic education. Davenport IA: Association for the History of Chiropractic, 1998.

LOPES, Evelyn Franca Souto Maior. **História da Quiropraxia no Brasil de 2004 a 2024, através da coleta de dados públicos**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Quiropraxia) - Centro Universitário FAI, Itapiranga, 2024.

LOPES, Evergisto Souto Maior. **A história da Quiropraxia no Brasil entre 1920 e 2004**. Novo Hamburgo: FEEVALE, 2004. Disponível em: https://www.clinicamoveu.com.br/img/galeria/quiropaxia/historia_quiropaxia_1920_2004.pdf. Acesso em: 28 maio 2025.

MARTINS, Maria Ines. **Chiropractic program evaluation as a dynamic system**. 2024. Final Report (Postdoctoral) - Ohio University, Ohio, 2024.

MCGOWAN, J. The history of osteopathy: a brief overview. **Osteopathic Medicine and Primary Care**, v. 4, n. 1, p. 1-6, 2010.

McNABB, B. The First Chiropractic Colleges in Brasil. **Chiropractic History: The Archives and Journal of the Association for the History of Chiropractic**, v. 24, n. 1, Summer, 2004.

MEEKER, William C; HALDEMAN, Scott. Chiropractic: a profession at the crossroads of mainstream and alternative medicine. **Annals of internal medicine**, v. 136, n. 3, p. 216–227, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.7326/0003-4819-136-3-200202050-00010> Acesso em: 10 fev. 2025.

MIDDENDORP, Joost J. Van; SANCHEZ, Gonzalo M.; BURRIDGE, Alwyn L. The Edwin Smith papyrus: a clinical reappraisal of the oldest known document on spinal injuries. **European Spine Journal**, v. 19, n. 11, p. 1815–1823, Nov. 2010. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-010-1523-6>. Acesso em: 22 fev. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. 18

ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

MOREIRA, A. **Projeto de Lei nº 114/2015**. Regulamenta o exercício da profissão de Quiropraxista. Brasília: Câmara dos Deputados, 03 fev. 2015. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=945503>. Acesso em: 18 nov. 2024.

NASCIMENTO, Marilene Cabral do *et al.*. A categoria racionalidade médica e uma nova epistemologia em saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, n. 12, p. 3595–3604, dez. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/pc64qpYhDGL9QDZp9DnJWzc/?lang=pt>. Acesso em: 24 mar. 2026.

NEVES, Selma Cosso. **D. D. Palmer (1845-1913) e as origens da quiropraxia no século XIX**. 2016. Dissertação (Mestrado em História da Ciência) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

NORUM, Evan. **Complete history of chiropractic care**. New Berlin, Wisconsin: Advantage Chiropractic, 26 Aug. 2024. Disponível em: <https://www.chiropractornewberlin.com/history-of-chiropractic/>. Acesso em: 02 fev. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Diretrizes da OMS sobre a formação básica e a segurança em quiropraxia**. Genebra: OMS, 2005.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Brasil**. Brasília, DF: OPAS/OMS, 2023. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/brasil>. Acesso em: 18 nov. 2023.

PAGE, M. J. *et al.* The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **The BMJ**, n. 71, 2021.

PALMER, Bartlett Joshua. **The chiropractic adjuster**: a compilation of the writings of D.D. Palmer: v. 4. Davenport, Iowa: Palmer School of Chiropractic, 1921. Disponível em: <https://archive.org/details/27.-volume-4-the-chiropractic-adjuster-palmer-1921-gbm-27>. Acesso em: 27 jan. 2025.

PALMER, Daniel David. **Text-book of the science, art and philosophy of chiropractic for students and practitioners**. Portland, OR: Portland printing house company, 1910.

PETERSON, Cynthia K. *et al.* The Councils on Chiropractic Education International Mapping Project: Comparison of Member Organizations' Educational Standards to the Councils on Chiropractic Education International Framework Document. **Journal of Chiropractic Humanities**, v. 29, p. 1-6, Dec. 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1556349922000018?via%3Dihub>. Acesso em: 25 maio 2025.

PETTMAN, Erland. A history of manipulative therapy. **Journal of Manual & Manipulative Therapy**, v. 15, n. 3, p. 165–174, 2007. Disponível em: <https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC2565620&blobtype=pdf>. Acesso em: 17 jan. 2025.

SAMPAIO, Rosana Ferreira; MANCINI, Marisa Cotta. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. **Revista Brasileira de Fisioterapia**. São Carlos, v. 11, n.1, p.83-89, jan./fev. 2007.

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais**, v. 1, n. 1, p. 1-15, jan./jun. 2009.

SCHEMES, Claudia; SILVA, Cristina Ennes da. **Aspeur/Feevale: 50 anos de uma trajetória comunitária**. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2019.

STILL, Andrew Taylor. **Osteopathy: research and practice**. New York: A.T. Still, 1899.

STRANG, Virgil V. **Essential principles of chiropractic hardcover**. Davenport, Iowa: Palmer School of Chiropractic, 1984. Disponível em: https://archive.org/details/isbn_9789996768293/page/4/mode/2up?view=theater. Acesso em: 27 jan. 2025.

THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Saturação em pesquisa qualitativa: estimativa empírica de dimensionamento. **Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 20-27, set. 2009. Disponível em: https://revistapmkt.com.br/wp-content/uploads/2009/03/SATURACAO_EM_PESQUISA_QUALITATIVA_ESTIMATIVA_EMPIRICA_DE_DIMENSIONAMENTO.pdf. Acesso em: 10 mar. 2025.

THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Saturação em pesquisa qualitativa: estimativa empírica de dimensionamento. **Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 20-27, set. 2009.

TROWBRIDGE, Carol. **Andrew Taylor Still 1828-1917**. Kirksville, Missouri: Thomas Jefferson University Press, 1991.

UNSCHULD, Paul U. **Medicine in China: a history of ideas**. Berkeley: University of California Press, 2003.

VEAL, Herbert J. *et al.* Quiropraxia ao redor do mundo. In: PETERSON, Dennis; WIESE, Glenda (ed.). **Quiropraxia: uma história ilustrada**. São Luís: Mosby-Year Book, 1995.

VEITH, Ilza. **The yellow emperor's classic of internal medicine**. Berkeley: University of California Press, 2002.

WANG, Ju-Yi; ROBERTSON, Jason D. **Applied channel theory in chinese medicine: Wang Ju-Yi's lectures on channel therapeutics**. Seattle, WA: Eastland Press, 2008.

WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC. **About WFC**. Toronto: World Federation of Chiropractic 2025a. Disponível em: <https://www.wfc.org/pt/about-us>. Acesso em: 28 mar. 2025.

WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC. **Chiropractic educational institutions**. Toronto: World Federation of Chiropractic, 2022. Disponível em: <https://www.wfc.org/pt/chiropractic-educational-institutions-flags>. Acesso em: 28 mar. 2025.

WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC. Consensus recommendations 2010. In: EDUCATION CONFERENCE, 2010, Madrid. Disponível em: <https://www.wfc.org/pt/consensus-recommendations-2010>. Acesso em: 02 jun. 2025.

WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC. **History of chiropractic**. Toronto, CA: WFC, 2024a. Disponível em: <http://wfc.org/pt/history>. Acesso em: 28 maio 2025.

WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC. **International chiropractic education alliance**: launch document august 2024. Toronto: WFC, 2024b. Disponível em: https://www.wfc.org/website/documents/1182_icea-launch-document-2024.pdf. Acesso em: 18 nov. 2023.

WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC. **Vision, mission and strategic pillars**. Toronto, CA: WFC, 2009. Disponível em: https://www.wfc.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=418&Itemid=91&lang=en. Acesso em: 18 nov. 2023.

WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC. **WFC history**. Toronto, CA: WFC, 2025b. Disponível em: <https://www.wfc.org/wfc-history>. Acesso em: 28 maio 2025

WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC. **World Health Organization**. Toronto: World Federation of Chiropractic, [2008?]. Disponível em: <https://www.wfc.org/pt/world-health-organization>. Acesso em: 01 jun. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **NGOs in official relationship with WHO related to Classifications and Terminologies (as of October 2021)**. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/classification/who-fic-network/ngos-designation-overview-as-of-october-2021_v2.pdf?sfvrsn=feb23497_7. Acesso em: 25 maio 2025.

ZULKE, R. **Projeto de Lei nº 1436/2011**. Regulamenta o exercício da profissão de Quiropraxista. Brasília: Câmara dos Deputados, 25 mai. 2011. Disponível em: <https://www.PLS2850/2021camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503822>. Acesso em: 18 nov. 2024.

APÊNDICE A

ARCABOUÇO PARA CONSTRUÇÃO DA DCN DA QUIROPRAXIA

Uma contribuição como sugestão a consubstanciar a construção de DCN para a graduação em Quiropraxia, conforme proposto na dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Educação, sob o título: O Processo de Formação Superior em Quiropraxia no Brasil – das Orientações da Organização Mundial da Saúde ao Processo de Construção das Diretrizes Curriculares Nacionais. Desenvolvido pelo mestrando, Evergisto Souto Maior Lopes, orientado pela professora doutora, Maria Inês Martins.

I – RELATÓRIO: ANÁLISE HISTÓRICO-REGULATÓRIA E MÉRITO ACADÊMICO

1. Histórico e Contextualização

O processo de institucionalização da Quiropraxia no Brasil remonta a 1913, com o pioneirismo de Isabel Bichels, embora a sistematização universitária tenha ocorrido apenas em 2000, por meio das universidades FEEVALE e Anhembi Morumbi. Tais cursos foram instituídos sob a égide do Artigo 81 da LDB, em caráter inovador e experimental. Contudo, após 25 anos de oferta ininterrupta e sucessivas renovações de reconhecimento com notas máximas pelo MEC, o exaurimento do ciclo experimental é flagrante. Em 2008, o pedido de construção das DCN foi protocolado, mas o processo foi obstaculizado pela ausência de oitiva de atores estratégicos como a OMS, o CCE-LA e a ABQ, resultando em um limbo normativo que fragiliza a segurança biológica da coletividade.

2. Do Mérito e da Necessidade Social

O mérito desta proposição reside no exercício do múnus público do Conselho Nacional de Educação (CNE) em garantir o padrão de qualidade preconizado pela Carta Magna. A ausência de DCN específicas fomenta a proliferação de ofertas despadronizadas, incluindo cursos 100% online com carga horária reduzida, o que banaliza a complexidade do diagnóstico quiroprático e coloca em risco a saúde pública. A formalização transmuta o ensino de Quiropraxia de um

fenômeno experimental para uma práxis consolidada, dotada de instrumentos de medição legítimos e éticos.

A formalização das diretrizes visa proteger a Quiropraxia de reducionismos técnicos, assegurando sua autonomia enquanto racionalidade médica (Nascimento *et al.*, 2013), o que é indispensável para a segurança biológica da coletividade e a preservação do tripé da raiz epistemológica da profissão em sua filosofia, ciência e arte.

3. Marcos Legais e Internacionais

A base legal ancora-se na Constituição Federal (Arts. 5º, XIII, 196 e 205), na Lei nº 9.394/1996 (LDB) e na Lei nº 8.080/1990 (SUS). Internacionalmente, fundamenta-se nas Diretrizes da OMS (2005), nos Standards of Accreditation do Council of Chiropractic Education International (CCEI) e do Conselho Latino-Americano de Educação em Quiropraxia (CCE-LA), assegurando equivalência global à formação brasileira.

II – OBJETO DE FORMAÇÃO E PERFIL DO EGRESSO

1. Objeto de Formação

O objeto central é a formação de um profissional de saúde autônomo e de primeiro contato, habilitado ao diagnóstico diferencial e ao tratamento conservador das disfunções biomecânicas da coluna vertebral e suas repercussões neurofisiológicas.

2. Perfil do Egresso/Profissional

O bacharel quiropraxista deverá possuir formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Deve ser capaz de atuar na atenção primária, secundária e terciária, pautando-se pelo paradigma quiroprático *sui generis* e pela ciência baseada em evidências, demonstrando autonomia técnica para tomada de decisões clínicas seguras e eficazes. Deve ser capaz de aplicar procedimentos avaliativos, intervencionistas e preventivos, com base nas ciências biológicas da formação universitária na área da saúde, direcionados à atuação na correlação da capacidade adaptativa do corpo humano por meio das interações do sistema nervoso com os seguimentos articulares da coluna vertebral e estruturas adjacentes nas funções corporais e os efeitos dessas correlações na saúde em geral.

O bacharel deve ser capaz de operar sob a racionalidade vitalista própria da Quiropraxia, reconhecendo a 'cosmologia' como a sexta dimensão que embasa teórica e simbolicamente sua prática clínica (Nascimento *et al.*, 2013).

Este perfil consubstancia-se na capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, utilizando os recursos disponíveis em prol de iniciativas e ações que se expressam em desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e sucesso, os desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes contextos do trabalho em saúde, abordando tanto o conjunto de competências profissionais para a inserção no mercado de trabalho, quanto um conjunto de competências transferíveis como comunicação, relacionamento interpessoal, flexibilidade e capacidade de trabalhar em equipe, e a capacidade de desenvolver novas competências.

3. Áreas do Conhecimento

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) contempla cinco áreas do conhecimento que objetivam formar profissionais aptos ao exercício seguro e qualificado da quiropraxia, nas diversas áreas e níveis de atenção à saúde, pautados em uma formação humanística, com tecnologia e inovação nos processos de ensino-aprendizagem para garantir a sólida formação:

1. **Ciência humanas e sociais aplicadas, ética e bioética:** Compreender os determinantes sociais da saúde, que consideram os fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, de gênero, e de orientação sexual, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais, ambientais, do processo de qualidade de saúde na prevenção e manutenção do paradigma quiroprático, bem como o contexto saúde-doença do indivíduo e da população.
2. **Ciências exatas:** Estudar o campo das ciências bioquímicas, físicas, matemáticas, estatísticas e de tecnologia da informação – domínio teórico e práticos aplicados às ciências quiropráticas.
3. **Ciências biológicas:** Contemplar as bases biológicas de interesse quiroprático, os processos fisiológicos, patológicos e fisiopatológicos da estrutura e da função dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas e dos aparelhos, e dos fatores de risco e de proteção para o desenvolvimento de doenças, aplicadas à prática dentro dos ciclos da vida.
4. **Ciências da saúde:** Contemplar o campo da saúde coletiva, a organização de pessoas, de serviços e do sistema de saúde, programas indicadores de qualidade e segurança dos serviços, políticas de saúde, legislação das práticas da saúde, bem como comunicação, educação em saúde, práticas integrativas e complementares que considerem a determinação social do processo qualidade de saúde na prevenção e manutenção proposto no programa quiroprático, bem como o contexto saúde e doença.

5. Ciências quiropráticas:

- Contemplar ciências básicas, ética, deontologia e legislação fundamentais à formação de profissional da saúde de primeiro contato, considerando o paradigma quiroprático necessário ao estudo, avaliação, diagnóstico e tratamento de disfunções biomecânicas na coluna vertebral e a sua influência na saúde em geral, em todas as etapas da vida.
- Estudar a raiz epistemológica da filosofia, da arte e da ciência quiroprática, sua fundamentação, história e estrutura de formação considerando os aspectos da legalidade, da legitimidade, da ética e deontologia no ordenamento brasileiro.
- Desenvolver habilidades psicomotoras, aplicabilidade das técnicas específicas e complementares, o uso de tecnologia e inovação direcionados ao exercício da quiropraxia em todas as etapas da vida.
- Estudar a inovação e os recursos tecnológicos contemporâneos aplicados ao empreendedorismo e a gestão clínica, comunicação, avaliação, cuidados e prevenção no exercício quiroprático.
- Pesquisar e desenvolver estudos e trabalhos para a inovação tecnológica da produção científica pertinente a formação e prática da quiropraxia no olhar da ciência baseada em evidência.

III – COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

A formação deverá assegurar o desenvolvimento das competências que integrem a cosmologia vitalista da quiropraxia ao seu sistema de intervenção terapêutico próprio (o ajuste), garantindo que o profissional atue sob uma racionalidade que reconheça a dinâmica vital humana em sua totalidade em atenção aos postulados nos *standards* do CCE-LA a partir da convergência entre as áreas do conhecimento propostas como a tríade formada pela filosofia, pela ciência e pela arte que fundamentam as distinções que legitimam a formação e a prática da quiropraxia.

Para o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e atitudes do profissional quiropraxista, são descritas a competência macro geral e oito meta-competências específicas, preliminares desdobradas em vinte e cinco habilidades, somadas como Conhecimento, Habilidade e Atitude (CHA):

1. Competência geral do bacharel quiropraxista:

Aplicar procedimentos avaliativos, intervencionistas e preventivos de forma conservadora, não medicamentosa e não cirúrgica, com base nas ciências biológicas da formação universitária na área da saúde, direcionados à atuação na correlação da capacidade adaptativa do corpo humano por meio das interações do sistema nervoso com os seguimentos articulares da coluna vertebral e estruturas adjacetes nas funções corporais e os efeitos dessas correlações na saúde em geral.

2. Meta-competências específicas do bacharel quiropraxista:

1. **Fundamentação:** Identificar alterações biomecânicas e patológicas que influenciam a homeostase corporal em todas as etapas da vida, com ênfase no complexo de subluxação vertebral e/ou disfunção articular;
2. **Capacitação:** Realizar a avaliação quiroprática baseada em um modelo biopsicossocial, considerando o exame físico e análise dos exames complementares, interpretar os achados clínicos e elaborar o diagnóstico quiroprático;
3. **Avaliação:** Solicitar, interpretar e analisar os achados dos exames de imagens, correlacionando-os com as informações clínicas do paciente para permitir a conduta quiroprática segura;
4. **Planejamento:** Traçar planos de cuidado e tratamento, contemplando a conduta e prognóstico quiroprático, produzir relatórios e documentação pertinentes à atuação profissional e o direito do paciente;
5. **Intervenção:** Executar as técnicas quiropráticas e orientações complementares de acordo com o plano de tratamento e cuidados traçados para o paciente;
6. **Reavaliação:** Reavaliar a evolução do paciente, confrontando as informações prévias e/ou nova condição, em conformidade com o protocolo de tratamento proposto, progresso na manutenção do cuidado quiroprático, proposta para exames complementares, transição para novas condutas e protocolos pertinentes, possibilidade de trabalho multiprofissional ou encaminhamento para outro profissional;
7. **Legitimação:** Compreender os aspectos legais da atividade quiroprática no Brasil em consonância com os fundamentos da legitimidade da profissão mundialmente, desenvolver estratégias para estrutura legal e de gestão na atuação quiroprática em ambiente clínico e afins, implementar métodos e

técnicas de comunicação e de marketing próprios da quiropraxia na educação do paciente, público em geral e meios de comunicação;

8. **Integração:** Avaliar métodos, equipamentos, inovações científicas e tecnológicas próprias da conduta quiroprática compreendendo deveres e obrigações, respeitando limites interdisciplinares com relação às demais profissões na área da saúde.

3. Habilidades Quiropráticas:

A competência geral e as meta-competências estão ancoradas no desdobramento de vinte e cinco habilidades compiladas das Diretrizes da OMS e das orientações do CCE-LA:

QUADRO DAS HABILIDADES QUIROPRÁTICAS		
Nº	Habilidade	Descrição
01	Obter, registrar e discutir a história	a. Obtém e registra e interage com o paciente o seu histórico clínico, social e estado geral de saúde;
		b. Avalia os fatores de risco individuais do paciente;
		c. Mantém registros seguros, precisos, consistentes, legíveis e contemporâneos de gerenciamento de pacientes, eletrônicos e/ou escritos.
02	Executar exame clínico	a. Explica a necessidade e o processo de exame.
		b. Realiza exames relevantes à avaliação dos pacientes.
		c. Obtém consentimento e realizar o exame físico com o devido respeito e preservação da modéstia.
03	Obter resultados de procedimentos clínicos, laboratoriais e outros procedimentos diagnósticos necessários para informar os cuidados	a. Identifica resultados e relatórios de pesquisas existentes.
		b. Determina procedimentos clínicos, laboratoriais e outros procedimentos diagnósticos relevantes para a apresentação dos pacientes.
		c. Encaminha ou realiza imagens quando clinicamente indicado.
		d. Faz encaminhamentos para outros profissionais de saúde ou obter mais informações, quando indicado.
04	Reconhecer os determinantes da saúde	a. Identifica e considera os determinantes da saúde, incluindo determinantes psicológicos, biológicos, sociais, culturais, ambientais, educacionais e econômicos, bem como fatores do sistema de saúde.
		b. Demonstra conhecimento de etiologia, patologia, características clínicas, história natural e prognóstico para apresentações comuns e importantes.
		c. Reconhece e responde às prioridades de saúde pública.
05	Analisar criticamente as informações disponíveis para gerar impressão clínica	a. Demonstra conhecimento de técnicas e procedimentos de diagnóstico por imagem, incluindo indicações e limitações das modalidades de imagem disponíveis.
		b. Interpreta e integra resultados de procedimentos clínicos, laboratoriais e diagnósticos no planejamento de

		cuidados.
		c. Forma uma compreensão do estado de saúde dos pacientes e/ou identifica possíveis diagnósticos.
		d. Identifica 'sinais de alerta', gerencia e/ou encaminha conforme apropriado.
06	Identificar opções de cuidado e manejo	a. Integra conhecimentos da quiropraxia e de outras ciências da saúde para informar sobre cuidados e opções de gerenciamento.
		b. Obtém, interpreta e aplica evidências e informações atuais para informar opções sobre cuidados e opções de tratamento.
		c. Identifica opções de cuidados e gestão que provavelmente serão terapeuticamente eficazes e seguras para os pacientes.
		d. Adapta a prática de acordo com as diferentes necessidades dos pacientes ao longo da vida humana, incluindo a necessidade de opções de cuidados e gestão adequadas aos pacientes.
		e. Considera oportunidades para melhorar o atendimento e o gerenciamento do paciente por meio do envolvimento de outros profissionais de saúde.
07	Discutir as opções de cuidado e manejo	a. Explica e discute os resultados e implicações da avaliação clínica com os pacientes.
		b. Discute o propósito, a natureza, os benefícios, os riscos e os resultados esperados do cuidado e do manejo com pacientes e outras pessoas.
		c. Discute e busca acordo com os pacientes e outras pessoas sobre os objetivos e prioridades dos pacientes.
		d. Descreve áreas de prática de outras profissões de saúde e explica abordagens interprofissionais para pacientes
08	Desenvolver plano de cuidados e manejo	a. Desenvolve plano de cuidados em colaboração com os pacientes, reconhecendo limitações pessoais e profissionais.
		b. Combina plano de cuidados centrado no paciente e baseado em evidências, incluindo tratamento quiroprático, cogestão ou encaminhamento.
		c. Estabelece planos para revisão dos cuidados e gestão (reavaliação)
09	Obter e registrar o consentimento informado do paciente em relação aos cuidados	a. Aplica requisitos legais, padrões profissionais e códigos relevantes para obter e registrar consentimentos de pacientes.
10	Implementar intervenções com segurança e eficácia	a. Executa ajustes, manipulações, intervenções manuais e outros procedimentos seguros e eficazes dentro do paradigma quiroprático.
		b. Fornece informações e conselhos aos pacientes para promoção da saúde, autogestão e escolhas de estilo de vida para uma saúde melhor.

		c. Adapta as intervenções levando em consideração fatores como idade, condição, estado de saúde, resposta aos cuidados e preferências do paciente.
11	Monitorar e avaliar o progresso do cuidado e os resultados de saúde	a. Reconhece possíveis complicações/eventos adversos decorrentes do manejo de pacientes e possui procedimentos apropriados para poder gerenciá-los de forma eficaz, incluindo encaminhamento para atendimento de emergência quando apropriado. b. Monitora o progresso dos pacientes no sentido de alcançar os resultados de saúde planejados usando medidas válidas e confiáveis, quando disponíveis. c. Monitora o gerenciamento e o cuidado de eventos adversos e mudanças na vida dos pacientes que podem afetar o cuidado. d. Considera opções alternativas quando indicado
12	Adaptar os planos com base na monitorização e avaliação	a. Colabora com pacientes e outros profissionais de saúde, quando indicado, para abordar questões decorrentes do monitoramento e avaliação.
13	Cumprir os requisitos legais e éticos	a. Adere à legislação relevante, direito consuetudinário, códigos, padrões e outras políticas que regulam a conduta e prática da Quiropraxia. b. Aplica os princípios éticos de autonomia, beneficência, não peculato e justiça. c. Aplica princípios de confidencialidade e privacidade. d. Estabelece e mantém relacionamentos e limites profissionais
14	Aplicar abordagem prática centrada no paciente	a. Reconhece e responde à diversidade da população, incluindo, entre outros, gênero, idade, religião, raça, deficiência, estatuto socioeconômico e orientação sexual. b. Reconhece e responde ao impacto da cultura, dos valores, das crenças, dos níveis de educação e das experiências de vida no estado de saúde, na saúde e nos comportamentos de procura de ajuda e na manutenção da saúde. c. Reconhece e responde à realidade emocional do paciente ao seu estado de saúde.
15	Aplicar abordagem prática baseada em evidências	a. Usa uma abordagem baseada em evidências no planejamento, prestação e avaliação de cuidados. b. Aplica pensamento crítico e resolução de problemas a todos os aspectos do cuidado.
16	Demonstrar integridade profissional	a. Demonstra compromisso com o desenvolvimento profissional contínuo e a aprendizagem ao longo da vida. b. Aplica habilidades de pesquisa para apoiar o desenvolvimento profissional e a aprendizagem ao longo da vida. c. Atua dentro dos limites de sua experiência e competência profissional e busca apoio profissional e revisão por pares quando necessário.

		d. Aceita a responsabilidade e a prestação de contas como profissional e membro da profissão de Quiropraxia.
		e. Aplica princípios de gerenciamento de risco e melhoria de qualidade à prática.
17	Demonstrar capacidade de autorreflexão	a. Demonstra habilidade em autoavaliação e avaliação crítica de conhecimentos, habilidades e experiência pessoal, incluindo consciência de preconceitos e crenças pessoais e como estes podem influenciar o atendimento ao paciente; tem estratégias adequadas para lidar com tais situações.
		b. Demonstra consciência dos fatores que afetam sua saúde e bem-estar, incluindo fadiga, gerenciamento de estresse, controle de infecções e prevenção de doenças, para mitigar os riscos à saúde da prática profissional.
18	Comunicar-se efetivamente com pacientes e outras pessoas	a. Comunica-se de forma eficaz, verbalmente, não verbalmente e por escrito, proporcionando clareza para cuidados e tratamentos seguros e acordados.
		b. Cumpre os requisitos de competência linguística estabelecidos na regulamentação da profissão.
		c. Adaptar o estilo de comunicação para reconhecer a segurança cultural e a diversidade cultural e linguística.
		d. Utiliza eficazmente a tecnologia da informação e comunicação para melhor clareza dos paradigmas quiropráticos na abordagem como profissão da cuidados da saúde.
19	Colaborar efetivamente com pacientes e outras pessoas	a. Demonstra empatia, escuta ativa, respeito mútuo e confiança no desenvolvimento de relacionamentos profissionais com pacientes e outras pessoas.
		b. Expressa opiniões profissionais com competência, confiança e respeito, evitando linguagem específica da disciplina quando necessário.
		c. Fornece feedback oportuno, sensível e instrutivo aos colegas da profissão de Quiropraxia e de outras profissões, e responde profissionalmente ao feedback desses colegas.
		d. Demonstra a capacidade de descrever e respeitar as funções e conhecimentos de outros profissionais de saúde.
		e. Demonstra capacidade de aprender e trabalhar de forma eficaz como membro de uma equipe interprofissional ou outro grupo profissional, inclusive por meio de delegação, supervisão, consulta e referências.
		Reconhece o potencial de desacordo e conflito em relação ao cuidado e à gestão, e responde para resolver problemas.
20	Implementar estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças	a. Reconhece a responsabilidade de proteger e promover a saúde e o bem-estar dos indivíduos, comunidades e populações.
		b. Participa de programas de educação em saúde e redução

		de riscos baseados em evidências para atender às necessidades identificadas na comunidade.
		c. Integra na prática a prevenção, a detecção precoce, a manutenção da saúde e a gestão de doenças crônicas, quando apropriado.
		d. Coloca as necessidades e a segurança do paciente no centro do processo de atendimento, demonstrando habilidades de segurança, incluindo controle de infecções, notificação de eventos adversos e cogestão e encaminhamento eficazes.
21	Gerenciar informações para cumprir obrigações legais e padrões profissionais	a. Cria, mantém e gerencia registros precisos e completos que atendem aos requisitos legais, padrões profissionais aceitos e regulamentos de confidencialidade.
22	Supervisionar o pessoal administrativo e outros	a. Define atividades que podem ser delegadas a pessoal administrativo ou outro.
		b. Explica a responsabilidade pela supervisão e treinamento de pessoal administrativo ou outro.
23	Desenvolver as habilidades necessárias para manter-se atualizado com pesquisas e literatura relevantes atuais	a. Participar de congressos e seminários relacionados com a educação continuada;
		b. Contribui para a discussão de políticas públicas, regulamentações e diretrizes que impactam a profissão;
		c. Desenvolve pesquisas.
24	Adaptar-se às diversas realidades e necessidades de seus pacientes	a. Reconhece a importância da empatia, comunicação efetiva, da escuta ativa, consideração positiva e da construção de relações de confiança e respeito mútuo;
		b. É capaz de atuar de forma sensível e adaptável às diversas realidades e necessidades de seus pacientes, integrando o cuidado quiroprático às dimensões psicossociais e espirituais do ser humano.
25	Cumprir responsabilidade social	a. Incentiva o compromisso com a promoção da saúde e a prevenção de doenças em comunidades;
		b. Promove a educação do paciente para desenvolver conscientização ética comprometida com a transformação social e a melhoria contínua da qualidade de vida dos indivíduos e da coletividade

IV – ESTRUTURA CURRICULAR MÍNIMA

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) deve ser centrado no estudante como sujeito ativo da aprendizagem, utilizando metodologias que articulem teoria e prática desde o início do curso. A coordenação do curso e o núcleo docente específico devem ser obrigatoriamente compostos por Bacharéis em Quiropraxia, garantindo a legitimidade do lugar de fala e a identidade

profissional.

1. Ciclos de Aprendizagem:

A triangulação entre as áreas do conhecimento, competência macro, meta-competências e as 25 habilidades quiropráticas deve compor o projeto pedagógico do curso (PPC) com uma estrutura curricular em espiral que transita de forma contínua em três ciclos de aprendizagem.

Ciclo I – bases biológicas e a fundamentação holística da quiropraxia

Ciclo II – treinamento de habilidades quiropráticas

Ciclo III – gestão, empreendedorismo e abordagem clínica em quiropraxia.

2. Parâmetros Estruturantes do PPC

1. **Carga Horária e Duração:** Mínimo de 4.200 horas, integralizadas em um período de 4 a 5 anos.
2. **Eixos Estruturantes:** Compreende as dimensões Biológica/Pré-clínica, Clínica (Diagnóstico), Específica (Quiropraxia), Humanístico/Social e de Investigação Científica.
3. **Estágio Curricular Supervisionado:** Etapa obrigatória e presencial de no mínimo 1.000 horas, sob supervisão direta de docente quiropraxista, visando a consolidação das competências clínicas.
4. **Trabalho de Conclusão de Curso (TCC):** Requisito indispensável para o fomento do pensamento crítico e da pesquisa científica na área.

V – REAVALIAÇÃO E QUALIDADE ACADÊMICA

O acompanhamento e a avaliação do curso de graduação em Quiropraxia devem constituir um processo contínuo de aferição da qualidade, fundamentado nos *standards* de acreditação internacional do CCE-LA, focado na melhoria contínua e na equivalência global da formação. Pautado nos *standards* de Acreditação do CCE-LA, o sistema avaliativo deve observar os seguintes critérios:

1. **Corpo Docente e Gestão:** A coordenação do curso e o núcleo docente específico devem ser obrigatoriamente compostos por bacharéis em Quiropraxia. A instituição deve demonstrar a existência de um sistema de supervisão acadêmica, centrado em métodos de ensino, avaliações e atividades de aprendizagem que assegure a integridade do projeto pedagógico, centrando-se em métodos de ensino e atividades de aprendizagem que contribuam

diretamente para o desenvolvimento da competência macro geral e as meta-competências específicas da profissão. Tal sistema deve ser administrado por órgãos designados com canais de comunicação claros e controle estabelecido pelas políticas institucionais.

2. **Infraestrutura:** Exigência de Clínica Escola equipada para o desenvolvimento das competências psicomotoras essenciais. O corpo docente deve utilizar sistemas instrucionais validados para avaliar constantemente as habilidades psicomotoras e o raciocínio clínico dos estudantes, priorizando a segurança do paciente e a qualidade do cuidado quiroprático. Tais avaliações devem incluir observação direta de procedimentos, raciocínio clínico e profissionalismo no ambiente da clínica-escola.

3. **Avaliação Institucional:** O programa de Quiropraxia deve estabelecer protocolos para a realização de autoavaliações periódicas em tempos determinados, fundamentados em critérios técnicos específicos e prazos determinados. Os resultados dessas aferições devem guiar o planejamento estratégico, a distribuição de recursos e a implementação de mudanças necessárias para a manutenção da qualidade e o cumprimento da missão e visão do curso.

4. **Acreditação:** Busca pela equivalência internacional dos diplomas brasileiros mediante o alinhamento aos critérios do CCEI. A revisão dos programas acadêmicos deve incorporar obrigatoriamente uma perspectiva externa, incluindo o acompanhamento por juntas qualificadoras (como o CCE-LA), auditores externos, egressos e outros profissionais quiropraxistas, garantindo que o currículo evolua em consonância com os padrões nacionais e internacionais de excelência.

5. **Integridade e Ética Acadêmica:** A instituição deve garantir a integridade acadêmica na atribuição de notas, créditos e certificações de competências. Devem existir políticas transparentes e justas para lidar com situações de má conduta acadêmica, como plágio ou fraude, promovendo um ambiente de honestidade e responsabilidade profissional.

6. **Planejamento Recursos e Sustentabilidade do Programa:** A qualificação acadêmica está intrinsecamente vinculada à estabilidade financeira. A instituição deve apresentar evidências de planejamento financeiro que garantam a todos os estudantes matriculados a conclusão de sua trajetória formativa com a infraestrutura física e tecnológica condizente com as exigências da disciplina.

VI – FONTES REFERENCIADAS

A fundamentação normativa deste arcabouço repousa sobre os seguintes marcos:

Nacionais: Constituição Federal de 1988; LDB (Lei nº 9.394/96); Lei Orgânica do SUS

(Lei nº 8.080/90); Resolução CNS nº 569/2017; Pareceres CNE/CES (Sanitarista e Físico).

Internacionais: Diretrizes da OMS sobre Formação Básica e Segurança em Quiropraxia (2005); CCE Accreditation Standards (2025); Standards of Accreditation CCE-LA/CLAEQ; Documentos de Identidade da Profissão da WFC; e, COUNCILS ON CHIROPRACTIC EDUCATION INTERNATIONAL. Chiropractic education and accreditation: current trends and future directions. Toronto: CCEI, 2022.

Institucionais: Proposta de Diretriz Curricular Nacional elaborada por ocasião do I Fórum de Educação em Quiropraxia organizado pela diretoria acadêmica da Associação Brasileira de Quiropraxia (ABQ) em 2023, e modelos pedagógicos das universidades pioneiras (FEEVALE e UAM).

Referência subsidiária de rigor normativo: STATE OF CALIFORNIA. BOARD OF CHIROPRACTIC EXAMINERS (BCE). Rules and Regulations. Sacramento, CA: Board of Chiropractic Examiners, Nov. 2021.

Aporte epistemológico: NASCIMENTO, Marilene Cabral do *et al.* A categoria racionalidade médica e uma nova epistemologia em saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, n. 12, p. 3595–3604, dez. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/pc64qpYhDGL9QDZp9DnJWzc/?lang=pt>. Acesso em: 24 mar. 2026.